

序

《百病良方》第一、二、三集相继出版并多次重印，总发行量已达65万多册。第一、二集还参加了1985年香港“中国书展”，备受海内外读者的青睐。

《百病良方》第四集仍保持了第一、二、三集的特点和优势，并自成系列。分科分病症列题，中西病名对照，简要地阐明一百种病症的定义、发病原因、临床表现、祖国医学相应的病证名称及病因病机、治则、方药等。对临床表现和治疗方法介绍得较详细、具体，便于读者掌握和运用。

我所贾河先主治医师是自学成才的佼佼者，曾荣获四川省职工自学成才奖，并被列入《中国职工自学成才者辞典》和《四川省职工自学成才名人录》。贾河先、邱运梨医师联合编著的《百病良方》第四集的出版，将有利于振兴中医事业，有利于中医学学术水平的提高，乐以为序。

中华全国中医学会重庆分会副秘书长
重庆市中医研究所副所长 冯淑兰

一九八八年一月

目 录

内	科
1. 流行性脑脊 髓膜炎……………(1)	12. 成人急性肺 炎……………(31)
2. 伤寒……………(5)	13. 肺水肿……………(34)
3. 登革热……………(8)	14. 成人呼吸窘 迫综合症………(36)
4. 慢性布鲁氏 菌病……………(12)	15. 慢性呼吸衰 竭……………(40)
5. 华支睾吸虫 病……………(14)	16. 肺部霉菌感 染……………(42)
6. 丝虫病……………(16)	17. 肺性脑病………(44)
7. 血吸虫病………(19)	18. 结核性干性 胸膜炎………(48)
8. 支气管哮喘 ……………(21)	19. 结核性渗出 性胸膜炎………(49)
9. 哮喘持续状 态……………(25)	20. 反流性食管 炎……………(51)
10. 休克型肺炎 ……………(27)	21. 重症肝炎………(53)
11. 金黄色葡萄 球菌肺炎………(29)	22. 乙型肝炎………(57)

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 23. 上消化道出血.....(60) | 37. 慢性肾功能衰竭.....(105) |
| 24. 老年便秘.....(65) | 38. 急性前列腺炎.....(110) |
| 25. 克隆氏病.....(70) | 39. 输尿管、膀胱结石.....(113) |
| 26. 急性腹膜炎.....(71) | 40. 三叉神经痛.....(118) |
| 27. 急性出血性坏死性肠炎.....(73) | 41. 老年性痴呆.....(122) |
| 28. 中毒性菌痢.....(77) | 42. 癫痫持续状态.....(124) |
| 29. 急性左心衰竭.....(86) | 43. 竞技综合征.....(126) |
| 30. 克山病.....(89) | 44. 散发性脑炎.....(127) |
| 31. 阵发性室上性心动过速.....(92) | 45. 进行性脊髓性肌萎缩症.....(130) |
| 32. 心源性休克.....(93) | 46. 肌萎缩性侧索硬化症.....(132) |
| 33. 感染性休克.....(95) | 47. 低血糖症.....(134) |
| 34. 压力性尿失禁.....(97) | 48. 传染性单核细胞增多症.....(136) |
| 35. 直立性蛋白尿.....(98) | 49. 阵发性睡眠性血红蛋白 |
| 36. 急性肾功能衰竭.....(99) | |

- 尿.....(139)
50. 弥漫性血管
内凝血.....(141)
51. 特发性水肿
.....(144)
52. 皮炎和多
发性肌炎.....(146)

妇 产 科

56. 外阴溃疡.....(160)
57. 前庭大腺炎... (161)
58. 老年性阴道
炎.....(162)
59. 子宫内膜异
位症.....(165)
60. 精神药物性
乳溢症.....(166)
61. 妊娠小便不
通.....(166)
62. 宫外孕.....(167)

儿 科

71. 小儿智能低
下.....(179)
72. 小儿大叶性

53. 系统性红斑
狼疮.....(150)
54. 干燥综合征
.....(154)
55. 强直性脊柱
炎.....(156)

63. 先兆流产.....(170)
64. 稽留流产.....(173)
65. 难免流产.....(174)
66. 完全流产.....(174)
67. 不完全流产
.....(175)
68. 感染性流产
.....(175)
69. 羊水过多症
.....(176)
70. 产后出血.....(177)

- 肺炎.....(183)
73. 小儿皮质盲...(186)
74. 白喉.....(188)

外科·皮肤科

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 75. 败血症…………(193) | 80. 淋巴结核……(205) |
| 76. 血栓性静脉炎…………(197) | 81. 手足口病……(207) |
| 77. 血栓闭塞性脉管炎…………(199) | 82. 蜂窝组织炎…………(208) |
| 78. 输精管结扎术后痛性结节…………(202) | 83. 天疱疮…………(210) |
| 79. 急性淋巴结炎…………(204) | 84. 沥青皮炎……(212) |
| | 85. 类丹毒…………(213) |
| | 86. 老年性瘙痒症…………(214) |

五官科

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 87. 视神经萎缩…………(218) | 93. 霰粒肿…………(238) |
| 88. 单疱病毒性角膜炎…………(220) | 94. 泪道阻塞……(240) |
| 89. 中心性浆液性视网膜脉络膜炎…………(225) | 95. 睑缘炎…………(241) |
| 90. 视网膜静脉周围炎…………(229) | 96. 泪囊炎…………(243) |
| 91. 视网膜静脉阻塞…………(232) | 97. 智齿冠周炎…………(245) |
| 92. 老年性白内障…………(235) | 98. 急性多发性眶脓肿……(247) |
| | 99. 疱疹性口炎…………(248) |
| | 100. 药物过敏性口炎…………(249) |

内 科

1. 流行性脑脊髓膜炎

流行性脑脊髓膜炎(简称“流脑”)是冬、春季常见的呼吸道传染病。致病菌为脑膜炎双球菌。从呼吸道侵入,经鼻咽部进入血液循环,造成败血症,最后局限于脑膜及脊髓膜,形成化脓性炎症。此病发病急,病情变化快,应引起高度重视。

临床表现

(1) 上呼吸道感染期。有发热、头痛、咽痛、四肢关节酸痛等症状。这一阶段的症状与一般上呼吸道感染相似,但头痛、咽痛等症状比较剧烈。这一阶段如能得到及时和正确的治疗,不致发展成脑膜炎而痊愈,如患者的抵抗力降低,脑膜炎双球菌很快就可侵入血液循环而进入菌血症期。

(2) 菌血症期。突然高热、寒战、呕吐、关节及全身酸痛,怕光,伴有痉挛。大部分患者皮肤上有淤点或淤斑,有时淤斑呈环状坏死。

(3) 脑膜炎期。出现高热、剧烈头痛、剧烈喷射性呕吐、烦躁、谵语、昏迷,甚至颈项强直、角弓反张、瞳孔对光反应迟钝等症状。婴儿则出现囟门凸起、烦躁、嗜睡、突然尖叫、两眼凝呆、惊厥等症状。

流行性脑脊髓膜炎可通过脑脊液检查而确诊。

流行性脑脊髓膜炎属于祖国医学的“温病”、“春温”、“风温”范畴。《灵枢·百病始生篇》说：“风雨寒热，不得虚，邪不能独伤人。卒然逢疾风暴雨而不病者，盖无虚，故邪不能独伤人。此必因虚邪之风，与其身形，两虚相得，乃客其形。”可见，风热之邪能否侵袭人体，或侵袭人体后是否发病，取决于机体抗御病邪的能力，即取决于正气的强弱。流行性脑脊髓膜炎系感受温热疫毒所致。由于温热疫毒之邪极易化火，传变迅速，所以病程中卫气营血各个阶段之间，往往无截然划分的明显界限，而较多见的是卫气营血相互兼病，如卫气同病，气营两燔等。部分患者邪毒炽盛，正不胜邪，可突然出现“邪陷心包”，清窍闭塞的深度昏迷，或直中厥阴，化火动风，风火相煽而出现剧烈头痛、惊厥、狂躁、抽风不止等症。同时，也有正气急剧衰竭，阴阳之气不相顺接而出现脉微肢冷、面色青灰、冷汗、血压下降等阳气衰竭的厥脱证。

辨证分型治疗

(1) 卫气同病（相当于上呼吸道感染期）。起病急骤，发热恶寒，头痛，呕吐，颈有抵抗，四肢关节酸痛，舌质红，苔薄黄，脉浮数。治宜清热解毒、疏表。

方药：银花30克，连翘30克，竹叶12克，荆芥12克，牛蒡子15克，淡豆豉10克，芦根30克，生石膏30克，知母12克，甘草10克，大青叶30克。水煎频服，必要时每日二剂，昼夜兼服（此为成人剂量，小孩酌减）。卫气同病型症状发展快，若出现气营两燔症状，应及时按气营两燔施治，不可耽误。医护人员应严密观察病情变化。

(2) 气营两燔（相当于菌血症期）。壮热，剧烈头

痛，嗜睡或烦躁，喷射性呕吐，皮肤可见出血点，怕光，颈强，舌红绛，苔黄，脉滑数。治宜清气凉营。

方药：生石膏30克，知母12克，生地30克，玄参30克，丹皮15克，紫草30克，黄芩15克，连翘30克，竹叶12克，黄连10克，茅根30克，银花30克，板蓝根30克。水煎服。

（3）热盛动风（相当于脑膜炎期）。持续高热，剧烈头痛，呕吐频繁（喷射状呕吐），躁扰不安，抽搐，角弓反张，神志昏迷，舌绛苔黄，脉弦数。治宜泻火解毒，凉肝熄风。

方药：山羊角30克，钩藤30克，生地30克，地龙15克，生石膏30克，僵蚕12克，龙胆草12克，菖蒲12克，板蓝根30克。水煎服。并另吞服紫雪丹3克。

（4）毒闭气脱（相当于休克）。突然高热或体温不升，四肢冰凉，面色青灰，冷汗，皮肤现花纹，斑疹成片，色紫暗，肢端青紫，呼吸弱，血压低，脉微细欲绝。治宜回阳救逆。

方药：红参15克，附片12克，生龙骨30克，生牡蛎30克，麦冬20克，五味子15克，急煎口服（若邪盛，神烦，加安宫牛黄丸或紫雪丹或至宝丹）。

单方验方治疗

（1）清热解毒注射液（河南中医学院验方）。生石膏15克，知母12克，玄参24克，麦冬12克，龙胆草15克，黄芩15克，连翘15克，栀子15克，板蓝根15克，紫花地丁18克，银花30克，生地18克，制成灭菌水溶液，每毫升相当于原药材3克。

用法：1—6岁，每次2—4毫升；7—12岁，每次4—6毫升；12岁以上每次6—8毫升。每6小时一次，肌肉注射，首次量加倍，用药3—5天。

(2) 双解素注射液(湖北中医学院验方)。 银花45克,连翘15克,生石膏30克,知母15克,黄连30克,贯众30克,板蓝根30克,龙胆草15克,钩藤30克,生甘草9克。制成灭菌水溶液。每毫升相当于原药材3克。

用法: 9—30克/千克体重/日,病情重者可选用大剂量。首次要用一日总量的 $\frac{1}{5}$ 行静脉注射,余量用10%葡萄糖液稀释后静滴。全日量的 $\frac{2}{3}$ 应在12小时内用完。病情好转后,减少 $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{3}$ 量作静脉或肌肉注射。病情继续好转,可改为口服,共用药3—7天。

由于流行性脑脊髓膜炎发病急骤,病情传变迅速,稍有变化,即要当机立断,提前使用下一阶段的治疗处方。

流行性脑脊髓膜炎的预防

(1) 早期诊断,早期治疗,及时隔离,并做好传染病的疫情报告。

(2) 流行期间,儿童少去公共场所,服中草药预防。也可用银花加水浓煎冷却后滴鼻、嗽口或喷咽喉。

(3) 开窗通风,衣服被褥常晒太阳,搞好环境卫生。

(4) 儿童作预防注射。

(5) 搞好个人卫生,坚持体育锻炼,增强身体抵抗力。

附:预防流行性脑脊髓膜炎的中药处方:

(1) 银花藤、板蓝根、大青叶各1500克,加水50公斤,煎成25公斤,供100人一日服用,连服三天(当茶饮)。

(2) 贯众、野菊花各1500克,加水50公斤,熬大锅汤(熬成25公斤),供100人一日服用,每日服二次,连服三天。

(3) 野菊花_{15克}，煎浓汁含漱，每日一次。

2. 伤 寒

伤寒是一种古老的全身性传染病，由伤寒杆菌感染所致。临床病征是：出现持续性发热，玫瑰疹（有的形容为“蔷薇疹”），相对脉缓，脾脏肿大，白细胞降低，特殊中毒症状。主要的并发症是肠出血、肠穿孔。最显著的病理变化是肠道内淋巴组织增生与坏死。

伤寒杆菌属沙门氏菌属，革兰氏染色阴性。当菌体分解时，产生强烈的内毒素。此种内毒素就是致病的主要祸根。

本病在世界各地均有发现，但在温带地区最多见。解放前，我国经常流行这种病，其发病率及病死率都相当高，占传染病中的第一、二位。解放后爱国卫生运动和预防接种普遍开展，工作卓有成效，发病率已大幅度下降。在临床上多见婴儿、老年、体弱及肥胖者，预后较差。

伤寒全年都有发生，但以夏秋季为多。男女的患病机会相等，青壮年及小儿比较多见。

诊断本病的主要依据是临床特征及实验室检查。要确立病原菌，必须做血、骨髓、尿、大便的培养，其中血和骨髓培养的阳性率最高。在找不到病菌时，伤寒血清凝集试验，即肥达反应，具有辅助诊断价值。

伤寒是西医的病名，而不是中医《内经》上的伤寒。中医书上说的伤寒，是多种热病的总称。本篇讨论的伤寒，隶属于中医湿温病范畴。吴鞠通说：“湿温者，长夏初秋湿中生热，即暑病之偏于湿也”。薛生白说：“太阴内伤，湿饮

停聚，客邪将至，内外相引，故病湿热”。由此说明，本病是由于感受外来的湿热疫邪，而在体内是素蕴湿热，里外相合所致。它的发病特点是：起病缓慢，热型稽留，病势缠绵，病程较长，变化多端。如果按卫气营血四个阶段划分，绝大多数患者的发病均在气分期，很少传入营血，热盛伤络的大便下血也很少见。

西医用氯霉素治疗本病，效果甚佳。一般在5天内退热，病情减轻，病程缩短，并发症减少，病死率降低。但是，氯霉素不是万应灵丹，首先是复发率较高，其次是有些人用氯霉素后效果不好，有些年幼体弱者不宜服用，有些人用后副作用较大。这样一来，改服中药就非常必要了。

中医治疗伤寒，效果亦很好。按辨证论治的方法分为下列几种类型。

（1）湿重于热：证见发热胸闷，渴不多饮，无汗，纳少便溏，腹胀恶呕，疲倦乏力，苔白腻，脉濡。

治宜芳香化浊，透热达表。

方药：藿香12克，厚朴12克，法夏12克，茯苓15克，淡豆豉10克，泽泻15克，杏仁12克，苡仁30克，白蔻仁8克，枳壳10克。水煎服。

（2）热重于湿：证见壮热口渴，心中懊恼，头昏头痛，大便秘结，小便黄少，舌苔黄腻，脉濡数。

治宜清热化湿，透热转气。

方药：黄连10克，厚朴12克，淡豆豉10克，栀子12克，半夏12克，菖蒲10克，枳壳12克，建曲15克，滑石30克。水煎服。

（3）湿热并重：证见高热稽留，胸闷面垢，腹胀纳少，小便黄少，大便干或稀溏，舌质红，苔黄根厚腻，脉濡数。

治宜清热化湿，解毒保津。

方药：石膏30克，知母15克，银花30克，连翘15克，丹皮12克，苍术10克，粳米15克，甘草5克。水煎服。

（4）湿热伤阴：证见午后潮热，口干唇燥，渴不多饮，尿黄少，大便干，舌绛，少津，苔光，脉细数。

治宜清化余热，养阴生津。

方药：青蒿12克，黄芩12克，白薇10克，鳖甲20克，秦艽12克，地骨皮12克，丹皮12克，北沙参30克，柴胡10克，知母12克。水煎服。

上述各型，皆可加服方：生地榆30克，黄芩15克，红藤30克，败酱草30克，生大黄10克。本方体现了下法和清法合用，有清肠泄热、凉血涤垢、化浊败毒之功。方中生地榆味苦，微寒，无毒，能清肠、止利、止血，可预防肠出血；黄芩苦平，无毒，可清热、利小肠、止利；败酱草苦平，无毒，能治痈肿，化脓为水，止腹痛；红藤苦平，无毒，治诸风，杀虫，通淋，疗肠痈、流注、内陷走黄；大黄直达邪热巢穴，促之而下，荡涤胃肠的热浊。因为湿温多夹食、夹滞，宜在早期予以疏通积滞，温邪就不致内传阳明，可减少肠出血，缩短疗程。方中用大黄突出了治本病宜“急早凉下”、“轻法频下”的特色。

单方验方治疗

方一：杏仁10克，紫蔻仁8克，苡仁30克，厚朴8克，淡竹叶12克，滑石30克，栀子12克。水煎服。在极期，每日两剂，五次分服。热退之后，每日一剂，均以冷服为优。

加减：午后热甚，脘痞便溏，苔白滑腻，选加藿香12克，法夏10克，通草10克；持续发热，烦渴腹胀，苔黄微腻，选加生石膏30克，知母10克，黄连5克；高热、汗出不解，口苦咽

干，脘闷不饥，大便不畅，苔黄腻，选加柴胡15克，黄芩12克，连翘15克；大便隐血，加地榆炭30克，侧柏叶30克，银花炭15克。

方二：小凤尾草60克，鱼腥草30克，绵茵陈12克，藿香梗10克。水煎服。

据现代药理研究，上述诸方中的杏仁、厚朴、滑石、黄芩、黄连、知母、连翘、地榆等，均对伤寒杆菌有较强的抑制和杀灭作用，石膏、栀子、竹叶、柴胡等有较好的解热作用。

伤寒的预防

(1) 对病人要早期诊断，及时隔离。一旦确诊，应立即报告疫情。大小便要等量10%漂白粉混合消毒，放置两小时后再倒入化粪池。饮食用具和衣物，应该煮沸消毒。

(2) 对带菌者尤其要密切观察，除了积极治疗之外，还应定期复查。

(3) 搞好饮食卫生，管好水源，不吃生冷和不洁的食物。

(4) 积极开展伤寒菌苗的预防接种工作。

3. 登革热

登革热是由登革热病毒引起的一种急性传染病，起病急，传播快，预后良好。登革热病毒是借伊蚊为媒介传染的。本病的特征是：骤然高烧，头痛，关节痛，肌肉痛，斑疹，脉浮数或滑数。实验室检查：白细胞减少，淋巴细胞增多，血小板减少。本病因肌肉关节疼痛极为剧烈，所以又俗称为“断骨热”。

登革热在东南亚地区有流行病史。近几年来，我国南方的部分县、市有流行，发病季节多在9—11月，无论男女老幼，普遍易感。历史上曾有几大次的流行，每次患病人数达百余万。

登革热宜与流行性感、钩端螺旋体病、疟疾、伤寒、麻疹、猩红热鉴别，鉴别的主要根据是病毒分离和血清学试验。

登革热属中医的外感热病，但又和一般的感冒不同。根据临床症状和发病季节，很似温病中的“温疫”、“湿热疫”、“暑燥疫”、“暑温”、“湿温”。个别散发于秋季的，又称“伏暑晚发”。《素问·刺法论》说：“五疫之至，皆相染易，无问大小，病状相似”。有的医家还说：

“一人受之谓之温，一方受之谓之疫”。登革热之所以属“温疫”的范畴，道理就在于此。

西医治疗本病，尚无特效疗法，主要采用综合措施。而中医治疗本病，侧重于清热解毒，和营凉血。在治疗过程中，对高热不可过早使用石膏清热，也不能用辛温发汗的方法，只能用疏利透达的方药，使邪从外透。另外，皮肤出疹是一种好的预兆，往往是疹出而热退，转危为安。

根据登革热的发病过程，可分为初期、极期和恢复期。

初期

（1）湿重于热：证见恶寒重，发热轻，无汗，头痛身痛，胸脘闷胀，恶心欲吐。苔白腻，脉濡缓。

治宜疏利达表，宣透膜原。

方药：厚朴12克，槟榔12克，草果8克，藿香15克，法半夏12克，黄芩12克，甘草5克，柴胡12克。水煎服。

（2）热重于湿：证见发热重，恶寒轻，少汗，头痛身

痛。口微渴，尿黄少，苔黄腻，脉濡数。

治宜清热祛湿，佐以宣达。

方药：银花20克，连翘15克，板蓝根30克，竹叶12克，杏仁12克，葛根20克，藿香12克，青蒿12克，滑石30克，甘草5克，黄芩12克。高热、汗多选加石膏50克，知母12克。水煎服。

极期

(1) 胃热亢盛：证见高热不退，或寒战，汗多，口渴，头痛如裂，目眶疼痛，全身肌肉、骨节烦疼，小便黄，眼红面赤，皮肤有斑疹，大便干结，舌尖红，苔黄腻或黄干，脉滑数。

治宜清热败毒。

方药：石膏60克，银花20克，连翘20克，知母12克，板蓝根30克，黄芩15克，甘草3克，竹叶12克，葛根15克。紫雪丹3克（化服）。斑疹多，可选加犀角粉3克，丹皮15克，赤芍12克，紫草15克，生地30克。苔白厚腻者加藿香12克，佩兰12克。水煎服。

(2) 气血两燔：证见高热，头痛剧烈，全身肌肉、骨节烦痛，腰痛如折，口干咽痛，双眼红赤，视物不清，面红尿黄，大便黑色，吐血，鼻血，皮肤有斑疹，烦躁谵语，呕吐频繁，舌质深红，苔黄干，脉数。

治宜气营两清，解毒救阴。

方药：石膏50克，水牛角50克，知母12克，丹皮15克，赤芍12克，连翘15克，黄柏12克，竹叶12克，黄芩12克，黄连10克，银花20克，生地20克，玄参15克，栀子10克，板蓝根30克，甘草3克。有高热、抽搐者，加服安宫牛黄丸1粒（化服）。大便秘结，加大黄8克（后下）。水煎服。

恢复期

(1) 气阴亏损：证见热退神倦，口干不饮，纳食少，尿少便秘，斑疹渐隐，舌质干红，苔黄，脉细。

治宜益气养阴。

方药：沙参30克，麦冬20克，玉竹12克，花粉15克，扁豆20克，石斛10克，玄参15克，谷芽20克，甘草5克，五味子6克。水煎服。

(2) 脾胃虚弱：证见面色苍白，神倦乏力，不思饮食，食后脘胀，大便溏薄，口淡恶心，头昏，舌质淡，苔薄白，脉细缓。

治宜健脾益气，开胃进食。

方药：太子参30克，扁豆15克，淮山15克，苡仁30克，茯苓15克，白术12克，鸡内金10克，藿香12克，法夏10克，砂仁8克，甘草5克。水煎服。

预防登革热的主要措施是灭蚊、防蚊。搞好清洁卫生，消除积水，疏通沟渠是灭蚊的有效措施。

本病属自限性疾病，多数患者能迅速恢复。病死率在0.1%以下。老年、体弱者以及严重出血者的预后较差。极个别有休克发生，应积极抢救。这类患者证见高烧突然退，身发凉，大汗淋漓，神志不清，面色灰白。脉散大无力。应当回阳救逆，益气敛津。药用：红参10克，枣皮20克，五味子10克，麦冬30克，附片12克（先煎20分钟），阿胶15克（烊化），煅龙骨20克，煅牡蛎20克，黄精30克。水煎服。为了取得速效，可配合用针灸。取穴：人中、中冲、涌泉、合谷。必要时当及时补充血容量，或加用血管活性药物。

除了上述分期、分型用药外，现录用两个验方，以供参考。

方一：青蒿12克，石菖蒲10克，板蓝根30克，藿香12克，白

薏仁10克，射干12克，木通12克，法夏12克，薄荷12克，黄芩12克，甘草5克，滑石30克。水煎服，每日一剂。

方二：板蓝根30克，葛根30克，茅根50克，大青叶30克，银花20克，连翘15克，芦根30克，甘草5克，竹叶12克，蝉腿8克。

加减：高热烦渴加石膏50克，知母15克，黄连10克，栀子12克，黄芩15克；腹泻加藿香12克，苡仁30克，黄连10克；皮肤出疹加生地50克，丹皮15克，紫草15克。此方用于初期和极期。

4. 慢性布鲁氏菌病

布鲁氏菌病是由布鲁氏杆菌引起。分急性和慢性两种。主要是人接触病兽及其分泌物，或食用染菌的食物而患病。按实验室检查可将布鲁氏菌病分为猪型、牛型和羊型。在牧区，以羊型多见；在大城市，以牛型多见。

布鲁氏菌病见于世界各地。发病年龄以青壮年为主，男多于女，主要患者多为畜牧业者、兽医、屠宰工人。发病季节以春末、夏、秋为多。发病地区是农村高于城市，尤以畜牧区为最。传染源多为羊、牛和猪。传染途径是消化道和完整的皮肤。

通过皮肤，或喝了没有消毒的病畜的生乳、乳酪、酸乳等，病菌可经口进入体内，在淋巴结内繁殖，以后侵入血液，流经全身，停留在淋巴结、脾、肝及骨髓内进一步繁殖，产生各种转移性病灶。布鲁氏菌病的主要病理变化见于网状内皮系统，其它如心血管系统、呼吸系统、神经系统、运动系统、泌尿系统都可受害而产生病变。

慢性布鲁氏菌病常反复发作，缠绵难愈。患者的临床表现多为倦怠无力，畏寒喜暖，低热，心烦不安，失眠多梦，周身不适，焦虑，忧郁，四肢发凉，但体征很少，仅见苔润，舌淡胖嫩，脉沉细无力。中医辨证多为虚损。究其原因，是由脾胃虚弱，正气不足，再外感湿热病邪，致使清阳不升，浊阴不降。日久不愈，上扰心肺，营卫失调；下犯肝肾，伤及精血；湿热郁久化火化燥，劫烁阴液，耗竭气血，酿成虚损。

治疗慢性布鲁氏菌病当以补为主，以通为辅，在调理中施以平补。用药原则是善于阴中求阳，阳中求阴，阴阳均衡。用通经活络的方法来治疗，近期效果好，但疗效不很巩固；用扶正固本法，远期疗效甚为理想。应用补法时，不可峻补，亦不可蛮补。临床中证实，治疗前17羟皮质类固醇值很低而用补正扶阳的方法治疗后都逐渐恢复正常。据推测，这类药物作用于下丘脑以下，调节垂体及肾上腺皮质功能而获得效果的。本病用西药效果不太理想。抗生素药物不易达到病灶，故难根治，很容易复发。

方一：党参30克，黄芪40克，肉桂10克，桂枝10克，鹿角霜30克，鸡血藤30克，狗脊20克，杭巴戟20克，续断20克，枸杞20克，五味子8克，当归15克，骨碎补15克，菟丝子20克，怀牛膝15克，陈皮12克。水煎服。

方二：云木香12克，党参30克，白术15克，砂仁8克，茯苓15克，陈皮12克，法夏12克，炙甘草10克，鸡血藤30克，黄芪30克，干姜12克。水煎服。适用于脾虚气弱的患者。

方三：苁蓉15克，菟丝子20克，黄芪30克，地龙12克，陈皮12克，枸杞20克，黄精30克，当归15克，穿山龙50克，锁阳12克，沙蒺藜15克。水煎服。

加減：怕冷甚者加制附子10克（先煎），桂枝10克，淫羊藿20克；口干、手足心熱、低熱者加白薇12克，女貞子12克，旱蓮草20克；面色晄白、頭昏者加首烏15克，白芍15克；口干苦、面紅赤、頭昏重者加鉤藤12克，天麻10克。

方四：桂枝12克，白芍15克，黃芪30克，炙甘草10克，大棗15克，生薑10克，杜仲15克，桑椹子30克，蓮米20克，防風10克。水煎服。

方五：菟絲子20克，黨參30克，黃精20克，懷牛膝20克，狗脊20克，桂枝10克，細辛8克，五味子8克，防風12克，陳皮12克，白朮15克，淮山15克。水煎服。

加減：腹瀉者加蒼朮15克；浮腫者加冬瓜皮30克；肢麻不仁者加雞血藤30克，丹參20克；氣下落，乏力者加升麻3克，黃芪30克；顏面少華、頭昏者加當歸12克，桑椹子30克。

應重視本病的預防。病畜要及時按規定處理；病畜的肉食品不應在市場上出售；處理病畜屍體，為病畜接生都應戴膠皮手套，注意防護；不吃生乳；對經常接觸牲畜的工作人員每年進行預防接種。

5. 華支睾吸虫病

華支睾吸虫病主要因進食未煮熟的淡水魚而被感染。感染後，華支睾吸蟲的成蟲寄生於人體肝内胆管系統，輕者無症狀表現，重者出現上腹隱痛、肝腫大、乏力等症狀。可并发胆管炎、胆石症、肝硬化等。感染嚴重的兒童常有顯著營養不良和生長發育障礙。

華支睾吸虫病有以下几种臨床類型：

(1) 肝炎型：本型最为常见，有乏力、消瘦等全身症状以及食欲不振等消化道症状。肝脏肿大但无压痛。部分病人血清转氨酶轻度升高，如不注意询问流行病史，易将本病误诊为病毒性肝炎。

(2) 胆管炎型：本型病人有发冷、寒战、发热、上腹呈阵发性绞痛、有时有黄疸、周围血白细胞总数升高，常伴有胆管炎或胆囊结石。

(3) 胃肠炎型：本型病人有腹泻、腹胀、大便日行3—4次、无脓血。镜检常无异常发现。

(4) 肝硬化型：本型病人有肝肿大、质硬、腹水、脾肿大、贫血、血浆蛋白降低和下肢浮肿。

(5) 侏儒型：本型多发生于严重感染的儿童病例，出现发育障碍，身高体重和年龄不相称。

(6) 隐匿型：本型属轻度感染的病人，一般无症状。

华支睾吸虫病可通过粪便检查或十二指肠引流胆汁中找到虫卵而确诊。

华支睾吸虫病属于祖国医学的“虫积”、“积聚”范畴。多因饮食不节，嗜食生腥，虫随口入，损伤脾胃，郁滞肝胆所致。脾损则运化失职，湿浊内生；肝郁则气机不畅，血行淤滞，遂有胸痛、黄疸、积聚、腹胀、纳呆等症。

辨证分型论治

(1) 肝郁脾虚：胁痛，腹胀，纳呆，疲乏，腹泻，舌淡苔白，脉弦细。治宜疏肝健脾驱虫。

方药：柴胡15克，白芍15克，茯苓15克，白术12克，郁金12克，佛手12克，槟榔30克，榧子肉30克，茵陈30克，乌梅30克。水煎服。

(2) 肝胆湿热：发冷，寒战，发热，腹痛，黄疸，舌

红苔黄，脉弦数。治宜清利肝胆湿热。

方药：茵陈30克，金钱草30克，郁金30克，虎杖30克，生军6克，槟榔30克，榧子肉30克，苦楝皮10克。水煎服

单方验方治疗

乌梅30克，榧子肉30克，槟榔30克，茵陈30克。水煎服。

6. 丝 虫 病

丝虫病是斑氏丝虫、马来丝虫、帝汶丝虫、盘尾丝虫、罗阿丝虫、链尾丝虫、奥氏丝虫、常现丝虫等8种丝虫寄生在人体淋巴系统等部位引起的一种慢性传染病。

临床类型：由于丝虫的成虫寄生部位不一，临床上就出现多种多样的症状和体征。

（1）生物潜伏期：此时多半患者无明显症状，偶可出现荨麻疹、轻度腹股沟淋巴结肿痛或精索肿痛，并伴有发热等全身症状。血内嗜酸粒细胞增多。此期的时间一般为2.5—6个月。

（2）微丝蚴血症期：患者出现淋巴系统炎症和发热，但症状轻微。过后血中嗜酸粒细胞数减少。

（3）急性炎症期：开始时症状不重，发作次数也不多，但是随着病情发展，临床症状加剧，不定时地反复发作。可出现四肢淋巴系统炎症，以腹股沟、腋窝等处多见。

（4）慢性阻塞期：淋巴结肿大，淋巴管曲张，睾丸鞘膜积液，乳糜尿，象皮肿。

除上述四期的一些症状外，还可见脾脏、乳房、臂、胸、背、颈等部位有丝虫性肉芽肿。

盘尾丝虫病可有皮下结节，皮肤过敏，眼神经损害，淋巴结病变等。罗阿丝虫病常引起“游走性肿块”的暂时性炎症，肿块大小似“鸡蛋”。除手、臂、面部有肿大外，还有皮肤痒，关节痛，肝区痛等。链尾丝虫病及奥氏丝虫病一般无特殊症状，链尾丝虫病有痒疹，奥氏丝虫病早期嗜酸粒细胞增多，关节痛较严重。

丝虫病患者血液中可找到微丝蚴。采血时间为午夜前后2小时。患者的乳糜尿或鞘膜积液或淋巴结抽液经离心沉淀后，取沉淀液检查，亦可发现微丝蚴。有助于确诊。

中医认为丝虫病系感受湿热疫毒所致。湿热疫毒从肌表而入，走窜孙络，郁结不解，故发为“流火”（淋巴管炎），壅阻经脉，则发为“痰核”（淋巴结炎），病久疫毒内传，损及肝肾，招致气化不利而病“膏淋”（乳糜尿），或脾肾俱伤，水湿不化，气血壅滞而发为“大脚风”（象皮肿）。

我国在公元前6—7世纪的中医古籍上已有“两足胫红肿，寒热如伤寒状。从此或一月一发，半月数月一发”，“小便白如米汁”，“膏淋”，“肿大如斗”等记载。对下肢象皮肿及淋巴管炎、淋巴结炎，在《诸病源候论》、《外台秘要》中均有不同程度的描述。《串雅》说“脚气一症，即俗称大脚风……，水乡农人多患之，一肿不消，与寻常脚气发过即消者迥别，……病初起，必胯间结核而痛，憎寒壮热，渐而下行至足，即肿胀木硬，终身不便，诚可悯也”。

炎症性丝虫病的治疗

（1）淋巴管炎、淋巴结炎。恶寒发热，全身无力，肌肉关节酸痛，淋巴管或淋巴结发炎，苔黄腻，脉浮数。治宜清热解毒，化湿通络。

方药：银花30克，紫花地丁30克，野菊花30克，丹皮12克，赤

芍药20克，黄柏12克，川牛膝30克，泽兰12克，知母12克。水煎服。

(2) 精索、睾丸炎。阴囊内疼痛，睾丸或副睾肿大，可以摸到精索结节性肿块，有压痛，伴有发热，苔薄白，脉细数。治宜行气破滞，散结利湿。

方药：橘核30克，荔枝核15克，昆布30克，海藻30克，桃仁12克，厚朴12克，木通10克，枳实10克，延胡索12克，马鞭草30克。水煎服。

乳糜尿的治疗

(1) 湿热下注。小便乳白粘稠或混有血丝，尿时阴中涩痛，小腹不适，腰酸疲乏，苔黄腻，脉弦数。治宜清热利湿。

方药：萆薢30克，黄柏12克，石菖蒲12克，茯苓30克，莲子心10克，车前草30克，茅根30克，丹参30克。水煎服。

(2) 脾虚气陷。少腹坠胀，面色萎黄，食少倦怠，气短懒言，尿浊如豆浆，舌淡苔白，脉细弱。治宜益气升陷，健脾摄精。

方药：党参30克，黄芪30克，白术15克，茯苓30克，当归15克，升麻10克，柴胡12克，芡实30克。水煎服。

(3) 肾虚不固。五心烦热，头晕耳鸣，腰腿酸软，小便乳白色夹有血丝，舌淡苔薄，脉细弱。治宜补肾固摄。

方药：金樱子30克，菟丝子30克，女贞子30克，党参30克，莲须10克，芡实30克，山药30克，益智仁12克，桑螵蛸10克。水煎服。

象皮肿的治疗

方一：红花12克，炮甲珠15克，当归30克，威灵仙10克，海桐皮10克，防己10克，防风10克，茯苓皮30克，川牛膝30克。水煎服。

方二：桑白皮30克，苍术30克，五加皮30克，木瓜30克，苡仁30克，紫草30克，槟榔12克，木通10克。水煎服。

方三：25%桑叶注射液，每次4毫升，肌注，每日一次，15—20次为一疗程。同时用绷带绑扎患肢。停止注射后，仍需坚持长期绑扎患处，每疗程可间隔15—30天。

7. 血吸虫病

血吸虫病是血吸虫寄生在人体静脉中所引起的一种疾病，对人民健康危害很大。寄生人体的血吸虫已知的有日本血吸虫、埃及血吸虫、曼氏血吸虫、间插血吸虫和湄公血吸虫5种。

临床类型

(1) 急性血吸虫病。发生在夏秋季，大多见于初次重度感染的患者，常有尾蚴皮炎史。潜伏期平均为一个月左右。临床表现以发热与变态反应为主。发热高低与持续时间取决于感染程度。热型以间歇热、弛张热为多，重度患者可持续发热，热程一般一个月左右，有的可达数月之久。变态反应有荨麻疹、血管神经性水肿、全身淋巴结肿大。白细胞总数可达1—3万或更高，嗜酸性粒细胞显著增多（但重型患者不增多）。肝脏可有肿大与压痛，腹痛腹泻，半数患者可出现肺部症状。

(2) 慢性血吸虫病。流行区农民自幼与河水接触，反复感染。轻者可无症状，仅感乏力，腹痛，间歇性腹泻，偶有痢疾样便，日2—3次。肝脾肿大。

(3) 晚期血吸虫病。因反复重度感染产生门脉性肝硬

化所致。食管下端静脉曲张为常见，静脉曲张（腹壁静脉曲张）破裂后每引起上消化道大量出血。脾充血或脾肿大。

（4）异位损害。虫卵沉积于门脉系统以外的脏器，引起一些症状和体征，如咳嗽、肺部可闻干湿罗音，X线可见肺纹增多、有片状阴影及粟粒样改变等。虫卵沉积在脑血管则可引发癫痫等。

粪便检查可找到血吸虫卵及毛蚴。肠粘膜压片检查可找到虫卵。粪便检查有助于确诊。

血吸虫病属于祖国医学的“水毒病”、“蛊胀”、“症瘕”、“积聚”等范畴。乃感受“水毒”、“溪毒”所致。蛊毒从外而入，先犯皮肤体表，有发热恶寒，皮肤痒疹。继而蛊毒内侵，蕴结脾胃，生湿化热成疾。若湿热交蒸，邪正相搏，则现寒热往来；热势缠绵不解，蛊毒湿热下迫肠道，则见腹痛下痢；湿热与蛊毒留聚肝脾，阻滞气血，则见胁痛痞块。日久发热虽退，但脾肾大伤，津液蒸运失常，水湿停聚，气血淤阻，故后期多有腹大如鼓，青筋暴露等蛊胀症状。

辨证分型治疗

（1）急性期

① 邪郁肺卫：发热恶寒、咳嗽、或身现风疹。舌淡苔白脉浮。治宜疏表宣肺。

方药：荆芥10克，防风10克，桔梗10克，前胡10克，羌活10克，杏仁12克，百部10克。水煎服。

② 邪伏少阳：寒热往来，朝轻暮重，入夜汗出热退。继而复热，胸闷胁痛，恶心欲吐。苔黄而腻，脉滑数。治宜和解少阳，清热利湿。

方药：柴胡15克，半夏12克，黄芩30克，青蒿12克，山栀12克，

陈皮12克，茯苓15克，竹茹12克，藿梗12克，茵陈30克。水煎服。

(2) 慢性期

① 肝脾不和：体倦乏力，纳差，腹胀，胁痛，腹泻每日2—3次。苔白腻，脉弦滑。治宜疏肝健脾。

方药：白术15克，茯苓15克，木香10克，香附12克，柴胡15克，赤芍30克，枳壳10克，槟榔30克，苦参30克。水煎服。

② 气滞血淤：消瘦，乏力，胁痛，腹胀，肋下有痞块，面色暗黄，纳差。舌暗红有淤点，脉涩。治宜活血化瘀。

方药：红花12克，桃仁12克，丹参30克，当归30克，鳖甲15克，炮甲珠15克，延胡索12克，三棱10克，莪术10克，熟地30克。水煎服。

(3) 晚期

气郁湿阻：腹大胀满，叩之如鼓，青筋暴露，两胁胀痛，恶心，纳差。治宜行气利水。

方药：苍术30克，茯苓30克，猪苓30克，泽泻30克，槟榔15克，车前草30克，黄芪60克，白术15克。水煎服。

单方验方治疗

(1) 南瓜子粉，每次80克，每天3次，连服3—4周。

(2) 茺莢10克，雷丸10克，槟榔30克，大黄12克，共研细末为丸，每次服10克，早晚各1次。

8. 支气管哮喘

支气管哮喘是一种很常见的阵发性过敏性疾病。在发作

间歇期或治疗缓解后，症状可完全消失，一如常人。

支气管哮喘典型发作前，常有先兆症状，如咳嗽、胸闷或连续打喷嚏等，此时如不及时治疗，可迅速出现喘息。支气管哮喘急性发作时有气急、哮喘、咳嗽及多痰、呼气困难。患者常被迫采取坐位，两手前撑，两肩耸起，额部冒冷汗，痛苦异常。严重时唇指发绀。每次发作，历时数小时甚至数日才逐渐缓解。

支气管哮喘可分为三种类型

(1) 感染性哮喘（内因性哮喘）。诱发原因多为反复的上呼吸道或肺部感染（此型农村多见）。

(2) 吸入性哮喘（外因性哮喘或花粉型哮喘）。这一类型的支气管哮喘与吸入外界过敏性物质有密切关系。如吸入各种风媒花粉、灰尘、尘螨、动物皮毛、人类和动物皮屑、真菌孢子以及多种有机粉尘，都能迅速引起哮喘发作，或几小时后才引起哮喘发作。这类病人往往有过敏性家族史。

(3) 混合型哮喘。兼有上述两型的特点。此类患者的病史多半较长，起病常属吸入型，由于以后反复发作，逐步成为终年哮喘而无缓解季节。哮喘病的发病季节以秋、冬两季为主。

支气管哮喘常由下列因素诱发：①外界过敏原，包括对食物如牛奶、鱼虾等的过敏；②呼吸道感染；③精神因素；④过度劳累。

支气管哮喘病人的体征为：胸廓膨胀，隆起呈桶状胸，胸锁乳突肌紧张，腹壁强直，肺部叩诊呈高清音。听诊呼吸音减弱，呼气延长，伴有干性罗音及哮喘音，当伴有支气管炎或继发感染时，可听到湿性罗音。

辅助检查：血白细胞计数一般正常，嗜酸性粒细胞可增至5—15%以上，免疫测验IgE大多高于正常。

支气管哮喘属于祖国医学的“哮”证范畴。多系肺内伏痰留饮外邪触发所致。肺中伏痰留饮之由，或因肺虚，肃降失常，津液不布，聚而成痰；或因脾虚，健运失职，湿停成痰；或因肾虚，气不化水，水饮上泛而为留饮。本病之发，每因六淫外邪，饮食失宜，情志不舒，操劳过度，触动肺中伏痰留饮，故痰随气升，气因痰阻，互相搏击，阻塞气道，肺气肃降不行，以致呼多吸少，喘咳倚息不得卧，喉间哮鸣。正如《证治汇补》所说：“哮为痰喘而常发者，因而内有壅塞之气，外有非时之感，膈有胶固之痰，三者相合，闭拒气道，搏击有声，发为哮病”。

辨证分型治疗

（1）发作期

① 寒哮证：天冷易发，咳痰清稀色白，形寒怕冷，口不渴，舌质淡或紫暗，舌苔白膩，脉弦紧。治宜解表散寒，温肺化饮。

方药：桂枝10克，炙麻绒6克，五味子10克，细辛6克，干姜10克，法半夏10克，甘草10克，苏子10克，白芥子10克，莱菔子10克，党参30克。水煎服。

② 热哮证：哮喘突发，发热，不恶寒，烦躁不安，口干欲饮，面赤自汗，胸膈满闷，大便秘结，小便黄。脉滑数，舌质红，苔黄。治宜宣降肺气，定喘化痰。

方药：生石膏30克，杏仁12克，炙麻绒10克，甘草10克，桂枝10克，白芍30克，细辛6克，浙贝10克，鱼腥草30克，黄芩30克。水煎服。并兑服鲜竹沥30毫升。

（2）缓解期

① 肺肾阴亏：气短喘急，呼多吸少，痰呈泡沫，手足心热，失眠多梦，口燥咽干，小便黄，大便干。舌淡红，脉细数。治宜滋阴补肾，纳气平喘。

方药：太子参30克，麦冬30克，五味子15克，淮牛膝30克，熟地15克，山药30克，山萸12克，茯苓15克。水煎服。

② 脾肾阳虚：气短息促，呼多吸少，痰清而稀，身倦畏寒，手足不温，胸闷便溏，腰酸腿软，小便清长，颜面少华。舌淡苔白，脉沉细。治宜温阳补肾，化痰逐饮。

方药：熟地30克，制附片20—30克（先熬），山药30克，山萸15克，茯苓15克，肉桂6克，补骨脂12克，淫羊藿30克。水煎服。

其他疗法

（1）针灸疗法

① 发泡灸：在伏天进行治疗，取穴足三里、大椎、灸至皮肤起泡。发泡灸能激发和调动人体自身的抗病能力，提高细胞的免疫功能。

② 体针：主穴取定喘、膻中、肺俞、大椎、合谷。配穴取足三里、肾俞、丰隆、天突。

③ 耳针：取平喘、肾上腺、交感等。

（2）平喘验方

① 地龙片。每次口服5片，每日3次。

② 蛭螭250克，捣成泥，加川贝粉或浙贝粉50克，做成绿豆大的丸子，每次口服10丸，每日服3次，并配合服牛黄解毒片。

③ 止咳喘热参片。每次1—2片，每日3次口服。

④ 牡荆丸。每次2粒，每日2—3次。

⑤ 艾叶油胶丸。每次2粒，每日3次。

⑥ 将红参粉10克，蛤蚧粉10克，胡桃肉50克（捣如泥）混匀。每次服5克，每日服3次，开水送服。

9. 哮喘持续状态

哮喘持续状态是指支气管哮喘严重发作持续时间24小时以上，甚至数日不止时称为“哮喘持续状态”。本病系变态反应，支气管的平滑肌痉挛，粘膜充血、水肿，分泌物增加，阻塞呼吸道而引起。哮喘持续状态是内科急症，若治疗不及时或治疗不当，易导致呼吸衰竭而死亡。

本病是过敏原作用于机体而发生的变态反应。过敏原可分外源性及内源性两类。外源性有草木的花粉、动物的毛、皮、乳类、蛋类，鲜虾等。内源性有鼻炎、扁桃体炎，慢性胆道感染等均可引起发病。有过敏体质的患者在吸入过敏原后，引起机体的过敏反应（或称变态反应）。如有下列因素存在，常引起哮喘持续状态，应仔细询问和检查，做到针对引起哮喘持续状态的主要病因，进行积极正确处理。①发作后多汗，张口呼吸和饮水过少，加以茶硷类药物的利尿作用引起失水，以致痰液更加粘稠，难以咳出，加剧症状。②呼吸道感染的病菌及其代谢产物未得到控制。③某些吸入性过敏原或刺激性气体持续存在。④精神过度紧张。体力不支或用药不当等综合因素。⑤缺氧。⑥并发肺不张、肺气肿、气胸等。上述因素可以引起哮喘持续状态的发作，而哮喘持续状态发生后又可加重上述因素，易形成恶性循环。因此，应注意找出重要病因，进行治疗。

哮喘持续状态属于祖国医学的“喘证”范畴。《丹溪手

镜》说：“喘，肺主也。谓气逆而上行，息数，气急，张口，抬肩，摇身，滚肚”。《杂病源流犀烛》说：“喘因虽多，而其原未有不由虚者，元气衰微，阴阳不接续，最易汗脱而亡，一时难救。古人言诸般喘证，皆属恶候是也。……故凡喘皆不可忽视也。”古人认识到哮喘持续状态应针对病因进行治疗。兹将本病的中药及针灸疗法介绍如下。

中药治疗

(1) 红参粉10克，蛤蚧粉10克，开水吞服。此为一日量，分三次服用。

(2) 麻黄10克，法半夏10克，桑白皮30克，五味子15克，细辛6克，山海螺12克，夜交藤30克，胡颓子6克，甘草10克。加水浓煎，待药液温度达37℃左右，作高位保留灌肠。一般于灌肠半小时左右，哮喘即开始缓解，也有病情严重者，须每晚灌肠一次，于灌肠一天半后哮喘开始缓解，五天左右临床症状可完全控制。

针灸治疗

(1) 体针：主穴为肺俞（双）、大椎、风门（双）。

配穴：咳嗽配尺泽、太渊；痰多配足三里、丰隆、中脘；肾虚配肾俞、关元、太溪。

操作：肺俞、风门直刺5—8分，大椎直刺1—1.3寸。留针20分钟左右，行针2—3次，施以提插捻转平补平泻手法。虚寒者配以艾灸，虚热或合并肺热较甚者，可针后拔火罐于大椎、肺俞之间。

(2) 穴位注射治疗：取喘息穴（第7颈椎旁开1寸）、气喘穴（第7颈椎旁开2寸）、合谷穴，各注射654-210毫克，一般在穴位注射后30分钟左右，哮喘大减，2小时左右哮喘停止发作。之后每日在两侧的喘息穴及气喘穴各注

射 654-2 10 毫克，连续注射 3 日。

654-2 等莨菪类药物系胆碱阻断药，穴位注射可直接或间接（反射性）地阻断或解除乙酰胆碱及其有害活性物质对平滑肌的作用，改变 cAMP/cGMP 比值失调状态，从而达到平喘作用。此外，654-2 尚能松弛支气管平滑肌，解除其痉挛，增强肺及支气管微循环血流速度，减轻支气管粘膜充血水肿，改善纤毛功能，利于排痰，并有镇静大脑皮层，兴奋循环中枢等功能。

喘息穴与气喘穴是治疗哮喘的主要奇穴，其有透表宽胸，理肺平喘之效，合谷穴亦有疏表理肺之功。穴位注射 654-2 抗胆碱药能起针灸与药物的共同作用。

10. 休克型肺炎

休克型肺炎是以微循环障碍为突出表现的一种重症肺炎（又称中毒性肺炎）。本病在各种年龄都可发生，但以年老体弱者居多。一年四季均能发病，但冬春两季为多。起病前常有受寒、上呼吸道感染、劳累或饮酒史。原有心肺疾患者易于发病。

引起休克型肺炎的病原菌大多数为肺炎双球菌，少数由肺炎杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、流感杆菌、大肠杆菌所致。病毒感染也可引起本病。

休克型肺炎的临床表现

（1）起病急骤。休克多半出现在开始发病的头 3 天内。年老体弱者可在发病前无咳嗽、发热等肺炎症状，而突然发生血压下降（血压常低于 80/50 毫米汞柱）甚至不能测

出。

(2) 发热。大多数病例起病前可毫无畏寒、发热症状，即使发热，体温达 40°C 者极少，多数在 38°C 以下，随病程的进展，体温可骤降而持久不升，或仅有低热。

(3) 神经精神症状。主要表现为表情淡漠，反应迟钝，烦躁不安，嗜睡，谵妄，严重时可进入昏迷。

(4) 消化道症状。食欲减退，恶心，呕吐，腹痛，腹泻等。

(5) 肺部体征。往往不突出，早期除少数患者有肺部变化外，大多数病例仅有呼吸音减低和少许湿罗音。

(6) 化验检查。白细胞计数多数升高，一般在 2—3 万/立方毫米，中性粒细胞明显增高，可达 90% 以上，并可有中毒颗粒。

凡肺炎患者血压下降 80/50 毫米汞柱以下，伴有面色苍白、四肢厥冷、口唇及指甲发绀、心音减弱、心律加速、脉搏细数（120 次/分以上），出现高热（或体温不升），表情淡漠、烦躁不安、谵妄、神志昏迷等症状，结合病史、年龄、季节等不难作出诊断。且早期诊断极为重要。因此，如出现下列情况时，必须想到有发生休克型肺炎的可能性。

①年老体弱、原有心肺疾病的患者，如有发热、咳嗽、血压偏低者。②在冬春季节，对于原因不明的血压偏低或有休克症状的患者应想到有休克型肺炎的可能。

休克型肺炎属于祖国医学的“厥脱”范畴。在祖国医学的文献中，不乏关于休克型肺炎类似症状的描述。《景岳全书》说：“犯之者……精神不宁，或口噤妄言，痰涎壅塞，或头旋运，倒不省人事”。并指出：“犯之者，突然手足厥冷，肌肤寒慄……”。《万病回春》指出：“如得之身冷脉

沉，四肢厥逆，足踈卧，唇口青”。其病因病机，不外热毒内陷，精气内夺，阴阳之气不相顺接，渐致离决。或由邪气内侵，正气受损，阴阳失调，脏腑功能虚衰，元气不固，或真阳虚脱所致。其治疗，多采用回阳救逆、益气养阴、清热解毒的综合治疗。

休克型肺炎的中医药综合治疗

- (1) 红参粉10克，冲服。
 - (2) 红参粉10克，麦冬30克，五味子15克急煎口服。
 - (3) 清开灵注射液 40—60 毫升静脉滴注。
 - (4) 人工牛黄粉 1 克，日服 3 次。大黄粉 3 克，日服 4 次。安宫牛黄丸或紫雪丹每次 1 粒，日服 3 次。
 - (5) 银花30克，野菊花20克，紫花地丁30克，蒲公英30克，紫背天葵12克，黄芩15克，黄连10克，黄柏10克，栀子10克。水煎服。
 - (6) 银花30克，连翘30克，蒲公英30克，鱼腥草30克，生石膏30克，知母10克，甘草10克，加水煎成 250 毫升，加入紫雪丹 2 粒，作直肠点滴。
 - (7) 针刺人中、十宣、内关。
- 以上治法可交叉选用或联合用药。

11. 金黄色葡萄球菌肺炎

金黄色葡萄球菌肺炎是金黄色葡萄球菌引起的一种肺部疾病。发病急，病情重，变化大，并发症多，加之广泛选用抗菌素使耐药的金黄色葡萄球菌菌株增多，故金黄色葡萄球菌肺炎已成为目前临床上多见的肺部疾病。

金黄色葡萄球菌肺炎多有高热、或弛张热或稽留热等，热型不定。其他常见症状有畏寒、咳嗽、谵妄、昏迷，部分患者呈极度衰弱、发绀、呼吸困难等。老年人尤易发生。婴幼儿患本病表现为高热、烦躁、发绀、谵妄或昏迷。常并发脓气胸和脓胸，病情严重。

本病肺部体征出现较早，早期呼吸音减低，发展成脓气胸或脓胸时叩诊浊音，呼吸音减弱，语音震颤增强。血白细胞计数可达15 000—30 000/立方毫米以上，嗜中性粒细胞占75—90%，但有时白细胞计数也可减低到5 000以下，而嗜中性粒细胞百分比仍较高。白细胞计数低者预后不良。如有条件，作咽部分泌物的细菌培养，可获阳性结果，对确诊有帮助。

本病胸部X线检查时具有多变、易变特点。临床症状与X线所见并不一致。在肺炎初期，临床症状很重，而X线征象却很少，仅表现为肺纹理增多，一侧或双侧出现小片浸润阴影，但病变进展迅速，甚至在数小时内，小片炎变就可发展成脓肿。

金黄色葡萄球菌肺炎属于祖国医学“风温”、“温病”范畴。中医认为“温邪上受，首先犯肺”，“邪气与正气相搏，不得宣通，……昼夜常嗽……”，“诸气皆属于肺，肺气和平，则升降自若，……邪所伤，则肺气壅塞，……”。在发病过程中，邪正交争激烈，正胜邪却，则热退身安；正不胜邪，热盛邪陷则可致厥脱。其病机为：风热之邪入肺，郁而化热，热灼津液而成痰，痰盛气滞，肺失宣降，逆而为咳，甚则唇口紫暗。热毒炽盛，内传入血，亦可神志昏迷。热毒伤阴耗液，可现烦躁、谵妄。其治疗多按温病、风温论治。

方一：黄芩30克，黄连10克，黄柏10克，银花30克，栀子10克，大青叶30克，紫花地丁30克，甘草10克。水煎服。恢复期改服清热养阴方剂。

方二：鱼腥草30克，鸭跖草30克，半枝莲30克，虎杖30克，白毛夏枯草30克，野菊花30克。水煎服，每日两剂。

加减：咯痰不畅者加桔梗、枳实、前胡。气急者加麻黄、苏子。胸痛者加旋覆花、乳香、没药。X线肺炎阴影持久不消者加丹参、桃仁。老年患者如气阴两伤，舌苔光剥迟迟不能复原，可用大剂益气养阴之剂。红参10克，石斛30克，生地30克，黄精30克，天冬15克，麦冬30克，茅根30克，芦根30克。水煎频服。

12. 成人急性肺炎

成人急性肺炎属于急性感染性疾病。肺炎的种类很多，按病变的解剖部位可分为大叶性肺炎，小叶性肺炎（支气管肺炎）和间质性肺炎；按感染方式可分为原发吸入性肺炎，继发吸入性肺炎和血行播散性肺炎；按病程又可分为急性肺炎和慢性肺炎；按病因可分为病毒性肺炎，立克次体性肺炎，衣原体性肺炎，支原体性肺炎，细菌性肺炎，霉菌性肺炎等。现谈谈成人急性肺炎的中医治疗。

成人急性肺炎有以下表现：病人有突发的寒战、高热、咳嗽、胸痛和血痰等典型症状。实验室检查时白细胞总数升高，中性粒细胞大多在80%以上，或有核左移或有中毒性颗粒。X线检查有片状炎性阴影。

成人急性肺炎属于祖国医学的“肺热”范畴。《素问·

刺热篇》云：“肺热病者，先淅然厥，起毫毛，恶风寒，舌上黄，身热。热争则喘咳，痛走胸膈背，不得太息，头痛不堪，汗出而寒”。这与现代医学描述肺炎典型症状极为相似。清代医学家谢玉琼在《麻科活人全书》中论述麻疹合并症时，正式使用“肺炎”一词作为中医病证。

关于肺炎的发病原因和转变规律，中医认为：①正气不足，温邪袭肺。病邪之所以能聚集于肺，其人的气机必有虚可乘，温热之邪便乘虚袭肺，因而出现肺卫的一系列典型症状，即所谓“温邪上受，首先犯肺”。②痰热壅肺，卫气同病。肺炎传变特点是卫分见证时间甚短，迅即出现高热，烦渴，咳喘，胸痛，痰中带血或咯铁锈色痰，脉洪数等气分症状。而恶寒，头痛等卫分症状仍然存在。③温邪挟毒，化火伤阴。如患者治疗不及时或者治疗失误，则邪热极易灼伤阴津。④邪热内陷，逆传心包。若患者邪盛热重。或病人体质素虚，正不胜邪，邪热内陷，可出现逆传心包的变证（出现神经系统症状）。⑤邪盛正衰，阳气欲脱。热邪伤阴，阴损及阳，阳气欲脱（休克）。⑥正虚邪恋，气阴两虚。此为肺炎复期的常见证候。

辨证分型治疗

（1）痰热壅肺：高热，不恶寒，反恶热，汗出而热不退，咳喘痰黄，胸部隐痛，痰中带血，舌质红，苔黄。脉滑数。治宜清肺化痰。

方药：苇茎30克，冬瓜子30克，苡仁30克，桃仁12克，赤芍30克，丹皮15克，生地30克，瓜蒌仁12克，法半夏12克，羚羊角1.5克（先煎），水煎服。

（2）痰湿壅肺：发热不扬，午后热甚，或有恶寒。痰涎壅盛，胸闷不渴，舌红苔白腻。脉滑数。治宜除痰祛湿，

清热宣肺。

方药：菖蒲_{12克}，厚朴_{12克}，枇杷叶_{30克}，黄芩_{30克}，杏仁_{12克}，黄连_{10克}，法半夏_{12克}，苇茎_{30克}，竹茹_{12克}，滑石_{30克}。水煎服。

（3）肝火犯肺：发热，面红目赤，口苦口臭、唇燥，烦躁易怒，咳嗽阵作，胸胁窜痛，甚则咳血，小便短赤涩痛，舌红绛，苔黄。脉弦数。治宜平肝泻火。

方药：龙胆草_{10克}，栀子_{12克}，木通_{10克}，泽泻_{15克}，生地_{30克}，黄芩_{30克}，白花蛇舌草_{30克}，瓜蒌仁_{12克}，法半夏_{12克}，生大黄_{10克}。水煎服。

（4）邪犯心包：高热、痰鸣气喘，胸痛且胀，神昏谵语，口唇发绀，舌红绛，苔黄厚，脉数。治宜解毒化痰，清心开窍。

方药：水牛角_{30克}，菖蒲_{12克}，生地_{30克}，黄芩_{30克}，连翘_{15克}，银花_{30克}，玄参_{30克}，紫草_{15克}，黄连_{10克}。水煎服。送服安宫牛黄丸一粒或紫雪丹3克。

（5）肝风内动：高热神昏，四肢抽搐，烦躁狂言，咳嗽痰鸣，气促胸痛，呼吸浅促，甚者则两目凝视，唇面青紫，舌红绛，苔黄燥，脉弦数。治宜平肝熄风，清心开窍。

方药：山羊角_{30克}，钩藤_{30克}（后下），生地_{30克}，麦冬_{30克}，连翘_{30克}，银花_{30克}，僵蚕_{12克}，白芍_{15克}，水煎服。送服紫雪丹3克。

（6）厥逆阳脱：突然高热下降，面色苍白，大汗淋漓，四肢厥冷，神昏不省人事，呼吸浅促，喉间痰鸣，唇面青紫，舌质暗淡，脉微欲绝。治宜益气固脱，回阳救逆。

方药：红参_{12克}（另炖），附片_{15克}（先熬）生龙骨_{30克}，生牡蛎_{30克}，麦冬_{15克}，五味子_{15克}，黄精_{30克}，甘草_{10克}。急

煎与服。

验方治疗

(1) 蚤休30克, 大青叶30克, 黄芩30克, 败酱草30克, 薤草30克, 小蓟12克, 鱼腥草30克。水煎服。每日一剂, 重症则日服二剂。

(2) 鱼腥草30克, 虎杖30克, 桃仁12克, 杏仁12克, 葶苈子12克, 苏子10克, 黄芪30克, 大黄12克。水煎服。保持每日大便2—3次。

(3) 大黄15克, 芒硝10克, 甘草10克, 黄芩30克。水煎服。并配合用蒲公英30克, 败酱草30克, 半枝莲30克, 虎杖30克。水煎服, 每日1—2剂, 直至病灶吸收为止。

验方2 验方3均用了大黄, 是用突击泻热通腑法, 有助于病原体的消除, 加速炎症的修复。中医认为“肺与大肠相表里”, 通腑泻热有助于肺部炎症的消除。这一方法治疗急性肺炎具有优越性, 现已为大家接受。

13. 肺 水 肿

肺水肿是血浆透过肺泡膜进入肺泡及支气管的一种常见性临床综合病症。有许多疾病最后都因并发肺水肿而死亡。

肺水肿可由下列疾病引起

(1) 心脏血管疾病: ①高血压; ②冠状动脉粥样硬化性心脏病、严重二尖瓣狭窄所引起的左心衰竭; ③心肌炎; ④充血性心力衰竭。

(2) 呼吸系统疾病: ①肺部感染, 如肺炎、肺梗塞等; ②溺水、绞缢、窒息、呼吸道梗阻(如喉头水肿、支气

管喘息)；③有害气体吸入、呼吸道粘膜烧伤；④其他如抽胸水过于迅速，胸部外伤，肺叶切除。

(3) 脑部疾病：如脑外伤，脑血管意外，脑肿瘤，各种原因引起的脑膜炎、脑炎。

(4) 过敏性疾病：神经血管性水肿、血清病、青链霉素过敏性休克。

(5) 输血、输液不当，麻醉意外等均可引起肺水肿。

急性肺水肿的发生往往比较突然，主要临床表现为严重的呼吸困难，胸前有压迫感，疼痛，不能平卧，发绀，面色苍白，汗流满面，冷汗蔽体，两眼向前，呈痛苦或恐怖的表情，阵发性咳嗽伴有吐白色或粉红色泡沫样痰，严重者其痰量1—2小时内可达2000—3000毫升的泡沫。这样多的泡沫痰，来不及咳出，竟由鼻腔和口腔涌出。肺部听诊变化巨大，也是最具有诊断意义和富有特征性，即随着呼气时能听到从细支气管内柔和的细湿罗音，以至于气管内泡沫痰产生的气过水声（大水泡音）。心脏听诊时有心动过速（每分钟可达140—150次）或出现心律不齐。实验室检查：红细胞和血红蛋白增加，随着肺水肿的发展，血红蛋白量成比例地上升。X线表现为浓密的软性阴影，从肺门向肺内中带散开，肺外周部分清晰，形成蝴蝶状阴影。熟悉了上述情况，肺水肿的诊断一般不难。

肺水肿属于祖国医学的“支饮”范畴。支饮是饮停胸膈，最易影响肺部。如肺气被水饮阻塞而喘息不得卧，其病机亦属饮邪结实。治宜攻逐水饮，泻肺通腑。

方一：葶苈子15克，大枣30克。水煎服。

加减：胸痛者加郁金、玄胡各10克；呼吸困难加麻黄、白果各10克；体质衰弱者加黄芪60克，白芍10克，桂枝12克，甘

草10克，生姜10克。

方二：鱼腥草50克，半枝莲30克，虎杖30克，生大黄30克，芒硝10克（冲服），麻黄10克，生石膏30克，杏仁12克，浙贝12克，赤芍30克，丹皮15克。水煎服。（《中医急症通讯》总第19期）。

中医认为，肺与大肠相表里，通大肠即可泻肺。本方以清热泻肺与通腑泻热双管齐下，腑气一通则肺热自泻，肺气一开则下结自解，二便自调。

14. 成人呼吸窘迫综合征

成人呼吸窘迫综合征（简称 ARDS）是由于感染、休克、创伤等多种原因引起的一种严重的呼吸衰竭。其临床特点为：既往无心肺疾病的成人，突然发生进行性呼吸困难，发绀，出现严重的顽固的低氧血症，用一般给氧疗法不能缓解。若治疗不当，往往于2—3天内死于严重呼吸衰竭。类似新生儿的特发性呼吸窘迫症。因发生于成人，故命名为成人呼吸窘迫综合征。本病过去又称为充血性肺不张、休克肺、呼吸机肺、氧肺、成人透明膜病等等。

下列疾病均可引起成人呼吸窘迫综合征：

（1）休克：各种类型的休克均可引起本病，其中以感染性休克为最常见。

（2）严重创伤：如胸部创伤、肺挫伤等。

（3）烧伤：多发生于大面积烧伤或合并休克、败血症以及呼吸道烧伤。

（4）感染：如败血症、病毒性肺炎、腹膜炎、急性胰

腺炎等。

(5) 颅脑外伤：脑外伤、脑出血、脑膜炎、脑肿瘤等。

(6) 吸入毒物：如高浓度氧、腐蚀性化学品。

(7) 重症妇产科疾患：如子痫、肺羊水栓塞症等。

(8) 其他：如有机磷杀虫剂中毒、过敏反应、输血或输液过量等。

成人呼吸窘迫综合征发病急，突然发生呼吸迫促与呼吸困难，进行性加重，严重紫绀，而且这种紫绀给氧后仍不能缓解，临床表现可分为以下四期：

第一期（过度换气期）：有原发病（如外伤、感染等）的症状。若治疗及时，可不发生呼吸窘迫症。

第二期（呼吸困难期）：多数在原发病 24—48 小时后出现，此期的早期病情可能有一度好转，呼吸平稳，但很快呼吸困难又出现，并逐渐加重。临床表现主要为胸闷、气促、呼吸浅速，每分钟在 30 次以上，心率也明显增快，紫绀也逐渐加重，肺部出现细小湿罗音或干性罗音。

第三期（肺功能不全期）：病情发展迅速，呼吸困难加重，极度窘迫，明显紫绀，吸入高浓度氧后发绀也难以纠正，肺部罗音增多。X 线检查提示肺水肿。

第四期（心肺功能衰竭期）：心动过缓，心率无力，往往是临终前数小时的表现。呼吸困难，严重发绀，呼吸浅而无力，神志模糊或躁动不安，血压下降甚至测不出，全身皮肤及粘膜有出血倾向。

成人呼吸窘迫综合征属于祖国医学的“喘”、“痉”、“厥”、“闭”、“脱”等范畴。《证治准绳》云：“喘者促促气急，喝喝息数，张口抬肩，摇身撷肚”。《直指方》

说：“诸有病笃，正气欲绝之时，邪气盛行都壅逆而为喘。”喘是邪盛正虚的表现。并指出喘症的病机主要与肺、肾有关。肺气壅滞，肺肾亏虚，血虚，血淤，均可引起喘症。

病因治疗

(1) 由外伤引起者：红参15克，苏木12克。加水急煎服。

(2) 由失血引起者：红参15克，苏木12克，水煎服。若有淤血而致气道阻塞、呼吸困难者，加大黄10克，当归30克，赤芍30克，桃仁10克，丹皮10克。

(3) 由高热引起者：红参15克，生石膏30克，知母12克，甘草10克，粳米10克，大黄10克，芒硝10克（冲服），厚朴10克，枳实10克，水煎服。

(4) 由皮肤严重感染引起者：银花30克，野菊花20克，紫花地丁30克，蒲公英30克，紫背天葵10克，黄芩30克，水煎服。

(5) 由产后恶露不行引起者：桃仁10克，红花10克，苍术12克，玄胡12克，生蒲黄12克，当归30克，泽兰12克，山楂15克，枳壳12克，水煎服。

辨证论治

(1) 痰火壅肺型：高热，神昏，痰声如锯，抬肩，鼻煽，掀胸，烦躁不安，时有抽搐。舌红苔黄脉数。治宜泻壅救肺。

方药：葶苈子15克，苏子12克，银花30克，红参15克，生石膏30克，知母12克，甘草10克，大青叶30克，瓜蒌30克，郁金15克，川贝10克，芦根30克，水煎服。

(2) 腑结肺痹型：呼吸短促，胸满抬肩，昏迷，唇

紫，谵语，抽搐，大便秘结三五日不下。治宜通下救肺。

方药：大黄10克，芒硝10克（冲服），厚朴10克，枳实10克，葶苈子15克，杏仁12克，知母12克，生石膏30克，红参15克，甘草10克，银花30克，水煎服。

气阴两竭型：喘息气短，呼吸浅表不匀，气难接续，鼻煽头摇，胸高腹凹，汗出如洗，抽搐，唇紫。治宜益气救阴，治喘防脱。

方药：红参15克，麦冬30克，五味子20克，生龙骨30克，生牡蛎30克，山萸肉15克，磁石30克。水煎服。

专方专药治疗

（1）苏合丸1—3粒，鼻饲。

（2）六神丸，每次服10粒，每1小时1次。最大量日服60粒。

（3）麝香、牛黄、冰片，按1:2:2比例，研成细末，混匀，每次服1—3克，开水冲服，每天1—2次。

针灸疗法

（1）针刺会阴穴，强刺激，留针1—2小时，每10—20分钟捻转一次。

（2）针刺人中、素髎穴，强刺激。

（3）耳针：取穴心、肺、交感、肾上腺、皮质下、脑干。

（4）穴位注射：

① 洛贝林3毫克，注射足三里或三阴交穴。

② 回苏灵8毫克，注射足三里或三阴交穴。

③ 醒脑静1—2毫升，注射膻中、曲池、中府、肺俞、足三里等穴，每20—30分钟更替穴位。

④ 氨茶碱0.5—1毫升，注射列缺、中府、合谷等

穴。可重复使用。

⑤ 75% 复方当归注射液 0.5—1 毫升，注射膈俞穴。

(5) 外治法：

① 细辛、皂角、半夏，等分，研细末和匀，吹入鼻腔取嚏。

② 猪牙皂、细辛、薄荷各 5 份，麝香少许，研细末和匀，吹入鼻腔取嚏。

③ 取青霉素小瓶一个，上面铅盖不动，下面去底（去掉玻璃瓶底）。药物为辣椒粉 21 克，枸杞子 15 克，五味子 15 克，以 75% 酒精浸泡 15 天过滤后备用。将去底小瓶按压在中府、乳根、合谷等穴位上，用注射器于穴位内注入药液 2—3 毫升，并从铅盖内抽气，使瓶内形成负压（拔罐的作用），每次按拔 15 分钟。

附：根据现代医学理论，认为急性呼吸窘迫综合征存在“湿肺”，可采用宣肺渗湿汤（杏仁 12 克，桂枝 15 克，葶苈子 12 克，赤芍 30 克，桑白皮 30 克，丹参 30 克，当归 20 克，郁金 20 克，黄芪 60 克，血竭 3 克），随证化裁。其目的在于排尽“湿肺”多余的水，改善肺水肿，促进病情的好转。

15. 慢性呼吸衰竭

呼吸衰竭有急性和慢性之分。急性呼吸衰竭指肺功能原来正常，由于突发原因如溺水、电击、外伤、药物中毒、呼吸道接受物理化学刺激等使肺功能突然衰竭的临床表现。慢性呼吸衰竭是指患者有慢性呼吸系统疾病，如慢性支气管炎、肺气肿、尘肺等，肺功能损害逐渐加重，导致缺氧和二氧

化碳潴留引起的一系列生理功能和代谢紊乱的临床综合征。慢性呼吸衰竭又有代偿性慢性呼吸衰竭和失代偿性慢性呼吸衰竭之分。

代偿性慢性呼吸衰竭是指患者有慢性呼吸系统疾病，肺功能损害逐渐加重，虽有缺氧和二氧化碳潴留，但通过代偿适应，仍能担负较轻的工作或从事日常生活活动，这种情况即称为代偿性慢性呼吸衰竭。若一旦并发呼吸道感染或由于其他原因，使呼吸生理负担加重，代偿丧失，即可出现严重缺氧和二氧化碳潴留症状，则称为失代偿性慢性呼吸衰竭。

慢性呼吸衰竭的临床表现：

（1）呼吸困难。轻者仅感呼吸费力，重者呼吸劳累窘迫，大汗淋漓，甚至窒息。呼吸可浅速或深缓，呈潮式呼吸，间歇或抽泣样呼吸等。

（2）紫绀。紫绀是缺氧的典型症状，但缺氧不一定都有紫绀。有无紫绀主要观察口唇。

（3）精神神经症状。急性严重缺氧可立即出现精神错乱、烦躁、昏迷、抽搐。慢性缺氧仅有智力障碍及定向功能障碍。

（4）血液循环系统的症状。心率增快，血压上升，心律不齐，心室颤动甚至心跳骤停。严重或长期缺氧则心肌收缩力减弱，心搏量减少，血压下降，最后引起循环衰竭。

（5）消化系统和泌尿系统的症状。转氨酶升高，消化道出血，尿中有蛋白及红细胞或管型。

慢性呼吸衰竭可通过血液气体分析检查氧和二氧化碳分压、pH值、剩余硷等确诊。

慢性呼吸衰竭属于祖国医学的“虚喘”、“闭证”、“脱证”等范畴。《太平圣惠方》说：“夫肺者，通行脏腑

之气，以荣华于经络也。若肺虚不足，为邪所乘，则气道不利，诸脏之气，上冲胸中，壅滞不通，故令上气喘急也”。肺主气，司呼吸；肾主纳气。肺肾气竭，则喘促气急，紫绀显露。

辨证分型论治

(1) 心火亢盛，肺络闭阻。唇鼻青紫，呼吸气微或渐断不续，神昏，烦躁谵语。舌红绛苔少，脉细微促，治宜清心泻火，宣通肺络。

方药：生地30克，木通10克，竹叶12克，黄连10克，丝瓜络15克，桑白皮30克，杏仁12克，滑石30克，茅根30克，西洋参15克，水煎服。配合针刺外关，三阴交、涌泉，会阴等穴。

(2) 肝风内动，气道阻塞。肌肉瞤动，手足抽搐，甚至癫痫样发作，气粗痰黄，继之呼吸微弱或渐断不续。苔黄腻，脉细数。治宜平肝熄风，清热涤痰。

方药：全蝎6克，蜈蚣8条，僵蚕12克，杏仁12克，黄芩30克，瓜蒌15克，茯苓30克，枳实10克，胆南星10克，法半夏12克。水煎服。配合针刺天突、合谷、丰隆、会阴等穴。

单方验方治疗

(1) 蟾力苏针：一次用2—4毫克，稀释后静注。

(2) 石菖蒲针（5%石菖蒲挥发油溶液）：每次20—40毫升，加5%葡萄糖稀释后静滴。

16. 肺部霉菌感染

近年来由于免疫性疾病的增多，临床上广谱抗菌素、激

素和免疫抑制剂的广泛应用，使人体内部的生态平衡紊乱，菌群失调，免疫力受到抑制，以致肺部霉菌感染逐渐增多。

肺部霉菌感染多为白色念珠菌感染。常表现有低热、乏力、咳嗽、粘液性痰，有时带血丝。如发展成肺炎则出现高热，症状加重。X线胸部透视呈支气管周围炎、支气管肺炎，亦可出现渗出性胸膜炎。一般呈慢性病程。患者多并发鹅口疮。

肺部霉菌感染的临床过程和肺结核或其他慢性肺部疾病颇为相似。X线检查也无特征性改变，极易延误诊断。因此，凡长期应用广谱抗生素、糖皮质激素、免疫抑制剂或抗癌药物的病人，如出现肺部感染，经一般抗菌药物或抗结核药物治疗无效，甚至病情反而恶化者，即应考虑有肺部霉菌感染的可能，应及时送痰或气管分泌物作霉菌培养，明确诊断。

另外，肺部霉菌感染多见于咳喘患者，中医认为，久病气虚，湿邪蕴结，复贪食生冷，致寒邪伤肺，阴盛阳微，秽浊之邪内侵，湿毒肆横，上攻肺咽，易于霉菌滋生。祖国医学还认为，人体的抗病能力悉赖正气，然而正气的强弱与脾肾有很大关系。因肾受之父母、内寓真阴真阳，机体五脏六腑悉赖肾阳的温运才能进行其正常生理功能，故肾为先天之本。脾胃为气血生化之源，脾胃健，气血旺盛，才能满足其他脏腑正常生理机能所需要的物质供应。故脾为后天之本。如果机体内阴阳平衡失调，就会产生疾病。若久病体虚，伤及脾肾二脏，肾阳虚衰，不能温煦他脏，脾阳不振，气血生化无源，则可致机体抗病能力低下，霉菌乘虚繁衍猖獗而致病。霉菌感染尽管发病部位不同，症状各异，但治疗上以健脾温肾为主，解毒利湿为辅。

方一：红参10克，制附片15克（先熬），肉桂8克（后下），干姜10克，茯苓30克，葶苈子12克，陈皮10克，法夏10克，败酱草30克，银花30克，马鞭草30克，紫菀12克，冬花12克，瓜蒌仁30克，大贝母20克。水煎服。本方用于肺部霉菌感染伴心衰尤为合适。

方二：白芍60克，生地30克，千里光30克，龟版30克，丹皮12克，银花藤60克，知母12克，黄芩30克，黄连10克，黄柏15克，茅根30克。水煎服。本方用于肺部霉菌感染，高烧，血象高，尿短赤不畅，下肢水肿患者，尤为适合。

中医治疗肺部霉菌感染，并非所用之中药皆有抑制霉菌的作用，而是中药改变了机体现状，增加了抵抗力。且中药没有副作用。以上两方都体现了中医药治疗肺部霉菌感染的优势。

方三：10%大蒜液20毫升，雾化吸入，每日2次。

17. 肺性脑病

肺性脑病是由慢性肺胸疾患伴有呼吸功能衰竭，出现缺氧、二氧化碳潴留而引起神经精神障碍的综合征。

下列几种情况，常是引起肺性脑病的病因：

（1）气道阻塞性疾病：如支气管喘息、支气管扩张、支气管内异物、肿瘤等。

（2）肺部疾病：如肺炎、肺结核、矽肺、肺不张、肺气肿、肺水肿等。

（3）胸部疾病：如大量胸腔积液、气胸等。

（4）治疗不当：如镇静剂使用不当，引起呼吸中枢的

抑制，供氧不当，降低了颈动脉体对缺氧的敏感性，导致呼吸抑制。

肺性脑病按临床表现可分为三型：

（1）轻型：神志恍惚，淡漠，嗜睡，精神异常或兴奋，多语，无神经系统异常体征。

（2）中型：半昏迷，谵妄，躁动，肌肉轻度抽动，语无伦次，对各种反应迟钝，瞳孔对光反应迟钝而无上消化道出血等。

（3）重型：昏迷，癫痫样抽搐，对各种刺激无反应，反射消失，瞳孔扩大或缩小，可合并上消化道出血，弥漫性血管内凝血或休克。

血液气体分析有助于肺性脑病的诊断。患肺性脑病时氧分压降低（正常值 95—100 毫米汞柱），二氧化碳分压升高（正常值 35—45 毫米汞柱，平均值 40 毫米汞柱）、pH 值降低（正常值 7.35—7.45）。

肺性脑病属于祖国医学的“闭证”、“厥脱”、“抽搐”等范畴。正虚是本，邪实为标，寒热错杂，虚实互见。

辨证分型治疗

（1）痰热蕴肺，蒙蔽心窍型：咳嗽，喘息，不能平卧，神识昏乱，谵语，心中懊恼，解衣去被，痰鸣，咯痰黄稠；重者昏迷，鼾声大作，唇绀，舌紫，指甲青紫。苔黄燥，脉滑数。治宜涤痰开窍，清泄肺热。

方药：黄连10克，栀子12克，胆南星10克，法半夏12克，瓜蒌15克，枳实12克，桑白皮15克，菖蒲10克，远志10克，杏仁12克，竹茹12克，朱茯苓15克，水煎服。并加用安宫牛黄丸或醒脑静，或清开灵。

（2）气阴两虚，热扰心神型：神志模糊，呓语，循衣

摸床，咳嗽痰少，气短息弱，喘促，两颧潮红，唇舌紫绀，舌质瘦小少津，苔薄黄或无苔，脉细数或结代。治宜养阴清热，益心宁神。

方药：红参粉6克（冲服），沙参30克，麦冬30克，五味子15克，莲米心6克，玄参20克，杏仁12克，冬瓜仁30克，黄芩30克，知母12克，川贝母10克，石菖蒲10克，朱茯苓12克，甘草10克，并加用紫雪丹或醒脑静等，并用参麦注射液20—40毫升加入5%葡萄糖液20—40毫升，静脉注射，一日一次。若四肢颤动者加天麻、僵蚕、白芍，重者加服羚羊角粉，每次1克，一日2—3次。

（3）阳虚水泛，心神失守型：神志昏乱，嗜睡，重则不省人事，四肢逆冷，或颤抖，张口呼吸，气短息弱，颜面及下肢肿胀，咳声低微，痰涎清稀，胸满腹胀，舌质胖紫暗，苔滑厚腻，脉沉细，或结代。治宜温阳化浊，纳气安神。

方药：红参粉10克（冲服），党参30克，制附片20克（先熬），白术15克，茯苓20克，猪苓20克，葶苈子12克，补骨脂12克，车前仁15克，泽泻15克，桂枝10克，杏仁12克，干姜10克。并加用苏合香丸，加用人参针或参麦针20—40毫升加入50%葡萄糖40毫升静脉注射，一日1—2次。动则喘剧汗多者加胡桃肉、山茱萸。

验方治疗

近代医学认为呼吸道感染是引起肺性脑病的重要诱因，有效地控制感染是重要的治疗原则之一。下列验方对肺性脑病有较好疗效。

瓜蒌30克，败酱草30克，鱼腥草30克，浙贝15克，黄芩30克，黄连10克，胆南星10克，杏仁12克，陈皮10克，法夏10克，桔

梗10克，前胡10克，茯苓10克，菖蒲10克，远志10克，郁金10克，枳实10克，厚朴10克，水煎服。

方中黄芩、黄连、败酱草、鱼腥草，能清泄肺热达到抗感染的目的。恰当地选用清泄肺热药物具有重要意义，祛除痰浊，保持呼吸畅通，改善肺的通气换气功能，是纠正缺氧和二氧化碳潴留的重要措施。应用陈皮、法夏、胆南星、瓜蒌、浙贝等药物在于化痰，祛除贮留于气管、支气管中的痰浊，使呼吸道通畅。中医认为，“善治痰者，不治痰而治气”。肺性脑病患者多因气郁而痰滞，痰阻则气机更为不畅，宣开肺气则痰浊易去。选用瓜蒌、前胡、桔梗、杏仁宣肺开喘，利于痰浊排除。中医认为，肺与大肠相表里，痰热阻肺，肺失宣降，必然影响肠道传导功能。腑气不畅，大便不通，邪浊之气不能从下排出，反而上扰神明，引起或加重躁动、谵妄、神志不清等神志障碍。应用厚朴、枳实消除痞胀，改善肠道传导功能，排除糟粕和代谢产物，邪浊之气从下而出，可促进神志苏醒。肺性脑病患者往往因循环障碍，影响肺的通换气功能，加重缺氧和二氧化碳潴留。肺为水之上源，通调水道，痰热阻肺，通调失职，小便不利、水饮留着。在清化痰热、宣肺平喘的同时配以茯苓分利水邪，通利小便，改善循环、呼吸功能，对苏醒神志也有裨益。肺性脑病出现神志不清，应用菖蒲、郁金芳香开窍，可促进神志苏醒。应用远志镇静安神，既可发挥镇静止痉作用，又能避免抑制呼吸现象。综上所述，这个验方治疗肺性脑病既能体现中医特色，又可弥补现代医药的不足，不失为良方之一。

18. 结核性干性胸膜炎

结核性干性胸膜炎往往由于肺结核蔓延至胸膜所致。有时可因干性胸膜炎的胸痛，进一步检查而发现肺结核。

结核性干性胸膜炎起病往往很急，症状轻重不一。起病时常有畏寒，一般可有轻度或中度发热。主要症状是针刺样胸痛。胸痛多发生在胸侧腋下部，也可放射至同侧肩部或心窝部。深呼吸及咳嗽时胸痛更甚。浅吸气、平卧或卧于患侧时胸痛可减轻。由于胸痛，患者多不敢深吸气，呼吸呈急促表浅。有时伴有干咳。

听诊可听到胸膜摩擦音，听诊器紧压胸壁时摩擦音增强。

病变局限者X线检查无明显变化。

根据病史、剧烈的针刺样胸痛、胸膜摩擦音等可以确诊。

结核性干性胸膜炎属于祖国医学的“胸痛”范畴。多因正气不足，肺痹侵袭致痰热蕴结，闭阻胸胁，不通则痛。

《诸病源候论》说：“邪气乘于胸胁，故伤其经脉。邪气与正气交击，故令胸胁相引而急痛也”。

辨证论治

(1) 痰热蕴结：恶寒发热，干咳少痰，胸胁刺痛，口苦纳呆，苔薄黄，脉细数。治宜清热化痰，和解少阳。

方药：玄胡12克，柴胡30克，黄芩15克，法夏12克，黄连10克，全瓜蒌30克，百部12克，生牡蛎30克，川楝子12克。水煎服。

(2) 气滞血淤：胸胁刺痛，痛有定处，日久不愈，咳

则痛剧，呼吸急促，胸闷不适。舌淡红，苔薄白，脉沉细。治宜活血通络，理气止痛。

方药：郁金30克，当归30克，玄胡12克，瓜蒌30克，薤白30克，生地20克，青皮10克，桃仁12克，三七粉8克（冲服），香附15克。水煎服。

19. 结核性渗出性胸膜炎

结核性渗出性胸膜炎是干性胸膜炎的进一步发展。结核病人处于变态反应状态时，胸膜易受结核菌的感染，出现渗液。结核性渗出性胸膜炎如果得不到及时的诊断治疗，常可遗留不同程度的胸膜肥厚、粘连，影响肺的呼吸功能，还可残存积液使肺内外结核复发和播散等，严重者危及生命。

结核性渗出性胸膜炎由结核菌引起。一般起病较急，开始往往有畏寒、发热、胸痛和气短。发热和气短的程度与胸液增加快慢有关。病初胸液不多，胸痛明显，深呼吸和咳嗽时胸痛加重。随着胸液的增多，阻碍了壁层和脏层胸膜的相互摩擦。因此，胸痛反见减轻或消失。大量的胸液压迫肺脏和心、血管，使呼吸面积减少，心搏出量减低，此时患者出现气短、发绀、呼吸困难和端坐呼吸。

积液较多时患侧胸廓饱满，下部较为明显，呼吸显著受限，可将气管、心脏向健侧推移。叩诊呈实音，听诊呼吸音减低或消失。

白细胞计数可增高，血沉增速。胸液为草黄色，透明或微混。

胸部X线检查，少量积液时肋膈角变钝，中等量积液时

在下胸部可见阴影增加，在阴影中出现上淡下浓，外高内低的弧形阴影。

胸部X线检查和胸腔积液检查，是诊断结核性渗出性胸膜炎的重要依据。

结核性渗出性胸膜炎属于祖国医学的“悬饮”范畴。

《金匱要略》说：“……饮后水流在胁下，咳唾引痛，谓之悬饮”。主要是由于邪郁肺经，通调失职，或脾肾不足，胸阳不振，以致水饮停聚于胸胁，或蕴而化热而成本病。盖胸胁为气机升降之道，饮停胸胁，脉络受阻，气机不利，故胸胁胀痛，咳唾、转侧、呼吸时均牵引胸胁经脉而致疼痛。水饮上犯于肺，肺气下行受阻，则气短息促而出现呼吸困难。

《证治汇补》提出了本病的治疗，初宜分消（攻逐水饮），次宜调养。

方一：葶苈子15克，冬瓜仁30克，鱼腥草30克，桑白皮12克，桔梗12克，茅根30克，大枣30克，蒲公英20克，黄芩30克，甘草6克，水煎服。

加减：热盛胸痛者加郁金15克，柴胡30克。

方二：椒目10克，生姜10克，桑皮30克，瓜蒌15克，法夏21克，茯苓皮30克，苏子10克，葶苈子12克，水煎服。

加减：热甚者加黄芩，咳甚者加川贝、杏仁、百部、膈肌粘连者加桃仁、红花、枳壳。

方三：芫花、大戟、甘遂各30克，研细末，用大枣90克煮烂去核去皮，打糊和为丸，每次服1.5—3.0克，每日1—2次，4天为1疗程。

方四：葶苈子10克，苏子10克，陈皮12克，桔梗10克，生大黄6克，芒硝10克（冲服），甘草10克，水煎服（服药后有腹泻，不需处理）。

方五：大枣 10 枚煎汤送服甘遂胶囊（每粒 0.2 克），每次 2—4 粒，饭前服用，每日 2—3 次，以排溏便，日泻 2—3 次为宜。并用链霉素、异烟肼、对氨基水杨酸钠配合治疗，不用激素，不抽胸水。隔日作 X 线胸部透视一次，观察胸水消失情况。一般于用药后 10 天胸水吸收。除腹泻外无不良反应。胸水吸收后停药甘遂胶囊，但抗痨治疗则需继续进行。

20. 反流性食管炎

反流性食管炎是指胃内容物如胃酸、胃蛋白酶、胆汁酸盐等反流入食管，使食管发生粘膜充血、糜烂、溃疡改变等的病症。

人体胃内容物的酸度较高。本来应当通过胃的蠕动，胃内容物缓缓进入肠道，肠道是硷性环境，所以不会发生病变。但由于某些原因使部分胃内容物逆流反回食管，使食管发生炎症病变。

医学研究证明，正常人的胃内容物也可向食管反流，但由于食道的蠕动，唾液的咽下等因素，使反流的胃内容物又回到胃内，避免了食管炎的发生。然而，当食管下口的括约肌功能低下时，或者食管的蠕动减弱时，或者胃内滞留较多的胃内容物长时间不能进入肠道时，极易发生反流现象而引起食管炎。这种食管炎即称为“反流性食管炎”。

反流性食管炎的临床表现有：

（1）剑突下烧灼感或疼痛，多在进食后一小时左右发生，半卧位或躯干前屈或剧烈运动也可诱发。服用抑酸性药

物，这种烧灼感或疼痛可消失。而吃过热、过酸食物则症状加重。

(2) 病情较重者，饭后或躯干前屈或卧床睡觉时，有酸性液体、食物从食管反流到咽部或口腔。

(3) 吞咽困难。

(4) 病情较重者可因食管粘膜糜烂而出血。长期出血或大量出血则可导致贫血。

反流性食管炎属于祖国医学的“气机升降失常”、“哕逆”等范畴。清气不升，浊气不降，胃气上逆，引发本病。脾胃共处中焦，为人体气机升降之枢纽。脾胃为后天之本，是人体一切能量的来源。脾气升，方能运化水谷精微以灌溉四旁；胃气降，方能受纳、腐熟水谷，传送糟粕于体外。脾胃气机升降失常或升降反常，该升不升，该降不降，则生哕逆。治宜降逆和胃，疏理气机。

方药：柴胡15克，枳实10克，白芍15克，甘草10克，降香12克，煅瓦楞子30克，水煎服。

反流性食管炎的预防

(1) 适当减肥：医学研究表明，肥胖能增加胃内容物反流的频度和反流量，而减肥后可以减轻症状，也可预防反流性食管炎的发生。

(2) 服装适度：腹压增加如衣着过紧可以助长反流，故穿着衣服不宜过紧，裤带更不宜太紧，最好改穿背带式裤子。

(3) 注意体位：胃内容物向食管反流和体位有很大关系。立位时，反流几乎不发生，而仰卧位则最易发生。为预防此病，睡眠时枕头可适当垫高一些。

(4) 调节饮食：饮食不宜过量，吃得过多有碍消化，

使胃的排空时间延长，食物滞留胃内较久，则易反流。此外，进食大量脂肪、酒类、巧克力糖、柑桔等也易引起反流。在睡觉前更不宜吃这类食物。

(5) 戒烟：抽烟能增加食物反流的机会，故应戒烟。

(6) 从事适当体育锻炼，增强体质。

21. 重症肝炎

重症肝炎是病毒性肝炎中之危重型，由肝炎病毒引起。是严重威胁人民健康和生命的疾病之一。

重症肝炎的临床表现有：1. 重度乏力，厌食，黄疸进行性加深。2. 迅速出现顽固性腹胀及腹水。3. 严重者出现嗜睡、谵妄、昏迷等症状。4. 出血现象，如鼻衄，皮肤粘膜出血，甚至呕血，便血。5. 肝脏肿大或进行性缩小。6. 肝功能检查可见黄疸指数增高，锌浊度在14单位以上，麝香草酚浊度在6单位以上。

重症肝炎属于祖国医学的“急黄”、“瘟黄”范畴。因为重症肝炎发病急骤，病情凶险，病死率高，所以有的学者把这种病列入温病范畴。

祖国医学对重症肝炎早有认识。《诸病源候论》说：“脾胃有热，谷气郁蒸，因为热毒所加，故猝然发黄，心满气喘，命在倾刻，故云急黄也。有得病即身体面目发黄者，有初不知是黄，死后乃身面黄者。其候，得病但发热心战者，是急黄也。”《外台秘要》云：“此病始得，与前天行病不多异，五六日但加身体黄，甚至涕泪汗唾小便如柏色，眼白睛正黄，其更重症状，与天行病候最重无别”。《圣济

总录》对急黄的临床表现描述得更具体：“病人心腹急闷，烦躁身热，五日之间便发狂走，体如金色，起卧不安。”《沈氏尊生书》云：“天行疔疫以致发黄者，俗谓之瘟，杀人最急”。《医宗金鉴》说：“天行疫疔发黄，名曰瘟黄，死人最暴也”。

针对主症的治疗

(1) 退黄疸

① 茵陈 60—120 克，大黄 50 克，水煎服。病情减轻后减量。

② 黄疸较深，湿热久滞者，可用茵陈蒿汤合桃仁承气汤加减：茵陈 60 克，栀子 12 克，桃仁 10 克，大黄 30 克，芒硝 10 克（冲），桂枝 10 克，水煎服。

③ 茵栀黄注射液 10—20 毫升，丹参注射液 4—6 毫升，加入 5 % 葡萄糖液 500 毫升中静脉点滴。

④ 熊胆粉，每次服 0.3 克，每日服 2 次。

⑤ 三七粉每日 3 克，或三七注射液 4—6 毫升加入 5 % 葡萄糖液 200 毫升中静脉滴注。

⑥ 甜瓜蒂适量研细末，搐鼻（使鼻孔流出黄水）。

(2) 消退腹水

① 五苓散、五皮饮合方：大腹皮 10 克，桑白皮 30 克，茯苓皮 30 克，陈皮 10 克，生姜皮 10 克，猪苓 12 克，泽泻 30 克，白术 30 克，桂枝 10 克，水煎服。

② 生大黄 10 克，玄明粉 10 克（冲服），丹参 30 克，枳实 10 克，厚朴 10 克，茵陈 60 克，金钱草 30 克，水煎服。

③ 茵栀黄注射液 10—20 毫升静脉滴注用法同上。

(3) 防治出血

① 茵陈 60 克，生大黄 10—20 克，犀角粉 8 克（冲），生

地30克，赤芍20克，丹皮15克，栀子12克，水煎服。出血量多者加黄芪60克，红参粉10克（兑服）或党参60克。

② 三七粉，每次服3克，每日1—3次，开水吞服。

（4）防治肝昏迷

① 紫雪丹每次1—3克，日服2—3次，口服或鼻饲（紫雪丹为治疗肝昏迷的首选药）。

② 安宫牛黄丸，每次1粒，日服2—3次，口服或鼻饲。

③ 生大黄30克，栀子12克，茵陈30克，芒硝10克（冲），丹皮12克，赤芍30克，水煎服或保留灌肠（本方通腑导泻，可减轻或预防肝昏迷）。

辨证分型治疗

（1）热陷心包，痰火内闭：高热烦躁，面黄气粗，口气臭秽，喉间痰鸣，大便秘结，小便短赤，或面目全身呈金黄色，胸腹胀满，甚至神昏谵语，烦躁不安，舌红苔黄燥或黄厚腻，脉弦数。

方药：犀角粉3克（冲），茵陈60克，栀子12克，板蓝根30克，丹皮12克，蒲公英30克，大黄15克，石菖蒲12克，水煎服。神昏谵语加服紫雪丹3克。

（2）湿困中焦，阳气虚衰：颜面灰暗黄滞，黄疸深重，神疲倦怠，少气懒言，怯寒肢冷，食滞纳呆，腹部膨隆胀满，神疲嗜睡，表情淡漠，甚则神识昏糊，语无伦次，循衣摸床，大便稀溏，尿少或癃闭，舌淡苔白，脉沉缓。

方药：茵陈60克，附片20—30克（先熬），白术15克，红参10克（或党参60克），黄芪30克，茯苓10克，菖蒲10克，远志10克，水煎服。

（3）阴虚阳亢，肝风内动：烦躁不安，唇干口燥，渴

欲饮水，目睛干黄而涩，神志恍惚，反应迟钝，或狂叫不止，口内臭秽（肝臭），尿深黄。舌红绛少苔，脉弦数。

方药：羚羊角粉1克（冲），钩藤30克，菊花15克，生地30克，麦冬30克，枸杞15克，川楝子12克，茵陈60克，龙胆草10克，栀子12克，珍珠母30克，白芍30克，石菖蒲12克，水煎服。神志不清加紫雪丹8克。

各地报道的经验表明，对于肝昏迷，采用紫雪散鼻饲，较口服安宫牛黄丸效果为优。因紫雪散内含芒硝、硝石，可泻热散结；石膏、寒水石、滑石清泻实火。有的学者认为，临床上应用开窍药治疗重症肝炎肝昏迷时，应将紫雪散列为首选药。

· 治疗重症肝炎，采用静脉滴注给药途径，可弥补口服汤药的不足。重症肝炎在消化道症状严重的情况下，再给予大剂量苦寒药组成的清热解毒方药，患者很难忍受，或不能口服，或服后即吐，达不到治疗效果，如采用静脉滴注，例如静滴茵栀黄注射液，大量清热解毒药通过静脉注射途径进入人体，免除了对胃的刺激，使药物作用得以充分发挥，收效较好。关于茵栀黄注射液，不仅具有清热解毒、利胆退黄的作用，而且具有较强的内源性干扰素的诱生作用（干扰素可增强人体抗疾病的能力），是治疗重症肝炎有希望的药物之一。

关于大黄和茵陈的使用，是阻止黄疸加深和尽快消退黄疸的重要措施。退黄疸的途径不外利小便，通大便两法（汗法很少用）。利小便须重用茵陈至60—120克，通大便则重用大黄至50克，病情减轻后减量。大黄味苦气香性凉，能入血分，治疗肝炎，应用甚广。古代用于治疗黄疸的百余方中，三分之一含有大黄，可见大黄为退黄疸之要药，有的医疗

单位还采用大黄注射液治疗重症肝炎，能较快的改善肝功能和临床症状，即使停药，亦无反跳现象。

采用通腑泻火法治疗重症肝炎肝昏迷及昏迷先兆均有一定疗效(肝昏迷的先兆症状为：频繁呕吐、频繁呃逆)。其作用为：①排出肠腔细菌分解代谢之有毒产物，减少毒素来源，减轻昏迷发生。②导泻法可增加肠蠕动，诱导排便，从肠腔可排出多量水分，起到结肠透析的作用。③导泻方药中清热解毒之品可通过结肠吸收，加强消炎解毒之效。④大黄等对消化道出血尚有止血作用。

22. 乙型肝炎

乙型肝炎是病毒性肝炎的一种，原名血清性肝炎，潜伏期2—6个月，传播方式，经血液（注射途径）传播，也可经日常生活接触传播。发病无季节性，多隐袭发病，大多数患者经普查才发现。乙型肝炎急性期可有低热。主要症状有乏力，纳食差，烦躁不安，手足心热，小便黄，胸闷，呕吐，腹胀，腹痛，胁痛等。

自从乙型肝炎表面抗原（HBsAg）发现以来，对乙型肝炎的诊断提供了新的依据。HBsAg检查连续三次以上阳性，同时HBeAg亦为阳性，且具有上面所述的肝病症状，肝功能异常，肝脾肿大者，即可确诊为乙型肝炎。

乙型肝炎属于祖国医学的“肝郁脾虚”、“肝肾阴虚”范畴。中医根据其发生、发展、变化及临床症候特点，认为热毒入肝是本病的主要原因。热毒入肝使肝气不舒，久之郁而化热，内外之热结合，使肝经热毒炽盛，导致肝阴耗损。

因“肝肾同源”，肾阴必也受损。又根据“肝病传脾”的理论，肝病久必伤脾胃，导致“肝郁脾虚”。

辨证分型治疗

（1）肝经热毒型：烦躁，睡眠不安，手足心热，大便干，小便黄，面红，舌赤，苔黄，脉弦或滑数，HBsAg阳性，肝功能异常。治宜解毒清肝。

方药：茵陈30克，白花蛇舌草30克，生地30克，板蓝根30克，半枝莲30克，木瓜20克，蚤休30克，山楂20克，神曲20克，麦芽20克，水煎服。

加减：脾虚纳差者加白蔻、白术；便干者加熟大黄；小便黄者加金钱草、木通；汗多者加浮小麦；谷丙转氨酶高者加五味子；麝浊高者加当归丸（成药）；HBsAg滴度高者加乌鸡白凤丸（成药）。

（2）肝郁脾虚型：神疲，乏力，两胁胀痛，不思饮食，腹胀，肠鸣，大便溏泄，口苦，舌质淡苔白或腻，脉弦。治宜疏肝补脾。

方药：柴胡20克，白芍15克，当归15克，山药30克，茯苓15克，白术12克，甘草10克，扁豆15克，党参30克，黄芪30克，菌灵芝30克。水煎服。

加减：肝区痛者加青皮、郁金；腹胀者加木香、大腹皮；口苦有热者加丹皮、栀子；纳差者加山楂、神曲、麦芽、鱼腥草；失眠者加夜交藤；便溏者加泽泻；苔厚者加厚朴、砂仁；谷丙转氨酶高者加白花蛇舌草、夏枯草、生甘草。

（3）肝肾阴虚型：头昏目眩，眼干涩，耳鸣颧红，口干咽燥，五心烦热，腰背酸胀，盗汗遗精，舌质红或有裂纹，苔少或剥脱，脉细弦。治宜滋补肝肾。

方药：生地30克，麦冬30克，沙参30克，枸杞15克，当归20克，川楝子10克，白芍15克，首乌15克，女贞子30克，旱莲草30克，党参30克，黄芪30克，菌灵芝30克，水煎服。

加减：五心烦热者加青蒿、地骨皮；口苦而干者加黄连；虚烦不寐者加远志、合欢皮；头昏目眩者加菊花、夏枯草；食欲不振者加鸡内金、山楂、神曲；遗精者加金樱子、芡实；大便干燥者加郁李仁、麻仁。

验方治疗

(1) 人参叶30克，乌梅15克，虎杖30克，枸杞15克，贯众12克，猪苓30克，黄芪30克，菌灵芝30克，五味子30克，水煎服。

(2) 复方贯众注射液（由贯众、土茯苓、丹皮、野菊花组成）静脉滴注，成人每天250毫升，15天为一疗程，一般1—3个疗程。

(3) 淫羊藿30克，白术15克，桑寄生30克，蚕沙10克，首乌15克，胡麻仁15克，板蓝根30克，党参30克，黄芪30克，赤芍30克。水煎服。

食物疗法

常食蘑菇、平菇等配合治疗。

应当指出，乙型肝炎虽然发病率高，流行面广，疗程较长，但并非不治之症。治疗的原则是急性期卧床休息，病情好转后逐渐增加活动量，病情稳定后可逐渐恢复工作，饮食宜清淡并富含蛋白质、维生素。患者应保持乐观主义情绪。

目前社会上有很大一部分人是乙型肝炎表面抗原(HBsAg 阳性)携带者。这些携带者无需悲观失望，因为大部分人经过几年，病毒会自然消失或终身带毒而不发病（带毒是指HBsAg 阳性而肝功能正常，又无症状）。当然，乙型肝炎病毒携带者要格外注意个人卫生，定期检查身体，发现肝功能

异常要积极治疗。

23. 上消化道出血

上消化道出血，系来自食管、胃、十二指肠、空肠上端以及胰管和胆道的出血。主要的病因有胃、十二指肠溃疡病，肝硬化引起食管下端和胃底静脉曲张破裂，出血性胃炎，胆道、胃癌等出血所致。其主要特征是呕血和黑便，急性大出血可出现周围循环衰竭，严重威胁患者生命。

上消化道因炎症、溃疡、憩室、肿瘤等引起出血。可引起出血的疾病繁多，如：

（1）食管疾病：炎症、溃疡、糜烂、癌肿、贲门粘膜撕裂症等。

（2）胃、十二指肠疾病：胃、十二指肠溃疡出血占上消化道出血的首位，其中十二指肠溃疡比胃溃疡出血多见。恶性肿瘤和胃癌、肉瘤等也易引起上消化道出血。胃部手术后出血也较常见。长期服用阿斯匹林、可的松、利血平、保泰松均可引起出血，严重的内脏功能不全均可导致胃粘膜屏障障碍，胃酸分泌增加等致使胃粘膜损伤引起出血。

（3）食管或胃底静脉曲张破裂：门脉高压所致食管或胃底静脉曲张出血是上消化道出血常见的原因之一，其中主要是肝硬化，其他如门静脉炎、门静脉血栓形成、肝静脉阻塞综合征等也可引起静脉曲张破裂出血。

（4）胆道出血：绝大多数胆道出血是由于胆管结石、胆道肿瘤、胆管狭窄引起局限性或较广泛的感染，形成脓肿，管壁坏死而蚀及血管引起出血。

(5) 全身疾病：全身疾病引起上消化道出血比较少见。其中有：全身急性感染如败血症、流行性出血热等；血液病如血友病、白血病等；血管性疾病如过敏性紫癜等。

上消化道出血的临床表现

(1) 呕血与黑便：呕血与黑便是上消化道出血的最主要症状。幽门以上出血多先有呕血，呕血者多有黑便。而幽门以下出血者，多表现为黑便。呕血及大便的颜色，取决于出血量和出血在胃肠停留的时间。在出血量少时，虽然出血部位在幽门以上也可能只表现黑便或潜血试验阳性。当幽门以下出血量大时，可返流到胃而致呕血。同时也可因大量出血使肠蠕动增强，血在肠腔内停留时间短而成为血便、非黑色便或柏油便。

(2) 出血的征兆：上消化道出血症状的轻重与失血的速度和出血量多少有关。一般成人失血在 400 毫升以下，除有贫血，黑粪之外，可无明显症状；失血在 400 毫升以上，病人可出现乏力、眩晕、眼花、面色苍白、手足厥冷、出冷汗、心悸、烦躁不安、脉搏细数，甚至昏迷。综合临床表现和实验室检查，有下列征象时提示有严重出血：①病人须卧床才不觉头晕。②心率每分钟超过 120 次。③收缩压低于 90 毫米汞柱。④红细胞低于 200—300 万/立方毫米，血红蛋白低于 7 克%。急性上消化道大出血血容量减少时，首先表现是心率加快，其次是血压下降，而红细胞数及血红蛋白下降较晚。故早期不能片面根据二者估计失血的程度。

上消化道出血属于祖国医学“血证”范畴。血由胃而来，从口而出者，称为呕血，又称吐血。常夹有食物残渣，血色紫暗或呈咖啡色，甚则鲜红。黑便乃指胃、十二指肠等离经下行之血，从大便而下。

上消化道出血的病因病机为：（1）胃热伤络，饮食不节，胃中积热，情志失和，肝郁化火犯胃，均可导致热伤胃络，迫血妄行而致出血。（2）脾虚不摄。劳倦过度或胃病、肝病日久导致脾胃虚弱，统摄无权，则血不循经，溢于脉外而产生出血。（3）胃络淤阻。肝病日久不愈，气滞血淤，肝血流行不畅；胃病反复发作，久病入络，均可引起胃络淤血内滞而致血不循经外溢，从而产生出血。

辨证分型治疗

（1）胃中积热：血从口出，色紫暗或呈咖啡色，甚或鲜红，常混有食物残渣，大便色黑如漆。口干口臭，喜冷饮，或胃脘闷胀疼痛，舌质红，苔黄，脉滑数。治宜清胃泻火，凉血止血。

方药：大黄15克，黄连10克，黄芩10克，紫珠草30克，水牛角30克，丹皮12克，赤芍30克，藕节12克。水煎（浓煎）放冷频服。

（2）肝火犯胃：吐血鲜红或紫暗，口苦目赤，胸胁胀痛，心烦易怒，失眠多梦，或有黄疸及胁痛等宿疾症积痞块。舌质红，苔黄，脉弦数。治宜泻肝清胃止血。

方药：龙胆草10克，栀子10克，丹皮12克，茜草根12克，黄芩30克，地榆15克，旱莲草30克，侧柏叶15克，水煎放冷服。

（3）脾虚不摄：血从口出，血色暗淡，大便漆黑稀溏，面色恍白，唇甲淡白或神疲乏力，气短，心悸，头晕。舌质淡，苔薄白，脉细弱。治宜健脾益气，温中止血。

方药：党参30克，黄芪30克，炒地榆15克，艾叶15克，阿胶12克，炒蒲黄12克，白芨30克，血余炭10克，炮姜10克，灶心土30克，水煎放冷服。

(4) 气衰血脱：吐血倾盆盈碗，大便溏黑甚则紫红，面色及唇甲皓白，眩晕，气短，心悸，烦躁，口渴，冷汗淋漓，四肢厥冷，尿少神志恍惚或昏愤。舌质淡，脉细数无力，微细欲绝。治宜益气固脱，止血。

方药：红参_{15克}，黄芪_{60克}，三七粉_{3克}，制附片_{15克}，云南白药_{3克}（冲），阿胶_{15克}，水煎服。

专方专药治疗

(1) 血宁冲剂（成都中医学院附院研制）每次1包，一日4次，冷开水送服。

(2) 紫地合剂（广州中医学院附院研制），每次50毫升，一日4次口服。在冰箱中放冷服，效果更好。

(3) 榭木合剂（浙江省中医院研制），每次1—2支，一日3次（口服安瓿剂）。

(4) 大黄醇提片（上海香山中医院研制），每次服3片，每日服3次。疗程一般为3天，最长不超过10天。服大黄引起的缓泻作用可使淤血迅速排出，便于及时观察大便色泽及性状，有利于止血，不应视为副作用。

科学研究证明，大黄等苦寒攻伐方药对急性上消化道出血的虚证不是加重病情，反而有治疗作用。单方单药能治疗不同证型的出血。

关于使用大黄止血，国内专家们认为安全而无毒，应用时毋须顾虑，我国应用大黄于临床已有2000多年的历史。近年来的药理实验表明，大黄能加强结肠蠕动，而不加强胃与十二指肠的蠕动，故对胃与十二指肠溃疡本身无害。它含有许多鞣质，有局部止血作用，对溃疡面本身也有一定保护作用。

大黄内既含有致泻的成份（大黄酸二蒽酮甙），又含有引

起便秘的成分鞣质,故在体内能互相制约,不致腹泻过度。服大黄止血,腹泻6次后,大便隐血试验可转阴,未发现因腹泻过多而出现低钾、低钠等不良反应。相反,由于大便次数增多,使淤血及时排除,吸收热迅速消退,有利于血管平滑肌收缩而促进止血,提早康复。由于大便次数增多,可以不必致掩盖矛盾,如果再有出血,可及时发现,及时处理。如果个别患者腹泻次数特别多者,可鼓励病人多吃流质饮食,必要时配合静脉输液。

(5) 中药液冰冻洗胃。对严重上消化道出血患者,把紫地合剂(广州中医学院附院研制)放入冰箱冰冻至3—4℃,每次经胃管注入胃内500—800毫升,协助患者作体位左右轻度转动,使药液与胃各部接触,随即抽出。反复2—3次。然后再注入200毫升保留胃内,每天1—3次。出血停止后再继续观察治疗24小时,后拔出胃管,改为口服紫地合剂。本法是有快速止血作用,(详见《中医急症通讯》总第2期)。

单方验方治疗

(1) 云南白药,每次1克,每日4次,口服。

(2) 大黄粉,每次3克,每日3次,口服。

(3) 苏子15克,降香15克,茜草根15克,血余炭30克,研净末。将3味上药加水约400毫升,煎数沸即成,共煎两次,去药渣,放冷。服药时调入血余炭细末,搅匀,徐徐服下,每次约50毫升左右,每隔数分钟一次。南京军区总医院沙星垣主任医师曾用此方治疗食道静脉曲张破裂大吐血数例,均获良效。

(4) 红参10克,浓煎,以参汤调止血散粉剂(三七、白芨、制大黄炭、黑山栀、明矾等各研成细粉),拌成浆糊

状，分多次缓缓服下，不宜一次大量进药，以防药液冲击胃部，反而导致继续出血。至于人参及止血散之用量，可按出血多少及症状轻重而定。对出血较多者，人参的一日量可用至30克。在治疗过程中，患者必须静卧。

(5) 对食道静脉曲张破裂引起的大出血，可在病人插入三腔管后，先将胃气囊充气，拉紧后牵引固定，然后口服大黄及白芨粉糊剂，使药物堆积于胃底及食管下段，再把食管气囊充气，以压迫止血，使食管静脉出血止住，且在三腔管放气后再出血的可能减少。

上消化道出血的护理

(1) 卧床休息，保持安静，注意适当保暖，严重出血者，绝对卧床休息，取平卧位，床上大小便。

(2) 安慰病人，消除恐惧心理及忧虑紧张，特别对肝郁患者，更应耐心细致做思想工作。

(3) 按病情分别给予禁食或流质饮食，病情好转后逐渐改为半流质饮食与软食，一般宜少吃多餐且放凉后进食。切忌吃粗纤维饮食，切忌进食辛辣、酒、煎炸、雄鸡、虾、螃蟹等食品，而免生火动血。

24. 老年便秘

老年便秘是常见的证候之一，它和一般便秘相比，有其特异性。特别是治疗方面，有很大的差异。

老年便秘发生的原因很多，不能一见大便不通就用大黄、芒硝之类的泻下药，也就是说，不可妄下，而要润通。一般说来，老年便秘是以虚为主。治疗时，应本着以食疗为主，

药疗为辅的原则，或审证求因，采用综合措施，方能收到理想的效果。

高龄的人，气血阴阳都已虚衰，孰轻孰重，孰主孰次，应该划分清楚。正因为老年人体虚，所以，一个人又常常同时患几种病，服用多种药物。在服用钙片、四环素、冬眠灵、利眠宁之类的药物时，就容易引起便秘。这就是药物所引起的便秘，不可不知。诸如此类的事情遇到一起时，治疗用药就当统筹兼顾了。此外，还要问清老年的生活习惯，如喜食辛辣厚味，酷爱浓茶，过饮烧酒，喜干食，不愿多饮水；或牙齿脱落，少吃含纤维的食物；或卧床多，活动少，等等，这样就有利于确定治疗方案。常见的老年便秘，有如下几种情况。

（1）气虚便秘。老年气虚，主要是指肺脾气虚。追根问底，大便并不干结，主要是排出不畅。虽有便意，努挣难出，解后汗多，体倦无力。

① 以肺虚为主者。多见于冬春之时，表现为上实下虚，即兼有咳嗽多痰，喘累，气逆，容易感冒。

方药：苏子15克，陈皮12克，肉桂8克，厚朴12克，当归20克，沉香5克，京夏10克，前胡15克，防风10克，甘草5克，水煎服。

② 以脾虚为主者。实际上为中气不足所致的气秘。证见大便难，解时汗多，气短，纳食少，面白头昏。舌淡苔薄，脉虚弱。

方药：党参30克，白术15克，炙甘草5克，当归50克，陈皮12克，升麻5克，柴胡5克，苁蓉20克，水煎服。

③ 肺脾两虚兼有者。便软而溏，解时艰难，胸胁痞闷，不思饮食，腹中胀满。苔薄白，脉细弱。

方药：柴胡10克，白芍30克，枳壳12克，甘草10克，陈皮12克，苍术10克，厚朴10克，党参30克，黄芪30克。

气虚便秘可用针灸治疗，穴位选大敦、足三里，用泻法；支沟，太白，用补法。

（2）血虚便秘。这种类型最为多见。证见大便努责难解，腰膝软弱，头眩心悸，唇甲皓白，面色无华。舌淡白，脉细涩。

方一：当归30克，生地黄20克，柏子仁12克，郁李仁12克，枸杞12克，苁蓉15克，火麻仁30克，陈皮10克，甘草5克，生首乌20克，水煎服。方中“三仁”宜捣碎入煎。

方二：当归50克，生地黄40克，白芍20克，川芎10克，女贞子15克，旱莲草15克，火麻仁30克（打碎）。蜂糖30克，兑入煎取的药液内。

方三：玄参20克，麦冬20克，生地30克，苁蓉20克，生首乌20克，水煎服。

（3）阳虚便秘。证见大便艰涩，面色青，腹中气胀，不渴，小便清长，四肢不温，喜热恶寒。舌淡白，苔白润滑，脉沉迟。

方一：半夏10克，硫磺8克，当归20克，苁蓉20克，核桃肉60克，水煎服。

方二：半夏硫磺可做成丸药。制法：西硫磺250克，捣碎，放入豆腐1000克，煮24小时，然后去豆腐，与法半夏等份，研细，蜜炼为丸，如梧桐子大。每服30丸，每日三次，饭前服。

方三：制附片30克（先煎半小时），干姜10克，葱白15克。若腹痛胀满，喜热饮，脉弦紧有力，去葱白，加肉桂10克，厚朴12克，甘草5克，大黄8克。

针灸疗法：取穴为大肠俞、肾俞、支沟、照海，用补法；关元，用灸法。

（4）湿浊便秘。患者素喜浓茶、烟酒，或湿浊化热，留于大肠，阻上隔下。证见大便溏泻，很难解出，面色晦滞。苔腻，脉濡缓。

方药：皂角子4克，茯苓15克，猪苓15克，晚蚕沙15克，寒水石30克，水煎服。

除了上述的分型论治外，下面介绍一些食疗方法，同时还录用一种外治方法，供临证时参考。

食疗方法

方一：紫苏麻仁粥（见《丹溪心法》）

苏子15克，火麻仁30克，共同捣烂如泥，滤汁去渣，加粳米100克，煮成稀粥食用。

方二：柏子仁粥（《粥谱》）

取柏子仁15克，去皮壳捣烂，加粳米100克同煮，待粥成之屑，兑入蜂糖50克，再煮沸即可食用。

方三：菠菜250克，洗净切成寸段，滤去水。在锅内放菜油10克，待清烟出后，将菜倒入锅内快炒，并加盐6克，味精1克，熟后起锅，即可食用。本法炒的菠菜清新，香脆，叶绿，根红，不但色鲜味美形好，而且增加食欲，调中通便。

方四：雪羹汤（王晋三方），适用于便秘而又兼有高血压患者。

荸荠20枚，海蜇皮50克，煎汤，频服。

方五：红薯粥（《粥谱》）

取鲜红薯250克（以红紫皮、黄心为佳），洗净，连皮切成小块，加粳米100克，水适量，同煮至熟，加白糖少许，

再煮成粥，即可食用。

方六：仙人粥（《遵生八笺》）

取制何首乌60克，煎汁去渣，加粳米100克，红枣20枚，在砂锅内同煮，待粥成时再加冰糖少许，稍等片刻，即可食用。

方七：决明子粥（《粥谱》）

把草决明15克放入锅内，炒至微香，待冷后煎汁，纳入白菊花15克，再煎，取汁去渣。用汁与粳米100克同煮，将成之时，加入冰糖少许，待糖化后而成粥时，便可食之。

方八：桑仁粥（《粥谱》）

取桑椹子60克，洗净后加粳米100克，加水适量，煮成粥后加冰糖少许即可食用。

方九：酥蜜粥（《本草纲目》）

取粳米100克，淘洗干净后煮成粥，再加酥油30克，蜂糖30克，再煮二沸，即可食用。

方十：白木耳30克，淘洗后，煮成羹糊状，加适量白砂糖。分两次食用。

方十一：取糯米100克，淘洗后，加清水煮成粥，再入去皮香蕉的碎块200克，冰糖100克，同煮15分钟，即可食用。

方十二：根据作者的经验，每日吃成熟的猕猴桃4个，久久食之，有通便奇效，且能治痔疮出血。

又：在日常生活中，进餐时多吃猪血、麻油、葵菜，有一定的益处。

外治方法：老年人的病多，用药宜慎；有的老年人又不愿服药，宜用下法。

方药：巴豆仁3克，干姜5克，良姜5克，韭子10克，硫磺3克，甘遂5克，槟榔5克。共研细末，用米汤调湿，分成两

丸。先以花椒30克煎水洗手，后用麻油涂手心，握丸药。大便通后，以冷水洗去手中的药。

25. 克隆氏病

克隆氏病又名局限性肠炎和局限性回肠炎，是一种病因不明的慢性肠道炎性疾病。

克隆氏病多见于年轻人，起病缓慢，临床表现多种多样，症状反复出现，常见的有腹痛、腹泻、发热、消瘦、贫血、食欲减退、恶心或呕吐、腹部肿块、渐进性肠梗阻症状及瘻管形成等。腹痛在脐周或右下腹，便前有轻度绞痛或不适，便后可缓解。腹泻一般每天3—6次，粪呈半液状。瘻管形成时可有发热，消瘦、贫血，右下腹有触痛。有半数病人腹部可扪及肿块。克隆氏病可通过X线钡餐检查等确诊。

克隆氏病属于中医的“腹痛”、“肠痛”、“泄泻”等范畴。其病因病机多为寒温不适，饮食不调，情志过极，湿热蕴结肠道，气血壅滞，病延日久致正气不足，脾土虚衰，肝木乘虚克伐中州，形成正虚邪实，本虚标实之证。治疗以邪实（标实）为主要矛盾时当以祛邪为主，以正虚（本虚）为主要矛盾时当以补虚为主。

基本方药：苡仁30克，附片10克，败酱草30克，当归15克，赤芍30克，白芍30克，丹皮12克，甘草10克，水煎服。

加减：脾虚者可伍用香砂六君子汤；肝脾不调，腹痛则泻者可伍用痛泻要方。

26. 急性腹膜炎

急性腹膜炎是由感染,化学刺激(胃液,肠液,胰液,胆汁等)或损伤引起的腹膜急性炎变。按病变的范围可分为弥漫性腹膜炎和局限性腹膜炎;按发病的来源可分为继发性腹膜炎和原发性腹膜炎(临床上以继发性腹膜炎最多见);按炎变开始时的性质可分为无菌性腹膜炎和感染性腹膜炎(无菌性腹膜炎如未及时治愈,发生细菌感染,也可能变为感染性腹膜炎)。

急性腹膜炎的病因主要有:①腹内脏器的急性穿孔与破裂。②腹内脏器急性感染的蔓延。③急性肠梗阻。④腹部外伤或手术消毒不严。⑤血行播散感染等。

急性腹膜炎的主要临床表现:有腹痛,腹部触痛和腹肌紧张,常伴有恶心,呕吐,腹胀,发热,低血压,脉快,气急,白细胞增多等中毒现象。因急性腹膜炎大多为腹腔内脏疾病的并发症,故起病前后常有原发病的症状。

腹膜炎病人,显甚痛苦状,腹痛多突然发生,迅速扩展。常因咳嗽、呼吸、转动身体而使疼痛加剧。病人被迫采取仰卧位,两下肢屈曲。由于高热,不进饮食,失水,酸中毒等情况,患者精神抑郁,面色灰白,皮肤干燥,眼球及两颊内陷,鼻部尖削,时出冷汗。患者可有低血压及休克表现,脉微欲绝,少尿或无尿,呃逆频繁。

急性腹膜炎属于祖国医学的“腹痛”、“肠痛”、“厥逆”等范畴。《外科正宗》说:“暴急奔走,以致肠胃传送不能疏利,败血浊气壅遏而成”。《诸病源候论》说:“由

于寒温不适，喜怒无度，使邪气与营卫相干，在于肠中，遇热加之，气血蕴结，聚积成痈，热积不散，血肉腐败，化而为脓”。《景岳全书》说：“厥逆之为病也，足暴青，胸若将裂，肠若将以刀切之，烦而不能食，脉大小皆涩”。可知腹膜炎之发病，多由于饮食、寒温、暴急奔走等所伤，常累及脾、胃、肠、胆等四个脏腑，气机郁滞，通降失司，郁结化热，热淤互结，聚而不散，以致血肉腐败，熟腐成脓，热毒炽盛，深入营血，导致气血逆乱，而致四肢厥冷，脉微欲绝。

辨证分型治疗

(1) 郁滞型(早期)：有腹痛，腹胀，腹部拒按，发热，口干，便秘，尿少，舌红苔黄腻，脉弦数。治宜行气清里。

方药：柴胡30克，黄芩30克，枳壳10克，大黄10克，栀子12克，元胡12克，川楝子12克，银花30克，连翘30克，白芍30克，甘草10克。水煎服。

(2) 湿热型(中期)：腹胀加重，便秘，高热出汗，舌红绛，苔黄燥，脉洪大数。治宜通腑泄热。

方药：生石膏30克，知母12克，大黄12克，芒硝10克(冲)，厚朴12克，黄连10克，黄芩30克，栀子12克，丹皮12克，赤芍30克。水煎服。

加减：腹腔有脓肿或有炎性肿块者加桃仁，乳香，没药，山甲，皂刺。

(3) 毒热型(晚期)：精神萎靡，口干舌燥，手足不温，四肢厥冷，体温不升，尿少，脉沉细无力(感染性休克)。治宜清热解毒，回阳救逆。

方药：犀角3克，生地30克，玄参30克，竹叶12克，银花30克，

连翘^{15克}，红参^{15克}，制附片^{30克}（先熬），麦冬^{30克}。水煎服。

加减：神昏谵语者加安宫牛黄丸。

针刺治疗

穴法：中脘、梁门、天枢、气海、足三里、内关、胃俞、大肠俞、合谷、曲池。强刺激，每次留针 30 分钟，每日 3—4 次（以上穴位交替选用）。

中药外敷治疗

（1）芙蓉叶 300 克，大黄 300 克，黄芩、黄连、黄柏、泽兰叶各 240 克，冰片 9 克，共研细末，用醋调成糊状，敷于腹壁，约 0.5 厘米厚。

（2）黄柏细末 8 份，煅石膏 10 份，加冰片少许，混匀，用醋调成糊状，敷于腹壁，约 0.5 厘米厚。

中药灌肠治疗

用于呕吐较重，不能服药者。方剂同辨证分型治疗。煎成 400—500 毫升，作保留灌肠。

27. 急性出血性坏死性肠炎

急性出血性坏死性肠炎是一种急性炎症性肠炎，主要的临床表现是：腹痛，便血，中等度发热，呕吐，腹胀，严重者可发生休克，肠麻痹等中毒症状和肠穿孔等并发症；主要的病理改变为：肠壁小动脉内类纤维蛋白沉着、栓塞而致小肠明显出血和坏死。病变部位以空肠及回肠为多见。本病的病情严重，病势凶险，发展迅速，又因病因不够清楚，所以治疗棘手，死亡率较高。

本病呈散发性，农村的发病率显著高于城市；全年皆有发生，但在夏秋季更为多见；患者主要为儿童和青少年。

急性出血性坏死性肠炎易与肠套叠、中毒性痢疾、阿米巴痢疾、过敏性紫癜、消化性溃疡、肠息肉等相混淆，应仔细鉴别。

本病属祖国医学的腹痛、肠风、脏毒、便血、远血、血痢等范畴。发病机理是正气内虚、复感热毒，内陷肠管络脉；或暴饮暴食不洁之品，损伤肠胃，导致小肠失职，气机痞塞，清浊不化，血聚而成淤，津留而为湿，淤、湿与热相并化生邪毒，使血肉腐败，肠壁坏死。从表现的证候来看，属本虚标实，病位在肠和脾；在疾病的早期阶段，以实热者多，后期已伤及阴份，恢复期要着重调理脾胃。

辨证分型治疗

（1）热毒伤络型：证见阵发性腹痛、腹胀、发热，呕吐、口渴、口苦，大便呈血水样或如果酱色，尿短赤。舌红，苔黄腻，脉弦数。治宜清肠解毒，凉血止血。

方药：鱼腥草30克，旱莲草30克，紫珠草30克，黄芩20克，黄连10克，生地30克，黄柏20克，水煎服。

（2）腑气闭结型：证见持续性腹痛，阵发性加剧，痛时拒按，压痛明显，频频呕吐，腹胀，大便初为水样，继之色红，有奇臭味。舌质红，苔黄，脉滑数。治宜峻下存阴，荡涤热结。

方药：大黄12克（后下），朴硝10克（后下），枳实10克，厚朴12克，白头翁30克，黄连10克，黄柏10克，侧柏叶30克。水煎服。

加减：腹痛甚者加广木香12克；莱菔子12克，槟榔12克；便血甚者加槐花15克，地榆20克，仙鹤草30克。

(3) 阳气暴脱型：证见面色苍白，四肢厥冷，神昏谵语，烦躁不安，呼吸深而慢，血压下降，皮肤呈网花纹。舌质淡，苔黄，脉细欲绝，治宜回阳救逆，益气固脱。

方药：红参10克，制附片20克（先煎），水煎服。若偏于气阴两脱，改用西洋参10克，麦冬20克，五味子3克，水煎服。

本型患者已到最危险的时候，宜配合西药抗休克抢救，给予大剂量抗生素和激素，待病情平稳之后，再随证选药。

各地介绍的有效方药很多，现择其优抄录如下。

方一：灶心土30克，生地15克，白术15克，黄芩12克，制附片20克（先煎两小时），阿胶10克（烊化后服），甘草5克，水煎服。

加减：腹痛剧者加川楝子12克，延胡10克；血便多者加地榆20克，茜草15克，茅根30克。

本方能温阳健脾，养血止血，宜于急性出血性坏死性肠炎之本虚标实、寒热错杂者服用。方中灶心土温中，收涩，止血，是君药；配白术、附子温中健脾，以复统摄之权；佐阿胶、生地、甘草以益脱竭之血；伍黄芩之苦寒；伍生地、阿胶共制白术、附片之温燥；生地、阿胶得白术、附子，可不虑其滋腻呆补。

方二：黄连8克，黄芩12克，大黄10克（后下），炒地榆15克，炒槐花15克，白头翁20克，丹皮12克，炒枳实10克，甘草5克，水煎，取汁200毫升，四次分服。若已昏迷者改为鼻饲给药。另外用1剂煎水，取汁400毫升，每次用200毫升保留灌肠，每日2次，药液温热要适度。

加减：腹胀甚者加厚朴12克，广木香12克；便血严重者加云南白药0.5克，血余炭3克（冲服）；高热、烦躁、谵妄、舌绛者加安宫牛黄丸1粒，化水服，亦可改用牛黄至宝丹，每

次2克，一日1次。

本方有导毒化淤、凉血止血、清热行滞、调整机体抗病机能、阻断病情发展之功。方中枳实、大黄相偶，能荡涤肠胃中的腐秽，破结除满，促进肠壁节律性蠕动，防止肠麻痹，排泄肠内毒物，从而减低肠腔内的压力，利于改善肠壁微循环，减少毒素的吸收，减少感染的机会。丹皮是活血化淤药，能使小肠血管流速加快，改善组织缺氧，恢复肠壁的通透性，消除肠壁的充血、水肿，防止血淤、血栓的形成。黄芩、黄连、大黄、白头翁，皆为苦寒药，可直达胃肠，善除肠胃热结蕴毒。槐花、地榆能凉血止血，保持毛细血管正常的抵抗力，减少血管通透性，恢复血管正常弹性，缩短凝血、出血时间，并能收缩血管。诸药合用，能使肠道湿热除，积滞祛，气机顺，津血通，功能复。

方三：生地25克，黄芩12克，淡竹叶10克，山栀子10克，木通5克，青皮5克，茵陈20克，白芍10克，滑石30克，甘草5克，水煎服。

加减：有血水样大便者加槐花15克，侧柏叶30克，地榆15克；腹胀，腹痛，呕吐，有腹膜刺激征者加丹参15克，毛冬青15克。

方中生地清热凉血；木通、竹叶清心降火，引热从小便而出；滑石清上利下，除三焦湿热；黄芩、栀子、茵陈清热燥湿止血；青皮白芍疏肝破气，消滞止痛；甘草缓急，调和诸药。据现代药理研究，芩、栀、茵陈对多种细菌有较强的抑制作用；草、芍、青皮能缓解胃肠平滑肌痉挛，解除腹痛；生地、滑石、甘草能使胃肠溃疡面形成薄膜，起到良好的保护作用。

方四：生地15克，玄参15克，麦冬15克，银花20克，白头

翁20克，地榆15克，丹参12克，槐花15克，丹皮15克，黄连10克，秦皮10克，甘草5克，浓煎，多次少量冷服。

加减：呕吐频或服药不受者加姜汁数滴。

方中银花、黄连、秦皮、白头翁、甘草清热解毒；生地、玄参、麦冬清热养阴；丹皮、丹参凉血活血；槐花、地榆凉血止血。配合补充液体，共起标本同治、扶正祛邪的作用。

针灸疗法

腹痛者刺足三里、中脘、天枢。

呕吐者刺内关、中冲、十宣。

发热者刺大椎、曲池、合谷。

腹泻便血者足三里透上巨虚，天枢透大巨，大肠俞透小肠俞，或刺天枢、水分、气海、足三里、阴陵泉。

厥逆者灸关元、气海、百会、肾俞、神阙。

调护和预防措施

1. 腹痛、便血时，应卧床休息和禁食。
2. 恢复后应给予驱虫剂驱虫。
3. 不吃未煮熟或变质的肉类食物。

23. 中毒性菌痢

中毒性菌痢（简称毒痢）是急性细菌性痢疾的一种类型，为常见的严重传染病。一年四季均可发生，但多见于夏季，大都发生在2—7岁体质较好的儿童。成人偶可发生。

临床症状

成人多表现为休克。儿童多表现为：

(1) 以中枢神经系统症状为主。高热、惊厥、神志萎靡或昏迷，有时以周围循环衰竭为主，如脸色苍白，口周发青，四肢厥冷，脉细，血压下降等。偶有呼吸衰竭表现如呼吸减慢而节律不整，呼吸暂停，叹息或双呼气等。

(2) 起病急，发展快。发病初期肠道症状多不明显，许多患者没有腹泻，脓血便的主诉，但用灌肠或肛门拭子采便检查可发现粘液样大便或脓血便，作显微镜检查。可发现大量白细胞。有时一次灌肠或肛门拭子检查大便为阴性，不能就否定中毒性菌痢，还须重复灌肠检查，并结合临床特点作出诊断。在得病的最初 24 小时病情变化最剧，若不及时正确治疗，病儿可于数小时内发生呼吸衰竭或循环衰竭而死亡。

按病情的轻重分，可分为以下三型：

(1) 轻型（具备下述一条者）

- ① 高热。伴有明显嗜睡，显著烦躁不安，寒战；
- ② 惊厥。三次以内。

(2) 重型（具备下述二条以上者）

- ① 惊厥三次以上；
- ② 神志半昏迷或昏迷；
- ③ 脸色苍白，口周青紫，指端发绀，心音弱钝；
- ④ 腹壁、提睾反射消失；
- ⑤ 消化道出血或其他严重出血现象。

(3) 极重型（具备下述一条者）

- ① 出现呼吸衰竭症状；
- ② 出现循环衰竭症状。

按病人微循环障碍的表现，可分为以下三型：

(1) 脑微循环障碍型（简称脑型）。面色苍白、高热、

惊厥、呼吸节律不整、瞳孔大小不等，最后呼吸可突然停止。

(2) 皮肤内脏微循环障碍型(简称皮肤内脏型)。主要表现为休克。

(3) 肺微循环障碍型(简称肺型)。常在发病后15—20小时左右呼吸突然加快加深，胸廓起伏极大，烦躁，肺部检查偶可听到细小湿罗音。

中毒性菌痢起病急，短时间内出现高热，反复惊厥等。根据临床表现、体征及化验结果，特别是大便常规和大便培养，再结合流行季节，不洁食物史等不难作出诊断。但有的患儿没有典型的毒痢的消化道症状，而是出现全身感染性中毒症状，应高度警惕。

中毒性菌痢属于祖国医学的“暴痢”、“疫毒痢”、“噤口痢”等范畴。治疗可分为急救治疗、辨证施治、随症施治、随症施护、并发症的治疗等。

急救治疗

鉴于毒痢发展迅速，变化甚快，中药口服往往不能立刻发挥效用，因此，应改变给药途径，采取直肠给药，使药物高浓度地直接作用于病变部位，迅速吸收，增强制邪(杀菌)能力，有利于组织修复，从而提高疗效。

方一：白芍30克，白头翁20克，黄连12克，黄芩15克，苦参30克，加水300毫升煎成100毫升，待药液温度降至40℃，作高位保留灌肠，一日2次，病重者一日4次。

方二：银花炭30克，地榆炭30克，山楂炭50克，黄连60克，吴茱萸60克，木香50克，白芍60克，老鹳草20克，研细，制成栓剂10枚备用。每枚含生药36克。用易溶薄膜包裹待用(可借用食品厂包装糖果用的内层可食薄膜)。

用法用量：患者取俯卧位，抬高臀部，每次用栓剂1—2枚，外涂少量润滑油，徐徐插入肛门内。病重者一次可用三枚，先后送入肛门内（一深一浅地、一枚接一枚地送入），用纱布裹棉花塞于肛门内，以防药栓流出。每隔三小时一次（一般在三小时内栓剂全部溶解）。

方三：炮姜炭20克，黄连50克，山楂炭50克，制附片（炒）30克，白芍50克，肉桂10克，木香20克，茯苓50克，当归20克。共研细，制成栓剂10枚备用，每枚含原药30克，包装同前。

本栓剂适用于中毒性菌痢属于寒湿者（下痢伴畏寒肢冷，脸色苍白，血压下降等）。

用法用量：同上。

辨证施治

（1）热毒炽盛（疾病早期）。高热口渴，面红头痛，烦躁不安，意识朦胧，神昏谵语，舌质红，舌苔黄燥，脉象洪数。

治疗法则：清热解毒，清心开窍。

方药：白头翁15克，银花30克，马齿苋30克，丹皮10克，黄连10克，赤芍15克，秦皮12克，黄芩15克，菖蒲10克，郁金12克，水煎服。送服至宝丹8克。

（2）肝风内动（相似于脑型）。持续高热，甚至痙痲，深度昏迷，呼吸急促，有时出现呼吸暂停，舌质红绛而干，脉弦数或细数。

治疗法则：

① 热极生风，治宜清热，镇肝熄风。

方药：黄连12克，黄芩15克，黄柏12克，苦参30克，秦皮15克，赤芍30克，丹皮10克，木香10克，水牛角30克，钩藤15克，全蝎10克，僵蚕10克，水煎服。送服紫雪丹1—1.5克。

② 血虚生风，治宜滋阴养血，镇肝熄风。

方药：天麻10克，钩藤30克，石决明15克，栀子12克，黄芩15克，夜交藤30克，旱莲草30克，生地30克，熟地30克，阿胶12克，水煎服。

(3) 内闭外脱（相当于呼吸、循环衰竭的混合型）。面色苍白，口唇青紫，四肢厥冷，脉微欲绝。有时出现超高热且反复惊厥，呼吸不匀。

治疗法则：开闭救脱，清热熄风。

方药：生龙骨30克，生牡蛎30克，制附子15克（先熬），甘草10克，水牛角30克，钩藤30克，僵蚕12克，干姜10克，水煎服，送服苏合香丸3克。

(4) 气虚欲脱（相当于肺型，见于疾病晚期）。呼吸深快，胸廓起伏极大，严重时气息奄奄，呼吸停止，四肢厥冷，脉微细。

治疗法则：益气救脱，泻肺涤痰。

方药：红参15克，制附子15克（先熬），干姜10克，五味子10克，麦冬15克。水煎服。

(5) 阳气将脱（相似于休克型，主要表现循环衰竭）。神志模糊，甚至昏迷，面色苍白，肢体发冷，皮肤发白，唇指青紫，头出冷汗，脉微难及，舌淡苍白或舌质紫绛，苔少，脉细数。

治疗法则：回阳救逆，益气生脉。

方药：红参15克，制附子15克（先熬），干姜10克，麦冬15克，五味子10克，生龙骨30克，生牡蛎30克，甘草6克，水煎服。

(6) 血结淤阻（相似于弥漫性血管内凝血现象）。病人可有多种临危表现，但突出的是出血倾向。皮肤淤紫，针

眼出血，鼻衄，便血，呕吐咖啡样物。

治疗法则：益气固本，活血化淤。

方药：当归15克，生地15克，赤芍30克，川芎10克，桃仁10克，红花10克，柴胡10克，枳壳10克，桔梗6克，牛膝10克，红参15克，仙鹤草30克，制附子12克（先熬），甘草6克，水煎服。

· 随症施治（对症治疗）：

（1）高热不退

① 针刺曲池、大椎、合谷、十宣。每次选1—2穴，强刺激不留针。

② 水针疗法：药品选柴胡注射液或5%当归注射液。穴位选曲池、足三里、阳陵泉。每次选1—2穴。每穴0.5—1毫升。

③ 放血疗法：首选少商，次选耳背静脉、耳尖，重者选用十宣穴。每次放血量：体质好的放3—5滴，体质差的放2—3滴。

（2）血压不升

① 针灸治疗：针刺选穴素髻、足三里、内关、合谷、人中。每次1—2穴，强刺激或用电针。必要时灸百会、神厥、关元、气海，任选1—2次。

② 口服或鼻饲独参汤：人参15克，水煎服。

③ 中药注射剂选用：

生脉注射液。每次5毫升加入10%葡萄糖液60毫升中静脉注射，或用生脉散注射液20毫升加入5%葡萄糖250毫升中静脉滴注。

枳实注射液。按说明书使用。

人参注射液。1—2支，每分钟一次，肌肉注射。

参附注射液。肌肉注射，每次一支。

(3) 昏迷不醒

① 针灸治疗：人中、合谷、太冲、任选1—2次。

② “三宝”的应用：至宝丹、紫雪丹、安宫牛黄丸任选一种，也可使用神犀丹。

③ 醒脑静注射液2—4毫升，肌肉注射或加入高渗糖液内静脉注射，也可以加入葡萄糖液内滴注。

(4) 抽风不止

① 针刺疗法：选穴人中、下关、颊车、内关、合谷透劳宫。

② 灌服或鼻饲中成药。羚羊角粉，止痉散（蜈蚣、全蝎各等分）。因高热引起抽风者也可使用万应锭。

(5) 呼吸骤停

① 针灸治疗：选穴太冲、内庭、涌泉、素髌、少商、或强刺激会阴穴。

② 针刺膈神经刺激点。

③ 应用中成药：灌服苏合香丸，六神丸均可。野人参粉5克顿服，静脉注射人参针。

(6) 脑水肿形成。针哑门、悬钟、百会、阴陵泉。采用重刺激。

(7) 弥漫性血管内凝血的处理

① 丹参注射液，静脉点滴。

② 川芎嗪注射液3—4毫克/公斤体重/日，分二次静滴。

(8) 控制感染。在各个证型中都不要忽视抗感染治疗。

① 苦参30克，白头翁15克，黄连15克，黄柏15克。加水浓

煎灌肠，每日1—2次。

② 加用抗痢疾杆菌之药物，马齿苋、黄连、黄柏、苦参、秦皮、白头翁、大黄、石榴皮、金银花、连翘、大青叶、白芷、铁苋菜、辣蓼、地锦草、三棵针、葶草、酢浆草、黄芩等。

辨证施护

(1) 隔离病人，控制传染。

(2) 严密观察病情变化。注意神志、皮肤、呼吸、大小便、分泌物、脉象（儿童观察指纹）变化。

随症施护

(1) 昏迷病人应鼻饲药物及营养物，维系生命，

(2) 高热病人可给予温水擦浴、柴胡注射液点鼻等退烧措施。

(3) 腹胀无便应及时灌肠，也可用中药灌肠给药。

(4) 气虚欲脱、阳气衰败病人应注意保暖。

(5) 抽搐病人要加强口腔护理，采取止痉措施，防止咬破舌头。

(6) 做好病情记录。

并发症的治疗

(1) 尿潴留。在抢救中毒性菌痢的过程中，大量使用莨菪类药物以及热毒湿邪引起肺热气壅、或正不胜邪，脾肾虚衰，往往出现尿潴留。若采用导尿，小儿插尿管困难，且易造成污染及感染后遗症；若用中药，有时效果也不佳，可用指压排尿法治疗。

排尿穴：在脐与耻骨联合的中点。

手法：两拇指压准穴位，其他四指固定在髂前上嵴，轻轻逐步向下压，压至患儿有痛感，四肢伸屈时，小儿先尿数

滴。若固定压力，接着病儿可排尿。

(2) 腹胀。中毒性菌痢救治过程中出现腹胀，一般有两种原因，一是湿热毒邪蕴结或气滞食阻，因此而引起中毒性肠麻痹，多属实胀。可采用通淤理气法治之。另一种腹胀是医源性腹胀，在抢救过程中使用大量冬眠药物、莨菪类药物造成植物神经功能暂时紊乱，或者由于缺钾等因素引起肠壁平滑肌蠕动功能障碍的腹胀，可用中药外敷。

淡豆豉60克，葱30克，生姜30克，捣碎炒热，滴入95%酒精5毫升拌匀，用布包裹后敷腹部。重度腹胀者可用麝香0.3~0.5克放入脐中，用胶布固定（对胶布过敏者用纱布覆盖亦可）后，再热敷（防止烧伤）。

(3) 久泻不止。中毒性菌痢急救后好转，但久泻不止，这多是虚中挟实，治宜攻补兼施。

方药：党参15—30克，白术6—10克，茯苓6—10克，炒扁豆10克，焦山楂10克，莲米10克，黄连10克，木香6克，诃子10克，干姜6—10克，肉豆蔻霜6克，甘草6克，水煎服。

(4) 脑性瘫痪。中毒性菌痢抽风时间长者，易造成脑的暂时缺氧，引起不同程度及不同类型的运动障碍，智能低下，视觉及听觉功能障碍，癫痫样发作，严重影响小儿的健康。在抢救中应加强护理，减少其发病率。若一旦发现“暴盲”、“暴聋”，应及早采用活血化淤，补气调气法治之。

方药：生地15克，党参15克，山药15克，桃仁6克，红花6克，生龙骨15克，谷精草6克，青葙子6克，枸杞15克，水煎服。并配合用维生素B₁₂200微克作穴位注射。选穴：安眠穴、合谷穴、三阴交穴、每日一次，七日为一疗程，一般需治疗1—2疗程。

(5) 营养不良。中毒性菌痢并发急性营养不良并不

少见。

① 脾弱邪伏型。肌肤枯瘦，无汗无泪，不食，神萎，泻痢，微热，脉细，苔光剥。

方药：党参15克，青皮6克，白术10克，茯苓10克、白芍10克，黄连6克，焦山楂10克，大腹皮6克，甘草6克，水煎服。

② 肝阴虚损型。肌肉干枯，“小老头貌”，久咳气短，高热或体温不升，舌红唇裂，苔薄无津，指纹淡滞。

方药：人参5克，麦冬10克，五味子6克，沙参10克，地骨皮10克，桑白皮10克，水煎服。

③ 真阳不足型。体小肌瘦，形寒肢冷，吐沫，泻痢，苔白，脉沉，指纹晦暗或细红达三关。

方药：人参5克，肉桂1克，白芍10克，干姜8克，补骨脂6克，水煎服。

④ 水气结滞型。肢体悉肿，腹水，便溏尿少，咳喘，舌质淡，苔白腻，脉濡。

方药：大腹皮8克，汉防己8克，丝瓜络10克，牛膝10克，桑白皮10克，泽泻6克，茯苓10克，桂枝8克，水煎服。

29. 急性左心衰竭

急性左心衰竭是比较常见的内科急症，常见于高血压性心脏病，冠状动脉硬化性心脏病，主动脉瓣病变和二尖瓣闭锁不全等。急性肾小球肾炎和风湿性心肌炎是儿童患左心衰竭的主要原因。

急性左心衰竭的临床表现

(1) 呼吸困难。患者多在夜间发生阵发性呼吸困难，常

在熟睡中突然胸闷、气急而惊醒，有窒息感，被迫端坐或站立呼吸，常伴有咳嗽和哮鸣性呼吸声，与支气管哮喘相似，故又称心脏性哮喘。轻者仅数分钟至1小时左右逐渐好转，重者可发展成为急性肺水肿。夜间阵发性呼吸困难，原因是由于平卧位使静脉回流量增加，加重肺淤血，熟睡后迷走神经紧张度增加，使冠状动脉和支气管痉挛，影响肺部气体交换和心脏血液供应，心肌收缩力减弱，故端坐时可减少下肢和腹部的血液回流，使肺部淤血减少，呼吸困难减轻。此外，坐位能使膈肌下降，增大胸腔容积，也有助于减轻呼吸困难。

（2）咳嗽和咯血。肺部淤血后，肺泡及小支气管分泌物增多，引起咳嗽、咳痰，肺底部有湿性罗音。咯血则是肺淤血时血液渗出或小血管破裂所致。

（3）急性肺水肿。由严重的左心衰竭引起，突然频繁咳嗽，气喘，呈端坐呼吸，极度烦躁，咯大量粉红色泡沫样痰，面色苍白，口唇、指甲发绀，皮肤潮冷，大量冷汗，脉搏加速，肺部布满湿性罗音。如不及时抢救，血压很快下降，脉搏细弱，发生休克。

急性左心衰竭属于祖国医学的“厥脱”范畴。中医认为心衰以气虚、阳虚、血淤、水停为其主要病机，其治疗可分为：①急则治其标；②针对气虚、阳虚、血淤、水停的病机予以积极治疗；③专方专药治疗。

① 急则治其标：

用蟾力苏注射液静脉注射，一次2—4毫克，稀释后静注。

用强心灵注射液，一次用0.125—0.25毫克，以10—25%葡萄糖液20毫升稀释后于10分钟内静脉注入，1日

1—2次。

针刺内关、心俞、肺俞、膻中、足三里、三阴交。不留针。

② 针对气虚、阳虚、血淤、水停的病机予以益气温阳，化淤利水。

气虚：治宜益气强心。

方一：生脉针，每次20毫升加入50%葡萄糖液30毫升，静脉推注，每日2次。

方二：红参15克，麦冬15克，五味子12克，加水急煎与服。兼阴虚者加生地、阿胶、酸枣仁等。兼血淤者加丹参、红花等。兼水湿内停者加猪苓、黄芪、泽泻等。

阳虚：治宜温阳强心。

方一：参附针20毫升加入50%葡萄糖液30毫升，静脉推注，每日2次。

方二：红参15克，附片30克，水煎服。兼气虚者加麦冬、五味子、玉竹、蛤蚧。兼阳气欲脱者加龙骨、牡蛎。兼血淤者加桃仁、红花。兼水湿内停者加黄芪、麦冬、茯苓皮。兼肾阴阳俱微者加龟版、仙灵脾、山萸。

水饮内停：治宜利水强心。

方药：葶苈15克，大枣30克，水煎服。兼腹胀、纳少者加猪苓15克，茯苓15克，泽泻30克，白术20克，桂枝15克。兼肢冷、畏寒者加附片15克，干姜10克，白芍15克，桂枝15克，泽泻30克，茯苓15克。

血淤：治宜活血化淤。

方药：红参15克，苏木10克，桃仁12克，红花12克，当归12克，熟地12克，川芎12克，赤芍30克，水煎服。

③ 专方专药治疗

方一：枳实注射液，静脉滴注。在静滴过程中无严重心律失常或其他不良反应，剂量易于掌握（详见产品说明书）。

方二：蟾酥：每次4—8毫克口服，每日2—3次。

30. 克山病

克山病是一种病因尚未阐明的地方性心肌病，其发病有明显的地区分布、时间分布和人群多发的特点。①病区分布在我国黑龙江到云南的一条自东北至西南向的狭长地带内，遍及13个省市自治区。②病区主要分布在丘陵山区。③有高发年和低发年的差异。急性型克山病在北方主要发生在寒冷季节，在南方如云南则全年皆可发病，但以夏秋季较集中。④在北方主要侵犯育龄期妇女，南方多见于断奶后、学龄前儿童。⑤外来人口在病区生活3个月以上方能发病。

克山病的病因至今仍未阐明，一般认为与水土、病毒感染，生物毒素中毒，微量元素特别是硒缺乏等因素有关。

克山病的临床表现为头晕，心窝部不适，恶心，呕吐，吐黄水，食欲不振，心悸，气短等。

克山病可分急性型、慢性型、潜在型三种。

（1）急性型。起病急，病情重，多表现为急性循环衰竭，如颜面苍白，四肢厥冷，全身冷汗，脉微欲绝，心律失常。心界向左扩大，心音减弱。

（2）慢性型。发病缓慢，病程长，多由潜在型逐步发展而来。急性流行后的春季发病较多。主要表现为慢性充血性心力衰竭。

（3）潜在型。由于心肌病变较轻，心脏代偿功能良

好，多无自觉症状，或仅全身衰弱伴有心脏轻度扩大。

急性型患者白细胞总数可增加。各型患者X线检查心脏普遍增大，心电图检查可有各种心律失常及心肌损害。

克山病属于祖国医学的“惊悸”、“怔忡”范畴。中医对克山病的病因病机认识、观点尚未统一：①认为克山病是一种由于“山岚瘴气”引起的痧症。②认为是由于“寒邪所伤，感受湿浊”而引起的一种“伤寒病”。③认为是由于“温燥之邪，侵犯肺胃”而引起的温病。

辨证论治

（1）急性克山病

① 寒厥。面色苍白，四肢厥冷，全身冷汗，虚烦呕吐，小便清利，大便溏薄，腹痛频繁，舌质淡嫩，脉沉迟。治宜回阳救逆。

方药：制附片15克（先熬），干姜10克，红参6克，党参30克，白术10克，砂仁6克，肉桂6克，炙甘草10克，水煎服。

② 热厥。面色紫暗，四肢不温，身热汗出，心烦喜呕，烦渴思饮，小便短少，大便干结，舌红少津，脉细数。治宜清热解毒，养阴益气。

方药：红参10克，生石膏30克，知母12克，玄参20克，丹参30克，银花30克，连翘15克，水煎服。

（2）慢性克山病

① 心肾阳虚。面色不华，神呆食少，面浮身肿，四肢不温，夜间多汗，时而喘咳，肋下痞块，脉细弱。治宜补益心肾。

方药：制附片15克（先熬），熟地20克，党参30克，山药30克，白术12克，泽泻12克，酸枣仁12克，茯苓20克，丹参30克，水煎服。

② 心气不足、痰淤阻肺。心悸、头昏、胸闷或痛、出汗或有恶心、呕吐、咳嗽、气短、甚则喘促气急，不能平卧，全身浮肿，舌质紫暗，苔厚腻，脉沉涩或结代。治宜益心通脉，化痰降气。

方药：当归20克，苏子10克，法夏10克，红参6克（嚼服），陈皮12克，肉桂6克，前胡12克，丹参30克，桃仁12克，炙甘草10克，水煎服。

③ 心脾两虚。行动后有轻度心悸、气短、头昏、出汗、倦怠、乏力、纳差、舌质淡，苔薄，脉细弱或结代。治宜补益心脾。

方药：党参30克，黄芪30克，白术15克，茯苓15克，阿胶15克，当归20克，柏子仁12克，紫石英12克，炙甘草10克，熟地20克，赤芍30克，水煎服。

（3）潜在型克山病。自觉症状不明显，但全身衰弱，心脏轻度扩大。行动后有轻度心悸，乏力，面色不华，纳差少眠，脉弱，舌淡红，苔薄。治宜养心补血。

方药：党参30克，麦冬30克，五味子15克，酸枣仁12克，白蔻10克，白术12克，茯苓15克，生牡蛎30克，珍珠母30克，水煎服。

单方验方治疗

方一：人参15克，白术15克，当归15克，川芎15克，甘草10克，茯苓20克，半夏10克，陈皮10克，黄芩30克，栀子30克，生地15克，熟地15克，研末制成15克重蜜丸，每日早晚各服2丸，连服3个月。

方二：五味子糖浆，每次服15毫升，每日服3次。

方三：败酱草片（每片相当于生药4.17克），每日口服24片，连服100天。

方四：黄芪50克，生地50克，赤芍40克，桂枝15克，水煎服。

31. 阵发性室上性心动过速

室上性心动过速是阵发性心动过速的一种，可见于基本健康的人，也可见于风湿性心脏病、冠状动脉硬化性心脏病、高血压心脏病、肺原性心脏病等患者。

阵发性心动过速可突然发作，突然中止。其诱发因素为情绪激动、突猛用力、体位突然转变或饱餐等，起始发作数年或数月一次，以后逐渐频繁，甚至一日数次。发作时伴恐惧、不安或多尿。

无器质性心脏病的人，室上性心动过速发作时心率在每分钟200次以下。有器质性心脏病者发作时心率每分钟超过200次，发作持续时间较长，血压下降甚至测不出，头晕，恶心，呕吐，心绞痛，甚至休克，急性心力衰竭甚至猝死。心电图检查可确诊。

阵发性室上性心动过速，属于祖国医学的“心悸”、“怔忡”等范畴。多由心血不足，心阳不振所致。

中药治疗

(1) 枳实针5毫升(含生药20克)加10%葡萄糖液20毫升静脉推注。

(2) 新福忒片。每次半片—1片，每日2次，口服。

(3) 参麦针20毫升加50%葡萄糖液20毫升静脉推注。每隔30分钟可重复推注一次。

针灸治疗

取穴：内关，合谷，人中。

手法：均施捻转泻法。患者取平卧位，常规消毒后，内关穴刺入1.2寸，合谷穴刺入0.8寸，持续捻转30秒钟。重病例加刺人中穴。

内关为手厥阴心包经络穴，合谷为手阳明大肠经原穴，两穴相配，具有平衡阴阳，调和气血，宁心定悸的作用。若心阳欲脱，神识朦胧，脉来数急者可加刺人中穴，以达宁心醒神之目的。

32. 心源性休克

心源性休克是心脏功能极度减退，心排血量过少，导致各重要器官和周围组织灌注不足而发生一系列代谢功能障碍的综合征，统称为心源性休克。引起心源性休克的常见原因有：

（1）心肌功能不全。有急、慢性之分。急性心肌功能不全，多见于急性心肌梗塞、感染性心肌炎（如风湿性、病毒性心肌炎等）；慢性心肌功能不全，多见于各类晚期心脏病。

（2）心脏舒张受限。如急性心包填塞、张力性气胸、心室内肿物、心瓣膜口阻塞或关闭不全、严重心律失常。

（3）心脏输出受限。急性肺心病、肺动脉栓塞、心瓣膜口狭窄等导致左心室排血量锐减，血压下降。

（4）诱因。由于血容量不足或毒素及缺血对心肌的损害等，导致心输出量减少，冠脉循环灌注量减少，发生心力衰竭，从而加重了休克。在感染性或出血性休克中，亦可诱发心源性休克。

临床表现：①休克早期，主要表现为神志清楚、烦躁、焦虑、激动、辗转不安等。②随休克加重，由兴奋转入抑制，患者表情淡漠或意识模糊，甚至昏迷，面色苍白，口唇或甲床轻度紫绀，四肢厥冷，大汗淋漓，恶心呕吐，心跳加快。若在治疗过程中，皮肤由苍白、紫绀转为发红，四肢转为温暖，大汗停止等，表示休克在好转。③脉搏细而快，常在休克早期出现，往往出现在血压下降之前。在休克晚期，脉搏可变为慢而细，亦可出现心率增快及心律不齐。④血压下降，常低于80/50毫米汞柱，甚至测不出。其脉压（收缩压和舒张压之差）常小于20毫米汞柱。⑤尿量减少。单位时间内尿量减少可说明休克的程度。如能留置导尿管观察每小时的尿量，甚至是比测血压更为可靠的指标。休克缓解的指标是尿量每小时在30毫升以上。

心源性休克属于祖国医学的“厥脱”范畴。中医认为，心源性休克多属“阳脱”之虚证。《类证治裁》说：“喘促不续，汗多亡阳，神气乱，魂魄离，即脱阳也。”关于出血性休克导致心源性休克，古人亦有描述。《景岳全书》说：“血脱者，如大崩大吐或产，血尽脱，则气亦随之而脱，……”《类证治裁》说：“吐衄暴崩，及产后血大脱，则气随之，故猝仆。”关于心源性休克尿量减少，古人亦有认识。《东医宝鉴》说：“凡汗多不止，则真阳亡脱，故谓之亡阳。其身冷……小便难……四肢拘急。”心源性休克的治疗以回阳救逆，益气固脱为主，尤用多种剂型、多种投药途径的联合治疗效果较好。

（1）人参四逆汤：是中医抢救亡阳厥逆的经典方药。近年用于治疗心源性休克疗效显著。传统用煎剂（红参15克，附子15克，甘草10克，麦冬15克，干姜10克，五味子10克）口服。

(2) 生脉散：生脉散是中医治疗气阴两虚的常用方剂。有益气敛汗，养阴生津的功效。临床上选用生脉散治疗心源性休克疗效良好。生脉散方剂：红参15克，麦冬15克，五味子10克。近年来亦有将其制成注射液用于临床，收效迅速。可用参麦注射液20—30毫升静脉注射或加10%葡萄糖液500毫升作静脉滴注。

(3) 参附针10—20毫升静脉注射，每日2—4次。

(4) 红参粉15克口服。

(5) 枳实针5—10毫升静脉注射，每日2—3次。

(6) 丹参注射液6毫升（相当于生药9克）加于15%葡萄糖液100毫升，静脉滴注。有的病例往往在加用丹参注射液后血压迅即恢复。

(7) 灸百会、神阙、关元等穴位。

33. 感染性休克

感染性休克（又称败血性休克、中毒性休克、内毒素休克等），主要由革兰氏阴性杆菌感染（败血症、化脓性腹膜炎、坏死性胆管炎等）、中毒性菌痢、中毒性肺炎、暴发性流脑、革兰氏阳性球菌败血症、流行性出血热及严重病毒感染（暴发性肝炎）等所致。其主要病理生理基础为微循环障碍。临床上主要表现为面色苍白，肢端湿冷，脉搏细弱，尿量减少，血压下降，表情淡漠，意识谵妄或昏迷等。感染性休克系危急重症，应争分夺秒积极抢救。

感染性休克属于祖国医学的“厥脱证”范畴。多由邪毒内陷所致。《温病条辨》说：“春温内陷，下痢最易厥脱……”

描述了热（邪）毒内陷有致厥脱的趋势。热毒内陷，正气受损，气血逆乱，阴阳之气不相顺接，导致正气耗脱，阴阳离决。临床上的阳气虚脱轻证，用温阳益气法治疗固然有效，但阳气虚脱，气机逆乱重症，仅予补益之法还不能使阳气运行于周身，须加行气之品，并需采用多种治则、多种剂型和多种投药途径的联合治疗。

针灸治疗

首先采用针灸治疗。针刺足三里、人中、内关、灸脐中、百会。

多种剂型、多种投药途径的联合治疗

对于感染性休克，应采用以清热解毒为主，结合养阴增液、益气、回阳、固脱、通腑、活血化瘀多种治则交叉应用。

（1）清热解毒。汤剂选用清热解毒方剂如五味消毒饮（银花30克，野菊花20克，蒲公英30克，紫花地丁30克，紫背天葵12克）合黄连解毒汤（黄连10克，黄柏10克，黄芩30克，栀子12克）每日两剂，4小时一次口服。粉剂采用人工牛黄粉1克，日服三次。大黄粉3克，日4次口服。丸剂选用安宫牛黄丸或紫雪丹1粒，日服三次。针剂可用清开灵（北京中医学院制药厂出品）40—60毫升静脉滴注。

（2）养阴增液。可用增液针（生地、麦冬、玄参）每日1000—3000毫升，静脉滴注。

（3）益气固脱。早期可用人参粉10克冲服，中期可肌肉注射人参针，每次4毫升，4—6次/日，中后期可用参麦针，每次40毫升，先行静脉推注，待血压恢复后，改为静脉点滴。

（4）回阳固脱。参附注射液每次10—20毫升静脉推

注或静脉滴注，或参附青针剂静脉滴注。

(5) 通腑与固脱并用。芒硝6克(冲)，大黄、厚朴、枳实各10克，水煎服。伴脱证者加生脉散(人参10克，麦冬10克，五味子10克)，如证见高热躁动或昏迷痉厥者加菖蒲、钩藤各10克，或配服安宫牛黄丸1粒或紫雪丹3克。大汗淋漓者可加龙骨、牡蛎各30克，附子10克，水煎，成人顿服，儿童分服。疗程10天。

感染性休克的病理特点是微循环衰竭，中医称为“热厥”，随着病情变化，可成为“脱证”或两者并存。“厥应下之”，“脱证应益气固脱”。用大承气汤(芒硝、大黄、厚朴、枳实)随证加减，患者多在24小时内大便通畅，肢端转温，紫绀减轻，血压回升，体温下降，病情好转。本方有“急下存阴”之功，是中医治疗热厥等证的传统方药。因“热厥”多是燥实壅塞肠道，腑气不通，里热伤津的结果。若能抓住这一病机，尽早地运用这一“急下大法”，多能收到“釜底抽薪”以救阴液的结果。但本方为泻下峻剂，病祛即止，不可过用。若伴脱证，必须伍用生脉散(红参10克，麦冬30克，五味子10克)。

(6) 活血化淤。对夹有淤者(舌有淤点或淤斑，或身有淤点者)加用丹参针肌肉注射，每次4毫升，日3—4次。

34. 压力性尿失禁

压力性尿失禁是一种症状，表现为：当咳嗽、喷嚏、大笑或改变体位等腹压突然增加时，尿不自主地流出。在一般

情况下，偶而有尿漏现象不能算作病态，只是症状严重者才能诊断为压力性尿失禁。常见于产伤或手术损伤以及功能障碍等情况。由于尿道膀胱颈部的螺旋状肌松弛，使尿道后壁与膀胱间的角度消失，尿道后壁与膀胱三角形成一个水平面，整个尿道呈松弛状态，又因女性尿道短而张力低，故更好发。

压力性尿失禁属于祖国医学的“遗溺”范畴。《内经》说：“膀胱不约为遗溺”。多因中气下陷，膀胱气化功能失调所致。多见于多次生育及流产的妇女。肾与膀胱互为表里，肾脏虚寒则不能制水。培本固肾，补中益气，振奋膀胱机能，是治疗压力性尿失禁的重要原则。

中药治疗

(1) 补骨脂12克，山药30克，益智仁12克，金樱子30克，五味子30克，菟丝子15克，巴戟15克，桑螵蛸30克，水煎服。

(2) 补中益气丸，每次服10克，每日服3次。

针灸治疗

1组：主穴为膀胱俞，配穴为中极。

2组：主穴为肾俞。配穴为三阴交。

3组：主穴为次髎（或上髎）、委阳。

每日一组，轮流选用。各穴留针30分钟，12天为一疗程，均用补法。针后加用艾条熏灸水道穴10分钟，并加强盆底组织锻炼，每日做缩肛运动3—4次，每次3—5分钟。

35. 直立性蛋白尿

直立性蛋白尿，指患者处于直立的体位时排出的尿液含

有蛋白，而在卧后排尿则蛋白消失。直立性蛋白尿属于体位性蛋白尿的一种。体位性蛋白尿的发生与体位改变有密切关系，其特点是：清晨尿无蛋白质，起床活动后渐出现蛋白尿。长时间直立、行走，脊柱呈前凸姿势（腹部向前突出）时，尿蛋白含量增多，平卧休息一小时后，尿蛋白含量减少或消失。患者多数为儿童，虽说预后较好，但毕竟对患儿的体质和生长发育有着不良的影响，仍应积极加以治疗。

方一：仙灵脾（淫羊藿）15克，补骨脂10克，山萸10克，黄芪15克，党参15克，升麻6克，当归10克，山药10克，白术10克，茯苓10克，水煎服。

方二：芡实15克，金樱子15克，桑螵蛸10克，枸杞15克，菟丝子15克，杜仲10克，女贞子15克，淮牛膝15克，水煎服。

36. 急性肾功能衰竭

急性肾功能衰竭是一组由各种原因所引起的症候群。它由肾中毒、肾缺血引起肾小管急性坏死，临床上以少尿、水盐代谢紊乱、氮质血症（尿毒症）为特征。急性肾功能衰竭可分肾前性（肾血流量急剧减少）、肾后性（尿路梗阻）、肾原性（肾实质损害）三种。

肾前性急性肾功能衰竭可由大出血、休克、呕吐、腹泻、烧伤、大汗、利尿剂过量、少盐性肾病、心肌衰竭、心包填塞、血管郁血等引起。肾后性急性肾功能衰竭可由尿道狭窄、膀胱颈阻塞、前列腺肥大、膀胱癌、泌尿系结石等引起。肾性急性肾功能衰竭可由肾小球肾炎、脉管炎、间质性肾炎、急性肾盂肾炎、流行性出血热、钩端螺旋体病、肾静脉

血栓形成、肾动脉闭塞、肾毒性药物、化学物、毒物过敏（如汞、镉、铊、铬，砷、铋、甲醇、乙二醇、甲苯、四氯化碳、氯仿、杀虫剂、酚、甲酚、新霉素、卡那霉素、庆大霉素、多粘菌素、粘菌素、头孢菌素、二性霉素、利福平等对肾的损害）等引起，也可由扑热息痛、保泰松、奎宁、有机磷、蛇毒、斑螫、毒蜘蛛、毒蕈等引起。严重创伤（如挤压伤、大的手术）、血型不合的输血、急性溶血性贫血、妊娠的合并症等也可引起肾性急性肾功能衰竭。

急性肾功能衰竭的临床表现

（1）少尿期

- ① 突然或缓慢发生少尿，少尿期平均持续7—14天。
- ② 少尿，每日尿量 <400 毫升或每小时 <17 毫升，甚或无尿，或每日尿量仅50—100毫升。
- ③ 出现尿毒症、代谢性酸中毒、电解质紊乱、水平衡失调，并发感染等。

（2）多尿期

- ① 缓慢或突然发生多尿，多尿期平均持续2—3周左右。
- ② 在少尿期后，一日尿量增多至400毫升以上，即为多尿期开始，以后逐渐增多，一日尿量在2500毫升以上。
- ③ 早期尿毒症的症状不减轻，甚至导致死亡。后期随尿量增多，尿毒症症状逐渐改善或消失。
- ④ 可迅速发生脱水、低血钠及低血钾症状。

（3）恢复期

尿量渐恢复正常，精神转佳，少数转为慢性肾功能衰竭。

尿常规检查、血液生化检查、肾功能及肾图检查有助于

急性肾功能衰竭的诊断。尿常规尿少,比重低,固定于1.010左右,有较多蛋白和红细胞、肾小管上皮细胞及各种管型。血液的尿素氮、非蛋白氮、肌酸、肌酐及尿酸增多,血钾增多,血钠正常或减低。

急性肾功能衰竭属于祖国医学的“癃闭”、“关格”等范畴。多系肾的气化失常,或真阴涸竭所致。中医认为:此病由:①疫毒犯肾。疫疔温病,深入营血,内攻肾脏,关门不利,小便不通;或热与血结,蕴蓄下焦,血淤水停可致小便不通。②毒物伤肾。如误食毒物,误服毒药或毒虫所伤,皆可攻伤于肾,致气化无权,小便不通。③气阴涸竭。如失血过多或剧烈吐泻,或温病耗津亡液,均可引起肾水枯耗、真阴涸竭,不能化气行水,出现小便闭而不通。《景岳全书》说:“小便不通是为癃闭,此最危最急症也。水道不通,则上犯脾胃而为胀,外侵肌肉而为肿,泛及中焦则为呕,再及上焦则为喘。数日不通,则奔迫难堪,必致危殆。”

急性肾功能衰竭的中医治疗

少尿期

(1) 辨证论治

① 热毒炽盛。小便短少、灼热、尿痛、高热、口渴、烦躁、谵语、便秘,舌红苔黄,脉洪数。治宜清热解毒。

方药:银花30克,连翘24克,生石膏30克,知母12克,茅根30克,龙胆草10克,鱼腥草30克,生大黄10克,水煎服。

② 湿热蕴结。小便灼热、短赤不爽、头胀昏沉、口苦口粘、渴不多饮、脘胁痞闷、大便秘结,苔灰白黄腻,脉滑数。治宜清利湿热。

方药:黄芩30克,滑石30克,茯苓皮15克,大腹皮12克,白蔻仁10克,通草10克,苡仁30克,猪苓30克,竹叶12克,生大

黄10克，水煎服。

③ 血淤水停。小便短涩、尿涩尿痛、鼻衄、咯血、便血、皮肤紫斑、身热夜甚、躁扰发狂，舌暗红，脉沉涩。治宜行淤散结。

方药：桃仁10克，红花10克，当归30克，赤芍30克，熟地15克，川芎12克，益母草30克，丹皮15克，生大黄10克，水煎服。

④ 气阴衰竭。尿少而闭、尿液清白、面色晦滞、气息欲绝、精神疲惫、汗出粘冷、四肢不温，舌淡苔白，脉细微弱。治宜益气养阴固脱。

方药：红参12克（另炖），麦冬30克，五味子15克，黄精30克，玉竹15克，生地30克，黄芪30克，甘草6克，水煎服。

（2）通里导泻疗法

急性肾功能衰竭少尿期尿少、尿闭每与大便秘结并见。根据中医治疗癃闭理论“二便不通，先通大便”，“通大便而利小便”和“六腑以通为用”的原则，采用通里导泻法治疗，疗效较好。通里导泻法具有泻热、祛邪、逐水、排毒等作用。大多数病人都有不同程度的利尿反应。由于水分和毒素的排出，对缓解高血容量综合征，解除或减轻肺水肿，脑水肿，降低血钾与尿素氮，减轻肾周围水肿，改善肾血流均有积极意义。

方一：番泻叶30克，开水冲泡代茶饮。

方二：生大黄30克，水煎服，芒硝12克，开水冲服。

方三：生大黄30克，牡蛎60克，浓煎150毫升，作保留灌肠，每日1—2次。

方四：桃仁10克，生大黄10克，芒硝10克（冲），葶苈子12克，大枣30克，瓜蒌15克，桔梗12克，川贝10克，水煎服（此方适用

于急性肾功能衰竭并发肺水肿)。

(3) 活血化淤疗法

淤血不但是造成创伤后急性肾功能衰竭的主要原因，而且血淤于肾与膀胱，是引起少尿无尿的重要机理之一。应用活血化淤药物，可获活血祛淤，通利脉络的功效，借以疏通肾与膀胱等脏腑脉络壅结的淤热，促使淤毒排除，改善因淤致毒的病变，达到利尿止血的目的。活血化淤疗法有改善微循环，抗细胞缺氧，阻止血小板凝聚，增强网状内皮系统功能，有利于改善肾缺血，清除内毒素。

方一：川芎嗪针，每次40—120毫克，加入10%葡萄糖液作静脉滴注。

方二：复方丹参针，每次8—16毫升，加入10%葡萄糖液作静脉滴注。

方三：丹参30克，桃仁10克，红花10克，赤芍30克，鸡血藤30克，木瓜30克，车前草30克，桑枝15克，泽泻30克，茯苓15克，猪苓30克，益母草30克，水煎服。

方四：赤芍30克，黄芪30克，水蛭8克，三棱10克，莪术10克，党参30克，川芎12克，桃仁12克，益母草30克，仙茅10克，甘草6克，水煎服。

(4) 多种治则的综合疗法

急性肾功能衰竭少尿期病情错综复杂，如能针对多个病理环节进行治疗，可望提高疗效。主要是将通里攻下，活血化淤，清热解毒，利尿除湿，养阴增液等治疗原则以不同的方式有机配合，充分发挥中药复方通腑去浊、消淤止血、养阴扶正、排泄水湿、中和毒素等综合作用，消除机体一切不利因子，增强抗病能力。

方一：大黄10克，厚朴10克，枳壳10克，莱菔子10克。煎汤

顿服。赤芍12克，紫草12克，丹皮10克，丹参30克，川芎10克，当归30克，益母草15克，玄参12克，麦冬30克，生地30克，白茅根30克，连翘15克，蒲公英15克，煎汤频饮。

方二：大黄12克。芒硝12克（冲），枳实10克，生地30克，麦冬30克，白茅根30克，桃仁10克，牛膝30克，水煎服。

加减：水邪犯肺加葶苈子。淤热壅盛加水牛角、赤芍、丹皮。津伤明显加玄参。小便赤少不畅加阿胶、猪苓、泽泻、车前草。

方三：生大黄30克，黄芪60克，丹参15克，红花10克，浓煎200毫升，作保留灌肠，每日1—2次。

方四：生地20克，麦冬20克，玄参15克，生大黄10克，栀子10克，丹参20克，白茅根30克，桃仁10克，芒硝10克，浓煎200毫升，作保留灌肠，每日1—2次。

注：灌肠疗法用于急性肾功能衰竭，效果好，方便安全。

多尿期

（1）辨证论治

① 湿热内困。小便频数，尿液较浊，纳呆食少，恶心腹胀，头昏心烦，下肢无力，苔黄腻，脉滑数。治宜清热燥湿，降逆和胃。

方药：黄连10克，法半夏12克，橘红12克，枳壳10克，炙甘草12克，竹茹12克，茯苓12克。水煎服。

② 肾气不固。小便清白，尿量增多，倦怠腰酸，口渴多饮，头晕耳鸣，手足心热，心烦少寐，舌红少苔，脉细数，治宜补肾固摄。

方药：熟地30克，丹皮10克，山药30克，茯苓12克，泽泻12克，山萸肉15克，益智仁12克，台乌12克，芡实30克，水

煎服。

(2) 针刺疗法

体针：取穴肾俞、大椎、三阴交、关元、气海透中极、足三里。

耳针：取穴肾、膀胱、三焦、内分泌。

综上所述，急性肾功能衰竭由多种原因引起，积极治疗原发病证，可以减少或避免急性肾功能衰竭的发生。特别是流行性出血热的治疗，在卫应兼清气，在气应先顾血，早投清营解毒凉血之剂，使邪不内传，或虽有内传亦有所制约。发热期就有轻度微循环障碍，应适当伍用活血化瘀之品。低血压期应注意通利小便，尿仍不通，应加大黄、芒硝通大便以利小便，以防止急性肾功能衰竭。

重视祛邪和综合治疗，可提高急性肾功能衰竭的疗效。这是因为急性肾功能衰竭少尿期多以邪实为主要矛盾，就是正虚较明显者，也因邪气伤正所致，故祛邪即所以扶正，釜底抽薪即所以养阴增液。此外，在某些方剂中，配伍养阴益气之品，也寓有祛邪之意，如增水行舟，益气利尿等。正如《中医急症大成》所指出的，在祛邪治疗中，即要注意复方组成后各药多种作用的复合效果，产生协同增效，拮抗毒副作用，又要注意发挥中医多种治疗方法的综合效应。大黄及其复方制剂在祛邪治疗中占有重要地位，因其具有下热结、下水毒，下瘀血等作用，是治疗急性肾功能衰竭的重要药物。

37. 慢性肾功能衰竭

慢性肾功能衰竭多见于多种慢性肾脏病的晚期，是因

肾脏排泄和调节功能障碍，导致体内氮质及其他代谢产物潴留，水电解质紊乱，酸硷失去平衡而自身中毒的一种综合征。

临床表现

尿毒症前期：仅有氮质血症的一般症状及原发疾病症状。

尿毒症期：

一般症状：面色苍白、萎黄而且灰暗、眼睑肿胀、乏力、消瘦、营养不良、皮肤干燥、瘙痒、色素沉着。

消化系统症状：厌食、恶心、呕吐、顽固性腹泻、呕血、便血、口中有尿臭味、口腔粘膜溃疡。

血液系统症状：严重贫血、晚期有出血症状。

心血管系统症状：高血压、心力衰竭、心律紊乱、严重者可有心脏摩擦音。

呼吸系统症状：呼气有尿味、胸腔积液、间质性肺炎、胸膜炎。

精神神经系统症状：头痛、失眠、记忆力减退、注意力不集中、性情改变，以后逐渐发生嗜睡、幻觉、谵妄、惊厥、最后昏迷。肌肉萎缩，感觉异常。

水、电解质紊乱及酸硷失衡：常有失水、少尿、水肿、低血钾或高血钾、低血钠、高血磷、低血钙、高血镁及代谢性酸中毒表现。

尿液检查、血液检查、肾功能检查有助于慢性肾功能衰竭的诊断。尿液比重固定在1.010左右，蛋白多少不定，或有红细胞、白细胞及管型。血液检查红血球、血色素降低，血非蛋白氮、尿素氮、肌酐、肌酸增高，胆固醇降低，二氧化碳结合力降低。肾功能检查出现肾小球清除率，肾小管酚

红排泄功能及浓缩稀释功能减退。肾图呈现无功能肾的图像。

慢性肾功能衰竭属于祖国医学的“关格”、“肾绝”、“癃闭”、“水肿”、“虚损”等范畴。《伤寒论叙例》说：“关则不得小便，格则吐逆”。《证治汇补》说：“既关且格，必小便不通，旦夕之间，陡增呕恶。此因浊邪壅塞三焦，正气不得升降，所以关应下而小便秘，格应上而生呕吐，阴阳闭绝，最为危候”。祖国医学认为肾司二便，肾系疾患久久不愈，肾阳衰败，气化无权，肾关开合不利，不能泌清泄浊，致使浊阴内滞，浊阴难从下窍而出，尿素氮，肌酐等代谢产物滞留体内，浊阴不泄，或上犯脾胃，或蒙蔽心窍，或惹动肝风，或入营动血，或水气凌心犯肺，从而显出种种危急病象。

中医药治疗慢性肾功能衰竭有较好疗效。

辨证分型治疗

(1) 尿毒症前期

① 以正虚为主。面色萎黄，轻度浮肿，头晕，腰酸乏力，舌质淡红，苔薄，脉弦细或缓。治宜益肾健脾，祛瘀化浊。

方药：鹿含草30克，淮牛膝30克，苡仁30克，党参30克，白术15克，黄芪30克，益母草30克，丹参30克，生大黄10克，水煎服。

② 以邪实为主。纳呆，恶心，呕吐，头晕痛，乏力，小便短少，大便干燥，舌质淡暗苔薄黄，脉细或弦。治宜清解通腑，祛瘀化浊。

方药：黄连10克，法半夏12克，陈皮12克，生大黄10克，半枝莲30克，丹皮12克，白茅根30克，水煎服。

(2) 尿毒症期

① 血热妄行。齿衄，鼻衄，皮肤紫斑，尿少，舌红绛，脉滑数。治宜凉血止血。

方药：水牛角30克，丹皮12克，白芍30克，白茅根30克，生地30克，旱连草30克，小蓟15克，水煎服。

② 痰浊蒙心。神志乍清乍糊，嗜睡或渐转昏迷，谵语，烦躁不安，头晕，恶心，舌淡苔白腻，脉滑数。治宜化浊开窍。

方药：菖蒲12克，郁金20克，山栀子12克，菊花12克，竹叶12克，丹皮12克，胆南星12克，川贝母10克，茯苓15克，水煎，送服安宫牛黄丸一粒。

③ 肝风内动。手指颤抖，手足抽搐，嗜睡或神志不清，头晕头痛，舌红少苔，脉细弦数。治宜镇肝熄风。

方药：白芍30克，天冬15克，麦冬30克，淮牛膝30克，代赭石30克，玄参30克，龟版30克，青蒿12克，生龙骨30克，生牡蛎30克，水煎服。另服紫雪丹3克。

④ 水凌心肺。喘促痰鸣，不能平卧，心悸怔忡，肢肿尿少，大汗淋漓，舌淡苔腻，脉细数。治宜宁心泻肺，化气利水。

方药：北五加皮12克，葶苈子12克，附片10克（先熬），党参30克，麦冬30克，泽泻15克，桂枝12克，黄芪30克，茯苓30克，人参叶30克，水煎服。

以大黄为主的通腑祛邪治疗

以大黄为主的祛除湿浊水毒是治疗慢性肾功能衰竭的重要方法，主要应用方式有口服和保留灌肠两种。

① 大黄粉，每次3克，每日3次，吞服。

② 生大黄10克，黑大豆30克，生甘草3克，水煎服。

③ 大黄15克，芒硝10克，茯苓15克，泽泻15克，陈皮12克，

黄芪30克，党参30克，焦三仙各15克，甘草6克，水煎服。

④ 生大黄15克，生牡蛎60克，制附片30克，浓煎成150毫升，保留灌肠，每日1—2次。

⑤ 生大黄15克，蒲公英30克，煅牡蛎30克，煎水600毫升，保留灌肠（20分钟），每日1次。个别病重者每日2次，以病人日泻3—4次为宜。

以大黄为主的中药保留灌肠可按辨证配用不同药物，如银花、槐花、黄芩、白头翁、益母草、山栀等。

以大黄为主的祛邪治疗能增加肠道氮质清除值，降低非蛋白氮，缓解氮质血症症状。在具体应用时应根据病情、体质、血压高低、电解质情况和排便次数等，掌握好配伍剂量和间隔时间，注意电解质平衡，切忌操之过急。同时，在使用过程中，可酌情配用调理脾胃之品。血氮降低后应注意补脾益肾，活血养血等治疗，以期改善肾功能。

活血化淤治疗

（1）当归30克，川芎12克，丹参30克，桃仁10克，红花10克，玄参15克，猪苓30克，黄芪30克，山楂15克，大青叶30克，银花藤30克，水煎服。

（2）丹参注射液，每次8—16毫升，加入10%葡萄糖液作静脉滴注。

动物实验证明，活血化淤方药有改善肾血流，增强肾小管排泄，增加纤维蛋白的溶解性，减少血小板凝聚，抗凝血等作用，有利于增生性病变的转化和吸收，促进已损组织的修复。活血化淤药与清热解毒药合用，可以抑制肾小球萎缩和纤维组织增生，促进废用的肾单位逆转。

以扶正为主的治疗

（1）冬虫夏草6克，研粉冲服，此为一日量，并配合

服用辨证论治方药。

(2) 红参10克,淫羊藿30克,枸杞15克,白术15克,山药30克,补骨脂12克,黄芪30克,泽泻15克,茯苓30克,大黄10克,甘草6克,水煎服。

临床经验表明,补益脾肾方药对改善整体状况、平衡阴阳、调节机体免疫功能、改善肾功能都有一定疗效。调节慢性肾功能衰竭病人的内环境平衡是重要的治疗措施。《上海中医药杂志》1984年第二期报道,用冬虫夏草治疗慢性肾功能衰竭的过程中发现,部分患者细胞免疫功能提高,肾功能改善,血色素升高;也有病人尿素氮下降而肌酐并未明显下降,患者病情却明显好转,由不能进食到顺利进食,由不能起床到下床,可以维持正常生活相当长的一个时期。提示慢性肾功能衰竭病人的内环境不平衡情况得到某种程度的改善,从而使患者健康状况有所好转。

最后,必须强调,由于慢性肾功能衰竭多见于多种慢性肾脏病的晚期,因此,加强对原发病(如慢性肾炎等)的防治,注意早期维护和恢复肾功能很有必要。对慢性肾炎患者来说,重视肾功能衰竭前的治疗,把维护肾小球功能作为治疗的主要环节,比消除水肿、减少尿蛋白的治疗更有现实意义。这一论点,非常重要。

38. 急性前列腺炎

前列腺炎分为急性和慢性。在本书第二集的51页,已经详细的介绍了慢性前列腺炎,本篇专门谈急性前列腺炎。临证时宜前后呼应,互相参照,以概其全貌。

急性前列腺炎是男性生殖系统的炎症之一，它分为淋菌性和非特异性两种。根据病史和细菌学检查可对这两种不同的类别进行鉴别。它们的临床表现大致都很相似，主要症状是高热、寒战、尿频、尿急、尿痛、尿道滴白、排尿困难、性功能障碍。查体时，直肠指诊发现前列腺肿胀、压痛明显。实验室检查发现尿内有白血球，前列腺液充满脓液。如果本病治疗不及时，或治疗不当，除了转为慢性前列腺炎外，还蔓延而引起精囊炎、附睾炎。

中医没有急性前列腺炎这个病名，而是称为“淋浊”、“精浊”、“肾虚”。《诸病源候论·小便诸候》说：“小便不通，由膀胱与肾俱有湿热故也”。急性前列腺炎属实，主要是湿热、淤阻血滞所致。若迁延日久，变成慢性前列腺炎；而慢性前列腺炎又极易复发，与急性前列腺炎的表现无异。慢性前列腺炎的急性发作，多为虚中夹实，常为淤血郁久化热。本病的病位在下焦，具体指肾、膀胱。

急性前列腺炎的治疗，按下列三种情况辨证选方。

（1）肝经湿热型。证见少腹、睾丸、精索胀痛，尿频，尿急，尿痛，解小便时有不适感，尿道口流白浊，或见血尿，口渴，喜热饮。舌苔黄腻，脉滑数。本型多见于青年男子，是首次发病。

治宜清热利湿，解毒通淋。

方一：柴胡^{25克}，黄芩^{20克}，龙胆草^{15克}，土茯苓^{30克}，焦山栀^{15克}，大黄^{10克}（后下），篇蓄^{15克}，川牛膝^{12克}，木通^{12克}，甘草梢^{10克}，水煎服。

方二：车前子^{60克}（布包入煎），白茅根^{60克}，海金沙^{30克}（布包入煎），琥珀粉^{3克}（兑服），水煎服。

(2) 淤血阻滞型。证见血尿、血精、阴部胀痛，腰膝酸胀。舌有紫色，或有淤点，苔白，脉弦紧。本型多为患前列腺肥大症后，继发前列腺炎，或为慢性前列腺炎急性发作，以老年人多见。

治宜活血化淤，通闭解结。

方一：柴胡20克，龙胆草12克，萆薢15克，银花藤30克，泽兰12克，赤芍12克，丹参20克，王不留行12克，败酱草30克，茅根30克，车前草30克，水煎服。

方二：丹参15克，赤芍15克，栀子12克，白头翁20克，连翘20克，野菊花20克，紫花地丁30克，车前草30克，蒲公英30克，水煎服。

上述两种类型除了辨证治疗外，均宜随证加减。现将通用的一些法则整理如下，以备选用。

湿热甚者加知母12克，黄柏12克，蒲公英30克，紫花地丁30克，银花藤30克；排尿不通畅者加琥珀8克（吞服），冬葵子12克，葶草30克，地龙10克；尿道灼热者加竹叶12克，木通15克；血尿者加茅根30克，瞿麦12克；血精者加槐花15克，知母10克，黄柏10克，生地15克；尿浊者加上茯苓30克，萆薢15克；阴部潮湿、多汗者加苍术12克，黄柏12克，苡仁30克；尿痛者加滑石30克，甘草梢10克，黄柏10克，凤尾草30克；前列腺肿硬或有结节者加炒甲珠12克，三棱10克，莪术10克，三七粉8克（冲服），桃仁12克，赤芍12克。

(3) 恢复期。症状消除一周后，宜补肾强身，清化余热。

方药：生地15克，丹皮10克，茯苓15克，泽泻15克，枣皮12克，淮山15克，茅根30克，水煎服。亦可改服六味地黄丸，或知柏地黄丸。

外治能辅佐内治，增强药力，促进湿热化解，特介绍外用坐浴方一个。

方药：黄柏20克，黄连须30克，枯矾20克，丹参30克，野菊花50克，煎水500毫升，冷至42℃左右，即可坐浴。

患急性前列腺炎之后，除了服药治疗外，还应注意调护，以利康复和巩固。调护的要点是：

- ① 禁酒。
- ② 忌食辛辣。
- ③ 不手淫。
- ④ 不骑自行车、马。
- ⑤ 合理的性生活。
- ⑥ 保持大便通畅。

39. 输尿管、膀胱结石

输尿管和膀胱结石，其特征是肾绞痛（肾结石移动时，病人常有阵发性的剧烈疼痛和放射痛。疼痛先在腰部，然后沿输尿管向膀胱、外生殖器、大腿内侧等处放射，称为肾绞痛。绞痛时病人坐立不安，痛如刀绞或如锥刺，冷汗淋漓，面色苍白，恶心呕吐，每次发作几分钟到几小时不等，当结石停止移动或进入膀胱后，疼痛突然消失），血尿（肉眼血尿或显微镜血尿），X线照片可见输尿管结石阴影。

现代医学认为，泌尿系结石的病因与下列因素有关：

（1）地理环境因素。调查表明，国内尿石发病率以黑龙江省为最低（仅占2.5%），贵州省最高达59%。世界上英国、荷兰、泰国的乌汶，印度东北部等都是尿石的高发区。

说明地理环境对泌尿系结石的形成具有重要意义。可能这些地区水土中某些元素过于饱和或含量不足。

(2) 饮食营养因素。泰国乌汶是著名的尿石区,其农村发病率又比城镇高14倍,调查发现农村食物钙和磷的含量比城镇高,而维生素A、C仅为城镇的三分之一。意大利西西里岛在二次世界大战时膀胱结石突然增多,明显与战时缺乏蛋白质有关。

(3) 激素因素。泌尿系结石的发病率男性明显高于女性。动物实验证实,将异物植入大白鼠的膀胱,切除卵巢者尿石的发病率显著高于未切除者,若再注入雄激素,则结石的数量和体积都增大。据此认为雌激素能抑制泌尿系结石(简称尿石)的生成,雄激素能促进尿石的生成。

(4) 炎症因素。反复感染导致尿流不畅,以致尿中有形成份留滞而成尿石。

(5) 其他因素。坐办公室的人比体力劳动者尿石发病率高。

输尿管、膀胱结石属于祖国医学的“砂淋”、“石淋”、“血淋”范畴。中医认为石淋、砂淋、血淋的成因不外乎膀胱有热,肾虚,三焦气化淤滞,劳累过度等。《金匱要略》云:“热在下焦则尿血,亦令淋泌不通”。《中藏经》指出:“石淋者,此由肾气虚弱……虚伤真气,邪热渐强,结聚而成砂”。《脉因证治》云:“膀胱有热则淋。然赤涩淋涩如脂膏,如砂石,皆内热也,如水煎盐而成也”。《诸病源候论》指出:“石淋者,淋而出石也。肾主水,水结则化为石,故肾客砂石,肾虚为热所乘,热则成淋”。《丹溪心法》说:“诸淋所发,皆肾虚而膀胱生热也”。《医学衷中参西录》云:“石淋之证,因三焦气化淤滞,或因劳心、劳

力过度，或房劳过度，膀胱暗生内热，内热与淤滞煎熬，久而结成砂石，杜塞溺道，疼楚异常”。

中医治疗输尿管、膀胱结石，积累了丰富的经验。兹将辨证分型治疗介绍如下：

（1）湿热型。多见于肾及输尿管结石并发感染患者，腰痛如绞，并牵引少腹至会阴，尿痛，尿黄带血，舌苔黄腻。属湿热蕴结下焦，治宜清热利湿，通淋排石。

方药：木通10克，车前子15克，篇蓄15克，瞿麦15克，石苇30克，生大黄15克，黄柏12克，冬葵子30克，淡竹叶12克，金钱草30克，水煎服。

（2）淤滞型。结石直径往往较大，且表面欠光滑，下移时易损伤脉络，常有腰胀腹痛，掣引会阴，尿赤如血，镜检时有多量红细胞，尿频，尿急，尿痛多不明显，结石较难排出。属气滞血淤，络脉受阻，结石留滞之症。治宜行气化淤通石。

方药：小蓟15克，蒲黄炭12克，滑石30克，五灵脂12克，川芎15克，赤芍30克，生甘草6克，金钱草30克，海金砂12克，冬葵子30克，沉香6克，醋柴胡12克，炮山甲15克，水煎服。

（3）脾虚型。结石内停日久，体质虚弱，腰腹酸痛，纳少乏力，尿短、尿频不爽，尿检可有少量红细胞。此属脾气虚弱。治宜益气健脾化石。

方药：黄芪30克，党参30克，内金15克，白术12克，茯苓20克，醋柴胡15克，升麻10克，当归12克，赤芍30克，生甘草6克，金钱草30克，炮山甲15克，王不留行30克，冬葵子30克，水煎服。

（4）肾虚型。多见于中年以上的患者，证见病程长，身体虚弱，且结石较多较大，常有腰腹坠胀不适，排尿无力，性功能衰退，尿检有红细胞。此属病久肾阳虚弱，肾气开阖

失度所致。治宜温肾益气，壮阳溶石。

方药：熟地20克，山药30克，山萸12克，杜仲15克，续断30克，骨碎补10克，金钱草30克，川牛膝30克，肉桂6克，仙灵脾30克，仙茅10克，石苇30克，海金砂12克，核桃仁30克（生服），木香10克，水煎服。

加减：热重加白茅根30克，生大黄10克；疼痛明显加白芍30克，元胡10克；淤血明显加泽兰12克，丹参30克；气虚明显加党参30克，黄芪30克。阳虚加附片、肉桂。阴虚加生地30克，鳖甲30克。

近年来，各地用小茴香总攻疗法和排石汤总攻疗法治疗输尿管、膀胱结石时都取得了良好的排石效果。兹分别介绍如下：

疗法一：小茴香总攻疗法。首先检查患者心脏、肾脏、肝脏均正常，然后进行治疗。

上午7 30分，口服小茴香水 500 毫升（小茴香 10—50 克加水熬成 500 毫升）。

上午7 点30分，又口服小茴香水 500 毫升。

上午8 点钟，又口服小茴香水 500 毫升。

上午8 点20 分，又口服小茴香水 500 毫升。

上午9 点钟至9 点30 分，电针。穴位：肾及输尿管上、中段结石者针刺患侧肾俞、膀胱俞、阿是穴，配同侧足三里。输尿管下段结石者取患侧阿是穴、关元、足三里。电针流量 4.5—5.0 mA，频率 2.5。

上午10 点钟至10 点20 分，运动，跳跃，跑步半小时。

每天总攻一次，每周3—4 次为一疗程，总攻2—3 周休息1 周，间歇期服小茴香水。总攻疗法是冲、松、攻相结合，

实行定期总攻治疗。

疗法二：排石汤总攻疗法。

遵义排石汤方随证加减。气滞型用Ⅰ号方（金钱草30—60克，海金沙20—30克，车前子24克，滑石15克，白芍30克，乌药10克，川楝子10克，木通10克，内金10克，甘草8克），水煎服。湿热型用Ⅱ号方（金钱草45克，石苇30克，篇蓄24克，车前子24克，大黄15克，滑石15克，甘草梢15克，栀子15克，瞿麦15克，木通10克，枳实10克），阴虚去大黄加生地15克、麦冬10克；内热加黄芩10克，知母10克，水煎服。

上午7点钟，口服排石汤500毫升。

上午7点20分，又口服排石汤500毫升。

上午8点钟，阿托品0.5毫克肌肉注射。

上午8点30分，饮水500毫升。

上午9点钟，口服双氢克尿噻50毫克。

上午9点30分，口服排石汤200毫升。

上午10点—10点30分，电针。（穴位同小茴香总攻疗法）。

上午10点30分至11点钟，运动，跳跃跑步30分钟。

以上两种总攻疗法，均有良好的排石效果。据重庆市中区研究所外科报道，采用小茴香水总攻疗法，排尿高峰及排尿量大于排石汤组，患者服用小茴香水较服用排石汤多排尿量42%，排尿高峰提前半小时，并向后持续延长30分钟，配合电针治疗，使排尿高峰之后发生较为明显的输尿管蠕动，增强和松弛扩张交替出现，促使结石下移，同时大量尿液冲刷肾或输尿管，加速了结石下行至膀胱经尿道排出体外，多数病人在20—30天内排出结石。

科学研究证明，小茴香能解痉，使输尿管平滑肌松弛，

并有理气止痛作用。此种治疗方法简便，疗效确切，容易掌握，有推广使用价值。

积极预防输尿管、膀胱结石，日常应多饮水，多运动，多跳跃，补充蛋白质及维生素A、C，得了泌尿道感染，应及时而彻底地治疗。

40. 三叉神经痛

三叉神经由感觉与运动纤维混合组成。它从颅内半月神经节至面部发出三大支：1.眼神经：分支分布在眼球、泪腺、结合膜等。2.上颌神经：分支分布至上颌牙齿和牙龈、上颌窦、鼻腔粘膜、下睑、上唇等。3.下颌神经：分支分布在咀嚼肌，下颌牙齿、牙龈、下唇等。三叉神经痛是在该神经分布区内反复发作的阵发性短暂剧烈疼痛，患者在疼痛发作时有特殊极度痛苦的表情，有痛不欲生的悲观呼救。因此，应及时采取治疗措施，解除患者的痛苦。

在《百病良方》第一集“头痛”一文中，曾对三叉神经痛作了附带的介绍。因三叉神经痛是一个独立的疾病，故在此作专文叙述。

三叉神经痛有原发性和继发性两种。继发性原因有三叉神经根处的肿瘤、血管畸形，小的脑膜瘤等所引起。原发性三叉神经痛的病因和病机则尚未完全了解。

三叉神经痛的临床表现

本病多发生在40岁以上女性，儿童及青年也有。多为单侧发病，双侧者很少见。但也不是同时发病，往往从一侧

先发。通常自第一侧上颌神经（第二支）或下颌神经（第三支）开始，由眼神经（第一支）起病者很少见。疼痛以第二支最常见，第三支次之，第一支最少见。亦有两支同时发病的，以第二支，第三支合并疼痛为最常见。

三叉神经痛主要的症状是剧烈疼痛，多无全身症状。若属原发性三叉神经痛患者，临床上X线、实验室、活体组织检查都不易找到病变。三叉神经痛具有下列特点。

（1）疼痛发作常无预兆，严格限于三叉神经感觉支配区内，为骤然发生的闪电样、剧烈、短暂的疼痛，每次发作持续数秒钟至数分钟即骤然停止，间歇期无任何疼痛，一切如常。经一段时间突然又再次发作。初期发作的次数较少，以后发作增多，严重者每分钟发作数次，一般夜间发作较轻或不发作。发作也可呈周期性，每次持续数周至数月，以后常可自行缓解数月至数年，未经治疗很少有自愈者。

（2）疼痛性质也多种多样，有如刀割样、电击样、针刺样、火灼样或撕裂样的剧烈疼痛。往往经治疗后多数病例可变为不典型的疼痛。

（3）引起三叉神经痛有各种诱因，某些诱因又因人而异，大多数情况下活动时易发作。常见于刷牙，洗脸，谈话，张嘴，或声、光刺激即可发作。打喷嚏，笑，舌头活动，转头，进食，饮水，皮肤触摸，甚至微风拂面皆可诱发疼痛。可因触及面部的某一点引起疼痛发作，如上下唇、鼻翼外侧，舌侧等这些部位称之为发痛点或扳机点。于发作终结时诱发区兴奋性减低或消失，患者常利用此时机而进食、洗脸、谈话等。

（4）由于疼痛剧烈难忍，发作时患者采取各种试图减缓痛苦的动作，如以手掌或毛巾紧按病侧面部或用力擦面部，

以期减轻疼痛。有的在发作时不断作咀嚼动作。发作严重者伴有同侧面部肌肉的反射性抽搐，口角牵向一侧，并有面部潮红，眼结膜充血，流泪或流涎等，所以又称“痛性抽搐”。

三叉神经痛属于祖国医学的“头风”、“面痛”等范畴。《医学精要》说：“头风即头痛也，浅而近者为头痛，解散之即安，深而远者为头风，作止无常，屡触屡发也”。中医认为头风多系风寒、风热、胃火、肝火、痰浊、血瘀为患，壅闭面部经络所致。并认为“初病在气，久病在血”、“久痛入络，不通则痛”、“内有伏邪，因加而发”。本病缠绵难愈之关键在于络有宿瘀。瘀阻少阳、阳明经络，气血失和，内风时时循经上扰而发。中医还认为，头面部乃阳气之会，足三阳经筋结合于颊（面颊部），手三阳经筋则会于角（侧头角）。面部脉络为邪气所阻，不通则痛，故三叉神经痛以半侧面部疼痛最为常见，且时发时止。

辨证分型治疗

（1）风热型。其痛如灼或胀痛，遇风得热则痛甚，或昼轻夜剧，口干喜冷，便干溲黄，舌尖红苔薄黄，脉浮数或弦滑。治宜疏风泄热。

方药：川芎15克，蔓荆子12克，生石膏30克，白芷12克，胆南星12克，青黛10克，蝉蜕6克，姜黄12克，水煎服。

（2）风寒型。每因冷天或感风寒加重。痛时头冒冷气，四肢末厥冷或凉麻，面侧呈阵发性刀割样疼痛，面肌有紧缩感，苔薄白或白滑，脉浮紧或沉迟。治宜祛风散寒。

方药：制川乌15—30克（先熬），川芎15克，白芷12克，细辛6克，草薢10克，藁本10克，甘草10克，羌活10克，牛蒡子20克，当归30克，水煎服。

方药：生大黄10克（后下），黄连10克，栀子12克，生石膏30克，知母12克，甘草10克，川芎15克，柴胡12克，牛蒡子20克，生地30克，麦冬15克，水煎服。

(4) 胃热阴虚型。面剧痛如刀割锥刺，颊红灼热，牙龈肿痛，嚼食困难，口臭流涎，寝难安枕，舌红苔黄脉细数。治宜清胃滋阴。

方药：生地60克，生石膏30克，川芎15克，麦冬30克，知母12克，川牛膝30克，白芷12克，细辛6克，当归30克，水煎服。

方药：龙胆草_{12克}，柴胡_{20克}，木通_{10克}，泽泻_{30克}，栀子_{10克}，黄芩_{15克}，川芎_{15克}，白芷_{12克}，牛蒡子_{20克}，当归_{30克}，细辛_{6克}，生地_{30克}，石决明_{30克}，水煎服。

方药：川芎_{15克}，党参_{30克}，白术_{12克}，白芷_{12克}，法半夏_{12克}，蜈蚣_{2条}，牛蒡子_{20克}，玄胡_{12克}，细辛_{6克}，~~白芍30克~~，黄芪_{30克}，甘草_{10克}，水煎服。

(7) 久痛入络型：病程较长，痛如锥刺刀割，~~指时锁眉~~，~~在~~ 呃嘴，以手揉搓面部，舌边有淤点，脉弦。~~治宜活血祛瘀。~~

方药：桃仁12克，红花10克，蜈蚣2条，当归30克，细辛6克，川芎15克，白芷12克，姜黄15克，全蝎6克，牛蒡子20克，地龙12克，玄胡10克，水煎服。

专方专药治疗

方一：葛根30克，川芎15克，白芷12克，蔓荆子15克，当归30克，细辛6克，牛蒡子20克，羌活12克，柴胡15克，菊花30克，僵蚕10克，玄胡10克，水煎服。

方二：守宫（壁虎），文火炕干，研成细末，干燥消毒，分装密封备用，每次服3克，一天3次，开水吞服，连服15天为一疗程。

方三：七叶莲片，每次3片，每片相当于生药5克，每天4次，或用针剂每次4毫升，每天2—3次，肌肉注射。

方四：鸡矢藤针，每支2毫升，相当于生药10克，每次肌注2—4毫升，每日2—4次。

方五：赤芍30克，柴胡20克，桔梗10克，川牛膝30克，桃仁10克，红花10克，僵蚕10克，全蝎6克，蜈蚣2条，当归30克，川芎15克，白蒺藜12克，钩藤30克，蔓荆子12克，水煎服。

针灸疗法

（1）体针：第一支痛取攒竹、鱼腰、阳白、太阳；第二支痛取颧髎、迎香、四白。第三支痛取下关、颊车、大迎、地仓。

（2）耳针：取穴神门、皮质下、交感等。

41. 老年性痴呆

老年性痴呆，又称阿尔茨海默氏病，是一种综合征。

65岁以后发病，起病虽缓慢，但病变却在悄悄地不停地进行，表现为智力机能低下，动作不灵活，记忆力明显减退，进入医学上所谓的“遗忘期”（老年性痴呆的第一阶段）。遇事多遗忘，常常借助于笔记，刚刚办完的事就忘得一干二净，继则出现注意力不能集中，定向力大受影响，词汇变得非常贫乏，难以想起恰当的用语（原先不是这样），进入医学上所谓的“混乱期”（老年性痴呆的第二阶段）。出现严重的定向障碍，分不清夫妻和父母，出现明显的焦虑，不知道自己下一步该做什么。妄想、幻觉日趋明显。气脑造影可见脑室扩大。

目前认为，引起老年性痴呆的原因很多，其中很主要的一条是由于动脉硬化引起大脑皮层的萎缩。中医认为，“肾主骨，生髓，通于脑”。中医还主张“补肾荣脑”，“补肾即补脑”。因此，用补肾活血方药治疗老年性痴呆具有一定的潜在优势。

方一：仙灵脾（淫羊藿）30克，仙茅10克，枸杞15—30克，熟地30克，黄精30克，首乌15克，当归15克，苁蓉15克，丹参30克，葛根30克，水煎服或制成蜜丸常服。

方二：菟丝子30克，复盆子12克，五味子15克，枸杞15克，葫芦巴10克，补骨脂12克，山药30克，赤芍30克，川芎10克，水煎服或制成蜜丸常服。

老年性痴呆重在预防。方法如下：

（1）生活有规律，早起早睡，不可长夜看电视，定时进食，定时解便，合理安排活动和休息。

（2）在饮食营养方面，力求做到三定、三高、三低和两戒。三定即定时、定量、定质；三高即高蛋白、高不饱和脂肪酸（如食用豆油、麻油、菜油）、高维生素（多食新鲜

蔬菜、水果)；三低即低盐、低热量、低脂肪(少食肥肉、猪油、牛油、奶油等)；两戒即戒烟、戒酒。

此外，坚持体育锻炼。“生命在于运动”，体育锻炼对于延年益寿和防治老年人疾病(包括老年性痴呆)确是一个重要而不可缺少的手段。从事一些适合自己兴趣的文娱体育活动，如慢跑、散步、打太极拳、练气功等均可改善情绪，又可保持大脑功能的正常运转。

42. 癫痫持续状态

癫痫持续状态是癫痫发作的一种最严重的表现，其主要临床表现是在短时间内抽搐大发作。病人始终处于昏迷状态，随反复发作而间歇期一次比一次缩短，体温升高，昏迷加深，这时称为癫痫持续状态。本病多见于长期服抗癫痫药物而突然停药，或全身感染的病员。由于长时间的持续性抽搐，如未能及时抢救，可导致严重生理功能紊乱，最终可因衰竭或严重并发症而危及生命。

癫痫属于祖国医学的“巅疾”、“痫证”、“癫痫”等范畴。《诸病源候论》说：“癫者，卒发仆也，吐涎沫，口喎，目急，手足缭戾，无所觉知，良久乃苏”。中医认为癫痫发作的病因、病机不外痰、火、惊、气、血和先天因素几个方面。①积痰内伏，扰乱神明，“无痰不作痫”，②郁怒忧思可生肝火，房劳伤肾，肾水不济，心火过盛，火邪炼熬津液，酿成热痰。另一方面触动内伏痰浊，使痰随火升，阻蔽心包，可使痫发，即“无火不动痰”。③惊恐之后，气脉不足，因惊而作痫。④先天因素：肝肾阴血不足，心肝之气

易于受损，致使肝气逆乱，神不守舍，则发昏仆、抽搐之症。

急救治疗

(1) 清开灵注射液 20 毫升，加入 5 % 葡萄糖液 100 毫升作静脉滴注。如抽搐仍未止，隔 20—30 分钟后，再用清开灵注射液 20 毫升加入 5 % 葡萄糖液 100 毫升作静滴。8 小时内清开灵总量可用至 80 毫升。

清开灵注射液系中成药安宫牛黄丸改变剂型后的新制剂（北京中医学院制药厂生产），其主要成份为牛黄、水牛角、黄芩、银花等，具有清热解毒，镇静安神等作用。

(2) α -细辛醚注射液（南京江浦制药厂生产），每支 10 毫克/2 毫升，肌肉注射，成人首次用 20 毫克，如半小时再发作再用 20 毫克，小儿 1—10 岁儿童用 10 毫克，11—15 岁 15 毫克。也可作静脉滴注， α -细辛醚是从石菖蒲中提取的一种活性成份，动物实验证明具有抗电惊厥作用，其抗癫痫效能优于石菖蒲，它是石菖蒲抗癫痫的有效成份。 α -细辛醚抢救癫痫大发作持续状态有较好的疗效，且无抑制呼吸中枢的作用。

针灸治疗

头针：刺激胸腔区，运动区，晕听区，制癫区，舞蹈震颤控制区。

辨证分型治疗

(1) 肝火痰热。平素情绪急躁，大便数日未行，癫痫持续发作，舌尖红苔黄，脉弦数。治宜泻火涤痰。

方药：大黄 10 克，黄芩 10 克，黄连 10 克，半夏 10 克，橘红 6 克，茯苓 10 克，枳实 10 克，竹茹 10 克，甘草 3 克，胆南星 10 克，川贝 10 克，天竺黄 10 克，石菖蒲 10 克，天麻 10 克，钩藤 30 克（后下），

僵蚕10克，全蝎10克。水煎服。

(2) 脾虚痰盛。平素面色萎黄，食欲不振，大便溏薄。舌淡苔白脉沉迟。治宜健脾化痰。

方药：陈皮12克，半夏12克，茯苓15克，川贝12克，白附子12克，胆南星10克，山药30克，鲜竹沥15毫升（兑服），菖蒲12克，郁金15克，干姜10克，水煎服。

43. 竞技综合征

竞技综合征系竞技前或竞技过程中（如比赛或考试）发生的失眠、心悸、烦躁、口干、食欲不振、头痛、多汗、恶心呕吐、腹痛、泄泻、视物模糊、手指震颤、小腿痉挛、智力低下、思想僵化、血压升高、甚至晕厥，女学生还会有痛经、月经紊乱，有的还发生精神变态。这些症状的发生，主要是由于精神紧张造成的。

祖国医学认为“恐伤肾、怒伤肝、思伤脾”，精神紧张可导致阴阳平衡失调。中医认为，阴阳是“万物之纲纪”，也是人体的纲纪，“人生有形，不离阴阳”。人体是阴阳对立统一的有机整体。阴阳在体内表现为多方面，多层次，多环节的对立和统一。阴阳相互依存和相互制约保持自身的相对平衡，以维护体内环境及其与体外环境间的协调稳定。持续性的精神紧张和消耗，可导致生理阴阳平衡的破坏。其治疗，宜调整阴阳。

针灸治疗

(1) 针刺百会穴，得气后提插，留针30分钟。也可作为预防用，预防者可在竞技（考试）前一天晚上针刺。

(2) 耳针。取穴：心、神门、皮质下、脾。方法：用黄荆籽，贴在胶布中心备用。选好穴位后，常规消毒，把粘有黄荆籽的胶布对准穴位贴上，按压胶布片刻，再用拇指、食指对按，以耳穴有压痛感为度，每日按压3—5次，每次按压10—20分钟，平时看书时亦可按压以加强刺激。

中药治疗

五味子30克，合欢皮30克，酸枣仁15克，菌灵芝30克，磁石30克，夜交藤30克，熟地15克，水煎服。

44. 散发性脑炎

散发性脑炎系病毒侵入脑实质所致（病毒包括柯萨奇病毒、疱疹病毒、腮腺病毒，流感病毒等等）。其发病无明显的季节性，故称散发性脑炎。

散发性脑炎又称非特异性脑炎，弥漫性脑病。儿童及青少年多见。

临床表现：①前驱症状。多有上呼吸道或消化道的急性感染，多以发热，头痛，恶心，呕吐等症状出现。②意识障碍。约有半数患者有不等程度的意识障碍，严重者早期即进入深昏迷状态。③精神症状。主要表现为痴呆、淡漠、不语或兴奋躁动。④可有癫痫发作或多汗、阵发性面红等症状。⑤可有偏瘫，不自主运动或脑膜刺激征。

约有半数患者于发病前数日至一个月左右有头痛、发热、流涕、咳嗽、恶心、腹痛腹泻等症状。实检室检查脑脊髓细胞数和蛋白增高。脑电图不正常。进行以抗病毒为主（中药、激素等）的诊断性治疗以后，常能获得明显效果。

散发性脑炎属于祖国医学的温病范畴。

辨证分型治疗

初期（郁热期）治疗：

（1）痰气郁结型。表情淡漠嗜睡，精神抑郁，恶心呕吐，舌苔薄腻，脉弦滑。治宜理气化痰。

方药：竹茹12克，陈皮12克，法夏12克，枳实10克，生姜10克，菖蒲10克，远志10克，板蓝根30克，水煎服。

（2）邪在肺卫型。发热微恶风寒，咳嗽，痰少，咽痛，脉浮数。治宜清热解毒。

方药：银花30克，连翘15克，竹叶12克，荆芥10克，牛蒡子15克，芦根30克，板蓝根30克，大青叶30克，水煎服。

（3）热入胃肠型。除以上邪在肺卫型的临床表现外，尚有恶心呕吐，腹痛腹泻，口渴心烦，舌苔黄燥。治宜泄热升津。

方药：葛根30克，黄芩30克，黄连10克，白芍30克，板蓝根30克，大青叶30克，生地30克，水煎服。

中期（昏躁期）治疗：

（1）痰蒙心窍型。头痛目眩，胸闷不适，神昏谵语或躁动不宁，毁物伤人，二便失禁，舌苔黄腻灰黑，脉弦滑数。治宜豁痰开窍。

方药：菖蒲12克，郁金40克，胆南星10克，法夏12克，竹茹12克，生姜12克，枳实10克，茯苓15克，橘红10克，红参10克，瓜蒌30克，水煎服。

（2）热入心包型。神昏谵语，不省人事，身热心烦，舌质绛，脉数。治宜清心开窍。

方药：犀角8克，生地30克，玄参30克，竹叶心10克，麦冬30克，丹参30克，黄连10克，银花30克，连翘15克，板蓝根30克，

水煎，送服安宫牛黄丸一粒。

(3) 肝风内动型。头痛目眩，心烦口渴，项背强直，阵阵抽搐，舌质红绛，脉弦数。治宜清肝熄风。

方药：羚羊角粉8克（冲服），钩藤30克（后下），桑叶20克，川贝母10克，竹茹12克，菊花15克，白芍30克，生姜10克，茯神10克，甘草10克，水煎，送服紫雪丹8克。

后期（恢复期或后遗症期）治疗：

(1) 气虚痰阻型。气短音微，吞咽困难，腰膝无力，震颤或瘫痪，二便失禁，语言不清。治宜益气养血，祛痰通络。

方药：黄芪90克，赤芍10克，红花10克，当归10克，川芎10克，地龙10克，菖蒲12克，郁金30克，陈皮10克，法夏10克，远志12克，水煎服。

(2) 热伤阴血型。手足心热，口干舌燥，神倦无力，面色㿔白，皮肤粗糙，耳鸣失听，肢体干瘦，手足麻木，脉虚无力。治宜滋阴增液。

方药：生地30克，麦冬30克，阿胶15克，太子参30克，玄参30克，黄连6克，麻仁10克，当归30克，甘草10克，水煎服。

(3) 余邪未清型。身热不扬，心烦喜呕，胸内懊恼，舌红苔薄黄，脉虚。治宜清热除烦。

方药：栀子12克，淡豆豉10克，枳实10克，竹茹12克，丹皮12克，赤芍20克，水煎服。

近年来各地治疗散发性脑炎，摸索出了一些新疗法，积累了一些新经验，例如，用通下法治疗散发性脑炎效果较好，方药为：

赤芍30克，生地30克，生大黄15克，黄连10克，黄柏10克，芒硝10克，栀子12克，丹皮10克，麦冬30克，甘草10克，水煎服。

方中的大黄、芒硝推荡胃腑热结；黄连、黄柏、栀子苦泄三焦邪热；赤芍、丹皮、生地、麦冬凉血通淤，滋养阴液，兼利小便；甘草甘缓和中。诸药配伍，既通大便，又利小便，邪得两解，气机畅达，可获神清窍开之效。

用南通蛇药片治疗散发性脑炎，为本病的治疗探索出了一条新的途径。方法为：

南通蛇药片口服，每次10片，每日3次。并配合服维生素B₁、维生素B₆、肌注维生素B₁₂等。

南通蛇药片具有清热解毒、消痈散肿、熄风定痉、活血化淤等作用。原用于专治毒蛇、毒虫咬伤，据《中西医结合杂志》1984年第8期报道，经试用于治疗散发性脑炎，具有见效快、疗程短、效果好、无副作用、价廉、用药方便等优点。

此外，下列基本方治疗散发性脑炎也有较好疗效。

方一：银花30克，连翘30克，荆芥12克，薄荷12克，牛蒡子20克，贯众15克，大青叶30克，板蓝根30克，水煎服。

加减：高热者酌加水牛角、丹皮、赤芍、黄连、生地。

轻度意识障碍者加远志、石菖蒲。

伴有抽搐者加钩藤、僵蚕、生牡蛎。

昏迷者用鼻饲安宫牛黄丸或清开灵注射液静脉点滴。

方二：草河车30克，板蓝根30克，大青叶30克，丹参30克，贯众20克，菖蒲12克，远志12克，郁金30克，瓜蒌15克，黄芩30克，僵蚕12克，石决明30克，全蝎10克，生牡蛎30克，水煎服。

45. 进行性脊髓性肌萎缩症

运动神经元疾病有不同组合的肌无力、肌萎缩或延髓麻

痹，但感觉正常。有的家族病例系遗传而来，有的癌症患者也可伴发运动神经元疾病。进行性脊髓性肌萎缩症是运动神经元疾病中的一种类型，病理特点是脊髓颈膨大的前角细胞受到损害，实际上是运动神经元发生了病变。

本病多在30岁左右开始发病，起病隐袭，病程进展较慢。患者表现为一侧或两侧手肌无力，大小鱼际、骨间肌萎缩，四肢肌力减退，肌张力降低，兴奋性增强，四肢腱反射减弱，感觉正常，有时有明显的肌束颤动。

本病属中医的“痿证”、“筋痿”的范畴。其病因为元气内伤，气血不足，阳弱阴损，精亏髓空。诱因多为六淫侵袭，劳役过度，感冒日久。

人体中的真阳很重要，可温煦躯体，安肢节，柔筋脉，充皮肤，密腠理，可化气成形，所以，温扶阳气是极为重要的。另外配合利湿宽筋，强筋健骨，就可收到较好的疗效。

（1）肝肾阴虚型。除了前面说的主要症状外，兼有少寐多梦，大便干，尿黄，手足心热，口渴饮少。舌质红，苔薄黄，少津，脉细数。

方药：龟板胶10克（冲服），炒杜仲15克，盐炒黄柏12克，麦冬15克，当归15克，木瓜20克，白芍20克，甘草10克，生白术15克，枸杞15克，川牛膝12克，鸡血藤30克，水煎服。

（2）脾肾阳虚型。除主证外，兼面色㿔白，语音低微，纳少胸闷，便溏畏冷，体瘦倦怠。舌淡、苔白厚腻，脉滑。

方药：鹿角胶10克（冲服），炒杜仲15克，党参30克，黄芪30克，白术20克，白芥子10克，茯苓15克，木瓜15克，牛膝20克，麦芽20克，破旧纸10克，桂枝8克，淫羊藿20克，水煎服。

（3）气血不调型。除了主要症状外，兼有面色萎黄，

形体瘦削，精神不振。苔薄，舌胖，边有齿印，脉细弱。

方药：黄芪 100克，淫羊藿60克，鹿筋50克，海龙30克，海马30克，人参30克，龟板胶30克，当归50克，白芍30克，熟地30克，枸杞50克，杜仲50克，川断30克，菟丝子30克，锁阳50克，白术40克，苡仁50克，陈皮20克，牛膝30克，木瓜30克，秦艽30克，蕲蛇20克，炙豹骨10克，补骨脂15克，知母10克，黄柏10克，桂枝10克，羌活10克，防风10克，独活20克。共研为极细末，水泛为丸。每次服9克，每日3次。

针灸疗法

第一组穴：阳陵泉、环跳、风市、承山、合谷。

第二组穴：肾俞、委中、合谷、次髎、承山。

两组穴位可交换使用，每1—2日针灸1次。

药物穴位注射疗法

第一组穴：右足三里、左曲池。

第二组穴：左足三里、右曲池。

每个穴位均注射麝香注射液2毫升，每1—2日1次，两组穴位交替使用。

穴位结扎疗法

第一组穴：右足三里、左承山。

第二组穴：左足三里、右承山。

用医用羊肠线穴位结扎，每半月交换1次。

46. 肌萎缩性侧索硬化症

肌萎缩性侧索硬化症是运动神经元疾病中的一种，西医目前尚无特效疗法。本病呈退行性变，属疑难之症，治疗很

棘手。用中药治疗，有一定的效果。

本病的临床表现是：肌肉萎缩，无力，肌束颤动，下肢多呈痉挛性瘫痪，行动困难，时有剪刀样步态，有的有呼吸吞咽障碍。

本病属祖国医学“痿证”、“筋痿”、“痿厥”等范畴，与肝脾肾亏损有关。肝主筋，为经脉之宗；脾主肌肉，是后天之本，气血之枢纽；肾主骨，是五脏六腑之本。若将息失宜，劳倦过度，喜怒失常，房事太频，都可造成劳损。

治疗上多以补火助阳，强筋健骨，活血化淤，清利湿热为治。

(1) 湿热阻滞经络型。除了上述症状外，兼有痰多，口渴喜饮，性情急躁，溲黄。舌质红，苔薄黄，根部厚腻，脉细弦。

方药：僵蚕10克，蜂房10克，苦参20克，土茯苓30克，银花藤30克，黄柏12克，赤芍12克，生地15克，鸡血藤30克，木瓜20克，牛膝12克，乌梢蛇20克，水蛭5克，水煎服。

(2) 肾虚夹淤型。除了主要症状外，兼有倦怠乏力，形体消瘦，肤色失泽。苔白润，脉沉涩。

方药：制附片15克（先煎2小时），肉桂10克，枸杞15克，熟地12克，当归12克，白芍12克，桃仁12克，红花10克，蜈蚣1条，全蝎8克，乌梢蛇20克，川芎10克，麝香0.25克（冲服），制马钱子粉0.25克（冲服），水煎服。

(3) 阴虚夹湿热型。除了本病的主要症状外，兼有形体消瘦，头昏耳鸣，口干饮少。舌苔黄腻，脉沉细数。

方药：知母12克，黄柏12克，生地15克，丹皮12克，泽泻10克，茯苓15克，防己12克，苡仁30克，蜈蚣1条，全蝎8克，红花10克，续断15克，牛膝12克，水煎服。

47. 低血糖症

低血糖症是由于多种原因引起的血糖浓度过低的症状群，发作时血糖浓度低于 55 毫克%。低血糖症状的轻重、发展快慢、持续时间长短均与血糖值高低有密切关系。血糖值愈低，发展愈快，持续时间愈长，症状愈严重。低血糖症在临床上并非少见，但有时因症状较轻，患者多不加以重视，医务人员也容易疏忽而造成漏诊或误诊，致使患者症状逐渐加重。

引起低血糖症的病因较多，常见的有以下数种：①胰岛功能亢进症；②胰岛外细胞瘤；③垂体前叶功能减退症；④慢性肾上腺皮质功能减退症；⑤甲状腺功能减退症；⑥肝炎；⑦肝硬化；⑧肝糖原累积症；⑨下丘脑疾病；⑩脑干疾病；⑪荔枝病等等。

此外，过度消耗，摄入不足，重症慢性疾病，年老衰弱，妇女哺乳、妊娠等，可引起低血糖症。应用胰岛素过量或应用苯乙双胍、甲苯磺丁脲、水杨酸制剂、保泰松、氨基酸、心得安、抗组织胺类药物、异烟肼等均可引起低血糖症。

低血糖症的临床表现有：饥饿感，软弱，疲倦，出汗，紧张，脸色苍白，心悸，血压偏高，恶心呕吐等等，此为血糖下降较快的症状群。如血糖下降较慢，历时久，血糖甚低，则可表现为精神失常，表情特异，易激动，恐惧，慌乱，狂躁，继之出现头痛，头昏，视力障碍，肌力软弱，痉挛状态，眼球肌瘫痪，反射亢进等。

低血糖症可通过血糖测定，饥饿试验，口服葡萄糖耐量试验等检查而确诊。

另有一类功能性低血糖，多发于中年妇女，且常与情绪波动有关，均在饭后2—4小时发作，平素血压及血糖正常，发作时血压轻度升高，血糖可低至36毫克左右，口服及注射葡萄糖不得缓解。

低血糖症属于祖国医学的“虚劳”、“心悸”、“眩晕”等范畴。《证治汇补》说：“虚者，血气之空虚也……”，《景岳全书》说：“劳倦不顾者多成劳损，……疾病误治及失于调理者，病后多成虚损”。中医认为“诸风掉眩，皆属于肝”。肝属木。凡人年迈气血衰弱，将息失宜，或妊娠哺乳，或疾病耗气伤津，皆可导致肝木失和；或因肾水不足，真阳失守，孤阳发越，水不涵木，木失所养，风自肝起，发为此症。治宜滋肝肾、补虚损。

急救治疗

参麦针20—30毫升加于10%葡萄糖液500毫升作静脉滴注，并口服糖开水。

其他疾病继发低血糖的治疗

熟地30克，龙眼肉15克，党参60克，当归20克，炙黄芪30克，炙甘草10克，白术12克，茯苓12克，川芎12克，饴糖30克，水煎服。

功能性低血糖（口服及注射葡萄糖不得缓解）的治疗

方一：当归30克，淮牛膝30克，麦冬12克，生地15克，白芍15克，玄参12克，茯神12克，生麦芽15克，桑叶10克，菊花10克，甘草10克，水煎服。

方二：杞菊地黄丸，每次服10克，每日三次。

48. 传染性单核细胞增多症

传染性单核细胞增多症是一种急性的网状内皮系统增生性疾病，多为自限性，属急性或亚急性传染病。临床的主要表现为：不规则发热，咽峡炎，淋巴结肿大，脾肿大，皮疹，血中淋巴细胞增多，并出现异常淋巴细胞。但是大多数患者的上述症状不典型。

本病由 EB 病毒所致，病变累及全身各系统的脏器。流行区域甚广，传染源是该病毒携带者和病人，主要传播途径是经口密切接触。发病以 15—30 岁的年龄为多，男性略多于女性。一般说来，全年均有发病，但以晚秋初冬为多。有脾破裂、脑膜炎、肝功能衰竭、气管阻塞和心肌炎等，病情严重者可导致死亡。

本病的病程较长，多为 2—3 周，少数病例可迁延数月，乃至数年之久。治疗的方法是对症为主，用抗生素与磺胺药无效，但在继发细菌感染时可适当选用。个别患者可能有复发。

根据本病的病程，可划分为前驱期、发热期和恢复期三个阶段。从脏器受损的情况，可分为 7 个临床类型。

(1) 发热型。以发热为主。多数患者为中等度发热，发热曲线好似伤寒，或类似疟疾，并呈相对脉缓。发热期为 5—10 天，可以骤然降低，也可逐渐退去。

(2) 腺肿型。以淋巴结肿为主。患者中有 60—70% 可有此典型表现。以颈部淋巴结肿为多见，其它淋巴结都被累及。直径约 1—4 厘米，呈中等硬度，压痛不明显，分

散，不粘连，不化脓。

(3) 咽峡类型。以咽峡、悬雍垂、扁桃体充血、水肿为主，部分患者有溃疡，或假膜形成，腭部可出现小出血点，齿龈可肿胀。约有半数的患者可有本型的种种表现，其中咽峡炎常为首先出现的一种症状。就诊者常主诉吞咽疼痛。应当警惕气管阻塞，否则后果严重。

(4) 肺炎型。以间质肺炎为主。常有咳嗽、咯痰，胸部X线表现有炎症。

(5) 肝炎型。以肝脾肿大、肝功能异常为主。约40%以上的患者有脾肿大。肝脏的变化近似肝炎，预后良好。发生黄疸者约10%左右。患者常觉乏力，食欲不振，恶心，脘腹不适。有部分人的胰腺可能被累及。

(6) 脑炎型。以神经系统症状为主。临床上表现为头痛，视力模糊，昏迷，颈强直，瘫痪等。

(7) 肾炎型。以血尿、蛋白尿为主。表现为眼睑和下肢浮肿。

本病尚无有效的预防措施，隔离病人并没有必要。患者在恢复期，仍可持续数月的病毒血症。所以，献血期限须延至发病6月之后。

中医认为，本病属热毒内侵，耗伤阴液所致，故见发热，乏力，咽喉肿痛，或见夜热早凉，午后潮热，口渴喜饮，舌质红，苔薄，甚则舌红无苔，脉细数。

方一：水牛角30克（先煎），生石膏30克，生地15克，赤芍10克，丹皮10克，知母10克，黄芩15克，栀子10克，玄参15克，连翘12克，淡竹叶12克，桔梗5克，黄连5克，生甘草5克，水煎服。

加减：肺炎型加麻黄5克，杏仁12克，葶草30克；肝炎型

加茵陈30克，生大黄5克（后下），金钱草30克；肾炎型加仙鹤草30克，炒槐花15克，玉米须30克，茅根30克；脑炎型加安宫牛黄丸1粒，化服。

方二：柴胡20克，连翘15克，板蓝根30克，黄连5克，夏枯草30克，玄参15克，牛蒡子12克，陈皮10克，银花15克，僵蚕12克，蝉蜕10克，水煎服。

加减：高热者加生石膏30克（先煎），黄芩12克；大便不通者加大黄8克（后下），芒硝10克（冲服）；肝脾肿大者加三棱8克，莪术8克，青皮10克，牡蛎20克（打碎）；纳少、恶心者加藿香12克，砂仁8克；淋巴结肿胀者加如意金黄散10克，调醋外敷。

方中板蓝根、黄连、黄芩、夏枯草、牛蒡子清热解毒，祛邪消肿；柴胡、陈皮疏解郁滞，和解少阳；玄参滋阴降火；银花清络中风火热毒，解温疫秽恶浊邪；蝉衣轻浮宣散，疏风除热；僵蚕祛风解痉，化痰散结，能疗急性喉痹和皮肤风疮。

方三：蒲公英30克，紫花地丁30克，板蓝根30克，地骨皮12克，沙参20克，生地15克，元参15克，生甘草5克，花粉15克，水煎服。

加减：发热者加荆芥10克，白薇13克，知母12克；淋巴结肿大者加夏枯草30克，生牡蛎20克，浙贝10克；肝脾肿大者加鳖甲25克（炙），郁金12克，石斛10克；咽峡炎者加山豆根10克，牛蒡子12克，锦灯笼20克；头痛者加菊花15克，蔓荆子10克，失眠者加夜交藤30克，合欢皮20克；黄疸者加茵陈15克，川楝子10克；皮疹者加苍耳子12克，白藓皮15克；血尿者加茅根30克，大小蓟各15克。

49. 阵发性睡眠性血红蛋白尿

阵发性睡眠性血红蛋白尿是一种较少见的原因不明的慢性溶血性贫血。目前，认为这种病与红细胞的内在缺陷或细胞膜的异常有关。

本病的主要症状为贫血，并有轻微出血倾向和血红蛋白尿。

血红蛋白尿一般在早晨较重，下午较轻，常与睡眠有关，甚至白日睡眠也易引起发作。故称为“阵发性睡眠性血红蛋白尿”。在睡眠时血红蛋白尿发作的原因，可能由于睡眠时呼吸中枢敏感性降低，血清 pH 趋向于酸性的缘故。血红蛋白尿的诱发因素与服用药物（如铁剂、肝浸膏、氯化铵、阿斯匹林、维生素 C、呋喃妥因、氯丙嗪等），感染，输血，过度疲劳，情绪波动，大量饮酒，摄入某些食物，月经或妊娠，手术等有关。发作时在睡眠后出现典型酱油色尿，有些病员未觉察尿色变化，而尿隐血试验却呈阳性。

血红蛋白尿的发作情况可分频发、偶发、不发三种类型。频发型多突然起病，伴发热，血红蛋白尿（酱油色尿）每月发作 1—4 次；偶发型每 1—2 月甚至半年才发作一次；不发作型则全血细胞减少。

阵发性睡眠性血红蛋白尿的临床表现：除血红蛋白尿外，尚有骨髓再生障碍，伴支气管肺部感染及泌尿生殖系统感染，易发生血栓。

骨髓象检查，尿隐血试验，尿含铁血黄素试验，血清糖水溶解试验，热溶血试验，酸溶血试验等均有助于本病的

诊断。

阵发性睡眠性血红蛋白尿属于祖国医学的“虚劳”、“黄疸”等范畴。多因气郁伤肝，肝失所养，疏泄失职，发为黄疸，亦可因劳倦伤脾，脾虚不运，化源不足，导致血虚。

辨证分型治疗

(1) 湿热内蕴。倦怠乏力，食少恶心，目黄尿赤，苔黄腻，脉滑数。治宜清热利湿。

方药：茵陈30克，栀子12克，茯苓15克，猪苓15克，白术12克，泽泻30克，板蓝根30克，茅根30克，水煎服。

(2) 气阴两虚。气短乏力，面色苍白，五心烦热，不规则发烧，有出血点，舌淡胖嫩，脉细弱。治宜益气养阴。

方药：西洋参10克，天冬15克，麦冬20克，生地30克，熟地30克，黄柏10克，砂仁6克，黄芪30克，当归20克，赤芍15克，茅根30克，茜草炭12克，水煎服。

(2) 脾肾阳虚。面色无华，气短懒言，四肢无力，腰膝酸软，便溏，脉细弱，舌淡苔白，治宜补脾温肾。

方药：茵陈30克，制附片15克（先熬），肉桂6克，补骨脂12克，菟丝子30克，黄芪30克，鹿角胶10克，党参30克，白术15克，水煎服。

单方验方治疗

方一：女贞子30克，山萸15克，熟地30克，补骨脂12克，茅根30克，附片15克（先熬），肉桂6克，黄芪30克，人参叶30克，水煎服。

方二：枸杞15克，黄精30克，阿胶12克，菟丝子30克，芡实30克，鹿角胶10克，三七粉8克（冲服），茜草10克，仙鹤草30克，川断30克，茅根30克，水煎服。

50. 弥漫性血管内凝血

弥漫性血管内凝血（简称 DIC）是由于各种因素引起凝血功能紊乱的一种综合征。由于某些致病因素的作用，促凝物质进入血液循环，引起毛细血管、小静脉、小动脉内广泛的纤维蛋白沉积和血小板凝聚，出现弥漫性微血栓。

引起弥漫性血管内凝血的病因有：

（1）传染性及感染性疾病。①病毒感染，如流行性出血热，暴发型传染性肝炎等；②立克次体感染，如斑疹伤寒，恙虫病等；③细菌性疾病，如各种细菌所致的败血症，严重粟粒性结核，流行性脑脊髓膜炎（休克型），中毒性痢疾等。

（2）心血管系统疾病。各种原因引起的休克、恶性高血压、肺梗塞等。

（3）消化系统疾病。急性出血性胰腺炎，急性出血性肠炎等。

（4）溶血性疾病。不适合的输血，阵发性睡眠性血红蛋白尿等。

（5）物理化学病因疾病。中暑、冻伤、大面积烧伤、毒蛇咬伤。

（6）小儿疾病。暴发性紫癜等。

（7）外科疾病。挤压综合征等。

（8）产科疾病。败血性流产、胎盘早期剥离、羊水栓塞、妊娠中毒症、葡萄胎等。

（9）恶性肿瘤。胃癌、胰腺癌等。

弥漫性血管内凝血的临床表现有：

(1) 广泛性自发性出血，表现为皮肤粘膜紫癜、咯血、呕血、黑便（内脏出血）、血尿和注射部位皮下出血等。

(2) 四肢发绀、恶心、呕吐、腹泻、腹痛、呼吸困难、意识障碍、尿少或无尿等（缺血、缺氧、功能障碍所致）。

(3) 血压下降，甚至休克。

(4) 发热、进行性贫血、黄疸、血红蛋白尿、腰背痛等。

诊断弥漫性血管内凝血可作以下辅助检查：①血小板计数少于10万/立方毫米，凝血酶元时间延长 >15 秒，纤维蛋白原定量减少 <200 毫克%。②纤维蛋白溶解活力检查：血块溶解时间缩短，尤其球蛋白溶解时间缩短，血浆素原定量下降，Fi试验效价 $\geq 1:16$ ，副凝试验阳性，凝血酶时间延长 >25 秒。③肝功能、肾功能检查可能异常，胸透肺部可有片状阴影。

弥漫性血管内凝血属于祖国医学的“淤证”范畴。见于多种危重疾病的晚期，均因脉络淤阻，气机闭绝所致。主要致病因素是：①气虚气滞。由于气虚，推动血流力量减弱，血行减慢，积而为淤，气滞可使血行受阻，停而为淤。②血寒血热。寒入血络，寒性收引，血行减慢，血停为淤。热入血络，燔灼营阴，阴液亏耗，血稠而淤。③外伤损害。跌打损伤，脉络受损，造成失血，致血虚气滞，或组织损伤造成局部气血凝滞，营血稽留于脉道中，导致淤证。

辨证分型治疗

(1) 热盛淤血。多见于感染性或传染性疾病（温热病）之危重患者，症见壮热烦躁，面色暗赤，神昏谵语，大

便秘结，尿短赤，吐衄便血，舌红绛有淤斑，苔糙腻，脉弦数。治宜清热解毒，活血化淤。

方药：银花30克，连翘30克，生地30克，丹参30克，赤芍30克，丹皮15克，生石膏30克，水牛角30克，皂刺12克，黄芩15克，桃仁10克，水煎服。

（2）血虚淤血。多见于广泛出血之患者。面色苍白或萎黄，心悸怔忡，头昏眼花，吐衄便血，烦躁不安。舌淡苍白，脉涩或细弱。治宜补血化淤。

方药：黄芪60克，当归30克，熟地30克，赤芍30克，丹参30克，桃仁10克，红花10克，鸡血藤30克，黄精15克，阿胶15克，川芎10克，水煎服。

（3）气虚淤血。多见于弥漫性血管内凝血的恢复阶段。面色少华，乏力，气短懒言，自汗，舌淡胖，脉细涩。治宜益气化淤。

方药：黄芪30克，党参30克，人参叶30克，白术12克，茯苓15克，麦冬15克，五味子15克，赤芍30克，丹参30克，当归15克，川芎10克，水煎服。

单方验方治疗

方一：桃仁12克，丹皮12克，赤芍30克，大黄12克，芒硝12克（冲服），桂枝12克，当归15克，甘草6克，水煎服。

凡弥漫性血管内凝血伴肾功能不全者，服本方后，随着通腑排便，尿常规明显改变。效果较好。

方二：丹参针10毫升（含生药20克）加入10%葡萄糖液500毫升作静脉点滴，每日2次。用于流行性出血热休克期伴DIC者，日用量可达80克。

丹参可扩张血小管，解除微血管的痉挛，并可使小血管渗出减少，毛细血管开放数目增多，血流速度加快，从而降

低全血和血浆的粘稠度，有利于细胞的解聚，改善微循环，抑制血小板的聚集，对已聚集的血小板有解聚作用，因而阻断血栓和 DIC 的形成。

方三：20% 红花泽兰注射液。每日 20—40 毫升，分 2—4 次，加入 50% 葡萄糖液 20—30 毫升作静脉推注，直至凝血象检查正常，临床症状好转。

方四：丹参针与生脉针合用。生脉针 10 毫升（生脉针 5 毫升内含人参 0.5 克，麦冬 1.6 克）丹参针 6 毫升，一日 2 次，静脉点滴，用于 DIC 早期，效果满意。

方五：川芎嗪针。每次用 40—120 毫克，加入 10% 葡萄糖液稀释后静脉滴注。

51. 特发性水肿

特发性水肿属于功能性水肿范畴，按其临床表现与中医的“肤胀”、“水肿”大致雷同。

本病很常见，多发于中年妇女，目前对其发病机制尚未明确，缺少特异性的诊断手段，亦无特效疗法。

本病的主要症状是水肿。根据临床观察，这种水肿有 11 个特点。即：①长期性；②反复性；③上午轻，下午重；④睡觉后轻，活动后重；⑤平时轻，月经前后重；⑥四肢水肿明显，躯干不明显；⑦与寒冷有关；⑧和情绪有关；⑨和疲劳有关；⑩消得快，肿得亦快；⑪肿胀难分，体重骤增。就水肿的程度而言，轻重皆有。轻的似乎胖了一点，变得丰满，用手按后留有压痕；重的臃肿，按之有凹陷，压之没指。除了水肿之外，常伴有怕冷，冬季尤怕冷，疲乏懒动，四肢困

倦，胸闷腹胀，登高或上楼即感心累心跳，气短气急，有时可有头昏头痛，面部烘热，失眠多梦，消谷善饥，口渴多饮。月经多数不调，后期多，先期少，经血颜色淡，经量少，经行不畅，或数月不行。虽然久病，但食欲如故，面色亦不晄白。苔薄白或腻，舌质嫩淡，有齿痕。脉多沉细或弦。实验室检查很难发现异常，诸如血、尿、大小便常规，肝肾功能测定；血浆蛋白定量；X线检查；心电图、心功能测定均属正常。

特发性水肿的发生，关键在于气，归咎于肺、脾、肾、肝。所谓“其本在肾，其标在肺，其制在脾”；肝之疏与结，直接影响气的运塞和水的流止。气行，水就行，人则康；气滞，水就聚，人则肿。所以，肝气疏泄得当，气机流行，水道通畅，津液随之升降上下出入，就不会水肿。反之，肝气郁结，水液滞留，就会罹患水肿。治疗本病时，不可一味盲目而见肿消肿，应要疏肝运脾，行气活血。这样治其根本，不利尿而水自行，肿自消。

方一：天仙藤15克，香附12克，紫苏12克，乌药10克，陈皮12克，生姜3片，木瓜12克，冬瓜皮30克，甘草5克，水煎服。

加减：颜面肿、足肿甚者加防风10克，防己10克，赤小豆30克，杏仁12克；小便少而不畅，加桂枝8克，通草10克，茅根30克；怕冷、头痛、嗜睡者加麻黄8克，制附片10克（先煎半小时），细辛3克；肢麻、手指难握拳者加丹参20克，豨莶草30克，鸡血藤30克；自汗、气短者加黄芪30克，白术20克；月经不调者选加当归10克，益母草15克，泽兰12克，丹参12克；面红、有烘热感、心烦者选加丹皮12克，栀子5克，白芍12克，枣皮12克；腹胀、纳少、便溏者加苡仁30克，砂仁8克，建曲10克，谷芽15克；疲乏、倦怠者加党参30克，黄芪30克，淫羊

藿20克；失眠多梦者加五味子5克，枣仁12克。

方二：木香20克，厚朴20克，腹皮20克，枳壳20克，桑皮30克，茯苓30克，苡仁30克，牛膝15克，冬瓜皮100克，水煎服。每日一剂，分两次服。服六天停一天，一个疗程为两个月。

方三：我常用当归芍药散加味治疗本病，效果佳良。当归12克，白芍12克，川芎10克，茯苓15克，白术12克，泽泻15克，玉米须30克，茅根30克，黄芪30克，冬瓜皮、冬瓜仁各30克，水煎服。

52. 皮炎和多发性肌炎

皮炎是一种急性或慢性的皮肤和肌肉的炎症性疾病。主要特征为出现淡紫红色水肿性斑片（以眼睑最为突出）以及病肌无力，自发痛和压痛。

皮炎多见于40—60岁的女性。本病可以急性发作，也可逐渐发生。皮肤损害和肌肉症状（肌肉无力，自发痛和压痛）可同时或先后出现。有些病人的肌肉症状不显著，而皮损明显；有些病人的皮损轻微，而肌肉病变严重。皮损轻微而肌肉病变严重的称为“多发性肌炎”。

皮炎的皮肤症状：初起皮肤见淡紫红色水肿性红斑，大小不一，以后逐渐扩大融合成片，有的附灰白色糠状鳞屑。再后皮损逐渐消退，遗留皮肤萎缩，毛细血管扩张，棕黑色色素沉着或色素减退。晚期病变部皮肤变硬。皮损好发于面部，特别是眼睑、两颊、前额和颞部最为突出。其次为颈部、上胸部和四肢伸侧。在手背处的淡紫红色红斑呈条状沿手指背面分布，有时可出现荨麻疹、皮肤划痕症（人工性

荨麻疹)、大疱、皮肤溃疡、结节性红斑、多形红斑、多毛、多汗等。

皮肌炎的肌肉症状：四肢近端肌肉先受累，以后再累及其他肌肉。初起病时患者肌无力，病肌处有自发痛和压痛。由于肌力明显下降，进而出现各种运动障碍，如上肢抬举困难，握力降低，下肢步行障碍。此时如活动眼肌、咽、喉、食道、横膈、肋间等肌肉受累，则可发生复视、斜视、声嘶、吞咽困难、呼吸困难等。如果病变侵犯心肌，可出现心肌炎的症状。

皮肌炎的其他症状：患者可出现不规则发热，关节痛，肢端动脉痉挛，浅表淋巴结和肝脾肿大，腹胀，腹泻，便秘，虚弱，倦怠，骨质疏松症，钙质沉着症，周围神经炎和视网膜炎。

化验检查：有时可见贫血和白细胞总数增多，血沉加快，血谷草转氨酶、谷丙转氨酶增加，尿中肌酸明显增高，肌酐明显减少。肌电图有改变。

皮肌炎属于祖国医学的“肌痹”、“虚劳”的范畴。多系先天不足，正气亏损，腠理不固，风寒湿三邪乘虚而入所致。主要伤及肺脾。肺主宣发、主皮毛，脾主运化、主肌肉。肺脾健旺，则皮润肉丰，肺脾虚弱，痹着皮肤肌肉，发为皮肤红斑，肌肉疼痛，病久则精血内耗，肌肤失养而枯萎，五脏俱虚，呈正虚邪恋之候。

辨证分型治疗

(1) 肺热伤津。起病较急，开始多见发热，肌肤红斑，身软乏力，咳呛咽干，心烦口渴，小便短赤，大便干结，舌质红，苔薄黄，脉细数。治宜清热润燥。

方药：沙参30克，麦冬30克，桑叶15克，杏仁12克，生石

膏30克，板蓝根30克，银花30克，连翘15克，苇茎30克，水煎服。

(2) 脾湿化热。肢体萎弱，下肢尤甚，或有发热，肌肤有红斑且微肿，骨节酸楚，肌肉疼痛，胸胁痞满，厌食纳呆，大便溏薄，面色萎黄，小便短少，苔腻，脉滑数。治宜清热利湿。

方药：苡仁30克，苍术15克，黄柏12克。川牛膝30克，茯苓30克，萆薢15克，茵陈30克，威灵仙12克，党参30克，水煎服。

(3) 肝肾亏虚。患病日久，肢体困倦，肌肉萎缩，吞咽不利，腰脊酸软，卧床不起，舌红少苔，脉细数。治宜补益肝肾。

方药：熟地30克，枸杞30克，锁阳12克，淮牛膝30克，鹿含草30克，桑寄生30克，杜仲15克，肉苁蓉15克，菟丝子30克，巴戟15克，鹿角胶10克，水煎服。

分期治疗

(1) 急性进展期。患者有发热，面部红斑，张口困难，肌肉疼痛，舌红苔黄，脉数。治宜清热解毒，活血凉血。

方药：生地30克，赤芍30克，羚羊角粉2克（冲服），银花30克，连翘15克，紫草30克，丹参30克，板蓝根30克，川芎10克，水煎服。

(2) 恢复期。红斑逐渐消退，肌肉疼痛减轻，但仍乏力，活动受限。舌淡红，苔腻，脉数。治宜益气养血，补益脾肾。

方药：黄芪60克，党参30克，制附片30克（先熬），当归30克，升麻10克，柴胡10克，肉桂6克，陈皮10克，丹参30克，

鸡血藤60克，枸杞30克，菟丝子12克，水煎服（根据病情，此方加减可连服3—5个月）。

单方验方

方一：黄芪45克，桂枝12克，细辛6克，当归30克，白芍30克，红花10克，淫羊藿30克，仙茅10克，党参60克，水煎服。

方二：白花蛇舌草30克，茵灵芝30克，黄芪60克，党参30克，生地30克，北沙参30克，紫草30克，丹皮12克，鸡血藤30克，络石藤30克，水煎服。

加减：病初发热、咽痛、红斑显著、舌红者加清热凉血药大青叶、银花、蒲公英，肌肉疼痛为主并伴畏寒或合并硬皮病者加温阳通络之附片、淫羊藿、羌活、独活。病久者加活血祛瘀药丹参、红花。

方三：大活络丹，每次服1丸，每日2次。

方四：昆明山海棠片，每次0.25—0.5克，每日3次饭后服。

方五：复方丹参针，每次2—4毫升，肌注，每日1—2次。

方六：银花藤30克，鸡血藤30克，乌梢蛇10克，蜈蚣2条，土鳖虫12克，地龙12克，僵蚕10克，全蝎6克，赤芍30克，穿山甲片12克，水煎服。

皮肤炎的护理工作也很重要。由于皮肤炎患者，常因无力吞咽而食欲减退，如果单纯靠患者自己进食来维持营养，很难维持机体需要量，首先要补充营养。对吞咽困难的重症皮肤炎患者，要进行鼻饲。其次，患者应侧卧，要及时清除口腔分泌物，要及时吸痰，要密切观察患者的呼吸情况，防止窒息。再次，要说服患者在恢复期坚持服药，病情好转后，应鼓励患者逐步地进行肌力锻炼，如下床活动，四肢伸

屈，提物，作吞咽动作。但要防止活动过度或因肌无力而跌伤。在整个治疗过程中，鼓励患者坚定治愈信念，配合治疗，预防褥疮。

53. 系统性红斑狼疮

红斑性狼疮是一种严重危害人体健康的疾病。多发生于20—40岁的女性。临床上分为局限性的盘状红斑狼疮和全身性的系统性红斑狼疮。盘状红斑狼疮较少见，病情亦较轻。这里着重谈谈系统性红斑狼疮的中医治疗。

系统性红斑狼疮的发病与下列因素有关：①遗传因素；②内分泌失调；③药物（如异烟肼、苯妥因钠、普鲁卡因酰胺、肼苯哒嗪、呋喃妥因、青霉素、D-青霉胺、链霉素、四环素、灰黄霉素、磺胺、硫氧嘧啶、甲基多巴、对氨基水杨酸、保泰松、羟保泰松、心得宁、冬眠灵、乙琥胺、去氧苯巴比妥、三甲双酮、利血平、奎尼丁、胰岛素）；④感染因素（结核、化脓性感染、病毒感染）；⑤紫外线因素；⑥精神因素等均可引起红斑狼疮。

系统性红斑狼疮的临床表现极为复杂（由于几个器官或组织同时或先后受累）。开始大都出现皮疹、关节痛、疲乏和发热，继则出现头痛，纳差，失眠，脱发，肾、心、肺、肝、消化系统、神经系统、眼、骨骼、淋巴结等不同程度被累及。临床症状表现有：

（1）皮疹。皮疹是系统性红斑狼疮临床诊断的主要依据。皮疹的表现多种多样，有红斑、丘疹、水疱、大疱、血疱、毛细血管扩张、紫癜、淤血、渗液、糜烂、结痂、坏

疽、溃疡等。面部可有环状红斑或蝶形红斑，多数对日光敏感。

(2) 关节症状。90%以上的患者有关节痛。大小关节或迟或早均受累。关节痛可为间歇性，常反复发作。日久手指可发生畸形。

(3) 肾脏病变。患者尿内出现红细胞、白细胞、蛋白质和管型，晚期可出现尿毒症或酸中毒、肾病综合征。

(4) 心血管系统病变。可见心包炎、心肌炎、心动过速、心脏扩大，甚至发生心力衰竭。

(5) 呼吸系统病变。可见胸膜炎、胸腔积液、肺炎。

(6) 消化系统症状。有恶心、呕吐、纳差、腹泻、腹痛、腹膜炎、持久性咽炎。

(7) 神经系统症状。有头痛、忧郁、烦躁不安、记忆力减退、打人骂人、无意识的活动、抽搐、脑电图异常。

(8) 眼部症状。泪腺增大伴肿痛和压痛。

(9) 内分泌系统症状。月经紊乱、闭经、痛经。

(10) 淋巴结肿大、肝脾肿大。

在患者的血浆、骨髓、浆膜腔积液中能查到狼疮细胞，有助于诊断。

系统性红斑狼疮属于祖国医学的“鬼脸疮”、“阴阳毒”、“蝴蝶丹”、“日晒疮”、“虚损”等范畴。其发病内因以先天肾阴亏损，阴虚火旺为发病之本；外因可因烈日暴晒为发病之标。烈日暴晒使人体感受火毒之邪，与体内阴虚火旺之内热相搏，毒火相煽，即出现热毒炽盛症状。热毒燔灼，伤津劫液，重者逼血妄行，出现衄血、尿血、紫斑；邪热攻心，则可见心阴内耗，心阳不足症候；邪热伤肝，则可见肝阴不足或肝肾阴虚症候；阴病及阳，肾阴不足可引起肾

阳不足；后天失调，脾胃虚弱，可见脾阳不足症候；如脾肾阳虚，则土不制水，肾水泛滥。

辨证分型治疗

(1) 热毒炽盛。高热不解，面见红斑，皮肤紫斑，关节疼痛，乏力，烦躁口渴，或见神昏，谵语，或见衄血，尿血，舌红或紫暗，苔黄腻，脉滑数。治宜清热解毒，凉血护阴。

方药：水牛角30克，生地30克，赤芍30克，丹皮12克，黄连10克，黄芩10克，黄柏10克，山梔12克，板蓝根30克，青蒿30克，水煎服。

(2) 风湿热痹。关节疼痛，彻夜难眠，屈伸不利，或有低热，血沉增高，舌质红，苔黄腻，脉滑数。治宜宣痹通络，清热除湿。

方药：青蒿30克（后下），防己15克，杏仁12克，苡仁30克，银花藤60克，威灵仙12克，海桐皮12克，连翘30克，滑石30克，蜈蚣2条，土鳖虫12克，水煎服。

(3) 气滞血淤。胁肋疼痛，胸脘痞满，腹胀，腹痛，肋下痞块，舌质暗红或有淤点，苔腻，脉弦涩。治宜疏肝理气，活血化淤。

方药：丹参30克，赤芍30克，桃仁10克，红花10克，当归30克，香附12克，延胡索12克，川芎12克，丹皮12克，陈皮10克，水煎服。

(4) 水气凌心。胸闷气短，心悸怔忡，倚息不得卧，肢体浮肿，小便短少，舌淡，苔白滑，脉沉细或结代。治宜温阳化饮，益气养心。

方药：红参10克，麦冬30克，五味子15克，桂枝12克，茯苓30克，白术15克，泽泻30克，黄芪30克，甘草6克，水煎服。

(5) 脾肾阳虚。面色少华，脘腹胀满，纳差便溏，腰膝酸软，畏寒肢冷，身疲乏力，舌淡苔白，脉细沉迟。治宜温阳健脾补肾。

方药：制附片15克（先熬），肉桂6克，党参30克，淫羊藿30克，山药30克，茯苓15克，白术15克，枸杞15克，菟丝子15克，仙茅10克，水煎服。

(6) 阴虚内热。低热神倦，腰酸腿软，头晕心悸，手足心热，自汗盗汗，脱发，皮肤红斑，舌红，苔光剥，脉细数。治宜滋阴透热。

方药：青蒿30克（后下），鳖甲15克，石斛15克，地骨皮30克，知母12克，生地30克，麦冬30克，玉竹12克，水煎服。

单方验方治疗

方一：黄芪30克，秦艽15克，黄连6克，乌梢蛇6克，漏芦10克，水煎服（此为名老中医赵炳南的经验方）。

加减：壮热不退者加青蒿、沙参、芦根、犀角（或水牛角）、生地；低热加地骨皮、青蒿、玄参、石斛；关节痛加桂枝、松节、伸筋草；肌肉酸痛加玄胡、乳香、没药；腰痛拒按加云南白药、路路通、丹参、茜草；腰痛喜按加杜仲、核桃仁、续断；腰软乏力加红参、玉竹、参茸卫生丸。麻木者加刘寄奴、桑寄生；颜面蝶形红斑者加红花、玫瑰花；指（趾）端苍白、青紫、冰冷者加鸡血藤；心慌、胸闷不舒、发作时不自主、阵发心痛者加桂枝、紫石英、瓜蒌、薤白、蛇胆陈皮末；胁痛、纳差、腹胀者加沉香末、木香、大腹皮、厚朴、苡仁；全身浮肿、小便量少、腹空痛者加红参、防己、泽泻、苡仁；尿检红细胞增多者加银花炭、生地、茅根、金钱草；尿蛋白加山萸、菟丝子、楮实子、韭子、石苇、赤小豆、木通、海金沙、瞿麦。

方二：青蒿蜜丸，每丸10克，每次服1—2次，每日服3次。或用青蒿30克，泡开水当茶饮。

方三：昆明山海棠片，每次服2—4次，日服3次，饭后服。或用火把花片，每次2—4片，日服3次，饭后服。

方四：青蒿30克，(后下)，党参60克，生地60克，^内紫草30克，蜈蚣2条，穿山甲15克，土鳖虫12克，桃仁10克，山萸肉30克，当归30克，丹参30克，石斛30克，白花蛇10克，秦艽15克，银花30克，水煎服。

54. 干燥综合征

干燥综合征为自身免疫性疾病。主要临床表现包括三大症状：(1)干燥性角膜、结膜炎；(2)口腔干燥症；(3)伴发结缔组织疾病，其中最常见者为类风湿性关节炎。三大症状中只具备二者即可诊断为干燥综合征。如只有口眼干燥症群亦可改称为口眼干燥综合征，绝大多数患者为女姓。

临床表现

(1)干燥性角膜、结膜炎。患者自感眼干，眼痒，有眼内异物感及眼内烧灼感，缺少眼泪，碎屑进入眼内可引起暂时的视力模糊。

(2)口腔干燥症。患者感口干，缺少唾液，味觉减退，舌及口角干裂疼痛，吞咽干食物有困难，需喝水帮助吞咽。唇干无光泽。不仅口腔干燥，而且鼻腔也干燥结痂，易出血，嗅觉不灵，声音嘶哑。支气管粘膜也干燥，干咳，痰稠粘不易咳出。皮肤干燥，阴道也干燥。

(3)结缔组织疾病。最常见者为类风湿性关节炎。

干燥综合征属于祖国医学的“燥证”范畴。由于阴津不足，官窍失于濡润。《素问·阴阳应象大论》说：“燥胜则干”。《素问玄机原病式》说：“诸涩枯涸，干劲皴揭，皆属干燥”。《医门法律》所记述的“……嗑干面尘，身无膏泽，足外反热，腰痛惊骇筋挛，……目昧眦疮”等燥证病情论述与干燥综合征十分相似。祖国医学认为“脾主散精”，“脾主升清”，“脾开窍于口”，一身之阴津赖于脾之健运，方能“水精四布，五经并行”。因此，干燥综合征患者不仅有阴津亏乏的症状，同时亦往往有气虚之象。其治疗，宜滋阴补气，方能“气旺津生”。

辨证分型治疗

（1）燥热犯肺。身热恶风，甚则高热，咽喉灼痛，咳嗽痰黄，口干舌燥，眼目干涩，皮肤、鼻腔干燥，舌红少津，脉浮数。治宜清宣凉润，益肺养阴。

方药：桑叶30克，杏仁12克，知母12克，沙参30克，生地30克，桔梗12克，菊花15克，石斛15克，麦冬30克，黄芩30克，枸杞15克，板蓝根30克，水煎服。

（2）气阴两虚。面眺无华，动则气急，口唇干燥，眼干涩无泪，口渴欲饮，皮肤、鼻腔及阴道均干燥，大便秘结，舌红少津，脉细数。治宜益气养阴，壮水润燥。

方药：生地60克，玉竹12克，枸杞15克，麦冬30克，五味子15克，太子参30克，沙参30克，石斛15克，黄芪30克，黄精15克，旱莲草30克，水煎服。

（3）阴虚内热。头晕、眼目干涩灼痛，鼻干心烦，皮肤皴裂，失眠多梦，纳差，味觉减退，大便结燥，舌红苔少，有裂纹，脉细数。治宜甘凉濡润，生津救燥。

方药：地骨皮30克，生地60克，石斛30克，知母12克，玉

竹12克,天花粉12克,淮小麦30克,大枣30克,甘草10克,首乌15克,鳖甲15克,青蒿30克,水煎服。

验方治疗

方一:六味地黄丸,每次服20克,每日服3次。连服1—3个月。

方二:桑椹30克,生地60克,山萸30克,枸杞15克,沙参30克,麦冬30克,川楝子10克,当归30克,桑寄生30克,火麻仁12克,黑芝麻15克,各研细末混匀,炼蜜为丸,每丸重10克,早中晚各服2丸,开水送服。连服2个月。

以上二方均从滋补肾阴着手,治疗干燥综合征效果良好。肾阴为先天之本,是人体阴液的源泉,对五脏六腑;四肢百骸有濡养滋润作用,肾阴充而肝阴、肺阴、胃阴满,肾阴虚则肝阴、肺阴、胃阴亏。故从滋养肾阴,填补阴血着手,辅以舒肝、润肝、滋胃之药,似为治疗干燥综合征的一条新的途径。

55. 强直性脊柱炎

强直性脊柱炎是一种原因不明的慢性炎性疾病,属多发性关节炎的一种类型。发病年龄多在15岁以后,最多的是21—30岁,其中青年男性患者占多数,男与女之比约为14:1。虽然病因尚未查清,但很多学者认为,本病属结缔组织的血清阴性疾病。

强直性脊柱炎起病缓慢,逐渐加重,病程较长。患者在早期感到两侧骶髂部及下腰部酸重、疼痛,或觉腰部僵硬,转侧不利,或不能久坐。其病情在劳累、活动过度之后加

重，休息后病情又缓解；或者在早晨腰部僵硬，适当活动后减轻。患者常将躯干及髋关节蜷曲起来，因为这种姿势可缓解疼痛。本病如果不及时治疗，或治疗不当，腰部疼痛逐渐向上发展，累及胸椎和肋椎关节时，胸部的扩张活动受限，呼吸不畅，有紧裹不适之感、咳嗽、喷嚏可使病情加重；病变进一步累及颈椎时，表现为头部活动不利，诸如后伸、侧弯、侧旋都受限制。最后累及脊椎时，可完全强直或出现驼背样畸形。最严重者，脊柱强直，向前屈曲呈 90° 的形状，使病者不能平视前方。若髋关节受累，则走路困难。一般来说，本病的病损是以躯干关节为主，偶可波及髋关节。

强直性脊柱炎的许多表现和类风湿性关节炎很相似，但此非彼，不可混为一谈。如在发病年龄、性别、遗传因素、患病部位和对治疗的反应，两者都有明显的区别。部份患者可能同时患有这两种疾病，而且先有类风湿性关节炎。本病比类风湿性关节炎的发病率低，有明显的遗传影响，很少波及四肢的小关节。

强直性脊柱炎从X线片上看，早期照片可见髋髋关节和椎间关节的间隙变宽，关节边缘呈锯齿状，软骨有硬化致密改变，以后关节面渐趋模糊，间隙变窄；后期可见双侧髋髋关节完全融合，椎体间的纤维环、前后纵韧带发生骨化。

中医的文献中没有强直性脊柱炎这个病名，但有类似的记载，如《灵枢·寒热病》记载有骨痹，举节不用而痛，汗注，烦心”。《素问·长刺节论》又说：“病在骨，骨重不可举，骨髓酸痛，寒气至，名曰骨痹”。由此可见，本病属“骨痹”范畴。根据临床体会，疼痛在夜间加重，多为血淤之征；脚后跟痛，多为阴虚之兆；腰部怕冷，得热痛减，又是阳虚的表现。

若见腰腿疼痛，腰背强直，僵硬，有沉重感，俯仰困难，转侧不利，遇寒痛剧，得热痛减，怕冷，四肢不温，舌质淡，苔薄白，脉细缓。此类属阳虚型。

若见腰腿痛，关节肿胀，腰脊强直，活动受限，口干苦，怕热，脚后跟痛，心烦失眠，小便黄赤，舌质红，脉滑数。这种情况属阴虚型。

证见腰腿痛，痛在夜间加剧，或有刺痛，腰脊僵硬，活动受限，乏力，双下肢肌肉萎缩。舌质淡黯，有淤斑或青紫，舌下静脉迂曲、粗长，苔白，脉弦，可判为血淤型。

除腰背痛之外，兼见口干，不欲饮。舌红，苔黄厚腻，脉濡。此种类型可定为湿热型。

方一：制川乌10克（先煎），制草乌10克（先煎），炙甘草10克，熟地30克，当归15克，川芎10克，独活12克，乳香10克，没药10克，桑寄生30克，细辛5克，蜂房10克，红花10克，桂枝10克。水煎服。适用于阳虚型。

方二：制附片15克（先煎），肉桂10克，淫羊藿20克，制草乌10克（先煎），雷公藤15克，鹿角霜10克，桑枝30克，巴戟天12克，狗脊15克，杜仲15克，牛膝12克，鸡血藤30克，水煎服。适用于阳虚型。

方三：白芍25克，甘草10克，生地30克，麦冬15克，丹参15克，木瓜15克，乳香10克，没药10克，蜂房10克，五味子6克，川断12克，桑寄生30克，知母10克，细辛5克，独活12克，水煎服。适用于阴虚型。

方四：当归15克，白芍15克，川芎10克，熟地20克，独活12克，桑寄生30克，鸡血藤30克，海风藤30克，秦艽12克，防风12克，石斛10克，银花藤30克，水煎服。适用于阴虚型。

方五：丹参30克，当归15克，乳香10克，没药10克，全蝎10克，地龙12克，蜂房10克，土鳖虫10克，桂枝10克，熟地15克，炙甘

草10克，独活10克，细辛5克，水煎服。适用于血淤型。

方六：桃仁10克，红花10克，鸡血藤30克，地龙12克，当归15克，牛膝12克，骨碎补12克，雷公藤15克，桂枝15克，沙蒺藜15克，姜黄12克，威灵仙15克，乌梢蛇12克，水煎服。适用于血淤型。

方七：黄柏10克，苍术10克，牛膝12克，苡仁30克，秦艽12克，白附子10克，防己10克，独活12克，川断12克，徐长卿20克，蜣螂虫5克，石楠藤30克，水煎服。适用于湿热型。

方八：黄柏12克，木瓜15克，泽泻15克，苡仁30克，防己12克，连翘12克，葛根12克，猪苓15克，羌活12克，苍术12克，当归15克，茵陈12克，防风12克，水煎服。适用于湿热型。

妇 产 科

56. 外 阴 溃 疡

外阴溃疡属于外阴部炎症。外阴部可由细菌或病毒感染，发生大小不等一个或数个溃疡，称为外阴溃疡，多发生于小阴唇内外两侧，有较重的烧灼痛，溃疡面上有较多分泌物。有时同时发生口腔粘膜溃疡、眼及外阴部溃疡。

外阴溃疡属于祖国医学的“阴痒”、“阴蚀”范畴。多由湿热之邪流注下焦所致。治宜清热利湿解毒。

内治方

方一：白藓皮30克，土茯苓30克，银花30克，鱼腥草30克，黄柏10克，泽泻10克，篇蓄10克，瞿麦10克，木通6克，甘草6克，水煎服。

方二：龙胆草10克，黄芩12克，山栀12克，泽泻30克，当归12克，生地30克，茵陈30克，地肤子30克，水煎服。

外治方

方一：苦参、蛇床子、川椒各15克，黄柏、防风各10克，食盐8克，煎汤洗涤外阴部或坐浴。

方二：蛤粉30克，黄柏末60克，薄荷1克，共研细末，调水外涂患处。

方三：青黛30克，滑石30克，冰片3克，共研细末，外搽患处，或调水外敷。每日2次。

方四：雄黄、樟丹各6克，冰片1.2克，制没药、制乳香各8克，共研细末，香油调成糊膏。先洗净外阴。将药膏涂于患处，每日1—3次。

57. 前庭大腺炎

前庭大腺炎是妇女外阴部炎症的一种。前庭大腺位于两侧大阴唇的下方，腺管开口于小阴唇内侧。由于前庭大腺解剖部位的特点，在性交、分娩或因其他污物接触致使外阴部感染细菌而导致本病。

感染初期。小阴唇局部红肿热痛，腺体粘膜充血水肿，局部可分泌大量脓液。当腺管肿胀，管口粘连堵塞，分泌物不能排出，便形成前庭大腺脓肿。检查脓肿局部有波动感，轻压腺体，可见脓液自管口流出。此时病人疼痛加重，行走困难。如未及时治疗，脓肿可自行破溃，脓液溢出。

急性感染期。患者可有全身症状如发热、倦怠、尿赤、便少、白血球总数升高等。

若急性炎症消失，有时可形成囊肿。病人可无自觉症状，多不注意。检查时可在小阴唇后部、处女膜外侧触及囊性肿物，大小不等，一般如枣或鸽蛋大小，无压痛，常单侧发生，可反复急性发作。

前庭大腺炎属于祖国医学“痈肿”、“疔瘰”范畴。多由毒邪外侵，正气虚弱而致痈肿。治宜清热解毒，活血化淤。

方一：赤芍30克，丹参30克，板蓝根80克，炮山甲15克，败

酱草30克，车前草30克，银花30克，水煎服。

方二：鸡血藤60克，当归30克，赤芍30克，银花30克，紫花地丁30克，丹皮12克，皂刺12克，三棱10克，水煎服。

急性期尚未化脓者，可用银花60克，紫花地丁30克，败酱草60克，煎水坐浴。

58. 老年性阴道炎

健康妇女，阴道本身能自洁，有自然防御功能。如青春期后，由于雌激素的影响，阴道上皮由单层变为复层，上皮细胞含有糖原，上皮细胞脱落后，阴道杆菌将糖原转化为乳酸，使阴道变成酸性(pH值4—4.5之间)，即能抑制其他细菌生长。若上述防御功能被破坏，病原菌侵入后便可导致阴道炎症。

老年性阴道炎发生于绝经期妇女，由于卵巢功能衰退，雌激素水平低落，阴道上皮萎缩，缺乏糖原，使阴道酸性降低，局部抵抗力减弱，致病菌得以繁殖而引起炎症。

老年性阴道炎的临床表现：阴道分泌物增多，呈黄色水样或脓性，有时为少量血性分泌物，可有气味，部分病人外阴有烧灼感，不痒。检查时外阴、阴道潮红，有脓性分泌物，阴道粘膜萎缩，皱折消失，无弹性，有时可见散在的出血点或表浅溃疡。

中医认为，老年性阴道炎由于肾气衰，天癸竭，气血弱，致使阴道失去防御能力，从而导致炎症。治宜滋肾益脾，清热解毒。

内服方

生地15克，熟地30克，山药30克，巴戟15克，枸杞15克，女

贞子30克,旱莲草30克,土茯苓30克,地榆15克,白术12克,水煎服。

外治方

方一:苦参、蛇床子各30克,黄柏15克,煎水熏洗患处,每日1—2次,或将以上药液用纱布过滤后冲洗阴道,日1次。

方二:黄连、黄柏、姜黄各4.5克,当归7.5克,生地18克,香油180克,黄蜡45克。以香油浸药2日,文火熬枯去渣,再煎入蜡成膏。用带线消毒棉栓,蘸药膏纳入阴道内,隔日更换一次。

59. 子宫内膜异位症

子宫内膜异位症是子宫内膜样组织长于子宫内壁以外部位的疾病。由于异位之内膜,在激素作用下不断的增生、分泌反应、脱落和出血,从而造成一系列的症状和体征。

子宫内膜异位症一般多发生于30—45岁妇女,常伴有不孕症。怀孕以后,病变和症状能缓解甚至痊愈。绝经以后卵巢功能消失,病变随即逐渐萎缩吸收。

子宫内膜异位症常见的症状有:

(1) 痛经。约半数病人以痛经为主要症状。痛经的特点是继发性和进行性加重。疼痛的部位开始在下腹、直肠,亦可扩展到腰骶部和大腿。往往于月经前1—2天开始痛,到月经干净后才缓解。此外尚有性交疼痛、肛门坠痛等。

(2) 不孕症。

(3) 月经紊乱。月经量多,经期延长或月经周期不规则。

(4) 脐部、腹壁伤痕、阴道或宫颈出现疼痛的蓝色结

节，在月经期明显增大。

(5) 少数病人可有低烧。

子宫内膜异位症的体征，随病变发生的部位而不同：病变在子宫时，子宫呈结节性增大，质比一般肌瘤要硬；病变在盆腔腹膜时，子宫呈后倾后屈位，周围增厚，活动受限，可在子宫直肠陷凹或子宫骶骨韧带上触及硬结节，有明显压痛，这些硬结节在月经期则增大；病变在卵巢。在一侧或双侧附件部位时可触及有粘连的囊性包块；病变在阴道或子宫颈时，可在后穹窿或宫颈粘膜下看到紫蓝色小结节。

子宫内膜异位症属于祖国医学的“痛经”、“症瘕”等范畴。《金匱要略》说：“经水不利，少腹满痛”，《医学入门》记载：“血滞淤积于中，与日生新血相结搏则为疼痛”，《医林改错》中有关少腹逐淤汤的用法，有如下的描述：少腹结块疼痛，或有结块而不疼痛，或痛而无块或少腹胀满，或经血来时先腰酸少腹胀或经血一月三、五次，接连不断，断而又来，其色或紫或黑或块或崩漏兼少腹疼痛……皆能用少腹逐淤汤治之。这里所列举的一系列症状，基本上是与子宫内膜异位症的一系列临床表现相符合的。

中医认为子宫内膜异位症的病因病机多因七情所伤，肝气郁结所致。气郁必致血凝血淤，聚而成症瘕，淤血阻滞经脉而致痛经。淤积日久不消，则化湿热，蕴结下焦，加重痛经，影响生育。总之，气滞血淤、症瘕积聚的形成是病理过程中的重要环节。

中药口服治疗

(1) 痛经型主方。柴胡10克，赤芍30克，丹参30克，丹皮10克，玄胡10克，川楝子10克，香附12克，广木香10克，生蒲黄10克，五灵脂10克，红藤20克，败酱草30克，夏枯草30克，煅牡

蛎20克，水煎服。

加減：经前一周痛经者用玄胡15克，另加黄柏、山梔、银花、没药、茴香，去夏枯草、牡蛎；月经期痛经者加玄胡用至15克，另加乌药、莪术、没药；排便肛门疼痛者加茴香、升麻、银花藤；粘连腹胀者加大腹皮、桃仁、陈皮、青皮、生军；有症瘕者加炙鳖甲、半枝莲、白花蛇舌草、三棱、莪术。

患者经前一周及月经期间服汤药（方药如上述）。平时则服成药：大黄廑虫丸、桂枝茯苓丸、延胡索片、复方丹参片等均可服用。

（2）月经过多型主方。党参30克，黄芪30克，白芍12克，白术12克，煅牡蛎30克，夏枯草10克，旱莲草30克，生蒲黄15克，仙鹤草15克，丹参30克，丹皮12克，生地炭12克，水煎服。

加減：同痛经型。

经前七天就要开始服药，每日一剂。

（3）痛经伴月经过多型治疗。经前一周服痛经型主方，配加党参、黄芪、旱莲草等，去木香、香附。经净后选服养血止崩剂（当归30克，白芍30克，仙鹤草30克，黄芪30克，党参30克）及乌鸡白凤丸。

外敷治疗

肿块近腹壁者，采用外敷治疗。可敷贴麝香止痛膏或麝香虎骨膏。

中药灌肠治疗

肿块位于子宫直肠陷凹者，可采用中药保留灌肠法治疗。处方：红藤30克，败酱草30克，三棱10克，莪术10克，玄胡12克，丹皮12克，丹参30克，白花蛇舌草30克，黄柏12克，加水浓煎，药液待温后保留灌肠。

60. 精神药物性乳溢症

乳溢症是指女性在非哺乳期，非妊娠后期，乳房出现乳汁分泌现象，男性也出现乳汁分泌现象者。其病因有多种，其中之一为精神药物（治疗精神病药物，如氯丙嗪等）引起。故名为“精神药物性乳溢症”。现代医学认为，精神药物性乳溢症是由于精神药物抑制了下丘脑催乳素抑制因子的释放，导致催乳素分泌增多。

祖国医学认为，乳汁同冲脉及脾之功能有密切关系。明代医家薛立斋说：“血者水谷之精气也，和调五脏、洒陈六腑，妇人则上为乳汁、下为月经”。《素问》说“冲脉者，起于气街，并少阴之经挟脐上行，至胸中而散”。《难经》说：“脾主裹血”。乳汁的正常分泌一方面受到冲脉的调节，另一方面又受到脾气的统摄。乳溢症患者的乳汁分泌失常，是由于冲脉与脾的功能失调所致。

中药治疗

白术15克，茯苓20克，党参30克，甘草10克，当归15克，芡实30克，莲米15克，益智仁12克，巴戟12克，菟丝子15克，五味子30克，茜草10克，黄芪60克，黄精30克，水煎服。

针灸治疗

取穴：公孙（双），直刺1寸，每日1次，每次留针20分钟，隔10分钟捻转一次。乳溢消失即停止治疗。

61. 妊娠小便不通

妊娠期间，孕妇饮食如常，但小便不通，小腹胀满，甚

者胀急疼痛，烦躁，不得安眠。

妊娠小便不通，祖国医学称之为“转胞”。《金匱要略》说：“妇人病，饮食如故，烦热不得卧，而反倚息者，何也？此名转胞，不得溺也”。多由孕妇素体虚弱，中气不足，妊娠后期胎儿渐大，气虚无力举胎，胎胞下坠，压迫膀胱，水道不通，尿不得出。若孕妇肾气素虚无力系胞，胞胎下压膀胱；或肾虚不能温煦膀胱化气行水，致尿不得出。

辨证分型治疗

（1）气虚型。妊娠期间，小便不通，小腹胀急而疼痛，神疲乏力，头重眩晕，心悸气短，坐卧不安，大便不畅，舌淡苔薄，脉虚弱。治宜补气养血，升陷举胎。

方药：黄芪60克，党参30克，白术15克，桔梗10克，当归10克，桂枝10克，通草10克，陈皮6克，升麻6克，柴胡10克，水煎服。

（2）肾虚型。妊娠期间，小便不通，小腹胀痛，坐卧不宁，头晕，腰膝酸软，面色晦暗，畏寒肢冷，舌淡苔薄，脉沉无力。治宜温肾扶阳，化气行水。

方药：熟地30克，山药30克，菟丝子12克，续断30克，泽泻30克，肉桂6克，巴戟12克，水煎服。

外敷药物治疗

（1）甘遂24克，研细末，用面糊捏成饼，敷贴脐下，另用甘草18克，煎汤频服，小便立通。

（2）冬葵子、滑石、梔子各等份为末，用葱汁调敷脐中。

62. 子宫外孕（异位妊娠）

子宫外孕又称宫外孕、异位妊娠。是妇产科常见的急腹

症之一，严重危害妇女的健康。过去手术是根治本病唯一的方法。近年来经中西医共同研究，正确认识和处理宫外孕的止血与活血、补与泻、治标与治本的关系，采用以中药为主的非手术疗法取得较好疗效。使绝大多数患者避免手术痛苦，并保留了不少无子女妇女的再孕机会。

宫外孕是指孕卵在子宫腔以外着床发育。由于孕卵着床部位不同，分别称为输卵管妊娠、腹腔妊娠、卵巢妊娠等，其中以输卵管妊娠最常见。输卵管妊娠是因卵子在输卵管受精后，由于通道被阻或行动迟缓，孕卵未达到子宫腔内已具备着床能力便植入输卵管的某一部分而发育，即成输卵管妊娠。这种孕妇在妊娠之前，大多有过慢性输卵管炎或慢性盆腔炎，多有长久不孕的历史。输卵管妊娠时，孕卵发育至45—60天（体积如桂圆肉大），由于输卵管不可能容许其继续成长（大多在停经2个月左右）便不可避免的出现输卵管破裂流产，造成腹腔内不同程度的出血。

临床表现：

（1）输卵管妊娠未破损前，往往无明显症状，有时病人停经后有早孕征象，或同时在下腹一侧有隐痛或憋胀感。妇科检查：子宫稍大变软，与停经月份不符。一侧附件处可有较小的软性包块，轻度压痛，尿妊娠试验阳性。

（2）输卵管妊娠破损（流产或破裂）后，症状体征皆较典型。

① 停经。多数病人在发病前有长短不一的停经史。

② 腹痛。病人突感下腹一侧有撕裂样疼痛或阵发性绞痛，持续或反复发作，伴恶心呕吐。随着病情发展，疼痛可扩展至全腹，甚至引起胃部疼痛或肩部反射痛，并有肛门坠胀和排便感。

③ 阴道不规则出血。有时呈点滴状。

④ 休克。内出血愈多愈急，休克愈严重。病人面色苍白，脉搏快而弱，血压下降。

输卵管妊娠破损后，体温一般正常。如合并感染，则体温可升高，在血液吸收过程中可出现低烧。

子宫外孕属于祖国医学的“症瘕”、“坠胎”、“经漏”等范畴。其病因病机是由于冲任损伤，冲脉受阻，孕胎不正，郁滞于胞脉而致气血运行不畅，瘀血内阻，新血不宁，迫血妄行，离经之血瘀积腹中出现里急、气逆、腹痛为主的少腹血瘀证。

辨证分型治疗

(1) 已破损型。

① 休克型（气血虚脱）。妇女停经2—3个月内，有妊娠反应，尿妊娠试验阳性。孕妇突然发生下腹一侧绞痛或撕裂痛，面色苍白，四肢厥逆，冷汗淋漓，头晕眼花，恶心呕吐，血压下降或烦躁不安，或表情淡漠，脉微欲绝。治宜益气回阳救脱。

方药：红参30克，制附片15克，急煎成浓汁，一次顿服，并配合输血输液。休克好转后，再服下方治疗。

当归15克，赤芍15克，丹参30克，桃仁10克，桂枝10克，茯苓15克，水煎服。

② 不稳定型（少腹血瘀）。宫外孕破损地方不大，时间不长，内出血不多，或一次短时间休克，经治疗后一般情况又趋平稳，但有反复出血的可能，病情不够稳定；腹痛拒按，但逐渐减轻，胚胎已死亡或尚存活，下腹可发现包块。舌质淡红，脉沉细或涩。治宜活血祛瘀止痛。

方药：赤芍30克，当归15克，丹参30克，桃仁12克，乳香10克，没药10克，三棱6克，莪术6克，水煎服。

加减：便秘者加玄明粉。

③ 包块型(症瘕积聚)。宫外孕破损时间较长,腹腔内出血形成的血性包块很局限,病人腹痛减轻,胚胎多已死亡,阴道流血基本停止。舌质淡红,脉涩或沉细涩。治宜消症散结。

方药：三棱10克,莪术10克,丹参30克,赤芍15克,桂枝10克,茯苓15克,桃仁10克,丹皮10克,水煎服。

加减：阴道流血未止者加生牡蛎、益母草。体力虚弱者加黄芪、党参。

(2) 未破损型

输卵管妊娠尚未破损以前,患者往往有早孕反应,有下腹一侧隐痛或坠胀不适感,下腹可触及软性包块,有压痛。尿妊娠试验阳性。舌质淡红,脉弦涩。治宜活血化淤消症。

方药：川牛膝30克,三棱12克,莪术12克,桃仁12克,丹参30克,赤芍30克,天花粉12克,蜈蚣1条,猪牙皂8克,水煎服。还可同时注射天花粉素(注射前必须做皮试)。

63. 先兆流产

流产系指妊娠28周以前,胎儿在子宫内尚未发育到能存活的阶段而妊娠中断。

从时间概念上来区分,流产发生在妊娠12周以前称为早期流产;在妊娠12—28周内的流产为晚期流产。

按临床发病过程和转归来区分,流产可分为先兆流产、难免流产,不全流产、完全流产、稽留流产(过期流产)及习惯性流产(习惯性流产在《百病良方》第一集中已作过介绍)。

流产原因:

(1) 胚胎方面的因素：①胚胎发育异常，②胎盘梗塞或发育不良，妨碍胎儿营养的供应。

(2) 母体方面的因素：①内分泌功能失调，影响孕卵或胚胎的发育。②生殖器局部病变，如子宫发育不良、子宫畸形、子宫肌瘤等影响胎儿的生长发育而导致流产。③周身疾病，如妊娠期间患流行性感、肺炎、伤寒等急性传染病，高烧时可引起子宫收缩而致流产。细菌毒素或病毒通过胎盘进入胎血循环，使胎儿死亡而发生流产。其他如严重贫血、心力衰竭、慢性肾炎等均可引起流产。④外界因素，如手术、外伤、过度疲劳均可导致流产。

先兆流产

先兆流产主要表现为闭经后阴道少量出血（比正常月经量少），开始血为鲜红色、粉红色，渐变为深褐色。存在早孕反应，有时伴有轻微下腹痛、腰痛腹坠。妇科检查时见子宫口未开，子宫大小与妊娠月份相符，尿妊娠试验阳性。如胚胎出血停止，无子宫收缩，妊娠可以继续。

先兆流产属于祖国医学的“胎动”、“胎漏”、“胞漏”等范畴。《女科经纶》说：“妊娠胎动不安者，由冲任经虚，受胎不实也；亦有饮酒房室过度，损动不安者；有忤触伤扑，而动不安；有怒气伤肝，或郁结不舒，触动血脉不安；有过服暖药并犯禁之药，动而不安；有因母病而胎动者”。中医认为“胎漏”多由肾虚、气血虚弱、血热、外伤等所致。①肾虚。禀赋素弱，先天不足，肾气虚怯，或纵欲不节，耗伤肾气。肾为生胎之元，乃胞脉之所系，肾虚则冲任不固，胎失所系，而致胎漏、胎动不安。②气血虚弱。平素体质较弱，脾胃亦虚。脾胃为气血生化之源，化源不足，以致气血虚弱，冲任不固。气虚不能摄血载胎，血虚不能滋养

胎元，而致胎漏、胎动不安。③血热。素体阳盛，或嗜食辛辣，或过服暖宫药物，或肝郁化热，复加孕后血聚于下以养胎，阴虚阳盛，以致血热。热扰冲任，迫血妄行，引起胎漏、胎动不安。④外伤。孕后起居不慎，劳力过度，跌扑闪挫，损伤气血，气血紊乱，冲任不固，胎元受损，发为胎漏，胎动不安。

辨证分型治疗

(1) 肾虚先兆流产。妊娠期间，腰部酸痛，小腹下坠，阴道流血，伴有头晕耳鸣，两腿酸软，小便频数（甚至失禁），舌质淡红，苔薄白脉沉细弱。治宜益肾气，安胎元。

方药：桑寄生30克，菟丝子30克，续断30克，阿胶12克，杜仲12克，水煎服。

加减：气虚者加党参、黄芪、白术；下血者加艾叶炭、棕榈炭；腹胀纳差者加砂仁、苏梗、陈皮；腹痛者加香附；小便失禁者加益智仁。

(2) 气血虚弱先兆流产。妊娠期间，胎动下坠，腰酸腹痛，阴道流血，精神萎靡，周身乏力，面色㿔白，皮肤不润，舌质淡，苔薄白脉细滑或沉弱。治宜补气养血安胎。

方药：白术15克，熟地20克，党参30克，黄芪30克，黄芩12克，当归10克，白芍12克，砂仁6克，炙甘草10克，糯米1撮，水煎服。

加减：气虚下坠者加升麻；纳少腹胀者加陈皮；腹痛者加香附。

(3) 血热先兆流产。妊娠期间，阴道流血，血色鲜红，胎动下坠，小腹作痛，口干咽燥，渴喜冷饮，或身热心烦，大便干，小便黄，舌质红，苔黄而干，脉滑数。治宜清热凉血，益阴安胎。

方药：山药30克，生地30克，熟地30克，续断30克，白芍30克，

黄芩12克，黄柏12克，甘草6克，香附12克，杜仲15克，水煎服。

(4) 外伤先兆流产。妊娠期间，有明显受伤史，受伤后腹痛腰酸，胎漏下血，脉滑无力。治宜益气养血，固肾安胎。

方药：桑寄生30克，杜仲12克，菟丝子20克，续断30克，党参30克，黄芪30克，白术12克，阿胶12克，香附12克，苏梗10克，陈皮10克，砂仁6克，水煎服。

64. 稽留流产

稽留流产，又称过期流产。胚胎或胎儿已在宫内死亡而未排出，稽留于子宫内，故称稽留流产。稽留时间可拖延1—2个月以上。多数病人曾有过先兆流产症状，以后子宫不再长大，妊娠反应消失，偶有少量的阴道出血，血呈暗褐色。妇科检查时见子宫小于妊娠月份，尿妊娠试验阴性。部分妇女死胎可自然排出，如死胎日久未排出，胎盘组织机化，与子宫壁粘连不易完全剥离，流产时易发生出血。

稽留流产属于祖国医学的“胎死不下”、“胎死腹中”的范畴。由于肾虚、气血虚、血热、外伤等因素，使胎死腹中。由于胎死血淤，淤久腐臭，上蒸脾胃，故口臭恶心；淤血内阻，气机不畅，故腰腹胀满，小腹发凉；血淤经脉，故患者唇暗舌紫，脉沉涩。治宜行气活血祛淤。

方一：当归30克，川牛膝30克，川芎12克，红花12克，车前子12克，肉桂6克，益母草30克，厚朴10克，水煎服。

方二：大黄12克，益母草30克，枳壳10克，桂枝12克，茯苓15克，桃仁15克，丹皮12克，赤芍30克，水煎服。

65. 难免流产

难免流产由先兆流产发展而来，继续妊娠已不可能。阴道出血量加多或有血块。由于子宫收缩导致下腹阵发性剧痛。妇科检查见宫口已开，有时可见胚胎组织堵塞于子宫口。子宫大小与停经月份相符或稍小。妊娠试验多为阴性。晚期难免流产除有上述症状、体征外，可有羊水流出或见胎胞堵塞子宫口。

中医认为难免流产病因与先兆流产相同，只是肾虚、气血虚、血热、外伤等程度比先兆流产更为严重。

难免流产的中医治疗，应根据停经时间长短而定，一般只适应妊娠8周以内者，妊娠大于8周者则应手术治疗。

治疗原则：温通冲任，活血催胎。

方药：当归30克，川牛膝30克，川芎12克，红花12克，车前子10克，肉桂6克，益母草30克，马齿苋30克，水煎服。

66. 完全流产

完全流产是指通过先兆流产及难免流产过程，在短时间内胚胎组织完全排出者。在此过程中，可有剧烈腹痛和阴道出血。待胎儿、胎盘、蜕膜组织完全排出后，阴道出血逐渐停止，腹痛随之消失。妇科检查见宫口关闭、子宫大小接近正常。

中医认为完全流产后淤滞解除，气血得通，只需益气补

血佐以活血即可。

方药：黄芪30克，党参30克，当归30克，川芎10克，炮姜炭10克，炙甘草10克，益母草30克，熟地15克，水煎服。

67. 不完全流产

不完全流产是在难免流产的基础上，部分胚胎组织已排出，因宫腔内仍残留部分胚胎组织，仍有腹痛及阴道出血。妇科检查见宫口已开，常可发现胚胎组织堵塞宫口。子宫大小比停经月份小。妊娠试验常为阴性。严重出血可发生休克。此外，残留在宫腔内的胚胎组织容易引起感染，时间愈长，感染机会就愈多。

中医认为不完全流产多由瘀血内阻，气机不畅，或由气虚宫缩乏力，无力排出残留胚胎，属气虚血瘀。治宜活血，行气，祛瘀。

方药：川芎15克，当归30克，党参30克，黄芪30克，生蒲黄10克，五灵脂10克，川牛膝30克，益母草30克，马齿苋30克，水煎服。

68. 感染性流产

在流产过程中，特别是在不完全流产的过程中，或流产后的短时间内发生的感染，称为“感染性流产”。残留在宫腔内的胚胎组织易引起感染，残留时间愈长，感染机会愈多。

感染性流产的临床表现有：发烧、腹痛、自阴道流出脓血性有臭味的分泌物，血白细胞总数及中性粒细胞均增高。

中医认为，流产过程中正气虚衰，抗邪之力下降，正不胜邪，邪伤胞络，引起感染症状。治宜清热解毒。

方药：银花30克，连翘15克，紫花地丁30克，蒲公英30克，野菊花15克，甘草10克，黄芪30克，鱼腥草30克，土茯苓30克，水煎服。

69. 羊水过多症

羊水量超过2000毫升，称为羊水过多。大多发生在妊娠28周以上。羊水量在短时期内很快增加者，称为急性羊水过多；若在较长时间内渐渐增加者，称为慢性羊水过多。

羊水过多与胎儿畸形有密切的关系。

羊水过多症可引起早产或死胎，在分娩时亦常引起子宫收缩无力，胎盘早期剥离或产后大出血等。

羊水过多症的临床表现

急性羊水过多症，较少见。其出现时间较早，大多在妊娠5—6个月左右，症状也较严重，孕妇自觉腹部迅速增大，有明显压迫症状；腹部胀痛，呼吸困难，心悸，不能平卧，行动不便，消化不良，呕吐及便秘等。

慢性羊水过多，多出现在妊娠晚期，时间较长，子宫逐渐增大，孕妇多可适应，自觉症状较轻。往往因羊水过多，导致胎位不正，或因宫腔内压力高，较易发生早产。

羊水过多的孕妇，腹壁紧张，皮肤发亮，子宫大小比妊娠月份大，腹部有液体震荡感，胎位不清，可有胎体浮沉

感，胎心音较远或听不到。必要时可作腹部X线检查。

羊水过多症属于祖国医学之“胎水肿满”范畴。中医认为本病的产生主要是由于脾阳素虚。妊娠期间，阴血聚以养胎，脾阳不运，以致水湿不行，积留胞中。治宜健脾行水。

方一：茯苓10克，白术30克，木瓜30克，槟榔10克，猪苓15克，泽泻30克，苏梗10克，桑白皮15克，大腹皮12克，砂仁6克，水煎服。

加减：喘甚加葶苈子，肿甚加防己。

方二：鲤鱼一条（重250克以上，去鳞去肠），白术30克，生姜皮10克，白芍12克，当归15克，茯苓30克，陈皮6克，菟丝子12克，肉桂8克，水煎服，并食鱼肉。

注：若经上述治疗效果不显著，胎儿畸形之可能性较大，应另作处理。

70. 产后出血

产后出血是指胎儿娩出后24小时内阴道流血量达400毫升甚至更多，迅速出现失血性休克。或者由于失血使身体抵抗力降低，以致诱发产褥感染。

产生出血的病因

（1）子宫收缩乏力。胎盘娩出以后，子宫收缩乏力，不能使血窦受压闭合，以致出血不止。

（2）胎盘滞留。胎儿娩出后30分钟胎盘尚未娩出，妨碍子宫收缩，造成产后出血。

（3）软产道损伤。

（4）凝血障碍。

产后出血的临床表现有：短时间内大量出血，可出现失

血性休克，产妇自觉头晕，出冷汗，打呵欠，恶心，呕吐，呼吸迫促或辗转不安，面色苍白，表情淡漠，血压下降，脉搏细数。

产后出血属于祖国医学的“产后血崩”、“产后血晕”范畴。多由元气亏损，劳伤冲任，气血虚弱或气滞血瘀而致血崩，或因气虚寒凝而胞衣不下。

急救治疗

(1) 用铁器烧红淬醋，熏鼻。

(2) 针刺人中、中冲，灸百会、关元。

辨证分型治疗

(1) 血虚产后血晕。产妇分娩后，出血过多，突然头目眩晕，不能起坐，心慌，愤闷不适，渐至昏不识人，口噤不语，甚则四肢厥冷，出冷汗，面色苍白，脉微弱或浮大而虚。治宜益气固脱。

方药：红参30克，水煎徐徐灌下。回苏之后，继服以下方药：

黄芪30克，党参30克，当归15克，附片15克（先熬），荆芥穗6克，炮姜炭30克，水煎服。

(2) 血瘀产后血晕。产后恶露不下，或下亦很少，少腹阵痛拒按，甚则突然昏倒，神志不清，不省人事，呼吸迫促，牙关紧闭，面色暗红，口唇青紫，脉涩。治宜行血化淤。

方药：炒五灵脂15克，炒蒲黄15克，桃仁10克，荆芥穗6克，水煎取汁，兑入黄酒15毫升，童便一小杯，徐徐服下。

加减：呼吸急促而气喘者加杏仁10克，甘草6克。

儿 科

71. 小儿智能低下

智能是指人的各种能力的总和，包括观察力、记忆力、思维能力、想象力、注意力等。小儿智能低下可因先天和后天等多种原因引起。现代医学目前对此尚无特效疗法。

现代医学实验证明，成人的脑神经原在胎儿第12周时已经形成。小儿出生时大脑皮层细胞达140—150亿个，出生后其数目不再增多，以后的变化主要是细胞功能的日趋成熟和复杂化。神经胶质细胞的增值、髓鞘质形成及树状连结器的发育，大都在二岁以内完成。髓鞘质的形成需要足够的脑甾及蛋白质，脑甾的形成需足够的必需脂肪酸。动物实验证明缺乏必需脂肪酸时，将出现缺乏脑甾的髓鞘质，脑重量降低，行为异常。

中医治疗小儿智能低下时主要是用补肾健脑药。补肾健脑药，可能是通过某些未知的化学成分，改善脑细胞的代谢和上述三部分神经的发育。

祖国医学认为，智能是人体精、神、魂、魄、心、意、志、思、虑、智一系列精神活动的综合过程。它们之间的关系诚如《灵枢·本神篇》所说：“故生之来谓之精，两精相

搏谓之神，随神往来者谓之魂，并精而出入者谓之魄，所以任物者谓之心，心有所忆谓之意，意之所存谓之志，因志而存变谓之思，因思而远慕谓之虑，因虑而处物谓之智。”智能活动是以人体五脏的物质功能为基础的，所以《灵枢·本神篇》又说：“血脉营气精神，此五脏之所藏也。”如果五脏所藏之精气离失，则“志意恍乱，智虑去身”。小儿智能低下，除了后天因素之外，还与先天因素有关。《小儿卫生总微论方》说：“儿在母胎时，血气未全，精神未备，则动静喘息，莫不随母。母调适乖宜，喜怒失常，或闻大声，或有击触，母惊动于外，儿胎感于内，至生下百日以来，因有所犯，引动其疾”。《幼科发挥》说：“盖小儿之在胎也，母饥亦饥，母饱亦饱，辛辣适口，胎气随热，情欲无节，或喜怒无常，皆能令其子受患”。古代医家观察到胎生失养，禀赋不足，元阳虚亏常可形成发育异常，每于生后发病。

中药治疗小儿智能低下，疗效尚称满意。

辨证分型治疗

(1) 肝肾亏损型：小儿生长发育迟缓，四肢拘紧，手足拳挛，坐立行走艰难，严重者惊悸抽搐，动作异常。并见神乏，面色青白，唇淡，舌质淡，苔薄白，脉沉弦，指纹淡紫。治宜养肝补肾，柔筋祛风。

方药：桑寄生10克，桑椹子10克，五加皮10克，木瓜10克，伸筋草10克，当归6克，桑枝6克，淫羊藿6克，水煎服。

加减：手拳不展，足挛不伸者加苡仁、秦艽，腰软无力，坐不稳者加续断、何首乌；胆怯流涎者加茯神、远志、益智仁；惊搐者不安加蜈蚣，钩藤。

(2) 心肾不足型：智力发育障碍，或伴有轻微的动作异常，语言不清，反应迟钝，表情呆滞，伸舌流涎，识算

困难，学习笨拙。甚者痴呆，傻笑妄动，面色苍白，舌质淡，苔少，脉沉无力，指纹淡滞。治宜养心益气，补血安神。

方药：当归10克，茯神10克，益智仁10克，黑芝麻10克，菖蒲6克，远志6克，水煎服。

加减：语言不清者加黑豆；神呆健忘者加芡实；少眠难睡者加沙参、酸枣仁；嗜眠多睡者加通草、乌梅；神乱呼叫者加徐长卿、白藓皮。

（3）混合型：运动障碍和智力发育障碍，兼有以上（1）（2）型的症状。

方药：以上方剂综合化裁。

针药结合治疗

（1）穴位注射

穴位：①哑门、肾俞；②风池、足三里；③大椎、内关。单纯智力低下者，可轮流选择上述一组穴位，交替使用。

方法：头部穴位注射乙酰谷酰胺，四肢穴位注射活血注射液（含当归、红花、川芎、丹参），每穴注入药液1—2毫升，隔日1次，10次为一疗程，间隔7天，一般需5—7疗程。

（2）耳针

穴位：脑干、皮质下、肾、心穴。

方法：两耳交替，20日为一疗程，间歇10天，以4疗程为度。

中成药治疗

（1）天王补心丹：照说明书中成人的剂量减半服用。常服能增强小儿智能。

（2）孔圣枕中丹：照说明书中的成人剂量减半服用。

久服益智聪明，已为历代医家所肯定。

(3) 河车大造丸：照说明书中的成人剂量减半服用。严苍山先生对河车大造丸曾作过这样的评价：“河车大造丸‘大’谓天地，‘造’为造物，言此方之妙，夺天地造化之功”。此方补阴补阳，诸法具备，力量宏深，小儿智能低下，久服可收奇效。

(4) 六味地黄丸：照说明书中的成人剂量减半服用。此方不仅能治小儿智能低下，亦治成人肾亏。在六味地黄丸的基础上加减制成的左归丸、右归丸，改善智能的疗效更为明显。

验方治疗

(1) 鹿角粉6克(冲)，熟地20克，砂仁4.5克(捣碎)，生龙骨30克，炙龟版15克，石菖蒲9克，炙远志8克，丹参15克，益智仁6克，枸杞子9克，加水浓煎，制成100毫升“清脑益智合剂”，每次服10毫升，每日服2次。

(2) 红参粉，每次1克，每日服3次。

(3) 白术2份，人参2份，鹿茸粉1份，熟地2份，砂仁1份，炙甘草2份，杜仲2份，巴戟天2份，山萸肉2份，肉苁蓉2份，牛膝2份，菟丝子2份，当归2份，枸杞子3份，山药2份，连翘2份。

上药按比例配制，分别烘干粉碎，制成片剂(不制片剂，研成极细粉末也可)，每片0.3克，每次服1—3片，每日服3次。

以上介绍的改善小儿智能的方药，大多数药物是扶正固本药。据中药药理研究的资料提示，人参、党参、黄芪、白术、山药等能提高体力和脑力劳动的效率，有明显的抗疲劳和抗应激作用。人参能改善智力，增强记忆，可直接兴奋中

枢神经系统，缩短神经反射潜伏期并加快条件反射的建立，提高工作能力和分析能力。鹿茸、鹿角对神经系统有兴奋作用，引起心脏活动增强，输出量增加，能提高机体工作效率，改善睡眠、食欲，消除疲劳而有强身作用。熟地、首乌、阿胶、紫河车、龙眼肉、白芍、枸杞子、龟版、鳖甲等含有多种维生素、蛋白质、激素，能营养脑细胞，促进大脑的发育，改善思维记忆功能。五味子、补骨脂、益智仁均有强壮益智作用。活血的丹参、当归等能改善脑血管微循环，增加脑血管流量，有利于提高大脑皮层功能。石菖蒲、远志、茯神、龙骨、牡蛎、枣仁、柏子仁等有镇静安神作用，与扶正固本强壮药物配合，能调节中枢神经系统的兴奋和抑制，改善人体的智能。

改善小儿智能，除服药治疗外，还必须重视环境因素、心理因素的影响，创造对改善小儿智能有利的环境，帮助小儿提高智能，如关心小儿的智力训练，经常给小儿讲故事，启发他的想象能力和思维能力。为什么从小与狼为伴的狼孩连说话都不会？就是因为没有促进智力发育的环境。

72. 小儿大叶性肺炎

小儿大叶性肺炎是年长儿常见的呼吸道疾病之一。本病绝大多数由肺炎双球菌引起，少数由链球菌、葡萄球菌、流感杆菌等所致。X线检查可见肺部有大片状炎性阴影。因其病变累及整个肺大叶，故名大叶性肺炎。

小儿大叶性肺炎的临床表现：起病急骤，寒战，高热，纳差，胸痛，咳嗽，吐铁锈色痰，有的出现抽搐、昏迷、血

压低、胸腔积液、心力衰竭。末梢血的白血球总数可升高，中性粒细胞多在80%以上，伴有核左移。痰液涂片或培养可获致病菌。X线检查肺部有大片阴影。

小儿大肺叶肺炎属于祖国医学的“肺热病”“风温”等范畴。常由寒温失调，饮食不节导致正气不足。卫表不固，复因外感风热时邪，或风寒入里，郁久化热，伤及于肺，发而为病。肺主气，为心之华盖，肺之病常可累及于心。心主血，而气为血帅，气行则血行，气滞则血淤。肺气闭，则心血淤阻，血流不畅，淤血与痰涎壅聚，而成“痰淤互结”（铁锈色痰），促使肺气闭郁更甚，颜面苍白，唇口发绀。热伤肺络，则咳吐痰血，胸痛。

小儿脏腑柔弱，易虚易实。患病以后，传变迅速。若邪毒内陷可有昏迷；热盛动风可致惊厥。

分期治疗

（1）发病期：发热，咳嗽，胸痛，纳差，舌红，苔黄，脉数。治宜辛凉解表，宣肺化痰。

方药：银花20克，荆芥10克，炒山栀10克，前胡10克，浙贝10克，杏仁12克，芦根30克，大青叶30克，板蓝根30克，水煎服。

（2）进展期：高热面赤，咳嗽气促，咳铁锈色痰，鼻翼煽动，胸痛明显，烦躁不安，舌红绛，苔黄燥，脉数。治宜清热解毒，宣肺化痰。

方药：生石膏30克，炙麻黄6克，杏仁12克，甘草6克，蚤休30克，大青叶30克，黄芩30克，败酱草30克，野荞麦根30克，水煎，日服两剂。

（3）恢复期：气虚邪恋，身热起伏，咳而微喘，口干，痰粘难出，舌红少苔，脉细无力。治宜益气养阴，清热化痰。

方药：沙参15克，麦冬12克，石斛10克，杏仁10克，知母10克，浙贝10克，银花10克，枇杷叶10克，桑白皮10克，地骨皮10克，瓜蒌仁10克，水煎服。

专方治疗

方一：元参10克，生地10克，芒硝10克（冲），大黄10克，甘草6克，水煎服。用于小儿大叶性肺炎初期，且见便秘者。

方二：当归10克，川芎10克，三棱10克，莪术10克，桃仁10克，红花10克，黄芩10克，败酱草10克，鱼腥草10克，水煎服。用于小儿大叶性肺炎初期或进展期。

方三：桑白皮10克，地骨皮10克，桑叶10克，枇杷叶10克，芦根30克，茅根30克，知母10克，浙贝母10克，杏仁10克，冬瓜仁15克，北沙参10克，南沙参10克，水煎服。

加减：舌苔黄腻者去北沙参、南沙参，加黄芩、焦山栀；痰多者去桑叶、枇杷叶，加仙鹤草，旱莲草；津亏舌绛者用玄参易南沙参，去桑叶、枇杷叶，加天冬、麦冬、生地、石斛；大便干结者去杏仁加瓜蒌仁、生大黄。

注：本方适用于小儿大叶性肺炎有阴虚症状者。

方四：蚤休30克，败酱草30克，大青叶30克，鱼腥草30克，黄芩15克，虎杖30克，桃仁12克，瓜蒌20克，茜草15克，芦根30克，水煎服。

方五：三黄针，肌注，每次2—4毫升，每日2—3次；静脉滴注，每次用30—50毫升加入在50%葡萄糖液500毫升中，每日2次。

方六：清气解毒针，每次用200—400毫升加入在10%葡萄糖液500毫升中静脉滴注，每日一次。

变证治疗

（1）内陷厥阴（闭证）：神昏，谵语，或燥扰狂乱，

四肢抽搐，两目窜视，唇面青紫，呼吸浅促，鼻翼煽动。治宜熄风开闭，清心通窍。

方药：山羊角30克(或羚羊角3克)，钩藤30克，生地30克，玄参20克，菊花15克，石菖蒲10克，郁金12克，鲜竹沥30毫升(兑服)，胆南星10克，银花30克，连翘15克，黄连10克，水煎服。另服安宫牛黄丸1粒或紫雪丹8克。

(2)心阳虚衰(脱证)：突然转变成面色苍白，四肢厥冷，呼吸浅促，大汗淋漓，舌暗淡，脉微欲绝。治宜回阳固脱救逆。

方药：红参12克，附子12克(先熬一小时)，干姜10克，肉桂6克，山萸肉12克，生龙骨30克，生牡蛎30克，炙甘草6克，水煎服。

73. 小儿皮质盲

大脑皮质视觉中枢受损后，引起视功能障碍，称为皮质盲，又叫做中枢盲。这种“受损”是高位视路损害。如果损害是单侧性的，就造成同侧性偏盲；若损害累及双侧，则造成全盲。本病的病因可概括为外伤、炎症、血管性病变及中毒等几个方面。临床特点是：视力完全丧失，即黑蒙状态，瞳孔对光反射正常，眼底未见异常。皮质盲比较少见，病情严重，治疗困难。

外伤所致的皮质盲，视力可急剧消失，但亦可能逐渐恢复。血管性病变可产生暂时性黑蒙，或留下永久性偏盲现象。脑血栓形成、高血压、动脉痉挛、铅中毒、肾炎、尿毒症等是皮质盲的常见原发病，其黑蒙症状可能是短暂的、局部的，或者是全部的，有的是几小时，有的可持续数天。小儿皮质盲多是热性病所致，治疗得当，可以逐渐恢复。

皮质盲属中医的“暴盲”、“青盲”范畴。《内经》说：“气脱者，目不明”。《审视瑶函》说：“此症谓目平素别无他病，外不伤于轮廓，内不损乎瞳神，倏然盲而不见也，其故有三：曰阴孤，曰阳寡，曰神离，乃闭塞关格之病”。小儿是稚阴稚阳之体，易虚易实，易寒易热。目与五脏六腑十二经脉关系密切。高热之后，火邪已灼阴，肾精不足，水不济火，造成心火燔炽，神受干扰，不主血脉，结果目失供给。肾水既耗，水不涵木，肝亦失滋濡，而致阳亢风动，气血郁闭，无精养目，终至眊眊然无所见。

辨证论治

(1) 淤热阻络型：高热退后，身凉无汗，双目失明，神志淡漠，偶有抽搐，半身不遂。苔黄，脉弦。治宜清热化淤，开通玄府。

方药：紫草10克，玄参10克，僵蚕10克，牛黄0.3克，桔梗5克，麝香0.06克（冲服），川芎8克，细辛8克，全蝎2个，赤芍12克，菊花15克，水煎服。

方中麝香走窜十二经，开关利窍，疏通玄府；细辛通络，引邪外达；牛黄、全蝎清热熄风；紫草、赤芍、川芎凉血活血，化淤行滞；菊花、僵蚕疏散风热；玄参清热养阴；桔梗载诸药上行，通至玄府。

(2) 气血郁闭型：高热渐退，阵发性抽风，昏迷，呼吸表浅，继而失明，纳少，精神差，体瘦，颜面少华。苔薄白，脉细涩。治宜疏肝解郁，养血明目。

方药：丹参10克，栀子8克，银柴胡8克，当归10克，白芍10克，茯神10克，钩藤8克，白术10克，枳壳5克，甘草5克，升麻5克，水煎服。

方中钩藤解痉熄风；丹参、白芍活血化淤；白术、甘草

健脾益气；茯神安神镇静；当归、白芍养血柔肝；栀子、银柴胡清解余热；枳壳调理气机；银柴胡、升麻引药直达眼部，充分发挥药效。

（3）热邪伤阴型：双目无所见，口干舌燥，小便短少，舌红少苔，脉细数。治宜清余热，养阴液，通玄府。

方药：生地12克，熟地12克，天冬12克，麦冬12克，茵陈8克，黄芩10克，石斛10克，枳壳8克，枇杷叶15克，甘草5克，麝香0.06克，（冲服），水煎服。

方中二地滋肾阴；二冬、石斛养胃阴；黄芩、茵陈清利湿热；枳壳调畅气机；枇杷叶开宣上焦，调和肺胃；麝香通络开窍。

（4）肝肾阳虚型：邪尽后，目不明，或眼睑下垂，或眼肌麻痹。苔花剥，脉细乏力。治宜滋养肝肾，填精补髓。

方药：楮实子20克，菟丝子20克，茺蔚子15克，枸杞子12克，木瓜10克，五味子5克，生三七粉3克（冲服），紫河车粉12克（冲服），寒水石10克，猪脊髓60克，水煎服。

方中楮实子、菟丝子、枸杞子、五味子、猪脊髓益肝肾，补精血；紫河车大补真元；木瓜调肝理气；三七活血祛瘀，生新通络；寒水石性凉，制温药之燥。

针刺疗法

选球后、睛明、光明、足三里穴。均取双侧。

另外一组选穴为：球后、睛明、承泣、曲池，亦取双侧。

上述两组穴位可交替使用，间日一次。

7.4. 白 喉

白喉发病急骤，病势危笃。其是由白喉杆菌引起的急性呼

吸道传染病。本病所表现的中毒症状是由外毒素所致，严重者可引起循环衰竭、心肌炎、周围神经麻痹和中毒性肾病。

白喉多见于温带地区，一般为散发性发病，也可流行。发病季节多在春初秋末，患者多为儿童，病后可获得终身免疫。传染源是病人和带菌者，主要由飞沫传染，其次可经玩具、衣服、用具等间接传染。

白喉杆菌在上呼吸道的咽、喉、鼻的粘膜表层组织内繁殖，分泌外毒素。外毒素使局部和周围的组织产生炎性、渗出性和坏死性反应。血管渗出的含有容易凝固的纤维蛋白液体将炎性细胞、粘膜坏死组织和白喉杆菌凝固在一起，逐渐形成假膜。假膜与粘膜下组织紧密粘连，不易分开。

白喉常分为咽白喉、喉白喉、鼻白喉和其它部位的白喉。临床上宜与急性扁桃体炎、鹅口疮、溃疡膜性咽炎、急性喉炎等疾病鉴别。

祖国医学称白喉“白缠喉风”，是感受时行疫疔之邪，从口鼻窜入，内应肺胃。而肺胃的门户是咽喉，疫毒火邪在内蒸腾，必然迫之于上，表露于外，故成此病。治疗本病，无论初、中期，只要没有出现变证，一般不必改方换药，可服至咽喉部、口腔内和鼻内覆盖的白膜全部脱落为止。另外，宜内服与外治相结合，利于截断病势，缩短病程。

辨证分型治疗

(1) 风毒型：中等度发热，扁桃体稍红肿，咽痛，头痛，口流涎液，继则咽头两侧及口腔粘膜被盖点状或小片状假膜。舌质红，苔黄，脉浮数。治宜辛凉透表，清咽利喉。

方药：桑叶12克，葛根10克，薄荷12克，川贝8克(冲服)，木通10克，竹叶12克，银花15克，生地10克，枇杷叶15克，甘草8克，水煎服。

(2) 疫毒型：口腔有腐臭味，颈部肿大，发热口渴，恶心呕吐，大便秘结，呼吸喘促，鼻翼煽动，喉中痰声如拽锯，语声嘶哑，饮食则呛咳。苔黄燥，舌质红，脉洪数。检查咽部可见充血明显，两侧扁桃体焮红肿大，表面布满白色假膜。治宜清解疫毒，逐邪达外。

方药：生地15克，丹皮12克，白芍10克，土牛膝15克，连翘12克，射干12克，山豆根10克，马勃10克，槟榔10克，草果10克，甘草5克，银花20克，厚朴10克，浙贝10克，水煎服。

(3) 阴虚型：热势不高，或高热已退，呼吸转平，流涎减少，饮水呛咳，喉声嘶哑，咽喉部红肿，有白膜。舌质红，脉细数。治宜养阴清热，排泄余毒。

方药：生石膏30克，生地15克，栀子10克，白芍12克，马兜铃12克，龙胆草10克，玄参12克，黄柏12克，瓜蒌12克，板蓝根30克，土牛膝10克，甘草5克，水煎服。

单方验方治疗

方一：生地10克，土牛膝根10克，玄参8克，麦冬6克，银花10克，川贝3克，丹皮5克，白芍5克，甘草3克，薄荷5克，煎水200毫升，6次分服。用于阴虚型。

方二：炙甘草10克，红参5克（另煎兑入），生地10克，麦冬15克，阿胶5克（烊化），桂枝5克，火麻仁20克（打碎），生姜5克，大枣10克，制附片10克（先煎半小时），水煎服。用于脉数乱或结代白喉患者。

方三：生石膏15克，生地10克，车前草10克，山栀子6克，龙胆草10克，黄柏6克，瓜壳8克，板蓝根10克，麦冬10克，大黄6克（后下），甘草3克，土牛膝根20克，水煎服。用于疫毒型。

方四：鲜酢酱草30克，捣烂，取汁15毫升，加入中白8克，

用冷开水调匀含漱，每日 1 剂，重症 2 剂，连用至假膜脱落为止。

方中酢酱草系酢酱草科植物，全草入药，性味酸涩寒，含有多量草酸盐、草酸，有行血止痛、散瘀消肿、清热利湿等作用。人中白性味咸寒，有清热降火，祛瘀止血的作用。主治咽喉肿痛，牙疳口疮。二药合用，具有清热祛瘀作用，有助于假膜脱落。

方五：竹叶 15 克，生石膏 20 克，麦冬 15 克，山豆根 10 克，射干 10 克，牛膝 15 克，生地 20 克，玄参 20 克，白芍 10 克，黄柏 10 克，丹皮 10 克，连翘 10 克，甘草 5 克，水煎服。

加减：热毒重者加银花 30 克，蒲公英 30 克；有外感表证者加粉葛 12 克，薄荷 12 克；并发心肌炎者加银花 20 克，党参 20 克，黄芪 20 克；肺部感染加桑白皮 12 克，鱼腥草 30 克。

方六：大黄 12 克（后下），玄参 25 克，金果榄 12 克，川贝 10 克，天花粉 12 克，枳实 10 克，薄荷 5 克，甘草 5 克，小皂荚 1.5 克，水煎服。

方七：生萝卜 2500 克，捣汁，当茶饮。配合内服药，可以提高疗效。

方八：银花 30 克，一点红 15 克，土牛膝 30 克，山大颜 30 克，水煎，浓缩成 30 毫升。每日 2—3 次。

方九：雄黄 30 克，郁金 30 克，巴豆 14 粒（去壳、油），研末和匀，瓶装备用。首次服 1 克。药后 15—30 分钟内可出现呕吐，腹泻。吐泻后梗阻症状明显减轻。若无效，再服 1—2 次；仍无效，停药。衰竭、昏迷者忌用。

方十：巴豆霜 0.15 克，调服。此为 1 日量。可作中药煎剂的补充。

巴豆霜具有泻下逐水、劫痰排毒、蚀疮化腐之功。其制

法是：将巴豆去壳，研成粗粉，用吸油纸包好，榨去油，隔日换纸一次，至油净为度，研细备用。

方十一：生巴豆、雄黄、桔梗、贝母、郁金，等分为末。每次用1—2克，调糖水服，亦可鼻饲。

外用方药

方一：硼砂12克，麝香8克，乳香6克，雄黄6克，熊胆6克，黄柏（猪胆汁炒）12克，牛黄10克，血竭6克，没药6克，梅片15克，孩儿茶6克，山豆根10克，鸭咀壳10克，山慈姑10克，花蜘蛛10个（可用子壁钱代之）。分别研末，混合，瓷瓶收贮，勿冷泄气。用时取少量吹咽喉患处。

方二：用万年青的新鲜根磨研食醋，拭擦咽部，再用吹药（百草霜8份，冰片、硼砂各1份，共研细末）吹入咽喉部。

方三：巴豆七粒，不去油，雄黄15克，郁金15克，浙贝15克，桔梗15克，共研细末，备用。用于白喉的探吐。

方四：将巴豆仁粉0.3克，朱砂粉0.3克置膏药中心，贴于两眉之间，8小时后取去。

方五：生巴豆与熟巴豆等份，去油，研末备用。用时取少许吹咽喉部。

方六：斑蝥焙干，研末，瓷瓶收贮。用时取少许加水，调成糊状，放在普通膏药的中间，贴于患者颌下软骨两旁，以局部起水泡为度。

白喉来势猛，病情严重者多加用西药，如青霉素、白喉抗毒素，或内外合治，其治愈率大大提高，而且并发症、气管切开率明显下降。

外科·皮肤科

75. 败血症

败血症是由致病菌侵入血液循环而引起的急性全身性感染。由于病原菌在血中生长繁殖，从而产生内毒素、外毒素。临床表现为寒战，高热，毒血症状（头痛、出汗、呕吐、腹胀、呃逆，呼吸加快、心率增速等），皮疹，肝脾肿大，感染性休克，迁徙性病灶等。

（1）发热。大多数败血症病人的发热可高达 39°C 以上，早期出现休克者则体温低于正常。热型一般以高度弛张型和间歇型最为多见。

（2）皮疹。部分败血症患者可有皮疹，以淤点为最多见，常分布于躯干、四肢、眼结膜、口腔等处。有的患者不出现皮疹，而出现荨麻疹、斑疹、丘疹、疱疹、脓疱、大片淤斑等。

（3）关节炎及骨髓炎。大关节疼痛，红肿，活动受限。儿童败血症可继发骨髓炎。

（4）肝脾肿大。败血症患者的肝脾呈轻度肿大，可伴压痛。

（5）感染性休克。谵妄，昏迷；脉搏快，四肢厥冷，尿量减少，血压脉压降低等。

(6) 迁徙性病灶或损害。败血症患者常有迁徙性病灶，如皮下脓肿、肺炎、化脓性脑膜炎、脑脓肿、化脓性心包炎、传染性心内膜炎、化脓性关节炎、肝脓肿、骨髓炎等。

败血症患者血白细胞计数大多增高，多数患者有进行性贫血。用血培养或骨髓培养能找到病原菌即可确诊。

败血症属于祖国医学的“疔疮走黄”、“疽毒内陷”、“毒邪内攻”、“脓毒流注”等范畴。祖国医学无败血症病名，但其临床症状为恶寒发热，或寒战高烧，昏迷谵妄，肢体或发斑疹或疮疡，实与温病学中之“温毒”症状颇为近似。《外科正宗》对“疔疮走黄”曾作过这样的描述：“其形虽小，其恶甚大，再加艾灸，火益其势，逼毒，内攻反为倒陷，走黄之症作矣。既作之后，头目耳项俱能发肿，形如尸胖，七恶顿作，治虽有法，有百中难保一二”。又云：“日久原疮无踪，走散之处，仍复作脓，脉数唇焦终死”。《外科大成》说：“……迟则走黄，变异莫测”。这些描述与金黄色葡萄球菌败血症和败血症的迁徙病灶有相似之处。

《疡科心得集》说：“外症虽有一定之形，而毒气之流行亦无定位，故毒入于心则昏迷，入于肝则痉厥，入于脾则腹胀痛，入于肺则喘嗽，入于肾则目暗，手足冷”。在其他医籍如《温病条辨》中有“大热大渴”、“面目俱赤”、“舌謇肢厥”、“腹满苔燥黄”、“口燥咽干”、“舌苔干黑”等诸症的记述。

中医认为败血症的病因病机是外感六淫，邪毒化火，或内有郁热，蓄而成毒，正气内虚，邪毒内陷，客于营血，入于经络，内陷脏腑，直犯神明，而成本病。如脾胃素虚，湿邪内困，外界湿热之邪乘虚而入也可导致败血症的发生。败

血症的病因主要是正虚和外邪。正虚是外邪入侵引起发病的重要条件。正虚可由饮食不节，起居失常，素体不足，或因病致虚，或药治欠当，峻泻伤正，或过表耗气伤阴，或严重烧伤，皮焦肉灼，或疮毒脓血，气血津液盈亏，或疮疖挤伤，局部气血功能障碍，或摔伤后造成气血淤滞，荣气不行，痈疔失治等，正不胜邪，导致邪毒内陷。正虚就为外界湿热之邪乘虚而入创造了条件。

辨证分型治疗

(1) 热毒炽盛型。寒战高烧，烦躁谵语，面红唇赤，气促鼻煽，头痛头晕，身痛骨痛或关节肿痛，咳嗽或咳痰，皮疹或皮肤脓点，疮疖及其他化脓性感染，尿短赤，大便干结，舌红绛或有芒刺、淤斑，苔黄或黄腻，脉弦数或洪数。治宜清热解毒。

方药：黄芩30克，黄连10克，黄柏10克，栀子10克，银花30克，连翘30克，紫花地丁30克，蒲公英30克，紫背天葵12克，赤芍30克，羌活12克，水煎服。

(2) 湿热蕴结型。恶寒发热，头身重痛，或有黄疸，神疲体倦，恶心呕吐，胸闷腹胀，腹痛腹泻，纳呆便溏，舌红苔黄腻或白腻，脉滑数。治宜清热利湿。

方药：茵陈30克，黄芩30克，滑石30克，竹茹12克，藿香12克，银花30克，苡仁30克，白蔻10克，紫花地丁30克，龙胆草12克，车前草30克，栀子12克，金钱草30克，水煎服。

(3) 热毒伤阴型。发热不退，口干唇燥，胃纳不振，大便燥结，小便短赤，或神志昏迷，渴喜冷饮；苔光剥或焦干，舌质红绛，脉细数或虚数。治宜清热养阴。

方药：生地60克，玄参30克，麦冬30克，黄芪15克，竹叶12克，黄连10克，栀子12克，黄芩20克，大黄10克，银花30克，芦根30克，

水煎服。

(4) 气虚阳虚型。病程较长，身无热或体温下降，神萎气怯，自汗肢冷，口不渴或喜热饮。甚则呼吸急促，手足震颤，舌淡苔白，脉沉细或细弱。治宜透脓托毒，补气温阳。

方药：黄芪60克，党参30克，苡仁30克，炮甲珠15克，皂刺12克，鹿角胶12克，白芥子10克，赤芍30克，丹皮12克，银花30克，蜈蚣2条，水煎服。

专方专药治疗

(1) 银花60克，连翘30克，山栀15克，黄芩30克，蚤休30克，黄连10克，蒲公英30克，生石膏30克，大黄10克，水煎服。

(2) 黄连素1.6克口服，6小时服一次。

(3) 黄芪30克，白花蛇舌草30克，黄芩30克，银花30克，党参30克，皂刺12克，炮甲珠15克，山药30克，连翘30克，水煎服。

针对疮疖等局部病灶的外敷治疗

方一：满天星鲜品120克，洗净捣烂，外敷局部病灶。

方二：大黄、黄柏、姜黄、白芷各10克，南星、陈皮、苍术、厚朴、甘草各4克，天花粉20克，共研细末，用银花露调匀外敷患处。

方三：炙象皮、血竭、儿茶、赤石脂、乳香、没药、煅龙骨各25克，冰片10克，共研极细末，过筛，即为生肌散。用生肌散一份，新大米饭一份，混合研如泥状，搓成火柴杆粗细的条，阴干备用。用时将此药条插入脓腔。

方四：鲜蒲公英，鲜野菊花各60克，洗净，捣烂外敷患处。

方五：儿茶、黄芩、黄柏各100克，冰片50克，泡入80%

酒精 1 000 毫升，浸泡一周后，外涂烧伤创面，并吹风将疮面吹干形成药痂，痂下有感染积液者，随时清理引流，反复涂药定痂。

附注：败血症，病情凶险，变化快。中药治疗败血症（特别是应用抗菌素治疗无效的败血症）不能急躁，用上面介绍的第一个专方治疗，要守方治疗，开始降热，一般需 2—4 天或 3—9 天体温才能降至正常。专方治疗可争取主动，并且无引邪入内之弊。

败血症变化莫测，病情瞬息万变，治法和方药也随证情变化而变化，但解毒养阴之治法，应贯穿始终。

败血症患者常伴大便秘结（阳明腑实），阳明腑实又往往加重病情，因此，治疗上除了清热解毒养阴之外，要重视泻下，釜底抽薪，伍用大黄。

76. 血栓性静脉炎

血栓性静脉炎是浅表静脉的一种急性非化脓性炎症。主要发生于四肢浅静脉。其临床特点为受累浅表静脉区的皮肤红肿、疼痛，可摸到有压痛的条索状物。

血栓性静脉炎主要由血流缓慢、静脉壁损伤和血液粘滞性增高所致。

血栓性静脉炎多发于四肢浅静脉，也可发生于胸腹壁静脉。急性期患处红肿疼痛，沿受累静脉可摸到有压痛的条索状物，其周围皮肤温度增高，稍红肿。一般无明显的全身症状。1—3 周后静脉炎症逐渐消退，局部遗留有硬条索状物和皮肤棕色色素沉着，常经久不退。

血栓性静脉炎属于祖国医学的“脉痹”、“筋痹”、“恶脉”、“痙病”等范畴。《难经》说：“痙皮厚也，在肌肉之间，而可见者也”。《中医名词术语选释》说：“痙是形容脐的两旁各有条状物筋块扛起，状如弓弦，大小不一，或痛或不痛”。中医认为血栓性静脉炎系湿热气滞等因素导致血淤，进而闭塞脉道。

辨证分型治疗

(1) 湿热淤滞型。多见于病起初期，有肢体肿胀、灼热、疼痛和表浅静脉曲张，伴全身不适，口干，尿赤，大便秘结，舌质暗，苔黄腻，脉弦。治宜清热解毒祛湿。

方药：当归60克，丹参30克，山慈菇15克，银花30克，蒲公英30克，连翘30克，苡仁30克，赤芍30克，莪术12克，丹皮12克，萆薢15克，茯苓15克，水煎服。

加减：气滞者加香附、枳壳；血淤者加土鳖虫；湿热较轻者加防己、赤小豆、地龙；湿热较重者加茵陈、黄柏、地龙；湿重者加黄柏、知母、川牛膝。

(2) 体虚淤滞型。多见于病程较长和体质虚弱的患者。肢体肿胀，疼痛，面色无华，气短乏力，眠食不佳，舌质淡，脉沉涩。治宜补虚活血化淤。

方药：当归60克，乳香10克，没药10克，丹参30克，连翘15克，蒲公英30克，桃仁10克，红花10克，茯苓30克，党参30克，黄芪30克，赤芍30克，皂刺10克，水煎服。

注：以上二方当归均应用至60克，其效乃著。活血化淤药宜随证使用，气血行、经脉通、血流畅、淤热除；祛淤生新，改善血淤和血液流变学的异常状态，有利于恢复血管内膜病变。

单方验方治疗

红花20克，赤芍40克，丹参30克，当归30克，乳香10克，没

药10克，水煎服。

加減：局部条索红肿、热痛明显者加生地、丹皮各15克，玄参、银花各30克；血脉淤滞、索条硬肿不消者加桃仁20克，王不留行50克，夏枯草10克；湿热者加黄柏、苍术各20克；气虚无力、胃纳不佳者加黄芪30克，党参、白术、茯苓各20克；胸胁满闷、呃逆、善太息者加木香、柴胡各20克，白芍、香附各30克。

77. 血栓闭塞性脉管炎

血栓闭塞性脉管炎是一种周围血管慢性闭塞性炎症疾病。以下肢为多见，多见于男性青壮年。其临床特点为患肢缺血、疼痛、间歇性跛行，受累动脉搏动减弱甚至消失，伴有游走性血栓性浅表静脉炎，严重者有肢端溃疡和坏死。

本病多发于体力劳动者，北方较多见。病因尚未阐明，有些患者发病前有患肢骤受寒冻、潮湿或创伤的病史。吸烟是致病因素之一。

血栓闭塞性脉管炎的临床表现：多在寒冷季节发病，病程较长，发展缓慢，常在数年后症状才趋显著，也有数月之内症状即很明显。局部血液供应改善时，症状可以缓解；随病变发展而症状加重，整个病程可反反复复。

（1）局部缺血期。往往在受寒冻或涉冷水后，觉足部麻木、发凉、疼痛，走路时小腿酸胀，易疲劳，足底有硬胀感。症状逐渐加重，发生间歇性跛行，每行1—2里路后，患肢小腿或足底即有胀痛或抽掣痛，被迫停步休息，然后疼痛逐渐消失，再行疼痛再出现。随病情的发展，患者在休息

时也出现下肢疼痛，抬高位时加重，下垂位时减轻。患肢动脉搏动微弱或消失。患肢抬高后皮肤苍白，下垂后潮红或发紫。用手指压迫趾端的皮肤或趾甲，转红缓慢（缺血所致）。约有半数患者在发病前或病程中小腿可反复出现游走性血栓性静脉炎（条索）。

（2）营养障碍期。病情继续发展，患肢麻木，冰凉，怕冷。静止时疼痛明显，夜间疼痛剧烈，患者常抱足而坐，不得安眠。患肢动脉搏动消失，局部不出汗，趾甲生长缓慢，增厚变形。皮肤干燥，呈潮红、紫红或苍白色，汗毛脱落，小腿肌肉萎缩。

（3）坏死期。患肢发生溃疡或坏疽，多局限在足趾或足部。当患肢溃烂后，创面经久不愈，疼痛更剧。患者体力日衰，食欲减退，消瘦无力，可伴有发热，明显贫血，甚至意识模糊。

血栓闭塞性脉管炎属于祖国医学的“脱疽”范畴。多由严寒涉水、寒湿下受，以致寒凝络痹，血行不畅，阳气不能下达，遂发此病。但寒湿郁久，亦能转化为热，故久则形成热毒为患。

辨证分型治疗

（1）寒湿型

初期：患肢沉重，麻木怕冷，行走疼痛，受冷后加剧，苍白臃，脉沉细。治宜活血温经通络。

方药：桂枝10克，当归15克，红花10克，赤芍30克，白芍12克，威灵仙10克，川牛膝30克，羌活10克，独活10克，葱管5根，制川乌10克（先熬），水煎服。

中期：局部皮肤发冷，患肢抬高则皮色苍白，下垂则转红，持续疼痛，趺阳脉微弱或消失。治宜温经散寒，补气

益血。

方药：独活10克，寄生30克，川牛膝30克，细辛6克，当归30克，赤芍20克，熟地20克，党参30克，黄芪30克，丝瓜络30克，肉桂8克，水煎服。

后期：寒化为热，溃烂出水，腐筋损骨，疼痛加剧，身心烦躁，发热。舌红苔黄脉数。治宜滋阴降火，和营解毒。

方药：当归30克，赤芍30克，银花30克，玄参30克，生地30克，川牛膝30克，黄柏12克，知母12克。水煎服。

（2）火毒型

初、中期：局部出现大小不等的黄水疱（溃烂），周围皮肤肿胀紫暗，焮热疼痛持续不断；不能安眠，趺阳脉消失。治宜解毒降火，滋阴养血。

方药：丹参30克，丹皮15克，桃仁12克，当归30克，玄参30克，银花30克，生地30克，川牛膝30克，紫花地丁30克，甘草10克。水煎服。

后期：黄疱变黑，疱破腐烂，创口流紫黑血水，肉色不鲜，气味恶臭，灼痛难忍，趺阳脉消失。治宜托毒消肿，补气益血。

方药：党参30克，黄芪60克，当归30克，赤芍30克，白芍15克，茯苓15克，生地30克，川牛膝30克，红花12克，炮甲珠15克，银花30克，甘草10克。水煎服。

外敷药物治疗

（1）未溃者，寒湿型用红灵丹油膏（雄黄18克，乳香18克，煅月石30克，青礞石10克，没药18克，冰片10克，火硝18克，朱砂60克，麝香3克，除麝香外，共研细末，用适量凡士林烱化稍冷后徐徐加入药粉，和匀成膏）外敷患处。火毒型用玉露膏（芙蓉叶，研成极细末，用适量凡士林调匀成膏）外敷

患处。

(2) 溃烂者，均先用九一丹（熟石膏27克，升丹3克，共研极细末）盖贴。脓腐将净则用生肌散（制炉甘石15克，滴乳石10克，滑石30克，琥珀10克，朱砂8克，冰片0.3克，研极细末）外抹。

血栓闭塞性脉管炎的预防

不吸烟，保护双足，防止寒冻和潮湿的侵袭，保暖（但不要热敷）。不穿紧而硬的鞋袜。劳动时适当变换体位，防止肢体血管长时间受压而影响血液循环。

78. 输精管结扎术后痛性结节

痛性结节是输精管结扎术后并发症之一。其发病机理认为与精子肉芽肿形成有关，有的认为系由输精管残端的纤维组织增生、神经纤维瘤、小脓肿形成、丝线异物反应等所引起。

凡行输精管结扎（或堵塞）术后，结扎（或堵塞）处出现结节（硬结），且在三个月以上仍能扪及（排除了精神因素），痛性结节的诊断即可成立。

痛性结节的主要症状为结扎处有疼痛和结节，疼痛有时放射到睾丸、腹股沟、下腹部或腰部等处。有的疼痛较短暂，有的疼痛持续较长，反复发作。

辨证分型针灸治疗

(1) 气滞经脉受阻。以疼痛为主，常放射至睾丸、腹股沟、小腹甚至腰骶部，多兼有胸胁不舒，脘腹痞满，暖气，纳呆，痛性结节不甚坚硬，脉小弦。

取穴：阿是穴（即痛性结节处）、气海、血海。

方法：将点燃的艾条，置于所灸穴上3—5厘米的距离，用气吹火，促艾条燃烧，使火力急强，灸至局部皮肤焮热红晕为度，而不按其穴（悬灸泻法）。

继用艾条悬灸膻中穴。

（2）血淤经脉不通。以刺痛为主，痛点不移动，入夜痛甚，痛结坚硬，舌体有淤点，脉弦涩。

取穴：阿是穴、气海、血海。

方法：同上悬灸泻法。

继用艾条悬灸膈俞穴。

（3）气虚运行不畅。以坠胀疼痛为苦，其痛不剧，常在劳动或性交后，坠痛加重，多伴有神疲乏力，食少纳呆，痛性结节不甚坚硬，舌淡苔薄，脉虚弱。

取穴：阿是穴、气海、血海。

方法：将点燃的艾条，置于所灸穴位上3—5厘米的距离，任其慢慢燃烧，火力和缓，灸至局部皮肤温热红晕时，再用手指按压所灸穴位至患者自觉酸胀为度（悬灸补法）。

继用艾灸足三里。

（4）阳虚寒凝不通。痛处不移，阴囊常湿冷，得温则痛减，面色苍白，畏寒肢冷，性欲减退，时现阳萎、早泄，痛性结节坚硬，但经热敷，按摩即变软、痛减轻，舌淡苔白脉沉弱。

取穴：阿是穴、气海、血海。

方法：同上（悬灸补法）。

继用艾条悬灸关元穴、肾俞穴。

中药外敷治疗

药物：乳香30克，五倍子30克，没药30克，大黄30克，三

棱15克，莪术15克，共研极细末。用凡士林适量调成膏状，备用。用药前先将阴囊皮肤剃毛，清洗阴囊后将药膏敷于痛性结节处，并予以固定，每日换药1次。七天为1疗程。连用2—3个疗程为宜。

阴囊皮肤有感染时则不宜使用本法。

79. 急性淋巴结炎

急性淋巴结炎多继发于其他化脓性感染后。其特征是在颌下、腋下、腹股沟等处的淋巴结肿大疼痛，伴有发热恶寒等全身症状。发病前多有扁桃体炎、咽炎、龋齿、头面疮节、皮肤皲裂破损等病史。初起局部淋巴硬结如杏大，皮色不变，微有压痛，逐渐变红肿热痛，脓成后有波动感。

急性淋巴结炎属于祖国医学的“颈痛”、“锁喉痛”、“腋痛”等范畴。多由外感风温、风热，挟痰壅结于少阳、阳明之络所致；或肺胃火毒上攻，挟痰凝结而成；或肝脾血热，气郁痰结；或皮肤破损，毒邪乘隙内侵所致。治宜清热解毒，疏表散结。

内治方

(1) 银花30克，连翘15克，赤芍30克，黄芩30克，板蓝根30克，夏枯草30克，牛蒡子15克，昆布30克，海藻30克，水煎服。

(2) 夏枯草膏，每次服15克—20克，日服3次，开水送服。

(3) 银花藤60克，蒲公英60克，紫花地丁60克，紫背天葵15克，野菊花15克，赤芍30克，夏枯草30克，黄芪30克。水煎服。

(4) 黄芩30克, 黄连10克, 山栀15克, 大黄10克, 连翘15克, 大力子15克, 甘草10克。水煎服。

外治方

(1) 芙蓉膏外敷患处。

(2) 紫金锭调水外敷患处。

(3) 已有化脓现象者用铁箍散软膏外敷患处。

(4) 脓已形成宜及早切开, 外用京红粉纱布条敷患处。

急性淋巴结炎的护理

患者应卧床休息, 多饮开水, 并用海带炖瘦肉佐餐。患处可作湿热敷, 以促进消散。

80. 淋 巴 结 核

淋巴结核由结核菌引起, 分原发性和继发性两种。以继发感染较为常见。人体抵抗力降低是引起淋巴结核的重要因素。淋巴结核好发于颈部、腋下、颌下、腹股沟等处, 局部结肿硬如核, 累累成串, 有时溃脓破口。伴潮热、盗汗等。

淋巴结核多见于青壮年及儿童。发病前可有虚癆病史。

初期, 淋巴结核如指头大, 只一枚或数枚不等, 皮色不变, 按之坚实, 推摸能动, 不热不痛。中期, 结核增大, 皮核粘连, 有的结核之间互相融合成块, 推摸不动, 渐感疼痛, 如皮色渐转暗红, 按之微有波动感者, 即内脓已成。后期, 结核破溃, 脓水清稀, 夹有败絮样物, 创口呈潜行性(空壳), 四周紫暗。本病往往此愈彼溃, 可形成窦道或漏管。若脓水转厚, 创口肉色鲜红者, 为即将收口。

本病初期一般无全身不适; 中期可有轻微发热, 食欲不

振等；后期日久不愈，可有潮热、盗汗、疲倦、头晕、失眠、闭经、消瘦、便溏等全身症状。

预后一般良好，但每因体虚而复发，尤以妇女产后更易复发。

淋巴结核属于祖国医学的“瘰疬”、“鼠疮”等范畴。多由情志不畅，肝气郁结，久而化火内燔，炼液为痰，痰火上升，结于颈项等处，遂成此证。病达后期，肝火愈旺，下灼肾阴，脓水淋漓，耗伤气血。亦有先因肺肾阴亏，以致水亏火旺，肺津不能输布，灼津为痰，痰火凝结而成瘰疬。

分期治疗

初期：治宜疏肝养血，解郁化痰。

方药：柴胡15克，当归30克，赤芍30克，白芍20克，夏枯草30克，昆布30克，海藻30克，法半夏12克，陈皮12克。水煎服。

加减：肝火偏旺者加山梔12克，黄芩15克。

中期：治宜托毒透脓。

方药：黄芪30克，皂刺12克，炮甲珠15克，夏枯草30克，昆布30克，海藻30克，浙贝15克，苡仁30克，赤芍30克，当归30克。水煎服。

后期：治宜滋肾补肺。

方药：党参30克，生地30克，山药30克，山萸肉15克，茯苓15克，沙参30克，黄精15克，麦冬15克，地骨皮30克，生牡蛎30克（先煎），炙鳖甲15克。水煎服。

单方验方治疗

（1）夏枯草膏，每次服15克，一日服3次，开水冲服。

（2）玄参、煅牡蛎、川贝等分，共研细末，米糊为丸，如梧桐子大，每次服10克，日服3次，开水送服。

（3）阳和解凝膏，敷贴患处。

(4) 铁箍散膏，外敷患处。

(5) 煅石膏80克，升丹20克，研细末，粘附于药线上，插入疮口引流。

针灸治疗

取穴：曲池、肩髃、天井、少海、百劳、肺俞、肝俞、脾俞、肾俞。

方法：每次选2—3穴，强刺激，不留针。

患者应坚持治疗，保持乐观情绪，节制性欲，平时应增加营养，增强抗病能力，注意休息，勿过度疲劳。

81. 手足口病

手足口病是由多种肠道病毒所引起的一种皮肤传染病，主要致病因素是柯萨奇病毒。好发于手、足、口腔粘膜处，故称手足口病。

本病多见于夏季，好发学龄前儿童，尤以1—2岁婴儿，有时有小流行。

多数患者可在疹出之前1—2天或与皮疹同时出现发热，体温多在 37°C — 38°C 左右， 39°C 以上者少见。体温多在2—3天内恢复正常。

部分患者可见颌下及颈部淋巴结肿大。

皮疹是手足口病的特异征象，多表现为充血性斑丘疹或疱疹。皮疹边缘清晰，直径为1—3毫米，有时呈密集性丘疹样皮疹。疱疹为白色透明状，溃疡后形成小溃疡面，周围红润、疼痛。皮疹多出现于手、足、口、臀部，也可见于肘膝部。面部及胸背部少见。口腔粘膜是皮疹最重要的受累部

位。初期有口腔粘膜充血，继而皮疹出现，皮疹可散布在唇颊粘膜、舌、颚、齿龈及咽部。一天左右可形成溃疡。手掌、指侧、指甲周围、足趾、趾侧、足跟边缘均可见皮疹，在臀部和腿部常见较密集的丘疹和疱疹。3—5天皮疹结痂和吸收。

手足口病的初期可见流涕、咳嗽、咽部充血，当皮疹出现时可见流涎、拒食、烦躁、大便秘结等症状，少数病例有腹泻。患儿舌质红，苔薄白或薄黄，脉滑数。

手足口病属于祖国医学的温热病范畴。致病原因是外感温热之邪，邪从口鼻而入，具有传染性、流行性、地区性、季节性。《温病条辨》说：“凡病温者始于上焦，在手太阴”。其治疗以清热解表为主，凉血解毒为辅。

方一：水牛角30克，生地炭15克，银花30克，莲心10克，茅根30克，栀子10克，紫花地丁30克，蚤休30克，黄连10克，生石膏30克，甘草10克。水煎服。

方二：银花30克，连翘30克，竹叶10克，荆芥10克，薄荷10克（后下），牛蒡子15克，桔梗12克，芦根30克，赤芍30克，丹皮15克，蝉蜕6克。水煎服。口腔溃疡可外敷锡类散。

手足口病病程最长10天，患者最好卧床休息，注意口腔清洁，多饮水，预防感染，食易消化食物。

局部可外用三黄软膏，口腔用银花煎水漱口。

82. 蜂窝组织炎

蜂窝组织炎为溶血性链球菌等细菌侵入皮下、肌膜下、肌间隙所致的急性弥漫性化脓感染。疖、痈等均可引起蜂窝

组织炎。其特征是局部皮肤及皮下组织红肿，热痛显著，炎变区域与正常组织分界不清（弥漫性炎症）。

蜂窝组织炎好发于下肢、足背、颜面、外阴、肛周等部。病变位置浅者，初期患部呈现弥漫性红肿，病损处皮肤紧张较坚实，中央炎症显著。以后变软，有波动感，溃破化脓，排出脓液及坏死组织。由葡萄球菌引起者脓液较稠，链球菌引起者脓液较稀。病变位置深者，红肿多不明显，有深部压痛。

蜂窝组织炎常伴有淋巴结炎、淋巴管炎、坏疽、转移性脓肿甚至发生败血症，无局部水疱。患者可有高热，寒战，全身不适等全身症状。血液中白细胞总数及中性粒细胞较高。炎变区域有明显的触痛及凹陷性水肿。

慢性蜂窝组织炎常呈板样硬化，色素沉着，潮红，灼热疼痛不显著，可见有皮肤萎缩，类似硬皮病，但较罕见。

蜂窝组织炎属于祖国医学“痈”的范畴，（与现代医学的“痈”有区别）。多由外感风湿燥火，邪热壅聚，或外来伤害，毒邪乘隙内侵，致使营卫不和，气血凝滞，经络壅遏不通而成痈。治宜清热解毒。

内治方

（1）黄连10克，黄芩30克，山梔15克，大黄10克，连翘15克，大力子15克，甘草10克，赤芍30克，丹皮12克。水煎服。

（2）银花30克，蒲公英30克，紫花地丁30克，野菊花12克，紫背天葵12克，赤芍30克，丹皮12克，黄芪30克。水煎服。

外治方

（1）六神丸调水外敷患处。

（2）紫金锭调水外敷患处。

护理：患肢应抬高休息，局部作湿热敷，疗效较好。患

者应卧床休息，大量饮水，成人平均每天应饮水 3 000 毫升左右。局部化脓时应切开引流。

83. 天 疱 疮

天疱疮是一组慢性复发性大疱性皮肤疾患，其特征为在外观正常的皮肤和粘膜上发生松弛性大疱，性质严重，可危及生命。

天疱疮分为寻常性天疱疮、增殖性天疱疮、落叶性天疱疮、红斑性天疱疮四型。其中以寻常性天疱疮为最常见，其临床表现如下：

(1) 常在外观正常的皮肤上出现黄豆、鸽蛋大小或更大的水疱。初期疱液清亮，继之混浊。大疱初起皮肤紧张丰满，但旋即松弛和破裂，形成糜烂面，出血，散发腥臭气味。可发生在全身皮肤的任何部位，痊愈后常遗留下色素沉着，而不形成瘢痕。

(2) 粘膜损害以口腔最常见，较皮肤损害出现为早。不形成水疱而形成大片糜烂面。口唇糜烂、结痂、流涎，张口及进食均感困难。侵犯喉部时则出现声音嘶哑。眼、鼻、阴道、阴茎、肛门等处亦可被侵犯。

(3) 用手指轻擦水疱间正常皮肤时，表皮即剥离。牵拉疱壁时表皮易于剥离。用手指轻压水疱，疱膜向挤压方向扩大移动。

(4) 寻常性天疱疮多发于中年人，病程缓慢。病程长，旧的损害不易痊愈，新的损害不断出现，互相融合扩大，严重者表皮呈大面积剥离。

(5) 患者自觉疼痛。全身症状有发热，厌食，乏力，体质消耗甚大，容易并发败血症等。

天疱疮属于祖国医学的“天疱疮”、“火赤疮”、“浸淫疮”等范畴。中医认为多因心火、脾湿蕴蒸，复感风热暑湿之邪，致使火邪犯肺，不得疏泄，熏蒸不解，外越皮肤而成本病。亦有因湿热内蕴，日久化燥，耗气灼津，致使气阴两伤。

辨证分型论治

(1) 湿热炽盛。发热，口渴，皮肤粘膜见红斑，大疱，糜烂，渗液，黄痂，舌红苔黄，脉弦数。治宜清利湿热。

方药：白藓皮30克，豆黄卷15克，苡仁30克，土茯苓30克，山栀12克，丹皮12克，银花30克，连翘15克，紫花地丁30克，滑石30克，木通10克，甘草6克。水煎服。

(2) 脾虚湿盛。体胖，倦怠，口燥，皮肤粘膜见大疱，糜烂，渗液，脉弦细，舌胖有齿痕，苔白。治宜健脾除湿。

方药：苍术20克，厚朴15克，陈皮12克，滑石30克，白术12克，猪苓15克，黄柏12克，苡仁30克，扁豆15克，黄精12克，茯苓皮15克。水煎服。

(3) 气阴两伤。病延日久，汗出口渴而不欲饮水，烦躁不安，倦怠无力，懒言、舌淡红胖嫩有裂纹，苔少或舌如镜面，脉细数。治宜益气养阴。

方药：生地60克，当归30克，黄芪30克，党参30克、白芍30克，知母12克，地骨皮30克，黄芩15克，泽泻30克。水煎服。

天疱疮病情危重，应采用中西医结合治疗。高热不退者加犀角粉0.5克；大便干燥者加大黄；口腔糜烂者加银花煎水含漱。

84. 沥青皮炎

沥青皮炎是一种职业性皮肤病。因长期接触沥青而引起。各种沥青（煤焦沥青、石油沥青、页岩沥青、天然沥青等）均对皮肤有不同程度的损害，其中以煤焦油沥青对皮肤损害较为严重。

沥青皮炎的特征是：接触沥青后经阳光照射，皮肤出现红肿水疱，自觉痒痛。反复接触沥青会使皮肤干燥，粗糙，色素沉着，日照后有烧灼感。

发病前有接触沥青和阳光照射史，夏秋季节发病最为严重。发病常在暴露部位，以颜面、颈、腕、手背、指背为最多见，也有遍体发生者。本病可集体发生。眼白变赤，日久可成竭黄色，常有流泪、羞明、视力模糊等。

沥青皮炎可分为干性型和湿性型。

干性型：皮肤见光泽红斑，干燥，自感灼痛或微痒，皮肤迅速转为暗红，约经3—4天后，轻微脱屑而愈。

湿性型：初起时皮肤红热，自感剧痒或微痛；继而皮肤肿胀、起丘疹和水疱；甚则水疱破裂糜烂，滋水淋漓，约七天后肿退，14天后滋水渐少而愈。

沥青皮炎的全身症状有头晕，头痛，咳嗽，多痰，神疲力乏，舌红苔黄，脉微数。

本病往往反复发作，症状亦渐趋增剧，皮肤可干燥粗糙呈棕黑色，起丘疹如黑头粉刺，或起小块，亦可形成多发性疖病。

沥青皮炎属于祖国医学的“沥青疮”范畴。多系禀性不

耐，皮毛腠理不密，外感沥青热毒之气，复受日晒，蕴蒸肌肤而发病。治宜凉血清热，解毒利湿。

内治方

(1) 干性型。生地30克，丹皮12克，赤芍30克，紫草30克，银花30克，紫花地丁30克，黄芩15克，山栀12克，板蓝根30克，制大黄6克，甘草10克。水煎服。

(2) 湿性型。上方加茯苓皮15克，车前草30克，桑叶15克，菊花15克。水煎服。

外治方

(1) 干性型。蒲公英30克，煎汤放冷作湿敷。

(2) 湿性型。青黛30克，黄柏粉30克，煅石膏粉20克，植物油调敷患处。

护理：保护皮肤，不要重擦皮肤，患处不可用热水洗涤。忌食烟酒、辛辣刺激之物。

预防：操作时尽可能戴防护用品，这些防护用品也要保持清洁，必须与清洁衣服分开放置。下班时须作淋浴，更换清洁衣服。外出时戴宽边草帽或撑伞，以防日光刺激。

85. 类 丹 毒

类丹毒是由猪红斑丹毒丝菌引起的一种传染性皮肤病。常与职业有关，皮肤症状酷似丹毒。由于猪骨或鱼刺刺伤皮肤，或皮肤有外伤，接触病原菌而引起。

病原菌多存在于病畜或病鱼的生肉上，这种病菌对外界环境抵抗力很强。从事肉类加工的工人以及渔业工作者；当接触患病的猪、羊、兔、鸟、鱼等动物或病畜生肉时，如皮

除有外伤，可受传染。

临床分为三型：

局限型。皮肤损害与丹毒相似，仅限于手指或手、足背。单侧发生，见红斑或紫红斑，边缘轻度水肿，境界明显，向周围扩展，中心可自愈，局部灼热瘙痒或刺痛，不化脓。

弥漫型。开始于手指端见丹毒性红斑，以后沿手臂向其他部位蔓延，皮疹时发时消，伴有关节痛、发热等症状。

败血症型。全身出现盘状红斑或紫斑，伴有关节痛及心内膜炎。血液细菌培养阳性。

内治法

方药：生地30克，丹皮12克，赤芍30克，银花30克，连翘15克，紫花地丁30克，山栀12克，制大黄10克，甘草10克。水煎服。如合并高热、神昏谵语等毒邪内攻症状者，加安宫牛黄丸1—2粒，开水化服。

外治法

(1) 金黄膏外敷。大黄、黄柏、姜黄、白芷各10克，南星、陈皮、苍术、厚朴、甘草各4克，天花粉20克，共研细末，加适量凡士林调匀成膏，外敷患处。

(2) 增减黑布膏药外敷。五倍子粉30克，黑醋60毫升，蜂窠12克，冰片适量。用砂锅将黑醋蜂蜜煮沸，徐徐加入五倍子粉，搅拌，熬成药膏，加入冰片，收贮备用，用时涂敷患处。

86. 老年性瘙痒症

老年性皮肤瘙痒既是一种症状，亦是老年人常见的一种

皮肤病。据统计，发病率为10%左右。这种瘙痒症是全身性的，原因是人至老年期，皮肤萎缩、退化，皮脂腺和汗腺分泌减少而皮肤干燥所引起。如老年性皮肤瘙痒是某些病的一个症状时，这些病可能是胆汁性肝硬化，或慢性肾功能衰竭，或缺铁性贫血，或某些肿瘤，或糖尿病等等。

本病的特点是自觉症状显著，部位以小腿及背部瘙痒最明显，夜间入睡前瘙痒最剧烈。如遇干燥气候、冬季、室温过高环境，可使皮肤角层所含的水分过度丢失，造成皮肤干燥，减弱对外界刺激的抵抗力。在瘙痒的初期，可见皮肤干燥，有细小皲裂，常脱落鳞屑；以后常有继发的抓痕，血痂表皮剥脱，色素沉着。久治不愈，皮肤有湿疹样变。

中医认为，老年性瘙痒症属“风瘙痒”范畴，有的又称为“痒风”，系精血不足，血虚生风所致；或为血燥生风所致；或为皮肤气血营运迟滞，血行不畅，风邪袭入，侵及肌肤，郁于肺经所致。

方一：当归15克，熟地15克，白芍12克，鸡血藤30克，酸枣仁12克，柏子仁15克，五味子8克，荆芥12克，防风12克，川芎10克，首乌15克，甘草5克，蝉蜕10克。水煎服。

加减：痒剧烈、皮肤如苔藓样者加乌梢蛇10克，僵蚕12克；大便结燥或有糖尿病者加草决明15克，生地15克；腹胀，食欲不振者加建曲15克，山楂25克；血压高者加钩藤12克，地肤子12克。

方二：熟地15克，首乌20克，黄芪30克，白蒺藜15克，当归15克，白芍12克，川芎10克，荆芥10克，防风10克，甘草5克，白藓皮20克。水煎服。

加减：冬春季加麻黄5克，蝉蜕10克；夏秋季加黄芩12克，紫草12克；顽固不愈者加全蝎10克；气虚者加太子参30克；恢

复按本方去荆芥、防风，加太子参20克，白术15克，茯苓15克，
眼差者加五味子8克，珍珠母20克。

方三：首乌15克，干地黄15克，山药12克，黄柏12克，五味子5克，菟丝子12克，沙苑子15克，生龙牡20克，茯苓15克，乌梢蛇10克。水煎服。

方四：生地15克，赤芍12克，川芎10克，天冬15克，麦冬15克，僵蚕12克，丹皮12克，大胡麻12克，当归15克，桑枝20克，首乌15克，炙蜈蚣5克。水煎服。

方五：乌梢蛇12克，防风12克，人参须3克，当归15克，蛇床子12克，苍术12克，牛黄0.1克，丹皮12克。水煎服。

方六：当归12克，赤芍10克，白芍10克，鸡血藤30克，党参15克，黄芪20克，白术12克，白藓皮15克，浮萍20克，地肤子15克，苦参10克，防风10克。水煎服。

方七：当归15克，熟地12克，生地12克，黄芪20克，天冬15克，麦冬12克，五味子8克，升麻5克，黄芩12克，桃仁12克，红花5克，瓜蒌仁12克。水煎服。

方八：知母12克，黄柏12克，当归12克，白芍12克，生地15克，茯苓15克，丹皮12克，泽泻12克，枣皮12克，淮山15克，川芎10克，夜交藤30克。水煎服。

方九：何首乌12克，生地15克，熟地12克，钩藤12克，菊花15克，防风10克，凌霄花12克，款冬花12克，红花5克，玫瑰花12克，白扁花12克，鸡冠花12克。水煎服。

方十：当归12克，白芍12克，川芎10克，麦冬12克，生地15克，玄参15克，蝉衣10克，蛇床子12克，合欢皮20克。水煎服。

方十一：蛇床子30克，地肤子30克，苦参20克，花椒15克，白矾15克。水煎，薰洗患处。

方十二：川椒20克，细辛8克，川槿皮30克，苦参30克，

射干15克，黄柏15克，连翘15克，五倍子15克，苍术15克，白藓皮30克，百部30克，蛇床子30克，地肤子30克，板蓝根30克，大青叶30克，蒲公英30克，苍耳子30克，艾叶30克，白矾30克，菊花30克，马齿苋30克，银花50克，儿茶10克，白芨10克，白芷10克，海藻20克，大黄20克，石菖蒲10克，蚤休20克。煎水45分钟，过滤取汁，将药渣再煎2次，取汁。3次药液混合，分3次备用，薰洗患处。

方十三：白芨60克，黄精30克，紫草30克，五灵脂30克，露蜂房15克。煎水，浸泡、外洗患处。

方十四：棉花籽30克，蒜瓣子30克，丝瓜络30克。煎水，薰洗患处。

方十五：红花、桃仁、杏仁、生栀子各等量，研细末，加冰片少许，用蜂蜜调成糊状。用时将药摊成小核桃大小之饼块，置于脐上，用敷料固定，每日换药1次。

五官科

87. 视神经萎缩

视神经萎缩是由多种病因影响所致的视神经纤维发生变性和传导功能障碍。这是一种退行性变，属难治之症。本病的病因复杂，如感染、肿瘤压迫、外伤、中毒、营养不良、某些遗传性疾病、情绪波动等都可导致发生本病。一般说来，儿童时期，以脑部肿瘤较多；青年时期，以遗传性视神经萎缩为主；中年时期多为视神经炎、外伤、肿瘤；老年时期，由青光眼、脊髓痨引起较多。本病的眼底变化是视乳头颜色变为苍白。自觉症状是视力逐渐下降，常伴有色觉障碍和夜盲症状，严重者可致失明。视野变化是多呈向心性缩小，有时为扇形缺损；视野缺损首先侵犯红色、绿色，然后累及白色。

祖国医学对本病称之为“青盲”、“暴盲”、“亡血”、“视瞻昏渺”。诸如因肝肾阴虚、心营亏虚、久病虚损、七情郁结、气血两亏、淤血阻滞、脾肾阳虚等均可导致玄府郁闭，精气不能注目，终至目系失养，枯萎失明。《审视瑶函》说：“玄府幽深之源郁遏，不得发此灵明耳”。治疗以开郁通脉为要。有虚者，宜补中寓通。

方一：柴胡10克，当归12克，白芍12克，焦白术15克，茯

苓15克，炙草10克，丹皮12克，焦栀子10克，菊花15克，薄荷10克（后下）。水煎服。本方用于儿童视神经萎缩的肝郁血虚。

加減：抽搐、肢体屈伸不利者加全蝎5克，僵蚕12克，钩藤10克，伸筋草30克；足软无力者加牛膝12克，桑寄生30克，伸筋草30克；瞳神散大者加五味子8克，全蝎5克；口噤不语者加胆星5克。

方二：龟版25克（炙），桑椹子30克，女贞子15克，夜明砂12克，黄精15克，熟地12克，生地15克，旱莲草20克，赤芍10克，红花5克。水煎服。本方用于阴虚血淤者。

加減：睡眠不宁者加远志10克，五味子5克；消化不良者加炒枳壳10克，鸡内金10克；上睑下垂者加黄芪30克，党参25克，陈皮10克；眼肌麻痹者加全蝎5克，羌活8克；牙关紧闭、手足抽搐者加全蝎5克，僵蚕10克。

方三：生地15克，熟地10克，淮山药15克，泽泻10克，龟胶12克（烔化），鹿角胶5克（烔化），首乌12克（制），枸杞15克，楮实子10克，茯苓12克。水煎服。本方用于肝肾不足者。

方四：党参30克，黄芪30克，丹参12克，赤芍10克，甘草5克，生地12克，枸杞15克，桑椹子30克，女贞子12克。水煎服。用于病后虚损者。

方五：丹参15克，丹皮10克，赤芍12克，白芍12克，茺蔚子10克，青箱子10克，三七粉3克（冲服），人工牛黄2克（冲服）。水煎服。本方用于嗜烟酒或过量服用药物而中毒者。

方六：当归12克，赤芍12克，生地12克，川断12克，刘寄奴12克，仙鹤草10克，三七粉3克（冲服）。水煎服。本方用于外伤失明者。

方七：丹参15克，丹皮12克，石决明20克，赤芍12克，白芍12克，潼蒺藜12克，白蒺藜12克，三七粉3克（冲服），茺蔚

子10克。水煎服。用于肝郁血淤者。

加減：有余毒未清者加人工牛黄2克，银花15克，菊花12克，夏枯草30克；气虚者加党参25克，白术12克，枸杞12克；病久者与杞菊地黄丸同服，每日2次，每次6克。

方八：天冬15克，麦冬15克，生地黄12克，山萸肉12克，枸杞子12克，女贞子12克，沙参30克，玄参12克，何首乌12克，石斛10克。水煎服。本方用于阴虚者。

针灸疗法

穴位：睛明、球后、风池、足三里、光明、临泣。

每日一次，轮流取穴，10天为一疗程。疗程之间间歇3天。

穴位注射疗法

主穴：承泣、球后。

配穴：风池、大椎、哑门。

每次轮流选用主、配穴各1个，隔天1次，10次为1疗程。疗程之间间歇7天。主穴注射维生素B₁₂，每穴0.5毫升；配穴注射乙酰谷酰胺，每穴2毫升。

88. 单疱病毒性角膜炎

单疱病毒性角膜炎是眼科常见的一种病毒性角膜炎，多发生于感冒发烧之后，故又称为热性角膜匍行疹。因溃疡形似树枝，亦称为树枝状角膜炎。

任何年龄均可发生单疱病毒性角膜炎，以一侧眼发病者多。本病病程冗长，极易复发。患者感羞明，流泪，有异物感及眼疼等自觉症状。常因反复发作，导致视力减退。检查：

见有不同程度的睫状充血，或混合性充血，角膜知觉减退。有相当一部分人感染单纯疱疹病毒后，并不发生症状，若在发烧、受凉、疟疾、日晒、月经期、情绪波动、消化不良、过敏、劳累、角膜外伤等特定诱因下而发病。

祖国医学对本病的称呼是根据角膜的形态、色泽而取名的，如角膜上有浅层点状浸润时，称为“聚星障”，角膜形成弥漫性组织坏死时，称为“花翳白陷”。病因多为风热外侵，或肝胆内热，或心火上炎，或肾阴不足。《原机启微·风热不制之病》说：“因热而召，是为外来；久热不散，感而自生，是为内发。内外之邪，为病则一”。

本病疗效不理想，缺乏特效药物，难以根治。用抗生素治疗，罔效；投用激素，可使病情恶化。临床所见以实证居多，少数为虚中夹实。常以内服中药为主，内外兼治。治疗应注意整体情况，并适当借鉴古人的经验，如“暴病在表”，“久病多虚”，“翳从风生”，“目病属火”。易感冒者宜用温肾固表法，常腹泻者，又当从健脾和胃法着手。

辨证论治

（1）风热型。感冒后发烧，口渴喜冷饮，颜面红赤，心中烦闷，尿少便干。舌质红或尖边红，苔黄，脉数。

方药：银花12克，连翘12克，牛蒡子10克，薄荷10克，桑叶12克，菊花12克，红花5克，秦皮12克，蜜蒙花12克，蝉蜕5克。水煎服。

加减：夹寒加麻黄8克，细辛8克；热重加龙胆草10克，栀子12克；兼湿加苍术12克，苡仁30克。

（2）肝热型。眼红疼痛，羞明流泪，口苦咽干，尿黄。苔黄，脉弦细。

方药：龙胆草（酒炒）10克，夏枯草30克，草决明12克，

紫草12克，蒲公英30克，黄芩12克，栀子12克，车前子15克，当归10克，大黄8克（后下），生地15克。水煎服。

加减：疼痛重、充血暗紫者加桃仁12克，红花10克；星翳密聚者加蝉蜕10克，蛇蜕10克，蜜蒙花10克。

（3）心火型。口渴喜冷饮，胸闷心烦，尿黄少。舌尖红，脉数。

方药：竹叶12克，木通10克，生地12克，连翘12克，板蓝根30克，芦根20克，知母10克，黄柏10克，黄芩12克，女贞子12克。水煎服。

加减：口渴甚者加玉竹20克，麦冬20克；心烦懊恼者加栀子10克，淡豆豉10克；失眠加五味子8克，夜交藤30克。

（4）阴虚型。病程久而常复发，口干舌燥，渴而饮少。苔花剥，少津，舌红绛，脉细数。

方药：石斛10克，麦冬20克，菟丝子12克，沙参30克，生地5克，当归12克，谷精草12克，白蒺藜12克，青箱子12克，女贞子12克，枸杞子15克。水煎服。

加减：口干舌燥甚者加知母10克，花粉12克；胸闷、乏力、纳少者加茯苓15克，生苡仁30克；倦怠、久不愈者加黄芪30克，党参30克，淮山15克，蜜蒙花12克。

验方

方一：柴胡12克，夏枯草25克，钩藤30克（后下），板蓝根30克，大青叶20克，黄芩12克，薄荷10克（后下），蝉蜕10克，赤芍12克，蒲公英15克，菊花15克，甘草5克。水煎服。

方二：紫花地丁20克，蒲公英30克，银花20克，菊花15克，赤芍12克，决明子12克，车前子12克，柴胡10克，薄荷10克，木通10克，蝉衣10克，黄精15克。水煎服，并可用复煎药渣液熏洗眼部，每日2—3次，每次约20分钟。

方三：大青叶15克，百部15克，羌薊10克，鹤虱10克，防风10克，蒲公英30克，茺蔚子20克，桑叶15克，芥穗10克，苦参10克，苍术15克，银花15克。水煎服。服用半月后宜去大青叶、百部、羌薊、鹤虱、银花，加木贼12克，刺蒺藜12克，桑皮15克，蜜蒙花15克。

方四：赤芍12克，黄芩12克，桑叶12克，菊花15克，丹皮10克，花粉12克，泽泻10克，车前子10克，银花15克，连翘15克，玄参12克，蒲公英30克，薄荷10克（后下）。水煎服。

方五：葛根20克，蝉蜕15克，牛蒡子15克，连翘15克，地骨皮15克，银花15克，生地15克，花粉15克，草决明15克，薄荷10克（后下），甘草5克。水煎服。

方六：丹参15克，桃仁12克，红花10克，银花15克，桔梗8克，菊花15克，生桑皮15克，荆芥10克，防风10克，羌活10克，蜜蒙花12克，甘草5克。水煎服。

方七：黄芪30克，党参30克，菟丝子15克，枸杞15克，女贞子15克，山萸肉12克，黄精20克，丹参10克，川芎10克，陈皮10克，升麻5克，柴胡10克，五味子10克。水煎服。适用于本病的后期。

方八：银花15克，蒲公英20克，桑皮15克，花粉12克，黄芩12克，黄连10克，胆草12克，生地15克，知母12克，大黄10克（后下），芒硝10克（冲服），木通12克，蔓荆子10克，枳壳10克，甘草5克。水煎服，适用于本病中期热邪较重者。

方九：生地15克，知母10克，元参12克，天冬15克，麦冬15克，花粉12克，黄芩12克，胆草10克，枳壳10克，木贼12克，银花15克，蝉衣10克，菊花15克，薄荷10克（后下），甘草5克。水煎服。适用于本病末期阴虚者。

注射药

银黄注射剂，是用银花、黄芩的提取物制成的注射剂。有清热、解毒、抗菌、消炎的功效。肌肉注射，每日2次，每次2—4毫升。亦可点眼及结膜下注射。

外用眼药

(1) 虎田点眼液。内含虎杖、小田基黄。每日点眼4次，病重者取0.5毫升于患眼结膜下注射。

(2) 角膜病眼药水。内含10%当归、5%菖蒲、1%紫草、0.05%蜂蜜。点眼用。

(3) 消炎明眼药水。由精制炉甘石、珍珠母、天花粉、野菊花、黄连、银花等煎汁制成，再加西瓜霜、西牛黄、冰片。点眼用。

(4) 清凉散。内含炉甘石30克，硼砂2.5克，黄连6克，麝香0.6克，冰片4.5克，南薄荷4.5克。研极细。点眼。用于本病早期。

(5) 四宝散。内含麝香0.9克，冰片4.5克，皮硝30克，芥丹15克。研极细，贮藏备用。点眼，用于本病中期。

(6) 神效云见消。内含犀黄0.6克，月石0.6克，蕤仁霜3克，濂珠3克，琥珀4.5克，熊胆4.5克，辰砂4.5克，海螵蛸4.5克，冰片9克，九制甘石30克，芥丹15克。研成细末，备用。点眼，用于病久或末期。

熏眼药

方药：秦皮10克，黄柏10克，红花6克，菊花15克，银花15克，桑叶15克，板蓝根30克，野菊花30克。煮沸，用蒸气熏眼。每日3次，每次20分钟。

89. 中心性浆液性视网膜脉络膜炎

中心性浆液性视网膜脉络膜炎是一种较常见的眼底病，受累部位主要局限在黄斑区。病因尚不明确，病名亦很混乱，有称本病为中心性血管痉挛性视网膜病变，有称为中心性血管痉挛性脉络膜视网膜病变，或称为视网膜前水肿，或称为特发性扁平性视网膜脱离，或称为中心性浆液性视网膜病变，或称为视网膜扁平脱离，或称为结核过敏性视网膜炎，或称为血管痉挛性视网膜脉络膜病变。

一般认为，黄斑区附近的小动脉收缩，使周围的毛细血管扩张，导致浆液渗入附近组织，形成周围组织的积滞现象。就病程而言，有水肿期、渗出期、恢复期、痊愈期之分。

本病的主要症状为视力模糊，眼前如有纱布遮挡，视物变小，或变形，或变大，中心暗点。在疾病的初期，视力尚好，有的只有偏头痛而已。因反复发作，才造成永久性视力损害。

中心性浆液性视网膜脉络膜炎属中医“内障”范畴，与“视瞻昏渺”、“视瞻易色”、“视物不真”、“目黑候”、“目茫茫候”、“视惑”等颇相似。《银海精微》说：“肝肾之气充，则精彩光明；肝肾之气乏，则昏朦眩晕”。《诸病源候论·目暗不明候》说：“五脏六腑，阴阳精气，皆上注于目。若为气血充实，则视瞻分明，血气虚竭，则风邪所侵，令目暗不明”。黄庭镜《目经大成·视惑》说：“此目人看无病，但自视物颠倒紊乱，失去本来面目，如视正如斜

……赤如白……小如大……之类”。本病属正虚邪盛，正虚主要为劳倦内伤，脾失运化，气血亏虚，精微不升；或情志失调，肝气郁法；或肝肾不足，阴津匮乏，目失滋养。邪盛主要为内湿停滞，痰聚血淤，闭塞玄府。

辨证分型治疗

(1) 肝肾阴虚。头晕耳鸣，腰酸腿软，遗精口干。舌质红。苔白而干，脉细数。

方药：生地15克，丹皮12克，枣皮15克，茯苓15克，赤芍12克，当归15克，淮山10克，泽泻10克，枸杞30克，菊花20克，丝瓜络25克，珍珠母50克。水煎服。

加减：初期加银花15克，连翘15克，芥穗10克，薄荷10克，黄芩12克；病久加桃仁12克，红花10克，苏木10克，丹参15克，三棱10克，莪术10克。

(2) 肝热脾湿。情志不舒，口干不喜饮，眼胀或头痛，胸闷纳少。苔薄白，舌质淡红，脉弦数。

方药：菊花15克，木贼10克，蝉蜕10克，银柴胡10克，羌活10克，生地10克，女贞子15克，苍术12克，赤芍5克，白术15克，防风10克，菟丝子15克，甘草3克。水煎服。

加减：眼雾加磁石30克，建曲10克。

(3) 脾胃虚弱。面色萎黄，腹胀便溏，胸闷食少，倦怠乏力，口不渴。苔薄白，舌质淡，脉缓。

方药：苍术20克，白术30克，草蔻10克，炒建曲15克，陈皮12克，羌活10克，防风10克，蝉蜕10克，木贼10克，茯苓15克。水煎服。

加减：气虚加党参20克，黄芪20克；血虚加阿胶15克，首乌20克。

(4) 淤血阻络。头痛，眼胀。舌质暗红，苔薄白，

脉沉。

方药：柴胡10克，白芍10克，枳壳10克，甘草5克，牛膝10克，桔梗5克，桃仁10克，红花10克，当归12克，川芎5克，生地12克，茯苓15克，白术15克，泽泻12克。水煎服。

加减：黄斑区水肿明显者加冬瓜皮30克；渗出物多者加丹参20克；充血明显者加茜草15克；吸收迟缓者加昆布12克，海藻12克。

（5）脾肾阳虚。胃纳不好，怕冷，腰酸膝软，五更溏泻，不渴。舌质淡，苔白，脉沉缓。

方药：吴萸10克，干姜12克，制附片10克（先煎两小时），白术30克，苍术20克，银柴胡10克，草薢10克，陈皮10克，蝉蜕10克，木贼10克。水煎服

加减：腰酸膝软甚者加仙茅12克，淫羊藿20克，补骨脂12克，沙蒺藜12克；

验方治疗

方一：茯苓12克，泽泻10克，猪苓10克，桂枝5克，白术12克，车前子15克，大豆卷30克，木瓜10克，龙骨20克，牡蛎20克，白芍12克，蔓荆子20克。水煎服。宜用于本病早期。

方二：桃仁12克，红花6克，当归12克，川芎10克，白芍12克，生地12克，丹参15克，仙鹤草30克，香附12克，枳壳10克，海藻12克，茺蔚子12克，龙骨20克，牡蛎20克。水煎服。适用于本病后期。

方三：熟地12克，丹皮12克，淮山12克，枣皮12克，茯苓12克，泽泻12克，白芍12克，贝齿12克，龙骨20克，蔓荆子12克。水煎服。本方宜用于素体虚弱，反复发作。

方四：党参30克，茯苓20克，苍术12克，桑皮20克，苡仁30克，甘草5克，神曲15克，焦楂15克，麦芽15克。水煎服。本方宜用

于脾气虚弱型。必要时加服归脾丸，或补中益气丸。

方五：楮实子12克，复盆子12克，女贞子12克，菟丝子12克，车前子12克，桑椹子30克，枸杞子20克。水煎服。本方宜用于肝肾阴虚型。

方六：夏枯草25克，黄精25克，黄连10克，栀子10克，菊花15克，女贞子30克，枸杞子30克，茯苓15克，丹皮20克。水煎服。

方七：生地15克，熟地15克，山药12克，当归12克，麦冬15克，五味子10克，银花12克，连翘12克，夏枯草20克，草决明15克，泽泻15克，车前子12克。水煎服。本方宜用于本病的水肿、渗出期。

方八：菟丝子15克，楮实子15克，枸杞15克，茺蔚子12克，生三七粉8克（冲服），木瓜10克，车前子12克，苡仁30克，炒谷芽15克，炒麦芽15克。水煎服。本方宜用于肝肾阴虚型。

方九：茵陈12克，苡仁30克，白薏仁8克，杏仁12克，枳实10克，竹茹12克，滑石20克，木通12克，竹叶10克，法夏12克，陈皮12克，茯苓15克。水煎服。本方宜用于肝热脾湿型。

方十：桂枝10克，白芍12克，炙甘草10克，大枣12克，生姜10克，龙骨20克，牡蛎20克，肉桂粉8克（冲服）。水煎服。配合其它方药，可提高疗效。

针刺治疗

有四组穴位可以选用：

（1）主穴：睛明、健明₁、球后、承泣。

配穴：太阳、风池、医明、足三里、合谷、曲池、肝俞、肾俞。

（2）向阳₁、向阳₂。

（3）新明₁、新明₂。

(4) 阳明穴，用五分针呈 30° 角向眉弓方向刺入，得气后小幅度捻转半分钟，留针 15 分钟后出针。

以上各组每日只针刺 1 穴，10 天为 1 疗程，疗程间可休息 3 天。

耳针治疗

穴位：目₁、目₂、肝、皮质腺。一般 2—3 天针 1 次，用患侧耳穴；也可每天针 1 次，取双耳穴，交替使用，留针 30—60 分钟。

90. 视网膜静脉周围炎

视网膜静脉周围炎是常见的眼底病，主要的特征是：视网膜和玻璃体反复性出血。因多发生于 20—35 岁的青壮年，故又名青年性反复性视网膜玻璃体出血。多见于男性，主要的临床症状是：视力减弱，甚而降至光感。

本病的成因尚不十分明确。多数学者认为与结核的变态反应有关，对身体其它部位的病灶感染和内分泌障碍也应加以考虑。如果患者精神过度紧张，常使病情加重，病程延长。西医多用消炎、抗癆、止血以及维护网膜功能等法，效果不甚满意。

诊断本病，主要根据发病特点和典型的眼底变化。特别是散瞳后详细地检查眼底周围边部，对早期诊断具有重要意义。

中医把视网膜静脉周围炎归属于“青盲”、“暴盲”范畴。出血量较少时对视力影响不大，仅觉眼前有飞蚊舞动，称为“云雾移睛”症；当出血侵入玻璃体时，患眼前可出现索条状黑影；一旦出血量较多，则有一过性红视，视力随即

降低，严重时仅能辨眼前指数。《血证论》说：“火热相搏则气实，气实则逼血妄行”。气逆则血升，使血从上窍而出。火热是气逆之本，气逆是火热之标。治疗原则是“上者抑之”、“清火亦即降气”。另外有一种是阴虚，血分伏热，导致血热气逆，迫血妄行。当滋阴清热治其本，凉血降逆治其标。病久多有气血不足，或有淤血停滞。宜配服用补气血、化淤血之品。总之，治疗本病，不能局限于眼底局部的变化，亦不可拘泥于一方一药，而要从整体出发，审证求因，调达情志。

（1）阴虚血热型。头晕耳鸣，口干喜饮，大便干结，眼球灼热、胀痛，失眠多梦，或五心烦热，腰膝腿软。舌质红，苔少，脉细数。

方药：黄连8克，生地20克，丹皮15克，石斛15克，玄参15克，白芍15克，茅根30克，银花30克，血余炭5克，羚羊角粉2克（冲服）。水煎服。

（2）肝经火炽型。烦躁易怒，胸闷纳少，口干尿黄。舌红苔薄，脉沉弦。

方药：夏枯草30克，菊花15克，木贼10克，蝉衣10克，银柴胡10克，羌活10克，防风10克，白术15克，生地15克，女贞子15克，菟丝子12克。水煎服。

（3）肝胃热盛型。头痛口干，渴多引饮。舌绛少苔，脉弦数有力。

方药：生石膏30克，知母12克，生地15克，代赭石30克，龙胆草10克，黄柏10克，生栀子10克，白蒺藜15克，竹叶12克，阿胶10克（烔化），陈皮10克，甘草5克。水煎服。

（4）心脾两虚型。病程迁延，或素来体弱，心累心跳，头晕眠差，纳食量少，食后不化，面白少华。舌润无苔，

脉虚数。

方药：当归15克，白芍12克，川芎8克，生地15克，太子参30克，淮山15克，玉竹15克，枣仁10克，五味子5克，黄芪20克，水煎服。

（5）气滞血淤型。病情日久，眼底出血反复发作。苔白，舌质紫，或舌下静脉怒张，脉涩。

方药：当归12克，丹参15克，赤芍15克，生地15克，熟地15克，丹皮12克，郁金15克，茜草15克，川芎10克，青皮10克，茅根30克，水煎服。

本病虽然按症状为分五型，但都要参照眼底检查结果，即（1）视网膜静脉周围的改变；（2）视网膜出血；（3）玻璃体出血；（4）视网膜和玻璃体的结缔组织形成。五型之中，以阴虚血热型和肝经火炽型较为多见。下面再介绍八个处方。

方一：生地20克，白芍10克，丹皮10克，女贞子15克，旱莲草30克，生栀子10克，赤芍12克，蝉衣10克，木贼12克，生龙牡各20克，沙参20克，知母12克，黄柏10克。水煎服。本方适用于阴虚血热型。

方二：龙胆草10克，栀子炭12克，黄芩炭12克，生地20克，车前子15克，丹皮15克，泽泻15克，银柴胡8克，白茅根30克，甘草5克。水煎服。本方宜用于肝经火炽型。

方三：桃仁10克，红花10克，当归15克，川芎10克，生地15克，赤芍10克，牛膝12克，银柴胡5克，枳壳5克，桔梗8克。水煎服。本方宜于气滞血淤型。

方四：地黄炭20克，白芍12克，茯神12克，旱莲草40克，女贞子15克，当归12克，阿胶10克（烔化）。水煎服。本方适用于出血期。

方五：当归尾15克，赤芍12克，红花10克，木通12克，细辛8克。水煎服。本方适用于出血停止，眼内积血期。

方六：炒生地15克，丹皮12克，丹参15克，当归尾12克，三七8克（冲服），茺蔚子12克，桔梗5克，白芨12克，楮实子15克，鳖甲20克（炙），山楂20克。水煎服。本方适用于出血大部吸收，伴有增殖性视网膜病变期。

方七：白芍20克，连翘20克，白茅根20克，丹皮12克，茜草根12克，旱莲草12克，生地15克，藕节15克，黑地榆10克，当归10克，女贞子10克，川芎5克，甘草5克，三七8克，（冲服）。水煎服。本方适用于急性出血期。

方八：海藻30克，昆布15克，藕节30克，滑石20克，海金沙15克，黄芪15克，鸡内金10克，血余炭10克，鹿角10克，夏枯草20克，桂枝8克，三七粉8克（冲服）。水煎服。本方适用于病程日久，气滞、血瘀内阻型。

91. 视网膜静脉阻塞

视网膜静脉阻塞发病急，常见而又难治，由视网膜中央静脉或其分支发生阻塞所致。眼底特征是：视网膜静脉高度曲张和以视乳头为中心的广泛性出血。好发部位多在视网膜中央血管颞上支。

本病的成因多与动脉硬化有关，患者多有高血压、慢性肾炎、糖尿病和血管炎等。与某些急性传染病、静脉血流迟缓亦有关系。近几年来，本病发病率有上升趋势，患者多为老年。

视网膜静脉阻塞的主要症状是中心视力下降，或有某部

分视力缺损；有的尚可保存一定的视力，能在数公尺内保持数指能力；严重者亦可失明。

中医称本病为“暴盲”，早期表现多“热”，后期表现多“淤”，体胖者有痰浊，年老体弱者有虚损。治疗时，多以清热、凉血、补虚、祛淤、活血、化痰等药物组成复方。这类方剂对外周血管多有扩张、降低通透性、改变血液粘度、改善微循环等多种作用。

（1）肝火上炎型。视力急骤下降，颜面红赤，心烦意乱，口干苦，大便结，小便黄。舌红，苔黄，脉弦数。

方药：龙胆草10克，木通12克，柴胡10克，车前子20克（布包入煎），生地20克，栀子10克，黄芩12克，泽泻15克，赤芍12克，丹皮12克，甘草5克，羚羊角粉8克（冲服）。水煎服。

（2）阴虚火旺型。视力缓缓减退，五心烦热，面部潮红，口干咽燥，眠差梦多，腰膝酸软，形体枯瘦。苔净舌红，脉细数。

方药：女贞子20克，旱莲草30克，知母12克，黄柏10克，生地15克，丹皮12克，茯苓15克，泽泻15克，枣皮12克，淮山15克，丹参15克，桑椹子30克。水煎服。

（3）肝郁气滞型。胸胁胀闷，多愁善感，易怒性急。苔白，脉弦细。

方药：柴胡10克，当归15克，白芍12克，赤芍12克，香附12克，郁金10克，枳壳10克，川芎5克，丹参15克，茯苓20克，茺蔚子15克，栀子12克，甘草5克。水煎服。

（4）痰浊内蕴型。形体肥胖，胸闷多痰，头昏晕。苔腻，脉弦滑。

方药：黄连3克，竹茹12克，枳实10克，陈皮12克，半夏12克，茯苓15克，黄芩12克，甘草5克。水煎服。

(5) 气虚血淤型。年老体弱，倦怠乏力，或无明显全身症状，只觉视力逐渐下降。舌有淤斑，脉涩。

方药：银柴胡10克，白芍12克，枳壳10克，牛膝12克，桔梗5克，桃仁12克，红花8克，当归15克，生地15克，川芎10克，黄芪30克，水蛭粉1克(吞服)。

除了辨证论治为主外，结合病情新旧、兼证等，可酌选下列药物。

(1) 早期。视力不断下降，应选止血而又不留淤之药，如蒲黄10克，茜草15克，侧柏叶30克，大蓟30克，小蓟30克，三七粉8克(冲服)，茅根30克，藕节30克。

(2) 中期。视力减退后，保持在一定水平上，应选用活血祛淤药，如桃仁12克，红花10克，当归12克，赤芍12克，生地15克，川芎10克，生蒲黄10克，丝瓜络15克，决明子10克。

(3) 后期。视力逐渐恢复时，应加软坚散结药，如昆布15克，海藻15克，夏枯草30克，生牡蛎20克。

(4) 热毒重者(全身有感染史)。加银花20克，连翘15克，蒲公英30克。

其它有效方药录于后，备急选用。

方一：当归12克，川芎10克，玉竹15克，怀牛膝15克，丹皮12克，黄芩12克，龙胆草10克，生桃仁12克，赤芍12克，决明子10克，丝瓜络15克，生蒲黄10克，甘草5克。水煎服。本方适用于肝火上炎型。

方二：桑椹子30克，决明子12克，苡仁30克，党参30克，桃仁12克，红花10克，玉竹15克，当归12克，女贞子15克，丝瓜络15克，三七粉8克(冲服)。水煎服。本方适用于阴虚火旺型。

方三：丹参15克，白芍10克，赤芍10克，银柴胡10克，羌活10克，防风10克，木贼12克，蝉蜕10克，当归12克，白术12克，

茯苓15克，甘草8克。水煎服。

方四：地龙10克，钩藤10克，知母10克，黄柏10克，牛膝10克，夏枯草30克，丹参15克，茺蔚子15克，生地20克，石决明20克，决明子20克，茯苓20克，木贼5克。水煎服。本方适用于老年而兼有高血压病者。

方五：银花30克，玄参30克，旱莲草30克，丹参25克，赤芍25克，当归15克，生黄芪15克，瓜蒌仁15克，茜草10克，黄芩10克，丹皮10克，炒槐米12克。水煎服。

加减：陈旧性出血者加三七粉8克(冲服)，生蒲黄10克，丝瓜络15克，地龙12克；新出血者选小蓟30克，地榆15克，白茅根30克，藕节30克；高血压者加石决明20克，钩藤15克，菊花15克。

方六：桂枝8克，黄芪40克，当归12克，白芍12克，川芎10克，党参30克，生地12克。水煎服。

方七：生地15克，玄参15克，麦冬15克，沙参30克，白芍12克，知母10克，黄柏10克，丹参15克，赤芍12克。水煎服。本方适用于阴虚火旺型。

方八：生地20克，赤芍12克，丹皮15克，夏枯草30克。水煎服。本方有凉血散瘀作用。

方九：人参田七注射液。此系成药，每毫升含三七总甙50毫克。每次用2—6毫升，加入在50%葡萄糖40毫升中，静脉注射，10次为一疗程。

92. 老年性白内障

老年性白内障是后天性白内障中最常见的一种，是老年

性常见致盲疾病之一。多发于45岁以上的中年人和老年人，女性多于男性，通常是双眼发病。

本病的病因不甚明确。一般认为是在老年性血管硬化的基础上，由于血液-房水屏障的功能失调，致使晶状体逐渐脱水、硬化、变性，终至混浊。本病一经罹患，多呈进行性加重，造成失明，极少有自愈者。至目前为止，治疗老年性白内障尚缺乏积极的有效办法，西医仍以等待晶状体全部混浊后行手术摘除为主。

本病属中医的“圆翳内障”、“如银内障”、“枣花翳”范畴。辨证多为气郁化火，肝肾阴虚，或中气不足，血少津亏。如若是性情忧郁或急躁易怒者，发病年龄多提早；情志波动之后，病情常加重。总的说来，老年性白内障与肝、脾、肾三脏关系密切。肝开窍于目，肝之经脉上连目系，肝喜条达，恶抑郁。若情志变化，疏泄失常，或气郁化火，灼伤津液，导致阴血不能上注，目失养则视物昏花；脾是后天之本，统血，运化输布营养精液，并上贯于目；脾旺则不受邪，虚则生百病。《素问·上古天真论》说：“肾者主水，受五脏六腑之精而藏之”，《证治准绳·七窍门》谓：“真精血，乃先后天元气所化之精汁，起于肾，施于胆，而后及乎瞳神也”。若真精不足，目失濡养，必然视力下降，最后酿成白内障。

方一：生地15克，熟地15克，决明子15克，桑椹子30克，山药15克，山萸肉12克，枸杞子15克，菊花15克，柴胡10克，女贞子12克，菟丝子12克，楮实子12克，白蒺藜10克。水煎服。本方适用于肝肾阴虚型。

方二：盐水炒菟丝子15克，酒炒黄柏10克，枸杞子15克，复盆子15克，山萸肉12克，五味子5克，降香5克，炙甘草5克。

水煎服。本方适用于肝肾阴虚型。

方三：黄芪30克，葛根12克，党参30克，茯苓15克，山药12克，白术15克，木贼10克，柴胡12克，当归12克，白芍12克，蝉衣10克，五味子5克，炙甘草5克。水煎服。适用于脾虚气弱型。

方四：黄芪30克，焦六曲15克，炒白术15克，葛根12克，升麻5克，炒党参30克，白芍12克，炙甘草5克，蔓荆子10克，盐水炒黄柏10克，桑椹子30克。水煎服。本方适用于脾虚气弱型。

方五：黄芪30克，炒枣仁12克，桑椹子30克，磁石30克，党参30克，茯苓15克，龙眼肉15克，蝉衣10克，白术15克，远志10克，白蒺藜10克，炙甘草5克。水煎服。本方适用于脾虚血弱型。

方六：女贞子12克，旱莲草15克，麦冬15克，生地12克，炒当归12克，炒枣仁12克，炒白术15克，龙眼肉15克，石斛10克，炒白芍12克，远志10克，广木香5克。水煎服。本方适用于血虚型。

方七：黑豆30克，枸杞子15克，沙苑子15克，菟丝子15克，何首乌15克，煅石决明20克，夏枯草30克，茺蔚子15克，决明子15克，楮实子15克，旱莲草15克。水煎服。亦可按此比例增加重量，制成丸药服。

方八：肉苁蓉15克，山萸肉12克，枸杞子15克，党参25克，黄芪25克，玉竹15克，甘草5克，升麻5克，石菖蒲10克，蜜蒙花12克，蔓荆子10克，川芎10克，菊花15克。水煎服。亦可按此比例增加重量，制成片剂服用。

方九：生地15克，熟地15克，石决明20克，珍珠母30克，山药15克，泽泻12克，枸杞12克，菊花15克，蜜蒙花15克，白蒺藜15克，谷精草15克，石斛10克，玉竹15克，云苓15克，女贞子15克，桑椹子30克。水煎服。亦可按比例增加重量，研末，

制成蜜丸服。适用于肝肾阴虚型。

方十：黄芪30克，党参30克，制首乌15克，云茯苓15克，丹参15克，白术12克，当归12克，远志10克，炒枣仁12克，白芍12克，谷精草12克，焦楂20克，鸡血藤30克，草决明10克。水煎服。亦可按此比例增加重量，研末，制成蜜丸服。适用于脾虚气弱型。

方十一：龙胆草10克，茺蔚子15克，白芍15克，旱莲草20克，丹参15克，丹皮15克，生地15克，刺蒺藜15克。水煎服。亦可增加药味的重量，制成片剂，常服。

外用点眼药液

方药：以威灵仙液制炉甘石500克，辰砂5克，牛黄8克，麝香1.5克，冰片50克，各研极细末和匀，点眼用。

耳针疗法

取眼、肝、肾、内分泌、交感、神门穴埋针，两耳交替，每3—5日针1次，5次为一疗程。

93. 霰粒肿

霰粒肿是由于睑板腺排泄管发生阻塞，腺内滞留的分泌物刺激周围组织而形成的慢性炎症肉芽肿。多发生于上睑，下睑较少，病程缓慢。

病人常无明显的自觉症状，初起时可见眼睑皮下有米粒大或绿豆大的圆形肿块，不红不痛，触之发硬，推之移动，与皮肤无粘连，翻转眼睑，睑内面可见紫红或灰白色隆起结节。以后逐渐长大，可大如樱桃，坚硬隆起，有胞睑垂坠和胀涩感。霰粒肿较小者，可自行消散，亦有复感毒邪而化

脓者。

霰粒肿属于祖国医学的“胞生痰核”、“胞睑肿核”范畴。多因胃肠蕴热与痰湿混结，致痰火结滞，阻塞经络，发于眼胞而成胞睑肿核。

辨证分型治疗

(1) 痰湿型。胞睑肿核不痛不痒，表面皮肤不红，肿核大，有坠胀及轻度异物感，按之坚实。治宜除湿化痰，软坚散结。

方药：昆布20克，浙贝12克，苍术15克，枳壳10克，茯苓15克，法半夏12克，陈皮12克，海藻30克。水煎服。

(2) 痰火型。胞睑肿核痛痒，患处睑结膜呈黄色，皮肤颜色红赤（继发感染）。治宜清热除痰散结。

方药：生石膏30克，枳实10克，胆南星10克，夏枯草30克，银花30克，连翘15克，赤芍30克，浙贝12克，白芷10克。水煎服。

单方验方治疗

(1) 紫金锭（成药）用冷开水调成糊状，涂患眼皮，不可入眼。每日涂3—4次。

(2) 甲珠15克，竹茹15克，浙贝12克，枳实10克，陈皮12克，法半夏12克，茯苓10克，甘草6克。水煎服。

(3) 防风、昆布、红花各等分，水煎汁作湿热敷，每日3次，每次15分钟。

(4) 生南星6克，冰片1克，共研细末，用醋调成糊状，涂患眼皮，不可入眼。每日涂3—4次。

(5) 五倍子6克，生半夏6克，蟾酥0.1克，共研细末，用醋调成糊状，涂患眼皮，不可入眼。每日涂3—4次。

针灸治疗

(1) 体针。取穴：合谷、风池、太阳。

方法：每日针一次，强刺激，适用于痰火型。

(2) 耳针。取穴：眼、肝、脾。

方法：每日针一次，每次留针 20 分钟。

94. 泪道阻塞

人体在正常情况下，泪腺分泌泪液，润湿和洗涤眼球表面。泪液大部分由眼球表面蒸发，少部分通过结膜囊的吸引进入泪湖，然后在泪囊的虹吸作用下经泪道而到达鼻腔。当某些原因引起泪道阻塞时，泪液从睑沿溢出。这是一种症状，老年患者居多。

泪道阻塞属于祖国医学“迎风流泪”的范畴。古人将本病分为迎风流泪、迎风冷泪、迎风热泪、无时泪下、无时冷泪、无时热泪等，归纳起来不外冷泪、热泪两大证。中医认为，目为肝窍，泪为肝液，肝肾同源，故流泪常与肝肾两经有关。肝经郁热，感受风邪而发，多与外障眼病并见，称为热泪。肝肾两虚，窍失所养，外受冷风刺激而发，称为冷泪。

辨证论治

(1) 热泪证。泪液流出时有热感，且粘浊，常大眦潮红，焮痛，发痒，甚者畏光羞明。治宜平肝，祛风，清热。

方药：石决明30克，草决明30克，荆芥10克，赤芍30克，青箱子18克，栀子10克，麦冬20克，木贼15克，防风15克，刺蒺藜25克，蔓荆子15克。水煎服。

(2) 冷泪证。眼睛不红不痛，泪下无时，迎风更甚。泪液清亮，流至睑缘或面部无热感。治宜温肝、搜风、止泪。

方药：白薇15克，羌活6克，石榴皮10克，防风15克，刺藜15克，川芎10克。水煎服。

单方验方治疗

(1) 桑叶15克，芒硝8克，水煎，澄清液洗眼，每日2—3次。

(2) 秦皮15克，水煎，澄清液洗眼。

(3) 巴戟10克，枸杞15克，菊花10克，肉苁蓉10克。水煎服。

(4) 川椒12克，生地30克，熟地30克，共研细末，炼蜜为丸。每次服10克，淡盐汤送服。

(5) 当归、熟地、谷精珠各等量，研细末和匀，每次服10克，开水送服。

(6) 木贼15克，党参30克，白术10克，枸杞15克，白蒺藜10克，赤芍30克，当归30克，川芎10克，谷精草10克。水煎服。

针灸治疗

取穴：睛明、球后、承泣、攒竹、肝俞、肾俞、阳白、合谷。

方法：每次取2—3个穴，行雀啄法，至有酸胀感后即退针，亦可留针20分钟。

95. 睑 缘 炎

睑缘炎是眼睑边缘的慢性炎症。本病的特点是眼睑边沿红赤溃烂而痒，病程缠绵，且易复发，常为双眼同时罹病。

睑缘炎的主要自觉症状为睑缘刺痒、干涩或灼热疼痛，少数伴有轻度羞明、流泪。

睑缘炎属于祖国医学的“睑弦赤烂”、“烂弦风”、“红眼边”等范畴。多由脾胃蕴结热毒，或因眼刺痒、异物感等用手揉擦过多，外受湿毒之邪侵犯，热与湿毒相搏，停于眼睑，发于睑缘。脾虚挟湿，水湿停滞，上攻眼睑而成本病。

辨证分型治疗

(1) 风热外袭。睑缘刺痒，干涩不适，睑缘睫毛根部漫生糠皮样鳞屑，除去皮屑，睑缘皮肤呈红色，睫毛易于脱落，但可以再生。治宜祛风清热。

方药：菊花15克，桑叶15克，刺蒺藜25克，防风10克，赤芍30克，薄荷10克（后下），僵蚕12克，生地30克。水煎服。

(2) 脾热上攻。睑缘刺痒、涩痛，常发透明水泡样细小颗粒，水泡擦破后，红赤湿烂，糜烂胶粘，痂皮积聚，拭去痂皮，则有出血的溃疡，睫毛卷曲，易于脱落，不能再生，可致眼睑变形。治宜清热解毒，祛风除湿杀虫。

方药：银花30克，连翘15克，蒲公英30克，苍术10克，黄芩15克，赤芍30克，栀子12克，蝉蜕10克，鹤虱15克，雷丸10克。水煎服。

(3) 表里俱虚。胞睑松弛，睑缘湿烂色白，流泪发痒。治宜温表固里。

方药：茯苓30克，桂枝12克，白术12克，甘草10克。水煎服。

单方验方治疗

方一：野菊花15克，白矾1.5克，水煎约500毫升，澄清，分为三等份，外洗患处，日三次。

方二：乌贼骨30克，白芷30克，薄荷15克，蔓荆子15克，蕤仁12克，芡实12克，刺蒺藜12克，蔻壳12克，蝉蜕10克，炉甘石500克，珍珠粉1.5克，猪油适量。

制法：将炉甘石火煨研细，分作两份待用。将乌贼骨、白芷、薄荷、蔓荆子、蕤仁、芡实、刺蒺藜、蔻壳、蝉蜕加水煎好去渣，倾入瓷器中，加入一份炉甘石，和匀，用棉纸将瓷器口封固，日晒夜露。待干后，再加珍珠粉和另一份炉甘石，和匀、研极细末，用猪油伴成油膏。

用法：涂眼睑患处，一日2—3次。

方三：桑叶30克，切细，放食醋60毫升内泡5天，过滤，用棉签蘸涂患处，每日2—3次。

方四：蚕砂15克，放新瓦上焙焦，研极细末，用醋适量调成糊状，临睡时涂患处。

方五：乳香10克，黄连10克，荆芥10克，灯心6克。水煎服。

96. 泪 囊 炎

泪囊炎是指从泪囊中流出脓浊眼泪的眼病。对整个眼球的健健康有很大的威胁。因为它不但减少泪液的清洁冲洗作用，同时，如有角膜损伤或作眼部手术时，有泪囊炎的存在易引起化脓感染。

泪囊炎有急性和慢性两种，常由于沙眼、慢性结膜炎、慢性鼻炎和副鼻窦炎等疾病引起。幼儿多为鼻泪管先天性残膜引起。由于鼻泪管阻塞，泪液储留在泪囊中，使泪囊逐渐扩大，增厚，产生粘液，继以细菌感染，形成脓液，便成慢

性泪囊炎。炎症骤然加剧，则为急性泪囊炎。

泪囊炎属于祖国医学的“眦漏证”、“漏睛证”范畴。多由心脾热邪，蕴蓄日久，上攻内眦，闭塞目窍，泪不流通，而与风热蕴结成脓；或因风热外侵，引动内火，内外合邪而病。

慢性泪囊炎的临床表现：脓泪频流，内眦睛明穴下方，有时可见隆起，压迫内眦处，有沁沁脓液自泪囊流出，病势缠绵，自觉目涩，视物昏蒙。

急性发作时，内眦睛明穴下方红肿焮痛，重者红肿波及眼睑；触之泪囊区有硬结，压痛明显，常伴有眼胀头痛，甚至有恶寒发热，口干便燥等全身症状。数日后泪囊部皮肤出现黄色脓点，按之有波动感，排脓后肿痛即可消退。

辨证分型治疗

（1）风热型。泪囊区轻度胀痛不适，局部皮肤颜色稍红，包块微隆起。舌红苔黄，脉浮数。治宜祛风清热。

方药：银花30克，连翘15克，野菊花15克，赤芍30克，防风10克，白芷10克，蒲公英30克，淡竹叶12克。水煎服。

（2）心火炽盛型。泪囊区胀痛明显，局部红肿，硬结，疼痛拒按，恶寒，发热，口渴，舌尖红，脉数。治宜泻心火，解热毒。

方药：生大黄10克，黄芩10克，黄连10克，荆芥10克，防风10克，知母10克，白芷12克，当归15克。水煎服。

（3）热邪滞留型。泪液胶粘，指压泪囊区见脓液或粘性脓液从泪点溢出。舌红苔黄，脉数。治宜清热解毒，托里排脓。

方药：黄芪30克，赤芍30克，蒲公英30克，甘草10克，浙贝12克，银花30克，皂刺10克，白芷10克，川芎12克，野菊花15克。

水煎服。

单方验方治疗

(1) 六神丸，水调化3—4粒，涂患处皮肤，不可入眼，每日涂3次。六神丸亦可内服，每次服10粒，每日3次。

(2) 野菊花叶（鲜品）15克，红糖适量，共捣烂，外敷患处。

(3) 龙胆草12克，当归12克，共研末，温酒调服。

(4) 黄芪30克，穿山甲10克，黄芩15克，大黄10克，防风10克，地骨皮15克，漏芦15克，远志10克，党参30克，赤芍15克，共研细末，每次服10克，每日服2次，开水送服。

97. 智齿冠周炎

萌出不全的智齿叫阻生智齿。智齿冠周炎是指阻生智齿牙冠周围软组织发炎。多发生在18—30岁的青壮年，是一种常见的口腔疾病。

人类进化。饮食改善使下颌后缩较显著，而牙齿变异却不显著，故本病多发于下颌。下颌智齿冠周炎，主要是由于智齿萌出困难或只萌出部分，在人体抵抗力减弱的情况下，这部分萌出的智齿牙冠周围软组织就容易发生炎症。

临床表现：初期牙龈疼痛，红肿，全身症状不明显。如炎症发展，则牙龈红肿加重，伴有不同程度的开口困难和吞咽疼痛，颌下淋巴结肿大并压痛，发烧，全身不适，食欲减退，大便秘结。随病情进一步发展，炎症扩散，可引起颊部脓肿或扁桃体周围脓肿甚至引起脓毒败血症。

智齿冠周炎属于祖国医科的“牙咬痛”、“合架风”范畴。多由风热之邪袭于少阳，或风热外乘，阳明湿热蕴蒸；或阴亏络空，少阳胆火循经上逆而成。《疡科心得集》说：“……若遏抑凝滞，则肿愈坚，牙关愈闭矣。至三、四日后，寒热不退，不能消散，其脓结于盘牙（智齿）尽处者为牙咬，结于腮边外者为托腮，结于牙根者为牙痛……”说明牙咬痛专指智齿周围的脓肿。治疗宜疏风清热，凉血解毒。

内治法

方药：牛蒡子20克，银花30克，连翘15克，生石膏30克，生山栀12克，芦根30克，僵蚕10克，赤芍30克，生地15克。水煎服。

加减：大便秘结者加大黄。胸闷呕恶者加陈皮、竹茹。咽喉不利者加桔梗、射干、山豆根。患处坚硬、牙关紧闭难开者加骨碎补。肿痛难消者加山药、苡仁、黄芪。

外治法

初起用金黄膏外敷（大黄、黄柏、姜黄、白芷各10克，南星、陈皮、苍术、厚朴、甘草各4克，天花粉20克，共研细末，加适量凡士林调匀成膏，外敷患处）。口腔内吹冰硼散（元明粉15克，朱砂1克，硼砂15克，冰片1克，各研极细末，和匀，瓶装备用，用时喷入患处）。

溃后外敷金黄膏，口腔内吹入青吹口散（煅石膏10克，煅人中白10克，青黛3克，薄荷1克，黄柏2克，黄连2克，煅月石18克，冰片3克，各研极细末，和匀）。

针刺疗法

对张口不利、疼痛者可针刺合谷、翳风、颊车等穴位。

智齿冠周炎患者应注意口腔卫生，常用淡盐水漱口，选用中草药牙膏刷牙。保持心情舒畅，注意休息，多吃新鲜水

果和蔬菜,少吃油腻食物,少饮酒,不要抽烟,节制房事,锻炼身体,防止感冒。

病期宜进软食、流汁,多饮开水。张口困难及高热者应卧床休息。

98. 急性多发性龈脓肿

急性多发性龈脓肿是一种急性感染性口炎,多发于青壮年男子,牙龈有明显的自发痛和触痛,龈乳头红肿,在每个红肿的龈乳头内有一个小的脓腔,有时同一个牙齿的颊舌侧龈乳头各有一个脓肿形成。因此,可与牙周脓肿相区别。牙周脓肿是在牙周病的基础上发生的,有牙周袋和牙齿松动,而急性多发性龈脓肿可发生在无牙周袋的龈乳头内,牙齿并不松动。牙周脓肿是单发的,但本症是全口性的、多发性的、普遍性的。患者有体温升高,全身不适,白细胞增高,局部淋巴结肿大,口臭,咽痛,龈沟处有脓液流出。口腔粘膜普遍红肿,但不形成溃疡,便秘,舌红,苔黄厚,脉弦数。

急性多发性龈脓肿属于祖国医学的“牙痛”范畴。多由阳明胃经火毒上蕴而成。治宜清热解毒,凉血,排脓。

内治方

生石膏30克,黄芩30克,赤芍30克,生地30克,玄参30克,紫花地丁30克,茅根30克,大黄10克,香薷10克,天花粉10克。水煎服。

耳针疗法

取穴:上颌、下颌、神门、交感、龈。

护理

小脓肿成熟，可刺破，并用银花60克，连翘30克煎水漱口。

99. 疱疹性口炎

疱疹性口炎是急性感染性口炎的一种，由单纯疱疹病毒所引起。本病特点是口腔粘膜发生小水疱，散在或成簇状，破溃时成浅层溃疡。

疱疹性口炎多见于婴儿或儿童，常继发于上呼吸道感染或其他传染病之后，初次发病全身症状较重，复发时因已有抗体存在，所以全身症状较轻。疱疹性口炎发生于唇红部并波及口腔粘膜或口周皮肤。粘膜充血水肿，有针头大小的透明水泡，水泡四周有红晕。由于水泡极易破溃，因此临床所见疱疹大都为破裂后的糜烂或溃疡阶段。糜烂或溃疡后彼此融合，病变扩大。溃疡的边缘多数成半圆形突出，系由小水泡破溃而成。溃疡表面覆盖黄白色假膜，边缘四周有炎症性红晕。有时在残根处（幼儿在出牙处）可见牙龈增生，色鲜红，龈缘有假膜。

疱疹性口炎的全身症状：见体温升高（39—40℃），头痛和食欲不振等。发病2—3天后体温逐渐下降。整个病程约1—2周，如有继发感染，病期可稍延长。

中医认为疱疹性口炎系外感风热，内夹湿热，风火蕴结，上蒸于口所致。治宜疏风清热，宣肺导滞。

内治方

银花10克，板蓝根10克，葛根6克，赤芍10克，生地10克，

黄芩10克，沙参10克，酒制大黄6克，薄荷6克。水煎服。

外用方

青黛、银花、甘草、冰片各2份，人工牛黄、黄柏、龙胆草各1份。分别研细末混匀，吹入口腔溃疡处，每3小时一次。也可用龙胆紫外涂患处。

护理

若合并有全身性疾病时，应积极治疗全身性疾病，注意口腔清洁卫生，注意营养。

100. 药物过敏性口炎

药物过敏性口炎是药疹的一种类型，因发生于口腔粘膜，故称为药物过敏性口炎。引起过敏的药物有巴比妥类、水杨酸类、磺胺类及抗菌素类药物。一般在用药后24小时内发病。

发病突然，可单独损害口腔粘膜，也可损害皮肤（药物性皮炎）。有的患者伴有畏寒、发烧等全身症状。

药物过敏性口炎表现：口腔粘膜充血水肿、发疱、糜烂或成浅溃疡，易出血，疼痛。口内损害愈合较快，唇部损害愈合较慢。

患者有明确的用药史。停药后上述症状可逐渐减轻以至消失，再服药，上述症状又复发，因此诊断并不困难。

口腔病损可发生在唇、颊、舌、腭、龈等部位，以唇部多见。

药物过敏性口炎属于祖国医学的“药毒”范畴。治宜清热解毒，疏风祛湿。

方药：防风12克，苍术12克，蝉蜕10克，防己15克，柴胡15克，甘草15克，紫花地丁30克，紫草30克，车前草30克，秦艽10克，黄芩30克，赤芍15克，生大黄10克。水煎服。

护理

立即停用一切可疑引起发病的药物，凡不急需之药一概不用。加强排泄，保持大小便通畅。

预防

以后禁用引起过敏的药物。

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名=百病良方 第四集

作者=贾河先 邱运梨编著

页数= 2 5 0

S S 号= 1 0 4 6 0 8 8 2

出版日期= 1 9 8 9 年 0 5 月第 1 版